患者与家属的循证治疗科普

抑郁症治疗

从治疗总论到药物、心理、物理治疗，再到疗程、复发与危机管理

13 个模块 · 63 篇 · V1.0 / 2026-10

本资料库仅用于科普学习，不能替代精神科医生面诊、诊断与处方。

出现自杀念头、意识障碍、严重过敏、胸痛晕厥等情况，请立即拨打 120 或前往急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

使用边界与安全声明

这是一本写给患者和家属的治疗科普书。它把抑郁症治疗拆成 13 个模块，覆盖从初诊、选药、心理治疗、物理治疗，到疗程、停药、复发和危机应对的完整路径。

它不能替代面诊、诊断和处方。所有具体用药、剂量、减量、住院与特殊人群决策，都必须由具备资质的精神科医生结合个体情况作出。

请先记住三件事

- 抗抑郁药通常需要 2–4 周甚至更久才逐步起效，早期出现的是副作用，不一定是疗效。
- 不要自行突然停药、减量、换药或叠加药物；停药需要在医生指导下缓慢进行。
- 出现自杀念头、自伤行为、意识障碍、高热、严重过敏、胸痛、晕厥、抽搐，立即拨打 120 或去急诊。

版本与引用

版本 V1.0，最后更新 2026-10。指南、药物适应证、医保政策与热线号码会变化；与面诊医生或最新指南不一致时，以医生和最新指南为准。引用请注明《抑郁症治疗资料库》V1.0，并附具体篇目。

书中案例均为合并、改写后的示意，不对应任何真实个人。

总目录

按模块顺序排列。每篇正文都可独立阅读；书末附 60 个术语与主要指南来源。

使用说明

00 使用说明与免责声明

模块 1：治疗总论

1.1 治疗目标与缓解标准

1.2 治疗分期与强度分层

1.3 共同决策与治疗联盟

1.4 一页式治疗路径图

模块 2：药物治疗

2.1 抗抑郁药如何起效

2.2 常见药物分类与代表药物

2.3 医生如何选药

2.4 起始加量与足量足疗程

2.5 常见副作用与应对

2.6 需要警惕的危险反应

2.7 换药联合与增效

2.8 停药与撤药反应

2.9 药物相互作用与禁忌

2.10 用药常见问题 30 问

模块 3：心理治疗

3.1 心理治疗总览与证据

3.2 认知行为治疗 CBT

3.3 行为激活

3.4 人际心理治疗 IPT

3.5 正念认知疗法 MBCT

3.6 其他疗法与如何找治疗师

模块 4：物理治疗与辅助治疗

4.1 重复经颅磁刺激 rTMS

4.2 无抽搐电休克 MECT

4.3 经颅直流电刺激与光照治疗

4.4 氯胺酮与艾司氯胺酮

4.5 运动营养与睡眠

模块 5：难治性抑郁与联合策略

5.1 难治性抑郁的评估

5.2 换药还是增效

5.3 难治性抑郁的综合路径

模块 6：特殊人群与特殊时期

6.1 青少年抑郁

6.2 老年抑郁

6.3 孕产期抑郁

6.4 躯体疾病共病抑郁

6.5 双相抑郁的识别与禁忌

模块 7：风险管理与副作用监测

7.1 自杀风险评估与沟通

7.2 抗抑郁药与自杀风险

7.3 转躁与双相转换

7.4 性功能体重与代谢

7.5 出血低钠与心脏风险

7.6 实验室检查与监测计划

模块 8：疗程、依从性与停药

8.1 为什么要足疗程

8.2 漏服忘服与自行减量

8.3 停药计划与撤药管理

8.4 维持治疗与依从性

模块 9：复发预防与危机干预

9.1 复发预警信号清单

9.2 安全计划模板

9.3 紧急求助渠道

9.4 住院治疗与家属应对

模块 10：共病治疗

10.1 抑郁合并焦虑

10.2 抑郁合并失眠

10.3 抑郁合并慢性疼痛与躯体症状

10.4 抑郁合并 ADHD PTSD 与物质使用

模块 11：就医、费用与权益

11.1 如何选择医院与医生

11.2 初诊与复诊准备清单

11.3 费用医保病假与权益

模块 12：误区、问答与决策

12.1 常见治疗误区 40 条

12.2 患者与家属高频问答

12.3 网络信息与偏方辨别

模块 13：记录工具与量表

13.1 情绪与症状日记

13.2 用药与副作用记录表

13.3 复诊沟通单

13.4 PHQ-9 与 GAD-7 使用说明

附录：术语与参考文献

A 术语表

B 参考文献与指南版本

使用说明

00 使用说明与免责声明

> 这是一套写给患者和家属的抑郁症治疗科普资料，共 13 个模块、60 余篇。它想帮你把“治疗”这件事看清楚：有哪些选择、各自能做什么、风险在哪里、什么时候该找医生。它**不能替代面诊、诊断和处方**。

这套资料想解决什么问题

确诊抑郁症之后，人最容易陷入两种状态：一种是“医生说吃药就吃药”，对治疗一无所知；另一种是“网上说什么的都有”，越查越怕。两种状态都会让人失去主动权。

这套资料的目标是把治疗拆成可以理解、可以讨论、可以执行的小块：

- **知道治疗的全貌**：不是只有“吃药”一个选项，也不是“吃药就一定好”。
- **知道每个选择的边界**：药物、心理治疗、物理治疗各自适合谁，起效要多久，常见风险是什么。
- **知道怎么和医生合作**：复诊时该说什么，哪些变化必须报告，哪些问题可以问。
- **知道什么时候危险**：自杀念头、转躁、严重副作用、拒食脱水，分别该怎么处理。
- **知道怎么预防复发**：症状好了之后还要走多远，停药怎么停，早期预警信号怎么看。

它不是什麼

- 不是诊断工具。对照症状给自己“确诊”，或对照目录给家人“判病”，都可能出错。
- 不是处方集。本资料刻意不写起始剂量、加量速度和减量方案，因为这些必须由医生结合诊断、年龄、体重、肝肾功能、合并用药、既往反应来决定。
- 不是“替代药物的自然疗法大全”。运动、睡眠、正念有证据，但不能替代中重度抑郁的规范治疗。
- 不是“保证康复”的承诺。抑郁症可以治疗，大多数人会好转，但路径因人而异，复发也并不罕见。
- 不是法律或保险意见。涉及病假、伤残、医保报销时，以当地政策和经办机构答复为准。

三种读法

第一种：从头读。 适合刚确诊、时间比较充裕的人。按模块 1 → 2 → 3 → 4 → 8 → 9 的顺序，先建立全局，再看具体治疗，最后看疗程和危机。

第二种：带着问题查。 适合已经在治疗中的人。直接看总目录里“这一页解决什么”，找到对应篇目；每篇都能独立阅读，不需要按顺序。

第三种：只看最要紧的。 如果现在情绪很差、注意力维持不了太久，先读三页：

1. 9.2 安全计划模板

2. 9.3 紧急求助渠道
3. 1.1 治疗目标与缓解标准

五种内容标签

为了让你知道一句话的“分量”，文中会用方括号标注：

标签	含义	你该怎么用
【指南】	NICE、CANMAT、APA、中华医学会等指南有明确推荐	可以作为和医生讨论的依据
【研究】	随机对照试验、系统综述支持，但未必已进入所有指南	可以了解，别当成唯一答案
【临床经验】	临床常见做法，个体差异大，证据等级较低	参考，不要照搬
【待验证】	机制推测、小样本研究、争议观点	保持开放，别当结论
【个人体验】	康复者或家属的主观感受	共情用，不代表普遍规律

同一句话可能同时有多个标签。标签不是“真假”的判决，而是提醒你：**这条信息有多硬，适不适合拿来指导自己的治疗。**

安全声明（请先读）

抑郁症的治疗里，有些情况不能等：

- **出现自杀念头、计划、准备行为，或已经自伤：**不要独处，立刻联系信任的人陪着你，拨打 120 或前往最近医院急诊；也可以拨打 12356 心理援助热线。把可能用于自伤的物品暂时交给他人保管。
- **出现高热、意识混乱、肌肉僵硬或抽动、大汗、心跳很快：**可能是严重的药物不良反应（如血清素综合征），立即急诊。
- **出现明显兴奋、话多、睡得很少却不困、冲动消费或冒险行为：**可能是转躁，尽快联系精神科医生，不要自行加药。
- **出现严重过敏（皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难）、晕厥、胸痛、抽搐：**立即呼叫 120。
- **拒食、几乎不喝水、连续多日不睡、行为失控：**需要尽快精神科评估，必要时住院。

如果你不确定“算不算严重”，按严重处理，先联系医生或急诊。**宁可白跑一趟，不要赌。**

关于药物：三句最重要的话

1. **抗抑郁药不是立刻见效的。** 情绪改善通常要 2–4 周甚至更久，早期先出现的是副作用，不是疗效。不要因为“吃了三天没感觉”就停。
2. **不要自行突然停药。** 突然停用可能出现头晕、恶心、失眠、电击感、焦虑加重等撤药反应，也会增加复发风险。要停，和医生一起定计划。

3. **副作用要报告，但不要自己处理。** 大多数早期副作用会减轻，但有些需要调整方案；有些是危险信号，必须马上就医。分不清时，联系开药医生。

关于心理治疗

心理治疗不是“聊聊天”，也不是“只有想不开的人才需要”。CBT、行为激活、IPT、MBCT 都有证据支持，但需要合格的治疗师、稳定的频率和主动的练习。它和药物不是二选一：中重度抑郁常常是“药物 + 心理治疗”一起做。具体怎么选，看 3.1 心理治疗总览与证据。

关于隐私与案例

文中出现的“小 A”“一位来访者”等，都是合并、改写后的示意案例，不对应任何真实个人。你自己的记录（情绪日记、用药记录）属于敏感信息，分享给医生之外的人之前，先想清楚边界。

如何纠错与更新

- 本资料版本：V1.0，最后更新 2026-10。
- 指南会更新，药物适应证会变化，热线号码会调整。看到与医生说法不一致时，**以面诊医生的个体化判断和最新指南为准**，并把差异告诉医生。
- 如果发现事实错误、失效链接、表述可能误导，请在资料库维护记录里标注“待核”，不要直接照用。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 1：治疗总论

先建立全局观：治疗要达到什么目标、分几个阶段、强度怎么定、如何和医生一起决策。这一模块不涉及具体药物，但决定了后面所有选择的方向。

1.1 治疗目标与缓解标准

很多人以为治抑郁就是“让心情好起来”。但在诊室里，医生说的“有效”“缓解”“康复”各有各的意思，混着用会让人做出错误的决定：要么过早停药，要么因为“还没完全好”而过度焦虑。这一页把这几个词拆开讲，也讲清楚症状之外，功能和生活的质量为什么同样算数。读完你可以大概判断自己在哪个阶段，知道下次复诊该跟医生谈什么目标，也明白为什么“感觉好一点”不等于可以停药。

一、四个最容易被混用的词

应答：治疗“方向对了”

应答（response）指症状比治疗前明显减轻。临床上常用一个粗糙但好用的参照：量表总分比治疗前下降一半左右，或者医生判断“比之前好了不少”。【指南】

应答是个好消息，说明这次治疗的方向大概率是对的；但它不是“治好了”。一个人可以从“每天躺着起不来”变成“能起床、能吃饭，但还是提不起兴趣、注意力很差”，这算应答，离缓解还有距离。把应答当成终点，是复燃最常见的原因之一。

缓解：症状基本消失

缓解（remission）指症状基本消失，量表落到很低的水平，并且这种状态持续一段时间。

- 用 PHQ-9 自评，常用“降到 5 分以下”作为缓解的参考线。
- 用他评量表（由医生打分，如 HAMD-17），常用“降到 7 分及以下”作为参考。

这两个数字是通行做法，不是绝对标准，不同医院、不同研究用的线会略有差别。【指南】更重要的是“持续”：今天分数低、下周又上去，不叫缓解。医生通常会看连续几周的表现，再判断你是否进入缓解。

缓解是急性期治疗最现实的目标。它意味着症状这团火基本灭了，但灰还热着。

康复：缓解稳住了，功能也回来了

康复（recovery）不是一个化验指标，而是一段时间的状态：缓解持续得够久（多数指南以数月计，常以半年左右作参照），功能基本回到病前水平，人际关系和生活质量也恢复。【指南】

“康复”容易被听成“彻底好了、以后不会再来”。更准确的理解是：这一段时间你回到了自己的生活里，但抑郁症是一种会复发的疾病，后面还需要维持和监测。康复是一段路走完了，不是一张终身免复发证书。

复发：火又着了

和“复发”相关的其实是两个词：

- **复燃**（relapse）：还在缓解期、甚至还在吃药，症状又回来了。常见诱因是过早减药停药、严重生活事件、睡眠长期不足。
- **复发**（recurrence）：已经康复一段时间，又出现一次完整的发作。

不同教材、不同指南对这两个词的用法不完全一致，有的干脆统称“复发”。你不用纠结名字，记住一件事就够了：缓解之后，风险并没有归零，所以才需要巩固期和维持期。【指南】

概念	大致意思	常见判断依据	容易误会的地方
应答	症状明显减轻，治疗方向对	量表分数下降约一半，或医生判断明显好转	把“有效”当成“治好”，急着减药
缓解	症状基本消失并持续一段时间	PHQ-9 常以低于 5 分为参考，症状持续数周	分数一低就宣布痊愈，忽略功能
康复	缓解稳定、功能和生活质量恢复	缓解维持数月，能承担日常角色	以为从此不会再复发
复发	缓解后症状再次出现	症状回到发作水平、功能再次下降	和撤药反应、季节性波动混为一谈

二、为什么不能只看症状：三个维度

医生评估抑郁，通常同时看三个维度。只盯其中一个，都会漏东西。

症状维度

情绪低落、兴趣减退、睡眠改变、食欲和体重变化、精力下降、注意力变差、自责无价值感、动作迟滞或烦躁、自杀念头。这些是诊断和量表主要覆盖的部分，也是最容易被看见的部分。

功能维度

能不能上班上学、做家务、出门买菜、和人说话、照顾自己、开车、管钱。功能恢复往往比症状恢复慢半拍：先能睡着，再能出门，再能坐住半天，最后才是稳定工作。这个顺序是正常的，不是“我不够努力”。

生活质量维度

关系好不好、有没有一点意义感、身体舒不舒服、能不能感到愉快。有的人症状分数已经很低，但仍然觉得“活着没意思、什么都没味道”，这就是生活质量还没回来。

维度	具体看什么	可以怎么问自己
症状	情绪、兴趣、睡眠、食欲、精力、注意力、自责、自杀念头	这一周有几天情绪很低？睡着要多久？半夜会醒吗？
功能	工作学习、家务、出门、社交、自我照顾	这周我完成了哪些以前能做的事？哪些做不了？
生活质量	关系、意义感、身体感受、愉快体验	有没有哪怕一小段时间，我觉得活着还行？

还要提一个词：**残留症状**。指症状大部分好了，但还剩下几样，比如总也睡不沉、下午就累垮、注意力像蒙了层雾、对什么都没兴趣。残留症状很常见，而且和之后复发的风险有关。【研究】所以复诊时不要只说“好多了”，要把“还剩下什么”讲清楚，这直接决定医生是维持原方案还是继续调整。

三、PHQ-9 只能作参考，不能作判决

PHQ-9 是九个条目的自评量表，问的是最近两周。它填写快、能重复、便于看变化，所以在门诊和随访里用得很多。但它有三条边界：

1. **它不能确诊。** 分数高只说明“可能抑郁、值得进一步评估”，诊断要靠医生访谈，排除躯体疾病、药物影响、双相障碍等。
2. **它会波动。** 昨晚没睡好、今天跟人吵了一架、正好在经期、感冒发烧，都会让分数上下浮动几分。单日分数没有太大意义，看的是两三周的趋势。
3. **它不测功能和生活质量。** 有人 8 分但完全没法工作，有人 10 分但生活基本正常，两人的处理方式可能完全不同。

更细的条目、计分和临界值，见 13.4 PHQ-9 与 GAD-7 使用说明。这里只需要记住一句话：**量表是帮你和医生对话的工具，不是给你自己下诊断的尺子。**

四、把“我自己的目标”放进治疗

医生习惯用分数和风险说话，你更在意的是具体生活。两套目标不冲突，合起来才完整。

建议在复诊前写下三个目标：

- 一个**近期**的（这一个月能做到的）；
- 一个**中期**的（这半年想恢复到的状态）；
- 一个**长期**的（你想回到什么样的生活）。

写的时候尽量具体、可观察，避免“我要开心起来”“我要恢复正常”这种没法验证的说法。

模糊的目标	可以改成
“我要开心起来”	“这周有三天，我能出门走 20 分钟”
“我要恢复正常”	“下个月试着回公司上半天班，先试两周”
“我不想再哭了”	“这周哭的次数从每天降到两三次，哭完能缓过来”
“我要跟家人关系变好”	“每周和妈妈吃一次饭，不中途离席”

这些目标有一个好处：它们能反过来指导治疗。如果药物让你白天昏沉、没法上班，那“能工作”这个目标就值得和医生讨论；如果心理治疗排在工作日白天、你根本请不了假，那这个方案在现实里就执行不了。

同时也要允许目标被修改。治疗初期定的目标，常常在两个月后看起来不切实际。这不是失败，是你更了解自己的病情了。

复诊前 5 分钟，可以照着勾一遍：

- ☐ 这周情绪最低的那天，大概几分（0–10）？
- ☐ 睡眠：入睡要多久、夜里醒几次、总共有几小时？
- ☐ 兴趣：还有没有一件事能让我稍微投入？
- ☐ 功能：这周缺勤/缺课几天？家务能做什么？
- ☐ 用药：有没有漏服？有没有副作用？
- ☐ 自杀念头：有没有？如果有，是“活着没意思”还是有具体想法？
- ☐ 这一个月我最想解决的一件事是什么？

五、为什么“感觉好一点”不等于可以停药

这是最需要说清楚的一件事。

第一，症状、功能、稳定性是三段路。 你感觉好一点，可能只是症状这一段走了一半。功能还没恢复，稳定性更没建立。这时候减药，等于火刚小一点就撤水。

第二，多数指南建议在缓解后继续治疗一段时间。 常用说法是：缓解后继续原方案数月（常以半年左右为参照），有过多次发作、上次发作严重、有残留症状或家族史的人，维持时间更长，部分人需要数年甚至更久。【指南】具体多久由医生结合你的发作史判断，不是一个统一的数字。

第三，突然停药本身会带来麻烦。 头晕、恶心、失眠、焦虑加重、像“电击”一样的感觉，都是常见的撤药反应；它们和复发很像，容易让人误判。要停，应该是和医生一起做的计划，慢慢来、有监测。

一个常见的场景是这样的：服药两个月，睡眠和情绪都好了，觉得“我已经没事了”，自己把药减半；三周后开始早醒、心慌、觉得拖累家人，又回到原点。这不是意志问题，是时机太早。停药该怎么停，见 8.3 停药计划与撤药管理。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**

- 出现自杀念头、自伤行为，或开始安排后事、把东西送人、上网查方法：**不要独处**，立刻联系信任的人陪着，呼叫 120 或去最近医院急诊；也可以拨打 12356 心理援助热线。
- 症状在几天内明显加重，整夜睡不着、吃不下、无法工作或照顾自己：尽快联系开药医生，争取提前复诊。
- 出现明显兴奋、话变多、睡得很少却不困、冲动花钱或冒险：尽快联系精神科医生，**不要自行加药**。
- 高热、意识混乱、肌肉僵硬或抽动、大汗、心跳很快：立即急诊，可能是严重的药物不良反应。
- 服药后出现皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：立即呼叫 120。

常见问题

“量表分数降了，就是缓解了吗？” 不一定。分数降了是好事，但缓解还要求“持续”和“功能恢复”。医生一般会结合这两点判断。

“医生说我缓解了，可我还是很累。” 这很常见。残留的疲乏、睡眠差、注意力问题可能持续更久，需要继续治疗和调整，而不是“你应该好了”。

“目标定高了，会不会更失望？” 可以定得小一点、具体一点。目标不是考核，是方向。做不到就改，改了才有用。

“家里人说我想太多，让我别吃药。” 这句话不能替代医生的评估。可以把家人的担心记下来，复诊时和医生一起讨论，而不是自己停药。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.2 治疗分期与强度分层

同样是“抑郁症”，有人只需要几次心理治疗和规律随访，有人需要药物联合心理治疗，还有人必须住院。差别不在于谁更坚强，而在于症状的严重程度、功能受损的范围和风险高低。这一页讲两件事：治疗为什么要分阶段，以及不同程度的抑郁大致对应什么样的治疗强度。读完你可以理解医生为什么这样安排，也能判断自己现在处在哪一段、下一次复评该看什么。

一、三个阶段：急性期、巩固期、维持期

抑郁症的治疗不是“吃上药，等它好”，而是一段有起点、有中途站、有终点的路。多数指南把它分成三个阶段，每个阶段要解决的问题不同。【指南】

急性期：先把火扑灭

目标：减轻症状，争取达到缓解（症状基本消失）。同时保证安全，处理最影响生活的问题，比如整夜失眠、吃不下饭、无法工作。

时长：从开始治疗到症状缓解，通常需要数周到两三个月。多数指南建议在治疗开始后数周内做一次评估，看有没有应答；如果没有，就要考虑调整剂量、换药或换治疗方式。【指南】

最容易犯的错：一是太急，吃药几天没感觉就放弃；二是太慢，明明一点没好转，还按原方案拖了几个月不复查。这两种都不好。急性期的关键动作是“定期回来看”。

巩固期：别让火复燃

目标：症状已经缓解，但这时的稳定是脆弱的。巩固期要把疗效固定下来，让功能逐步恢复，防止复燃。

时长：多数指南建议在症状缓解后继续原来的治疗数月，常以半年左右作参照，具体长短看发作次数、严重程度和残留症状。【指南】

最容易犯的错：感觉好了就自行减药或停药。这个阶段复发的人最多，因为“感觉好了”和“病好了”之间还有一段距离。

维持期：防止下一次发作

目标：预防新的发作，让你在生活里站稳。

时长：不是每个人都需要很长的维持期。多数指南建议，有过多次发作、上次发作严重、有残留症状、起病年龄早、有家族史或共病人群，维持治疗两年或更久；发作次数越多，维持时间往往越长，少数人需要长期治疗。【指南】

最容易犯的错：把维持期当成“多余的治疗”，或者反过来，明明已经稳定多年却不敢和医生讨论减量。两种情况都值得摊开来谈。

阶段	主要目标	大致时长	复评重点与常见错误
急性期	减轻症状、争取缓解、保证安全	数周到两三个月	看有无应答和副作用；常见错误是太早放弃或太久不复查
巩固期	固定疗效、恢复功能、防复燃	缓解后继续数月，常以半年为参照	看残留症状、功能恢复、依从性；常见错误是感觉好了就自己减药
维持期	防复发、回归生活	通常一年以上，复发多者两年或更久	看早期预警信号和生活事件；常见错误是擅自停治疗，或不敢谈减量

二、严重程度决定起点

治疗强度不是“越强越好”，而是“匹配”。轻度用重手段，副作用和负担可能超过收益；重度只用轻手段，则可能耽误时间、增加风险。

医生判断严重程度，通常看三样：症状的数量和强度、功能受损的程度、有没有风险（自杀、精神病性症状、拒食脱水等）。量表分数只是其中一项参考，不能单独拿来定级。

严重程度	常见表现	常用治疗强度	通常在哪看
轻度	症状数量少、程度轻，日常功能基本维持，只是效率下降、常感吃力	心理治疗（如认知行为治疗、行为激活、问题解决治疗）、规律随访、睡眠与运动调整；部分人可先观察并主动监测	综合医院精神科/心理科、基层医疗机构
中度	症状明显，工作学习、家务、社交已受影响，但尚能勉强维持	药物或心理治疗，很多时候两者联合；定期复评	精神科门诊
重度	症状多而重，功能严重受损，可能伴精神病性症状、拒食或明显自杀风险	药物联合心理治疗，必要时物理治疗（如 rTMS 经颅磁刺激、MECT 无抽搐电休克），部分人需要住院	精神专科医院或综合医院精神科，必要时住院

“轻度”不等于“不用管”。轻度抑郁也可能拖成慢性，也可能在某次生活事件后迅速加重。可以不用药，但需要有人跟着看、需要知道自己该在什么情况下回来。【指南】

“重度”也不等于“没希望”。重度往往更需要组合治疗和专科资源，而不是更少。

三、阶梯式治疗：能轻则轻，不够就升

阶梯式治疗（stepped care）是很多指南采用的组织方式：从侵入性最小、负担最轻、成本最低的有效干预开始；如果不够，再往上升；稳定之后，也可以往下降。【指南】

这个思路的好处是，不必一上来就用最重的方案，也不会在无效的方案上无限停留。它有个前提：每一阶都要有明确的复评节点，不能“上了台阶就忘了看”。

层级	适合谁	主要做什么	由谁提供
第 1 阶	所有人	识别、评估、告知、安全计划、随访安排	基层医生、精神科门诊
第 2 阶	轻度，或不愿/不能用药者	低强度心理干预：自助材料、团体课程、行为激活、规律运动、睡眠调整	心理治疗师、护士、基层医生
第 3 阶	中度，或第 2 阶无效	规范药物治疗，或高强度心理治疗，或两者联合	精神科医生、心理治疗师
第 4 阶	难治、共病复杂、需要物理治疗	换药、增效、联合治疗、rTMS/MECT、专科会诊	精神专科医院
第 5 阶	高风险、功能崩溃	住院、危机干预、24 小时监护	精神专科病房

有几点需要说明：

- **阶梯不是电梯，可以上下。** 升上去不代表失败，降下来也不代表复发。稳定一段时间后和医生讨论降阶，是合理的。
- **升阶要有依据。** 通常是“足量足疗程后仍无应答”，或者出现新的风险。不是“今天心情不好，明天就想换方案”。
- **不是所有地方都有完整的五阶。** 现实里可能缺心理治疗资源、缺专科床位。这种情况下，医生会在能用的资源里做取舍，这并不等于你的病不重。

四、什么时候需要转专科或住院

多数人在门诊就能完成治疗。但有些情况，门诊的条件不够，需要往上转。以下情况值得尽快和医生讨论转诊：

- 诊断不确定，尤其怀疑双相障碍、精神病性障碍、器质性疾病所致；
- 有明显自杀风险，或已经有过自伤行为；
- 出现幻觉、妄想等精神病性症状；
- 拒食、几乎不喝水、体重明显下降，有脱水或营养不良风险；
- 门诊治疗一段时间无应答，或反复调整仍不见好；
- 合并严重躯体疾病、物质使用、妊娠或哺乳期、老年多重用药；
- 需要 rTMS（经颅磁刺激）、MECT（无抽搐电休克）等物理治疗；
- 青少年、孕产妇等需要特殊评估的人群。

住院通常考虑这些情况：自杀风险高、门诊无法保证安全；精神病性症状明显；拒食脱水需要静脉补液和监护；需要 MECT；门诊治疗关系建立不起来、治疗无法推进。【指南】

住院不是“关起来”，它的核心作用是：把人放在一个能保证安全、能 24 小时观察、能集中调整治疗的环境里。关于住院的流程、探视和权益，见 9.4 住院治疗与家属应对。

我国《精神卫生法》对非自愿住院有严格的条件和程序要求，不是家属或单位想送就能送。遇到这种情况，可以要求医院说明依据，也可以寻求法律帮助。【指南】

五、时间框架怎么理解

治疗需要时间，但“需要时间”不等于“无限等待”。可以把复评理解成几个节点：

1. **开始治疗后数周**：看有没有早期改善的迹象，看副作用能不能耐受。
2. **一两个月左右**：多数指南把这段时间作为判断“有没有应答”的窗口。有应答就继续，没有就调整。【指南】
3. **症状缓解后**：进入巩固期，复评重点从“症状”转向“功能”和“残留症状”。
4. **巩固期结束前**：和医生一起决定维持多久、要不要减量。
5. **停药后**：仍需随访一段时间，观察早期预警信号。

这里说的都是大致框架。有人两周就有明显改善，有人要两三个月，还有人需要几次调整才找到合适的方案。**慢不等于没效，但“一直没变化”需要被讨论。**

下次复诊前，可以照着勾一遍：

- ☐ 我能说清这两周的睡眠、食欲和情绪最低的那几天
- ☐ 我知道现在这个阶段的目标是什么（减轻症状 / 固定疗效 / 防复发）
- ☐ 我知道下一次复评大概在什么时候
- ☐ 我知道出现什么情况要提前联系、什么情况要去急诊
- ☐ 如果方案一直没效果，我知道可以问医生哪些下一步选项

六、什么时候需要联系医生或去急诊

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或开始安排后事、查方法、送东西：**不要独处**，立刻联系信任的人，呼叫 120 或去最近医院急诊；也可以拨打 12356 心理援助热线。
- 拒食、几乎不喝水、连续多日几乎不睡、行为失控：尽快精神科评估，必要时住院，不要在家硬扛。
- 出现幻觉、妄想、坚信被害或被监视：尽快联系精神科医生，这类情况需要专科处理。
- 突然变得异常兴奋、话多、睡得很少却不困、冲动消费：可能是转躁，尽快联系医生，**不要自行加药**。
- 服药后高热、意识混乱、肌肉僵硬、大汗、心跳很快：立即急诊。

常见问题

“轻度是不是可以不管？” 可以不用药，但建议有人随访、有复评节点，并知道加重时找谁。轻度也可能拖成慢性。

“医生让我住院，是不是说明我完了？” 住院是治疗强度的一种，不是判决。它通常说明现在需要更密的观察和更集中的调整，不代表以后都好不了。

“我可以要求转院或换医生吗？” 可以。带上病历、用药记录和检查结果，向新医生说明既往治疗和效果。转诊时尽量不要中断用药。

“方案没效果，是不是我自己的问题？” 治疗无效有很多原因：剂量不足、疗程不够、诊断需要修正、共病没处理、依从性问题、个体差异。这些是医生要排查的，不是你的错。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.3 共同决策与治疗联盟

治疗抑郁，不是把处方单接过来照做就行。同样一套方案，有人执行得很好，有人两个月就放弃，差别常常不在药，而在“这个方案是不是我们一起定下来的”。这一页讲三件事：怎么和医生一起做决定、怎么把顾虑说出口、以及当你觉得“这个医生不适合我”时该怎么办。读完你可以带着一份自己的偏好清单进诊室，而不是空着手、点着头出来。

一、共同决策是什么

医患沟通大致有三种样子：

- **家长式**：医生定，你照做。好处是快，坏处是你不知道为什么，遇到副作用或生活变化时容易慌。
- **告知式**：医生把选项摊开，你自己选。听起来自由，但缺少专业判断的引导，患者常常更焦虑。
- **共同决策**：医生提供专业信息和证据，你说出自己的处境、价值和顾虑，双方一起定一个都认账的方案。【指南】

共同决策不是“患者说了算”，也不是“医生推卸责任”。它的前提是：医生懂病，你懂自己的生活。两边信息合起来，才可能做出一个既医学上合理、现实里又执行得下去的决定。

它还有一个实际好处：一起定下来的方案，执行率更高，复诊也更愿意去。【研究】

二、共同决策的六个步骤

这六步不必每次都走全，但心里有个顺序，谈话会顺很多。

第一步：明确这次要决定什么。 是“要不要开始吃药”，还是“现在这个药没效果，换还是加”，还是“要不要做心理治疗”。问题越具体，讨论越有效。

第二步：请医生列出选项。 包括“先观察一段时间”“先做心理治疗”“药物加心理治疗”“换一类药”。别忘了“什么都不做、只随访”也是一个选项，尤其对轻度抑郁。

第三步：问每个选项的收益、风险和不确定性。 比如：大概多久能看到变化？常见副作用是什么？如果无效，下一步是什么？这个方案有多少把握？证据强不强？

第四步：说出你的价值和顾虑。 你最怕的是什么？是发胖、是性功能受影响、是白天犯困没法开车、是怕被单位知道、是担心吃上就停不下来？这些不是“不配合”，是方案能不能落地的前提。

第五步：讨论现实条件。 费用、医保、请假、路程、复诊时间、家里有没有人帮忙、能不能固定每周同一时间做心理治疗。

第六步：一起决定，并约定复评。 明确“我们先按这个方案走，几周后回来看什么；如果出现什么情况，提前联系”。这一步最容易被跳过，但它决定了后面有没有退路。

步骤	你可以这样问	医生通常会怎么回应
明确问题	“这次我们需要决定的是什么？”	把问题收敛成一两个具体选择
列出选项	“除了这个，还有别的选择吗？”	补充心理治疗、观察随访等
比较利弊	“这个方案大概多久能看出效果？常见副作用是什么？”	给出时间框架和监测计划
说出顾虑	“我最担心的是白天犯困，因为我要开车。”	调整用药时间或换方案
谈现实条件	“这个治疗每周要请半天假，我请不了。”	换成周末门诊、线上随访或别的形式
约定复评	“如果两周后更差了，我该怎么办？”	给出提前复诊或急诊的指引

三、把偏好和顾虑说出口

很多人不是没有想法，是说不出来。怕耽误医生时间，怕被当成“不听话的病人”，怕说错。下面这些句式可以直接用：

- “我想先弄清楚……再决定。”
- “我最担心的是……，这个担心合理吗？”
- “我之前试过……，那次体验很不好。”
- “如果……，我可能坚持不下来。”
- “我查到的说法和您说的不太一样，能不能帮我分辨一下？”
- “我需要回去想一想，可以下次再定吗？”

如果当面说不出口，可以提前写在纸上或手机备忘录里，进诊室递给医生。也可以让陪同的家属帮忙补充。写下来不丢人，反而是效率最高的办法。

还要区分两件事：**“我不愿意”** 和 **“我担心”**。不愿意是价值选择，比如不想吃药；担心是信息不足，比如怕伤肝。对前者，医生需要尊重；对后者，医生可以解释。把两者混在一起，讨论就容易变成争执。

心里的话	可以怎么说
“我不想吃药，怕上瘾。”	“我担心长期吃会依赖，这个担心有依据吗？”
“这药让我白天昏沉，没法工作。”	“我上午开会必须清醒，现在的困倦影响到工作了，有没有调整空间？”
“我没钱做心理治疗。”	“自费心理治疗我负担不起，有没有别的途径或更便宜的选项？”
“我不信任这个医生。”	“我有一些顾虑想说，可以占用两分钟吗？”
“我想停药。”	“我现在状态不错，想了解什么时候可以减量、怎么减。”

进诊室前，可以照着勾一遍：

- ☐ 我最想解决的一个问题是什么
- ☐ 我最担心的副作用或后果是什么

- ☐ 我能接受的时间、费用和复诊频率大概是多少
- ☐ 我希望家属参与到什么程度（陪同、旁听、还是不参与）
- ☐ 我准备好的三个问题，按重要程度排好序

现实因素不是小事

诊室里最容易被忽略的，往往是决定治疗能不能坚持下去的那些事。

- **费用**：不同药物、不同心理治疗的自费比例差别很大。可以问“有没有医保内可选的”“门诊慢特病能不能报”。费用问题不丢人，说不出口才麻烦。
- **副作用与工作**：嗜睡、注意力下降、手抖、出汗，都会影响开车、操作机器、开会发言。这些要具体说，医生才能调整服药时间或换方案。
- **哺乳与备孕**：不是“吃药就一定不能喂奶”，也不是“喂奶就一定不能吃药”。这需要精神科和产科一起评估，把两边风险放在一起看。见 6.3 孕产期抑郁。
- **时间与路程**：心理治疗通常需要固定时段、连续多次。如果每次要跨城、要请假，方案本身就会崩。
- **隐私**：单位、学校、家人知道多少，是你的边界。可以问医生病历和诊断证明会怎么写、会给谁看。

这些因素不改变“医学上该怎么做”，但会改变“现实中能怎么做”。一个好的方案，是两者都能成立。

四、治疗联盟：三个零件

治疗联盟（therapeutic alliance）是心理治疗研究里的概念，后来被用到整个精神科治疗中。它大致由三部分组成：

1. **目标一致**：你和医生对“要治到什么程度”有共识。
2. **任务一致**：你认可这个方案里的任务，比如按时吃药、做记录、每周来一次。
3. **情感联结**：你觉得被听见、被尊重，而不是被审问、被评判。【研究】

三者缺一个，联盟就会松。比如目标一致但任务不接受，人就会表面答应、背后减药；任务接受但情感联结差，人就会越来越不想来。

联盟破裂的信号：每次复诊前都紧张、想请假；觉得医生总打断你；方案从来没被解释过；你开始瞒着漏服；迟到、失约变多；走出诊室觉得“说了也没用”。

可以怎么办：

- **先试一次当面说。** “我有个感受想说：上次我讲副作用的时候，我觉得没被听完。”很多误会一句话就能解开。
- **给一次机会，也给自己一个期限。** 比如“这次说清楚，如果还是这样，我就换”。

- **换医生不是背叛，也不是矫情。** 匹配度是治疗的一部分，换一个更合适的人，比硬撑着中断治疗好。
- **换的时候别断药。** 提前拿到处方、病历摘要和检查结果，向新医生说明既往用药、效果和副作用。突然停药的风险，比多跑一趟医院大得多。
- **如果暂时换不了**，可以先把需求写下来、请家属陪同、或先解决最急的一个问题，不必等到“关系完美”才开始治疗。

情况	可以怎么做
觉得医生不解释方案	直接问“能不能帮我讲讲为什么选这个”
觉得被评判	说出感受，或换一位医生
想换医生但怕断药	先要到处方和病历摘要，再约新医生
医生很忙、每次几分钟	提前写纸条，把三个重点放在最前面
家属和医生意见冲突	让患者本人表态，家属补充信息而非代替决定

五、家属在其中的角色

家属能做的事，比想象中多，也比想象中需要分寸。

能做的：陪同就诊、帮忙记录、在患者说不清时补充观察（“他这两周每天凌晨三点就醒”）、提醒复诊和服药、观察危险信号、在患者犹豫时帮忙问出那个问题。

需要分寸的：不代替患者做决定（除非本人已无法表达意愿）、不隐瞒病情、不在诊室里替患者“认错”、不把治疗当成“管教”。患者对隐私的边界要尊重，哪些话可以对家人说，由患者决定。

家属自己也需要支持。 长期照护会耗尽一个人。家属可以有自己的咨询、自己的休息、自己的求助渠道。你倒下了，对谁都没有好处。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或开始安排后事、把东西送人：**不要独处**，立刻联系信任的人，呼叫 120 或去最近医院急诊；也可以拨打 12356 心理援助热线。
- 因为对治疗不满而打算自行停药：先联系医生说明，不要突然停。突然停药可能出现撤药反应，也会增加复发风险。
- 出现严重副作用（皮疹扩散、面唇肿胀、呼吸困难、高热、意识混乱、肌肉僵硬）：立即急诊。
- 治疗关系严重破裂、无法继续，同时症状在加重：尽快联系医院转诊或换医生，不要空档期拖太久。

常见问题

“换医生会不会得罪原来的医生？” 一般不会。医生更在意你能否继续治疗。带上病历，说明原因，体面地转过去就好。

“医生说必须吃药，我不同意，怎么办？” 可以要求医生解释依据、说明替代方案和不治疗的后果。你也可以选择先做心理治疗，但要约定复评时间，并知道什么情况下需要回来。

“家属该不该进诊室？” 由患者决定。患者愿意就可以，家属可以补充观察、帮忙记；患者不愿意，也应尊重。

“我什么都说不出来，是不是没救了？” 说不出来很常见。写下来、让家属陪、先只说一件事，都是办法。治疗不要求你口才好。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

1.4 一页式治疗路径图

治疗抑郁像走一条有岔路的长路：先要看清起点，再决定走哪条道，中间要定期回头看有没有走偏，最后还要知道什么时候可以慢下来。这一页把整条路压缩成一张图、几张表，方便你贴在病历本上、存在手机里。它不能代替医生判断，但能让你在每次复诊时知道自己走到哪一步、下一步该问什么。如果只读一页，就读这一页。

一、总览：从初诊到维持



这张图里有两个地方最容易被跳过：**复评**和**停药计划**。前者决定治疗有没有效，后者决定会不会白治一场。

二、逐个节点：每一步在做什么

节点	要做什么	大致时间点	谁负责
初诊	说清最困扰的三件事、带齐既往资料和正在吃的药	首次就诊	患者 + 家属
评估	症状、功能、风险、躯体疾病、用药史、家族史	初诊及每次复诊	医生
分层	判断严重程度与风险等级，决定治疗场所	初诊后	医生，与患者讨论
决策	比较选项、说明利弊、结合现实条件	初诊或第二次就诊	医生 + 患者

节点	要做什么	大致时间点	谁负责
急性期	规范治疗、监测副作用与风险	数周至两三个月	医生 + 患者
复评	判断应答、耐受性、安全性，决定继续或调整	治疗后数周、之后定期	医生
巩固期	维持原方案、恢复功能、处理残留症状	缓解后数月	医生 + 患者
维持期	继续治疗、监测预警信号、处理生活事件	通常一年以上	医生 + 患者
停药	评估时机、制定缓慢减量计划、约定随访	由医生判断	医生 + 患者
随访	观察复发信号、调整生活节奏	停药后数月到一年	患者 + 家属 + 医生

初诊时最值得带来的东西：正在吃的所有药（包括保健品、中药）、既往的处方和化验单、之前看过的诊断记录、一张写好的“三个最困扰我的问题”。很多人第一次进诊室会大脑空白，写下来说是最省力的办法。

评估不只是问心情。 医生还会问睡眠、食欲、体重、注意力、兴趣、自责、自杀念头，也会问有没有过异常兴奋的时期（排查双相）、有没有躯体疾病、有没有在吃其他药。这些不是八卦，是选方案的前提。

三、分岔口：不同情况走不同的路

情况	优先考虑	需要特别留意
轻度抑郁	心理治疗、行为激活、规律随访、睡眠与运动调整	不用药也要有复评节点，别“自己扛着”
中度抑郁	药物或心理治疗，多数时候两者联合	定期评估应答，别在无效方案上停太久
重度抑郁	药物联合心理治疗，必要时 rTMS（经颅磁刺激）、MECT（无抽搐电休克），部分需住院	安全评估放在第一位
伴精神病性症状	抗精神病药联合抗抑郁药，常需住院	这类情况门诊很难处理，尽快专科
伴自杀风险	安全计划、密切随访、必要时住院	不要独处，不要隐瞒念头
怀疑双相	先明确诊断，慎用抗抑郁药单药	转躁的信号要提前告知
孕产期	精神科与产科共同评估	治疗与不治疗都有风险，需要一起权衡
老年	低起点、慢调整、查相互作用与低钠风险	跌倒、认知、多重用药
青少年	心理治疗为主，药物需密切监测	家庭与学校配合，关注自伤
治疗无效	核对诊断、剂量、疗程、依从性、共病	排除“假难治”再谈换药

这张表只给方向，不给处方。同一格里的人，具体方案也可能完全不同，因为年龄、体重、肝肾功能、合并用药、既往反应都不一样。

四、红旗信号：看到就动

红旗信号的意思是“不能等到下次复诊”。下面这些情况，按严重程度处理，宁可白跑一趟。

红旗信号	可能是什么	你要做什么	时间
自杀念头、计划、准备行为，或已经自伤	抑郁加重、风险升高	不要独处，移除危险物品，呼叫 120 或去急诊，拨 12356	立即
幻觉、妄想、坚信被害、行为紊乱	精神病性症状	尽快精神科就诊，必要时住院	当天
拒食、几乎不喝水、明显消瘦、站起就晕	脱水、营养不良	急诊，可能需要补液	立即
突然兴奋、话多、睡得少却不困、冲动花钱	转躁	尽快联系精神科医生，不要自行加药	24 小时内
高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快	血清素综合征（药物相关的严重反应）	立即急诊，带上药盒	立即
皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难	严重过敏	呼叫 120	立即
黑便、呕血、明显皮下出血	出血	急诊	立即
抽搐、胸痛、晕厥、意识丧失	需排除躯体急症	呼叫 120	立即
产后两周内出现混乱、幻觉、极度兴奋或极度低落	产后精神病	立即急诊	立即

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 自杀念头、自伤行为、安排后事：不要独处，呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 拒食脱水、意识不清、抽搐、胸痛、晕厥、严重过敏：立即呼叫 120。
- 转躁、幻觉妄想、副作用明显加重但意识清楚：当天或 24 小时内联系精神科医生。
- 症状在几天内快速恶化、无法工作或照顾自己：尽快提前复诊，不要等预约日。

五、复诊节奏与自我监测

复诊不是“去拿药”，是整条路径的校准点。

每次复诊，尽量说清四件事：

1. 睡眠和食欲这两周怎么样；
2. 情绪最低的那天大概几分，持续了多久；
3. 药有没有漏、有没有副作用；
4. 有没有自杀念头，或者“活着没意思”的念头。

每次复诊，尽量问清四件事：

1. 现在这个方案的目标是什么，多久评估一次；
2. 如果没效果，下一步有哪些选择；

3. 出现什么副作用需要立刻联系、什么可以观察；
4. 下次复诊什么时候，中间出问题找谁。

家里可以提前准备的东西（照着勾）：

- ☐ 一份正在服用的药物清单（药名、剂量、每天几次）
- ☐ 一本记录睡眠和情绪的本子，或手机备忘录
- ☐ 一份安全计划：危机时打给谁、去哪里、把什么收起来
- ☐ 家属知道的“红旗信号”清单
- ☐ 主治医生/医院的联系方式，以及 12356 这个号码

六、常见问题

“路径图上说数周复评，我两周没变化，是不是要换药？” 不一定。早期先是副作用，疗效通常要更久。但如果一点改善都没有、副作用又难受，值得提前联系医生，而不是自己停。

“我能不能跳过评估直接开药？” 不建议。评估决定诊断和分层，跳过它，后面可能一直在治错的方向。

“我一直在门诊看，需要去专科医院吗？” 看情况。诊断明确、治疗顺利的门诊随访就够；出现红旗信号、治疗无效、需要物理治疗或复杂用药时，专科更有条件。

“停药后还要复查吗？” 要。停药后的一段时间是复发的高风险期，通常需要随访观察，具体频率听医生的。

“这张图能当诊断依据吗？” 不能。它是帮你理解流程和沟通的工具，诊断与处方只能由医生面诊决定。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 2：药物治疗

这是全库篇幅最大的模块。目标不是让你“会开药”，而是让你知道医生为什么这样开、吃药期间该观察什么、哪些情况必须报告。

2.1 抗抑郁药如何起效

这一页讲清楚一件事：抗抑郁药到底在脑子里做了什么，为什么它不能在三天内让你好起来。刚被开药、刚开始吃药、或者吃了两周觉得“没用”的人，都适合先读这一页。读完之后，你至少能判断两件事：现在出现的变化是不是正常的，以及什么时候该跟医生说。

一句话版本：先改变化学信号，再等大脑重新适应

抗抑郁药进入身体后，几个小时之内就会改变脑内某些化学物质的浓度。但人的情绪、兴趣、精力、睡眠节律，并不是一个开关，而是一套需要重新校准的系统。药物先把“信号”调上去，大脑再花几周时间，把被抑郁拖慢的连接一点点修回来。所以起效慢不是药“没力气”，而是它工作方式的一部分。

理解这一点很实用：它解释了为什么前两周你感受到的几乎都是副作用，也解释了为什么“感觉没变化”并不等于“这个药对我无效”。很多人就是在第二周放弃的，而那恰恰是最不该下结论的时候。

单胺假说：一个有用、但不完整的解释

最早的一批抗抑郁药是偶然被发现的：用它们治疗别的疾病时，患者的情绪意外好转。研究者顺藤摸瓜，发现这些药都能提高脑内三类“单胺”递质的水平——**5-羟色胺（也叫血清素，和情绪、睡眠、食欲有关）、去甲肾上腺素（和警觉、精力、注意力有关）、多巴胺（和动机、奖赏、快感有关）**。这就是“单胺假说”：抑郁被认为与这些递质信号的不足有关。【研究】

单胺假说很好用，因为它能解释不少现象：为什么提高 5-羟色胺的药对焦虑和反复思考有帮助，为什么提高去甲肾上腺素的药让人更有精神，为什么有些药让人犯困、有些药让人清醒。它也是今天大多数抗抑郁药的设计基础。

但它有一个明显的漏洞：药物在几小时内就把递质浓度提上去了，人的情绪却要两三周才动。如果抑郁只是“血清素不够”，补上去应该立刻见效。事实不是这样，说明“浓度”只是故事的前半段。【研究】

从“化学失衡”到“神经可塑性”

后半段的关键词是**神经可塑性**——大脑根据经验不断调整连接强弱的能力。神经元之间靠“突触”连接，突触不是焊死的，用得多就加强，长期缺乏刺激或长期处在压力下就会减弱。

长期抑郁和长期压力状态下，一些脑区（比如负责情绪调节和记忆的海马）会出现可测量的变化：树突分支减少、突触密度下降、新生神经元减少。这些发现主要来自动物实验和影像研究，人类身上的因果链还没完全查清，所以只能说“相关”，不能说“抑郁就是海马萎缩”。【待验证】

抗抑郁药长期使用后，会促进一种叫 **BDNF（脑源性神经营养因子）** 的蛋白表达，帮助突触重新长出来、让信号通路恢复。这个过程需要时间，而且和临床起效的时间窗大致对得上。【研究】更直接的证据来自氯胺酮：它能在数小时内促进突触形成，情绪也随之快速松动，这被认为是“可塑性假说”的有力支持。【研究】

所以更准确的说法是：抗抑郁药不是“补血清素”，而是**通过改变递质信号，启动一串下游的适应过程，让大脑慢慢恢复调节情绪的能力**。把这句话记住，后面很多困惑会自然消解。

为什么通常要 2–4 周：三条时间线叠在一起

临床上常说的“2–4 周起效”，是一个大致范围，不是承诺。有人第一周睡眠就变好，有人第六周才觉得“世界有点颜色了”，都算常见。背后至少有三条时间线在同时走。

时间	常见变化	怎么理解
第 1 周	副作用先出现：恶心、头晕、口干、出汗、睡眠改变	身体在适应药物，不代表疗效
2–4 周	睡眠、食欲、精力可能先松动，情绪随后	植物性症状常比情绪更早起反应
4–6 周	多数人出现“应答”：症状明显减轻	这是评估“有没有效”的第一个窗口
6–12 周	部分人达到“缓解”：基本回到病前状态	没达到也不等于失败，需重新评估

第一条线是**药理适应**：受体长期被占用后会下调或脱敏，信号系统重新找平衡，这需要一到两周。第二条线是**细胞内信号和基因表达**的改变，起效更慢。第三条线是**突触与网络重塑**，往往以周计。三条线叠加，才有了“两三周”这个经验值。【研究】

还有一个常被忽略的因素：**抑郁本身会拖慢自我观察**。情绪低落时，人对“有没有好一点”的判断是迟钝且偏负面的。有时候是身边人先发现你话多了、愿意出门了，你自己还没感觉到。

早期副作用不等于没效，也不等于药效强

吃药头几天难受，是极其常见的经历。恶心、头重、犯困或睡不着、口干、出汗，这些通常出现在药物浓度刚开始稳定的阶段，和“疗效好不好”没有对应关系。

有两种误解需要拆掉：

- **“副作用这么明显，说明药在使劲，忍忍就有效了。”** 副作用强弱和疗效强弱之间没有可靠关系。副作用重，只说明你对这个药敏感，不代表它会更有用。硬扛不是美德，扛到停药才是损失。
- **“一点副作用都没有，是不是假药或者剂量不够？”** 也无关。很多人几乎没有早期反应，照样在四周后明显好转。

真正要区分的是三类情况：**能忍、会自行减轻的**（多数恶心、头痛、口干）；**需要调整方案的**（持续失眠、明显嗜睡、性功能受影响、体重持续上升）；**必须马上处理的**（高热、意识混乱、肌肉僵硬、皮疹扩散、出血、晕厥）。第三类在本模块的“需要警惕的危险反应”一页有详细清单。

抗抑郁药不是抗生素，也不是“快乐药”

很多人下意识拿抗生素做类比：吃够一个疗程，病菌杀光，病就好了，药就可以停。抗抑郁药不是这个逻辑。

对比项	抗生素	抗抑郁药
打击目标	外来的病原体	大脑自身的调节功能
起效方式	直接杀灭，起效以天计	间接调节，起效以周计
疗程结束	病原体清除即可停	症状缓解后仍需继续一段时间防复发
复发逻辑	再感染是新一轮	停药太早，原病容易回来

它也不是“快乐药”。抗抑郁药不会制造欣快感，不会让人无缘无故开心，也不会把悲伤的人变成没心没肺的人。它更像把情绪的“地板”抬高一点：原来一件小事就能把你压到谷底，现在你还有余地反应。该难过的事还是会难过，该处理的问题还是要处理。药物负责让你有力气去处理，不负责替你把生活过好。

顺便说一句：正因为不是“快乐药”，它没有成瘾性药物那种“越吃越想要”的体验。这一点下一节展开。

依赖、成瘾、撤药反应：三个常被混用的词

“吃抗抑郁药会不会上瘾”是诊室里出现频率最高的问题之一。答案取决于你说的是哪一个概念。

概念	核心特征	抗抑郁药的情况
成瘾	渴求、失控性使用、越用越多、明知有害仍继续	不具备，抗抑郁药不产生这类行为模式
身体依赖	身体适应了有药的状态，突然撤走会不适	部分存在，表现为撤药反应
撤药反应	停药或减量后出现头晕、恶心、电击感等	常见，可预防，通常暂时

成瘾的核心是奖赏回路被劫持：想要、失控、加量、戒断后复吸。抗抑郁药不符合这个画像，它不会带来欣快，也不会让人“为了舒服而多吃一片”。【指南】

身体依赖是另一回事，很多常用药都有，比如某些降压药、激素。身体适应了有药的状态，突然撤掉就会有一阵不适。抗抑郁药属于这一类，尤其是起效快、半衰期短的药。

撤药反应就是这种不适的具体表现：头晕、走路发飘、恶心、疲倦、入睡困难、易怒、焦虑回升，有些人形容像“脑子里有电流闪过”或“像戴了顶不舒服的帽子”。这些反应通常在停药后几天内出现，可能持续一两周，缓慢减量可以大幅降低风险。它和“复发”不是一回事：撤药反应来得快、有身体症状为主、补回药物后很快缓解；复发是原来的抑郁症状在数周内重新长回来。详细区分见 2.8 停药与撤药反应。

大概要吃多久：三个阶段，不是“吃到好为止”

规范治疗把用药分成三个阶段，各有各的任务：

1. **急性期**：从开始用药到症状明显减轻或基本消失，通常以周计。
2. **巩固期**：症状已经缓解，但大脑的调节功能还不稳，需要继续维持同一方案，让改善“坐实”。
3. **维持期**：预防复发。首次发作、缓解顺利的人，通常建议在缓解后继续服药至少半年；反复发作、慢性化、症状重的人，往往需要一到两年甚至更久。【指南】

“吃到好为止”是常见的误解。症状消失是巩固期的起点，不是终点。很多人在这里停药，几个月后复发，然后又从头开始——这是治疗中最可惜的一种循环。

一份可以照做的观察清单

开始用药后的前四周，可以用下面这份清单记录，复诊时直接给医生看：

- ☐ 每天大致同一时间服药，记录有没有漏服
- ☐ 记录睡眠：入睡时间、夜醒次数、总时长
- ☐ 记录食欲和体重变化（每周固定时间称一次）
- ☐ 记录最难受的 1–2 个副作用，以及它出现和消退的时间
- ☐ 每周给自己的情绪打一个 0–10 分，只记趋势，不纠结单日
- ☐ 记录有没有出现“从来没出现过”的念头或行为
- ☐ 记录同时吃的其他药、保健品、中药
- ☐ 复诊前把这张纸拍下来或带上

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤冲动、制定计划，或已经开始准备：**立即呼叫 120 或去最近医院急诊**，不要独处。
- 出现高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快：**立即急诊**，可能是血清素综合征。
- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 突然变得异常兴奋、话多、睡得很少却不困、冲动消费：尽快联系精神科医生，不要自行加药。

- 副作用重到影响吃饭睡觉上班，或持续两周不减：联系开药医生，讨论调整，不要自己停。
- 分不清“算不算严重”时，按严重处理，先联系医生。

常见问题

“吃了三天没感觉，是不是药不对？” 三天太早，绝大多数人在这个时间点感受到的是副作用而不是疗效。给自己和药物四周时间，再和医生一起评估。

“第一周特别难受，是不是要停药？” 先联系医生，不要自行停。多数早期反应会在两周内减轻；如果影响到基本生活，医生有办法调整服药时间、剂型或方案。

“好了一点，是不是可以减半？” 不建议。症状刚松动时，大脑的调节功能最脆弱，此时减量容易反复。减量要由医生根据病程、发作次数和当前状态决定。

“是不是要吃一辈子？” 不一定。有人半年到一年后可以在医生指导下逐步减停，有人需要更长时间。反复发作次数越多、病程越长，维持治疗的时间通常越长。【指南】

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.2 常见药物分类与代表药物

这一页把常用的抗抑郁药按“作用机制”分成几组，告诉你每组大致是什么脾气、常见的不舒服在哪、医生为什么会在这组里挑一个。它不教你选药，也不写剂量，只帮你听懂处方上的名字。看完之后，你至少能分清“我吃的是哪一类”，以及复诊时该重点说哪些感受。

先理解“分类”这件事：按什么分，为什么要分

抗抑郁药的分类依据是**它主要作用于哪种递质、通过什么方式起作用**。同样是提高 5-羟色胺，有的药阻止它被回收（SSRI），有的药同时影响去甲肾上腺素（SNRI），有的药干脆绕开它去作用别的受体（安非他酮、米氮平）。机制不同，副作用谱就不同，药物相互作用也不同。

分类是地图，不是排行榜。同一类里的药，疗效大体接近，但副作用、代谢途径、停药难度可以差很多。比如同属 SSRI，氟西汀半衰期（药物在体内浓度减半所需的时间）很长，停药时比较“平缓”；帕罗西汀半衰期短，撤药反应更明显；舍曲林在孕期和哺乳期的数据相对多一些。这些差别才是医生真正在权衡的东西。【指南】

一句话：**类别决定“大致方向”，具体药物决定“你个人能不能受得了”。**

九类常用药物一览

下表按机制分组，只列常见代表药和特点，不涉及剂量与适应证细节。国内不同医院的可及性差异很大，表里没有的药不代表不能用，表里有的药也不代表适合你。

类别	代表药物（举例）	主要特点	常见不适
SSRI（选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂）	舍曲林、艾司西酞普兰、西酞普兰、氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明	一线用药，疗效稳、安全性好、过量风险相对低	恶心、腹泻、头痛、失眠或嗜睡、出汗、性功能受影响
SNRI（5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂）	文拉法辛、度洛西汀	兼顾精力与疼痛，对伴随躯体疼痛者常被考虑	恶心、出汗、血压升高、口干、撤药反应较明显
NaSSA（去甲肾上腺素和特异性 5-羟色胺能抗抑郁药）	米氮平	镇静明显，改善睡眠和食欲，常作增效或助眠	嗜睡、体重增加、食欲增加、水肿
NDRI（去甲肾上腺素和多巴胺再摄取抑制剂）	安非他酮	偏“激活”，较少影响性功能和体重	失眠、焦虑、口干、震颤；癫痫风险人群慎用
褪黑素能抗抑郁药	阿戈美拉汀	调节昼夜节律，助眠，较少性功能影响	头痛、恶心、肝功能异常（需监测）
SARI（5-羟色胺拮抗和再摄取抑制剂）	曲唑酮	低剂量多用于助眠，抗抑郁需较高剂量	嗜睡、头晕、体位性低血压、口干
TCA（三环类抗抑郁药）	阿米替林、氯米帕明、多塞平	老药，疗效确切，但副作用和过量风险大	口干、便秘、尿潴留、视力模糊、心悸、嗜睡
MAOI（单胺氧化酶抑制剂）	吗氯贝胺等	用于难治性抑郁，饮食与药物禁忌多	体位性低血压、失眠、体重增加；高血压危象风险
NMDA 受体拮抗剂	艾司氯胺酮	起效快，用于难治性抑郁，须在医疗机构给药观察	解离感、血压升高、头晕、恶心；有滥用潜力

镇静、体重与性功能：最影响日常生活的几件事

患者最常抱怨的不是“疗效不够”，而是“吃了想睡”“吃了睡不着”。这跟药物对组胺、去甲肾上腺素等系统的影响有关。

- **偏镇静**：米氮平、曲唑酮、帕罗西汀、氟伏沙明，以及多数 TCA。常被安排在晚上吃，利用它的困倦感改善入睡。代价是第二天上午可能发沉、反应变慢。
- **偏激活**：安非他酮、氟西汀，以及较高剂量的文拉法辛。常安排在早上吃，避免影响夜间睡眠。代价是初期可能心慌、坐立不安、焦虑加重。
- **相对中性**：舍曲林、艾司西酞普兰、阿戈美拉汀。多数人白天不困、晚上也能睡，但个体差异仍然很大。

需要提醒的是，**“镇静”和“激活”在用药初期最明显，之后常会减弱**。如果四周后仍然白天睁不开眼，或者仍然整夜清醒，那不是“忍一忍”的问题，而是需要和医生讨论换时间、换药或调整方案。

体重与性功能：最容易被忍着不说的两件事

这两件事对生活质量的影响，往往比情绪症状本身更持久，也是擅自停药的头号原因。它们不是“小事”，更不是“矫情”。

类别	镇静或激活	体重与性功能	撤药反应风险
SSRI	中性偏激活（帕罗西汀偏镇静）	体重多无明显变化；性功能受影响较常见	中等，帕罗西汀较明显
SNRI	中性偏激活	体重变化不一；性功能受影响较常见	较高，尤其文拉法辛
米氮平	明显镇静	体重增加较常见；性功能影响相对少	中等
安非他酮	偏激活	体重多不增加；性功能影响少	较低
阿戈美拉汀	中性偏镇静	体重多不增加；性功能影响少	较低
曲唑酮	明显镇静	体重变化不一；性功能影响相对少	较低
TCA	明显镇静	体重增加常见；性功能影响常见	较高
MAOI	不定	体重增加常见；性功能影响常见	较高
艾司氯胺酮	短暂解离	长期体重与性功能数据有限	需在医疗监护下使用

表里的“常见”“较少”是群体层面的概率，不是对你的预测。有人吃米氮平体重纹丝不动，也有人吃 SSRI 完全没有性功能变化。**出现问题时，解决方案不止“停药”一种**：换同类里的另一个药、换类别、调整服药时间、短期加辅助药，都是医生手里的选项。具体见7.4 性功能体重与代谢。

药物相互作用：哪几类需要特别小心

相互作用不是“多多益善”的反面，而是两件很实在的事：**一种药让另一种药在血里变多或变少**，以及**两种药的作用叠加**。

- **MAOI** 是相互作用最多的一类。与 SSRI、SNRI、曲马多、哌替啶、部分曲普坦类、拟交感药合用，可能引发高血压危象或血清素综合征。换用或停用 MAOI 都需要足够的间隔期，必须由医生安排。【指南】
- **TCA** 的治疗窗窄，过量可致严重心律失常。与其他延长 QT 间期的药、抗胆碱能药合用要谨慎，通常需要心电图监测。【指南】
- **SSRI 与 SNRI** 与抗凝药、抗血小板药、NSAIDs（布洛芬、阿司匹林等）合用，出血风险上升；与曲马多、曲普坦类、圣约翰草合用，血清素综合征风险上升。
- **氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明** 对肝药酶 CYP2D6、CYP1A2、CYP3A4 的抑制较强，会影响很多合并用药的浓度，比如某些抗心律失常药、他汀、抗精神病药。
- **阿戈美拉汀** 主要经 CYP1A2 代谢，与氟伏沙明这类强抑制剂合用属禁忌；用药期间需要查肝功能。
- **安非他酮** 降低癫痫阈值，与某些药物、饮酒、进食障碍史叠加时风险更高。

这些细节不需要你背下来。你只需要做一件事：**把正在吃的所有东西告诉医生和药师，包括中药、保健品、减肥药、助眠药。** 详细内容见2.9 药物相互作用与禁忌。

同类药也不是都一样：三个真实存在的差异

第一，**半衰期不同，停药体验不同**。氟西汀在体内停留很久，突然停用往往比较平缓；帕罗西汀、文拉法辛离开身体快，撤药反应更明显。这不是“好”与“坏”，而是“适合慢慢减”还是“必须更慢地减”。

第二，**代谢途径不同，合并用药的冲突不同**。肝功能不好、同时在吃多种药的人，医生会优先选相互作用少的那种。

第三，**特殊人群的数据量不同**。孕期、哺乳期、青少年、老年人，不同药物积累的研究证据多少不一样。医生在这些人群里选药，往往不是选“最强”的，而是选“资料最多、最有把握”的。

就诊时可以问的几个问题

- ☐ 我吃的是哪一类药，主要作用机制是什么？
- ☐ 这个药偏镇静还是偏激活，我应该早上吃还是晚上吃？
- ☐ 常见副作用有哪些，哪些会自己好，哪些要报告？
- ☐ 它和我现在吃的其他药、保健品有没有冲突？
- ☐ 如果效果不够，下一步通常是加量、换药还是联合？
- ☐ 需要定期查血、查心电图或查肝功能吗？

☐ 如果将来要停，大概怎么安排？

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 服药后出现高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快：**立即急诊**。
- 皮疹迅速扩散、面唇或喉咙肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 出现解离感、幻觉、血压明显升高（尤其使用艾司氯胺酮后）：立即告知给药医护。
- 突然异常兴奋、话多、几天不怎么睡却不困、冲动花费：尽快联系精神科医生，不要自行加药。
- 排尿困难、严重便秘腹胀、视力突然模糊、心跳明显不规则：当天联系医生。
- 任何自伤或自杀念头：**立即呼叫 120 或去急诊**，不要独处。

容易踩的坑

“新药一定比老药好。” 新药的优势通常在副作用和安全性，不在于疗效更强。TCA 是老药，对某些难治性抑郁仍然有效，只是需要更多监测。

“同一类药换一个肯定也一样。” 不一定。同类之间在代谢、半衰期、副作用上差异不小，换同类有时正好能解决耐受问题。

“别人吃这个好，我也要吃这个。” 疗效的个体差异很大，别人的有效方案只能作为线索，不能作为处方。

“中药和西药一起吃没关系。” 圣约翰草是明确有相互作用的例子，部分中成药也可能影响肝酶或出血风险。加任何东西之前，先问医生或药师。

参考来源

- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.3 医生如何选药

同样诊断为抑郁症，为什么隔壁床吃的是舍曲林，你拿到的是米氮平？这一页讲医生在处方背后真正权衡的东西：不是“哪个药最好”，而是“哪个药和这个人最匹配”。适合刚拿到处方想不通的人，也适合吃了几个月效果不理想、准备和医生谈换药的人。

选药不是“找最强的药”，而是“找最合适的匹配”

抗抑郁药之间，整体疗效的差距没有想象中那么大。多数一线药物在群体研究里的有效率接近，真正拉开差距的是三件事：**这个人能不能耐受、会不会和现有治疗打架、以及他能不能长期吃下去**。

所以选药更像配眼镜，而不是打靶。验光要看你近视多少度、有没有散光、平时开车还是看电脑；选药要看你的症状长什么样、身体有什么底子、生活里有什么限制。同一个诊断，不同的人，合理的方案可以完全不同。

这也意味着：**别人的“神药”对你不一定好，别人吃了难受的药对你不一定差。** 听到这类经验，可以当作线索去问医生，但不要当作依据去要求处方。

医生通常会权衡的十个维度

维度	医生想知道什么	为什么重要
既往用药反应	吃过哪些药、吃了多久、有没有效、有什么副作用	有效且耐受的药，再次使用往往仍有效
家族反应	直系亲属用某类药的效果和不良反应	药物反应有部分遗传基础，可作参考
症状特点	睡眠、食欲、精力、焦虑、疼痛、思维迟滞哪个突出	不同药对不同症状的改善速度不同
共病	焦虑、强迫、物质使用、躯体疾病、进食障碍	有些药一箭双雕，有些药会加重共病
副作用偏好	你最怕发胖、性功能受影响，还是白天犯困	耐受性决定能不能长期吃
相互作用	正在吃的所有药、保健品、中药	有些组合会改变血药浓度或叠加风险
肝肾功能	有没有肝病、肾病，近期化验结果	影响药物代谢和清除，决定要不要调整
孕产计划	是否备孕、已孕、哺乳	需要单独权衡，不能照搬普通方案
费用与可及性	医保、自费能力、当地能不能买到	吃不起、买不到的药等于没有效
个人偏好	对药物的态度、对副作用的容忍度、生活节奏	依从性差，再好的方案也落不了地

这十个维度不会每次都问全，急诊或轻症时医生可能只抓最关键的几条。但如果你主动提供，决策质量会明显不一样。

症状特点：为什么“抑郁”两个字不够

抑郁症是一个综合征，不同人的症状组合差别很大。药物的“性格”正好和这些组合对应：

- **睡不着、早醒、没胃口、体重掉**：可能优先考虑镇静作用强一些的药，比如米氮平，或安排在晚上的曲唑酮。睡眠和食欲常常是最先改善的。
- **整天没劲、动不起来、注意力散**：可能优先考虑偏激活的药，比如安非他酮、氟西汀，或较高剂量的 SNRI。但这类药初期可能加重焦虑和失眠。
- **焦虑、反复担心、躯体紧张突出**：SSRI 和 SNRI 通常是不错的选择，起效后对焦虑也有效。初期可能有一过性的焦虑加重，需要提前知道。
- **伴随慢性疼痛、纤维肌痛样表现**：度洛西汀等 SNRI 有较多证据。【指南】
- **季节规律明显、入睡困难**：阿戈美拉汀或光照治疗会被考虑。【研究】
- **思维迟滞、表情淡漠、快感缺失突出**：可能需要考虑作用谱更广的方案，或评估是不是双相。

这只是“可能优先考虑”，不是规则。医生还会看年龄、体重、既往反应，把几条线合起来判断。

既往反应与家族反应：最有分量的两条线索

如果一个人两年前吃舍曲林好过，这次复发，医生大概率会先考虑再用舍曲林。**“曾经有效”是临床上最有说服力的证据之一**，比任何指南里的一线推荐都更贴近你本人。【临床经验】

反过来，如果某个药吃到足量足疗程完全没反应，再次使用价值就低；如果是有效但副作用受不了，可以考虑同类换药或换类别。

家族反应的价值在于：药物代谢酶的活性、受体敏感性有遗传成分。如果父母或兄弟姐妹用某类药效果特别好或特别差，这条信息值得主动告诉医生。它不是决定性的，但常能帮医生少走一轮弯路。

共病与身体情况：一张处方要管好几件事

抑郁症很少单独出现。共病会改变选药逻辑：

- **合并焦虑或强迫**：SSRI、SNRI 通常能同时覆盖，有时需要更高剂量和更长疗程。
- **合并双相**：这是最重要的一条红线。单用抗抑郁药可能诱发转躁或快速循环，通常需要先用心境稳定剂。选药前必须筛查有没有轻躁狂史。【指南】
- **合并心脏病、心律失常**：TCA 要慎用，部分 SSRI 与 QT 延长相关，可能需要心电图监测。
- **合并肝病**：肝功能不好会影响代谢，医生可能选对肝脏负担小的药，并更频繁复查。
- **合并肾病**：部分药物及其代谢产物经肾排泄，需要调整。
- **合并青光眼、前列腺增生**：抗胆碱能作用强的药（如 TCA、帕罗西汀）可能加重症状。
- **合并癫痫**：安非他酮会降低癫痫阈值，通常避免。
- **老年**：低钠血症、跌倒、多重用药的风险更高，选药更保守，监测更密。

副作用偏好：你更怕哪一个，直接说

这一条常常被患者忽略，其实非常关键。医生手里有几个疗效相当的选项时，**你的优先级就是决定因素**。

有人最怕发胖，因为体重增加会直接影响坚持治疗的信心；有人最怕性功能受影响，因为这关系到亲密关系；有人最怕白天犯困，因为要开车、要上班；有人最怕失眠，因为失眠本身就是最痛苦的症状。

这些偏好没有对错，也不需要不好意思。你越具体，医生越容易选对。比如“我下个月要考试，不能白天犯困”比“我不想有副作用”有用得多。

一张处方要照顾的其他事：相互作用、身体、钱与偏好

这三件事属于“不主动说就可能出事”的类型。

相互作用：不只是处方药，还包括中药、中成药、保健品、减肥产品、助眠软糖。圣约翰草、部分含贯叶金丝桃的中成药会明显影响肝酶，可能让抗抑郁药失效或浓度升高。

肝肾功能：体检报告上的转氨酶、肌酐、肾小球滤过率，医生会看，但如果你最近在别的医院查过，主动出示能省一次抽血。

孕产计划：备孕、已孕、哺乳是三条不同的决策线。核心不是“吃药一定危险”或“停药一定安全”，而是**不治疗的风险和治疗的风险哪个更大**，需要精神科和产科一起评估。计划怀孕时提前说，医生有时间选数据更多的药、安排更慢的调整，而不是等测出两条杠才慌乱处理。具体见 6.3 孕产期抑郁。

费用与可获得性：这不是“次要问题”

一个药再好，如果每月自费负担不起，或者当地医院经常断货，它就不是一个现实的选择。医生通常清楚本院的药品目录和医保情况，你可以直接问：

- 这个药在医保里吗，自付大概多少？
- 有没有同类的、价格更低的替代？
- 医院药房能开到吗，还是需要去外面买？
- 如果换成国产仿制药，疗效和副作用会有差别吗？

仿制药与原研药在有效成分上一致，辅料和工艺可能不同，少数人对辅料敏感。如果换厂家后感觉不对，告诉医生，而不是自己停。

个人偏好：你想参与到什么程度

有人希望“医生你决定就好”，有人希望知道每一种选择的利弊再决定。两种都可以，重要的是让医生知道。共同决策不等于医生把选择推给你，而是医生提供专业判断，你提供自己的处境和优先级，一起定一个能执行的方案。

如果你对某类药物有顾虑（比如看过负面报道、家里有人吃出过问题），说出来。医生可以解释，也可以换方案；憋着不说，最后往往变成私自减药。

换药不是失败

这是这一页最想说的一句话。

治疗无效或不能耐受，说明的是**这个方案和你不匹配**，不是“你的病没救了”，也不是“你没配合好”。抑郁症的治疗本身就带有试错性质：没有哪种检查能提前告诉你哪个药有效，医生只能根据证据和你的反馈逐步逼近。

换药有很多种方式：直接换、交叉重叠、逐步减量后再换，MAOI 相关的换药还需要洗脱期。这些都必须由医生安排，因为不同组合的风险差别很大。具体见2.7 换药联合与增效。

判断“该不该换”的时机也很重要：剂量是否足够、疗程是否够长、有没有在按时吃、有没有同时喝酒或使用其他物质、有没有被忽略的共病。这些“假难治”的因素排除了，再谈换药才有意义。

复诊前可以准备的清单

- ☐ 现在吃的药名、厂家、剂量、每天几点吃
- ☐ 从什么时候开始吃，中间有没有调整过
- ☐ 最困扰的 3 个症状，按严重程度排序
- ☐ 副作用清单：出现时间、持续多久、有没有减轻
- ☐ 睡眠、食欲、体重的变化（有记录最好）
- ☐ 正在吃的其他药、中药、保健品
- ☐ 最近的化验单、心电图
- ☐ 你想问医生的 3 个问题，写在纸上

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：**立即呼叫 120 或去最近医院急诊**，不要独处。
- 服药后高热、大汗、肌肉僵硬、意识混乱：**立即急诊**。
- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 突然兴奋、话多、睡得极少却不困、冲动消费：尽快联系医生，不要自行加药。
- 换药后症状明显反弹、焦虑剧烈加重、整夜不睡：尽快联系开药医生。
- 黄疸、尿色明显变深、持续呕吐、心跳明显不规则：当天就医。

参考来源

- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.

- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.4 起始加量与足量足疗程

“医生给我开的剂量是不是太小了？”“吃了两周没效果，能不能加一片？”“足量足疗程到底要多久？”这一页把这三个问题拆开讲。它不会告诉你具体吃几毫克、几天加一次——那必须由医生定——但会告诉你医生在调整时看什么、你自己能观察什么、什么时候该回诊。

为什么从低剂量开始：不是保守，是算过风险

很多人拿到处方第一反应是“这么小的剂量能有用吗”。低剂量起始的理由很实在：

第一，先确认耐受性。 抗抑郁药的早期副作用（恶心、头晕、嗜睡、焦虑加重）和血药浓度上升速度有关。从低处起步，身体有时间适应，副作用通常更轻。

第二，每个人的代谢速度不一样。 同样的剂量，有人血里浓度刚好，有人偏高出现副作用，有人偏低几乎没反应。老年人的代谢慢，肝功能不好的人清除慢，体重低的人分布容积小，这些人更需要“慢慢来”。

第三，少数人属于“慢代谢者”。 他们的肝药酶活性天生较低，常规剂量就可能出现明显不良反应。低剂量起始是一种低成本的试探。

第四，早期副作用会影响你愿不愿意继续吃。 这一点最现实。第一周就难受到无法上班的人，很难坚持到第四周看见疗效。起始剂量小一点，是为了让你能走到起效那天。

所以“低剂量起步”不是医生不重视你，恰恰是治疗计划的一部分。**起始剂量是起点，不是终点。**

缓慢调整：调的是“平衡点”，不是“越高越好”

抗抑郁药有一个大致的特点：疗效在一定范围内随剂量上升，但副作用也随剂量上升。医生要做的，是找到**对你个人来说疗效够用、副作用能忍的那个点**。

这个过程通常按“评估—调整—再评估”的节奏走。调整的依据包括：

- 症状改善了多少（不是“有没有一点点好转”，而是睡眠、兴趣、精力、工作能力的具体变化）
- 副作用能不能忍，有没有影响到吃饭、睡觉、上班
- 有没有出现新的症状，比如焦虑加重、情绪波动、转躁迹象
- 有没有漏服、合并用药、饮酒
- 血药浓度（只有少数药需要）

“缓慢”不等于“拖着不加”。如果剂量明显不足，症状迟迟不动，医生会在评估后往上走。反过来，如果低剂量就已经效果不错、副作用也轻，未必需要加到很高。**目标不是把剂量顶满，而是找到有效的最低够用剂量。**

“足量足疗程”到底指什么

“足量”到底指什么

“足量”常被误解成“最大量”或“说明书上的上限”。更准确的理解是：**在耐受的前提下，达到对你有效的剂量范围。**

这带来两个推论：

- 别人吃这个剂量有效，不代表你需要同样的剂量；你吃这个剂量没效，也不代表剂量一定不够——可能疗程还不够，可能这个药不适合你。
- “足量”是一个区间概念。医生会在区间内根据反应调整，而不是一次性给你一个固定数字。

需要警惕的是另一种极端：为了“快点好”自行加量。抗抑郁药不是止痛药，多吃一片不会让今天的心情立刻变好，只会让副作用更集中地出现，严重时可能引发心律失常、癫痫发作或血清素综合征。

“足疗程”到底要多久

临床上常用的评估窗口是**4–8周**。意思是：在剂量合适、按时服药的前提下，给药物四到八周时间，再判断它对你有没有用。

阶段	大致时间	医生关注什么	你可能感觉到什么
起始适应	第1–2周	耐受性、副作用强度	恶心、头晕、睡眠改变，情绪多无明显变化
早期评估	第2–4周	睡眠食欲是否先改善、有无危险信号	可能先觉得“睡得着一点”“想吃东西了”
疗效评估	第4–8周	症状减轻幅度、功能恢复	情绪、兴趣、精力开始松动
方案决定	第6–12周	继续、加量、换药还是联合	达到缓解，或仍未达标需要调整

为什么是4–8周而不是4–8天？因为起效依赖受体适应、细胞内信号改变和突触重塑，这些过程以周计。太早下结论，会把一个本来有效的药误判为无效；太晚不下结论，则会让无效的方案拖上几个月。

对于部分人，起效可能更晚，尤其是长期慢性抑郁、伴随人格特质或躯体症状的人。医生会根据病程决定要不要再等一等。**“等”和“拖”的区别在于：等是有评估节点的，拖是没有的。**

复诊节奏：不是“吃完药再说”

规范的复诊节奏大致是这样，具体由医生根据病情定：

- **开始用药后较早的一次复诊**：看耐受性，处理早期副作用，确认有没有危险信号。
- **第二到第四周**：评估初步反应，判断要不要调整剂量。
- **第四到第八周**：做正式的疗效评估，决定继续、加量、换药或联合。
- **达到缓解后**：进入巩固期，复诊间隔可以拉长，但仍需定期评估。

- **维持期**：通常数月一次，同时关注复发预警信号。

症状重、有自杀风险、老年人、合并躯体疾病、刚开始用药的人，复诊会更密。这不是“医生不放心你”，而是这些情况的变量更多，需要更密切的观察。

如果你在两次复诊之间出现明显不适，不必等到预约日。**提前联系不丢人，也不浪费医疗资源。**

血药浓度：只有少数药需要测

“要不要查一下血药浓度，看看够不够？”这是很常见的疑问。答案是：大多数抗抑郁药不需要。

药物类型	是否常规定量监测	说明
SSRI、SNRI、米氮平、安非他酮等	通常不需要	剂量与疗效的关系相对平缓，按临床反应调整即可
三环类（TCA）	需要，尤其老年与合并用药者	治疗窗窄，过量风险高，浓度与毒性相关
锂盐（增效治疗用）	需要，且需定期监测	治疗窗窄，脱水、肾功能变化都会影响浓度
艾司氯胺酮	不需要测浓度，但需监测血压与解离反应	在医疗机构内给药并观察

血药浓度也不是“越高越好”。对治疗窗窄的药，浓度过低无效、过高中毒，医生要的是落在安全区间内。具体数值由实验室和医生判断，不适合自己对照网上的表格。

不要自行加量：三个真实的风险

风险一：副作用集中出现，反而吃不下去。 加量后恶心、失眠、出汗可能同时加重，人很容易因此彻底停药。

风险二：危险反应的门槛被拉低。 血清素综合征、心电图上的 QT 间期延长、癫痫发作的风险都与剂量相关。自行叠加两种药，风险不是相加，而可能成倍上升。

风险三：掩盖了真正的问题。 吃了四周没效，可能是剂量不足，也可能是诊断需要修正、有未处理的共病、或者你其实一直没按时吃。自行加量会让这些线索变得模糊，医生更难判断。

同理，**自行减量**也有风险：症状可能反弹，撤药反应可能出现，而你以为是“病情恶化”。

复诊时带得走的一张纸

- ☐ 药名、剂量、每天几点吃、有没有漏服
- ☐ 这四周睡眠、食欲、精力的变化（各写一句话）
- ☐ 最难受的两个副作用，出现时间和变化趋势
- ☐ 情绪自评：0–10 分，每周一个数
- ☐ 有没有出现从没出现过的念头或行为
- ☐ 同时在吃的其他药、中药、保健品

☐ 这次最想问的一个问题

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 加量或刚开始服药后出现高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快：**立即急诊**。
- 出现自杀念头、自伤行为或具体计划：**立即呼叫 120 或去急诊**，不要独处。
- 突然异常兴奋、话多、睡得极少却不困、冲动消费：尽快联系精神科医生，不要自行加药。
- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 心悸、胸闷、晕厥、抽搐：**立即急诊**。
- 副作用重到无法进食、无法入睡、无法工作，持续数日不缓解：尽快联系开药医生。

容易踩的坑

“吃了一周没效果，肯定是剂量不够。” 一周太早。这个阶段感受到的多是副作用，疗效还没开始。先看四周。

“症状好了就可以减量。” 症状缓解是巩固期的开始，此时减量复发风险最高。

“别人吃两片，我也吃两片。” 剂量和体重、代谢、肝功能、合并用药都有关，不能横向比较。

“加量后难受，说明药效上来了。” 副作用和疗效是两条线，难受只说明浓度上升快，不代表更有效。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.5 常见副作用与应对

吃药第一周，很多人不是被抑郁打倒，而是被恶心、头晕、失眠打倒。这一页把最常见的副作用列出来，告诉你它们大概什么时候来、会不会自己走、能做什么、哪些必须马上报告。适合刚开始服药、正在加量、或者被副作用折磨到想停药的人。

副作用从哪来：药“顺手”碰到了别的受体

抗抑郁药的目标是 5-羟色胺、去甲肾上腺素这些系统，但这些递质在全身都有受体：肠道里最多，血管里有，唾液腺、汗腺、心脏、膀胱里也有。药物提高了递质水平，情绪相关的好处还没显现，这些“顺手”的影响先到了。

所以早期副作用的分布很符合药理：

- **5-羟色胺在肠道**：恶心、腹泻、食欲下降。
- **5-羟色胺在血管和脑膜**：头痛。
- **去甲肾上腺素**：心慌、手抖、出汗、血压升高、入睡困难。
- **抗胆碱能作用**（TCA、帕罗西汀较明显）：口干、便秘、视力模糊、排尿不畅。
- **组胺受体被阻断**（米氮平、TCA）：嗜睡、食欲增加、体重上升。
- **α 1 受体被阻断**（曲唑酮、TCA）：体位性低血压、头晕。

这也解释了一个常见现象：**同一个人吃不同类别的药，副作用完全不同。** 不是身体变差了，而是碰到的受体不一样。

时间线：哪些会走，哪些会留

副作用	常见出现时间	会不会自行减轻	一般应对方向
恶心、胃部不适	第 1 周内	多数在 2 周内明显减轻	随餐服、避免空腹、少量多餐
头痛	第 1 周	多数几天到两周缓解	规律作息、补水、必要时问医生能否用止痛药
腹泻	第 1 - 2 周	常自行缓解	补水、避免生冷油腻、观察有无脱水
失眠、多梦	第 1 周起	部分持续	改早上服（需医生同意）、睡眠卫生、失眠的认知行为治疗
焦虑、坐立不安	第 1 - 2 周	多数在 2 - 4 周减弱	避免咖啡因、告知医生、必要时短期辅助
出汗、夜汗	数周内	部分持续	透气衣物、补水、避免酒精和辛辣
口干	数天到数周	部分持续	少量多次饮水、无糖口香糖、口腔护理
头晕、起身发黑	第 1 - 2 周	常减轻	缓慢起身、避免空腹久站、

副作用	常见出现时间	会不会自行减轻	一般应对方向
			补足水分
食欲增加、体重上升	数周到数月	可能持续	固定称重、调整饮食结构、增加活动
性功能受影响	数周后	常持续	主动告知医生，有换药、减量、加药等选项

这张表是群体规律，不是对你的预言。有人几乎没有早期反应，有人第 10 天开始恶心，都属于正常范围。**判断“要不要处理”的标准不是“有没有”，而是“有没有影响到吃饭、睡觉、上班、安全”。**

逐个数：九个最常见的不舒服

恶心

最常见，也最容易造成停药。通常在服药后半小时到几小时出现，几周内逐渐减轻。可以试着随餐吃、避免空腹、把服药时间和最容易反胃的时段错开（具体怎么调问医生）。如果持续呕吐、吃不下东西、尿量明显减少，那是脱水信号，需要当天就医。

头痛

多为紧箍样或胀痛，和血管扩张有关。规律睡眠、足量饮水、减少屏幕时间有帮助。需要注意的是：如果头痛突然剧烈、伴随呕吐、视物模糊、肢体无力，那不是普通药物性头痛，要急诊。

失眠

两类情况要分开。一类是药物偏激活，晚上吃了睡不着，通常调整服药时间就能改善；另一类是抑郁本身的早醒，反而可能需要镇静作用强的药。不要自行加安眠药，也不要用酒精助眠。

焦虑加重、坐立不安

用药头两周出现“激活综合征”并不少见：心慌、手抖、来回走动、静不下来。多数会随适应而减弱。但如果出现强烈的冲动、自伤念头，或者完全无法静坐，必须当天联系医生。咖啡、浓茶、能量饮料会让它更明显。

腹泻

常和恶心一起来，一两周内多能缓解。重点是补水，可以喝淡盐水或口服补液盐。如果一天多次水样便、伴发热或便血，要就医。

出汗

以夜间和手掌、头面为主，和体温调节、5-羟色胺有关。穿透气衣物、保持室温、避免酒精和辛辣会有帮助。明显多汗导致乏力、心悸时，要查一下电解质。

口干

抗胆碱能作用的典型表现，也常见于 SSRI。少量多次喝水比一次猛灌有效，无糖口香糖、含片能刺激唾液。长期口干要注意牙齿健康。

头晕、体位性低血压

从坐到站、从躺到坐时眼前发黑、发飘。曲唑酮、TCA 较常见。起身放慢、避免长时间热水澡、保证饮水量。如果出现晕倒、摔伤，或头晕持续加重，要联系医生。

食欲和体重变化

有的药让人吃不下，有的药让人特别想吃碳水。体重上升常是渐进的，容易在几个月后才发现。建议每周固定时间称一次，记录而不是评判。具体策略见7.4 性功能体重与代谢。

一般应对原则

- ☐ 先记录：什么症状、什么时候开始、什么时候最重、有没有减轻
- ☐ 不要自行停药或减量，先联系开药医生
- ☐ 不要自行加用安眠药、止痛药、抗过敏药，先问相互作用
- ☐ 避免酒精、咖啡因、能量饮料，它们会放大焦虑、失眠、心悸
- ☐ 保证饮水，尤其在恶心、腹泻、出汗多的时候
- ☐ 把服药时间和生活节奏对齐：偏激活的药放早上，偏镇静的药放晚上（需医生确认）
- ☐ 副作用影响进食、睡眠、工作超过一周，主动回诊，不要硬扛
- ☐ 复诊时把记录给医生看，比“最近有点难受”有用得多

哪些必须报告，哪些可以观察

可以观察一两周：轻度恶心、轻度头痛、口干、出汗、轻微头晕、食欲的轻微变化。

需要尽快联系医生：持续失眠超过一周、焦虑明显加重、坐立不安无法静坐、性功能受影响、体重快速增加、持续腹泻、头晕影响行走、任何让你想停药的不适。

必须当天就医或急诊：见下方提示块。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快：**立即急诊**，警惕血清素综合征。
- 皮疹迅速扩散、面唇或喉咙肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 持续呕吐、无法进食饮水、尿量明显减少、站起来就晕倒：**立即急诊**，可能脱水或电解质紊乱。
- 呕血、黑便、明显皮下瘀斑、鼻血止不住：**立即急诊**。
- 意识模糊、嗜睡、抽搐（尤其老年人）：**立即急诊**，需排查低钠血症。
- 自杀念头、自伤行为：**立即呼叫 120 或去急诊**，不要独处。

- 心跳明显不规则、胸闷、晕厥：**立即急诊**。

常见问题

“副作用越大，说明药效越强吗？” 不是。副作用强度和疗效没有可靠关系，只说明你对这个药敏感。

“忍过前两周就好了，是吗？” 多数早期副作用确实会减轻，但“忍”不是无限度的。影响到基本生活，就该调整方案。

“能不能自己减半吃，副作用小一点？” 不建议。减半可能让浓度不足、疗效打折，也可能引发撤药反应。调整要医生来做。

“副作用这么难受，是不是该换药？” 可能，也可能只需要调整服药时间、剂型或加一点辅助药。把具体感受告诉医生，让他来权衡。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.6 需要警惕的危险反应

绝大多数人吃抗抑郁药不会遇到这一页写的情况。但这些反应一旦发生，进展可能很快，早一小时和晚一小时的结果不一样。这一页把八类需要警惕的危险反应列清楚，每一种都写明“典型表现”和“立即怎么做”。建议患者和家属都读一遍，并把急诊电话存进手机。

为什么要单独讲“低概率、高后果”的事

抗抑郁药的整体安全性不错，严重不良反应的发生率不高。问题在于，这些反应早期看起来可能只是“有点不舒服”，容易被当成普通副作用忍过去。

比如血清素综合征刚开始可能只是烦躁、出汗、手抖；低钠血症刚开始可能只是乏力、头昏、不想吃饭。等到出现意识改变或抽搐，就已经不是“观察一下”的阶段了。

这一页的目的不是让你提心吊胆，而是给你一条清晰的判断线：**什么情况可以等复诊，什么情况必须当下行动。** 记住一条总原则：**不确定时，按严重处理。**

八类反应速查表

反应	典型表现	立即怎么做
血清素综合征	高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳快	立即停用相关药物并急诊，不要等待
严重过敏	皮疹迅速扩散、起疱脱皮、面唇肿胀、呼吸困难	立即呼叫 120
低钠血症	头痛、恶心、乏力、意识模糊、走路不稳、抽搐	立即急诊查电解质
出血	呕血、黑便、血便、皮下大片瘀斑、鼻血不止	立即急诊
QT 间期延长	心悸、胸闷、头晕、晕厥	立即做心电图，晕厥者急诊
转躁	睡眠需求骤减、话多、思维飞快、冲动消费	当天联系精神科，不要加抗抑郁药
自杀念头增加	新出现或加重的自伤、自杀想法、安排后事	立即呼叫 120 或去急诊，不要独处
药物性肝损伤	尿色深、眼白发黄、右上腹痛、持续呕吐	当天就医查肝功能

逐个讲：八个危险反应

血清素综合征：最需要抢时间的一种

它是什么。 5-羟色胺在体内过多，导致神经和肌肉过度兴奋。最常见于两种及以上“提高 5-羟色胺”的东西一起吃：SSRI、SNRI、曲马多、哌替啶、曲普坦类（偏头痛药）、圣约翰草、部分止吐药、亚甲蓝等。也可能发生在刚加量或换药之后。【指南】

典型表现可以记成三组：

- **精神**：烦躁、坐立不安、意识模糊、话多而混乱。
- **自主神经**：高热、大汗、心跳很快、血压忽高忽低、瞳孔放大、腹泻。
- **神经肌肉**：肌肉僵硬、震颤、反射亢进、脚踝处出现阵发性抽动（阵挛）。

和普通副作用怎么分。 普通早期副作用是恶心、头晕、轻度焦虑，人能正常对话、走路、吃饭。血清素综合征的特点是**进展快、组合出现、肌肉和意识出问题**。出现发热加肌肉僵硬加意识改变，基本可以直接按急症处理。

立即怎么做：停用可疑药物，立即去急诊或呼叫 120，告诉接诊医生你吃了哪些药、什么时候吃的、最近有没有加量或换药。不要自己吃退烧药或安眠药掩盖症状。

严重过敏：皮疹不是小事

典型表现：服药后出现皮疹，且在数小时到数天内迅速扩散；伴随发热、口腔或眼睛黏膜糜烂、皮肤起疱或大片脱皮；或者面唇、舌头、喉咙肿胀，声音变哑、呼吸费力。后一组是过敏性休克的信号，几分钟内就可能危及生命。

需要区分：轻度、局限、不痒或轻痒的皮疹，可能只是短暂反应，可以联系医生评估；**扩散快、伴发热或黏膜受累、伴呼吸困难**，一律按急症处理。

立即怎么做：呼吸困难、面唇肿胀→立即呼叫 120；皮疹迅速扩散或伴发热→立即急诊，不要等第二天门诊。就诊时带上药盒。

低钠血症：老年人尤其要留意

它是什么。 一部分抗抑郁药会让肾脏排水变多、血钠被稀释，医学上叫抗利尿激素分泌异常综合征（SIADH）。老年人、体重低、同时吃利尿剂的人风险更高。常发生在开始用药后的头几周。

典型表现：头痛、恶心、食欲差、乏力、注意力涣散、走路不稳、手抖；加重时出现意识模糊、抽搐、昏迷。这些症状很容易被当成“抑郁加重”或“年纪大了”。

立即怎么做：出现意识改变、抽搐、持续呕吐→立即急诊，查血钠。平时如果老人突然变得特别迷糊、走路发飘，别只当成情绪问题。

出血：不只是“容易淤青”

它是什么。 血小板要靠 5-羟色胺才能正常聚集，SSRI 和 SNRI 会削弱这个功能。单独使用时出血风险不高，但和 NSAIDs（布洛芬、双氯芬酸等）、阿司匹林、抗凝药（华法林、利伐沙班等）合用时，消化道出血风险明显上升。【研究】

典型表现：刷牙出血、鼻血不易止、皮肤出现大片瘀斑、大便发黑像柏油、呕血或咖啡色物、月经量突然明显增多。

立即怎么做：黑便、呕血、头晕乏力→立即急诊。计划做手术、拔牙、胃肠镜前，要主动告诉医生你在吃抗抑郁药。

QT 间期延长：心脏电活动的变化

它是什么。 心电图上一次心跳的时间被拉长，极端情况下可能诱发严重心律失常。部分 SSRI（如西酞普兰）、TCA 与 QT 延长相关；低钾、低镁、心脏病、同时使用其他延长 QT 的药物会增加风险。【指南】

典型表现：心悸、胸闷、头晕、眼前发黑、晕厥。很多人完全没有症状，只在心电图上发现。

立即怎么做：晕厥或持续心悸→立即急诊并做心电图。有心脏病史、正在吃多种药、或医生建议查心电图的人，按约定复查，不要嫌麻烦。

转躁：最容易被忽略的一条

它是什么。 抑郁患者如果其实属于双相障碍，单用抗抑郁药可能把情绪推向另一端：从低谷直接冲到高峰。这在双相抑郁中是需要特别防范的风险。【指南】

典型表现：睡眠需求明显减少（只睡两三个小时也不困）、话比平时多很多、思维飞快、注意力跳来跳去、自我评价突然变得很高、冲动消费或投资、开车冒险、易怒、和家人激烈冲突。严重时出现幻觉、妄想。

立即怎么做：当天联系精神科医生，不要自行加抗抑郁药，也不要自行停药。如果出现伤人、自伤、彻夜不眠、行为失控，去急诊。把“最近睡眠少了多少、花了多少钱、说了什么话”具体告诉医生，比“他最近有点兴奋”有用。

自杀念头增加：必须直接问、直接管

它是什么。 治疗初期，尤其是 25 岁以下的年轻人，部分人会出现自杀念头加重或新出现的自伤想法。可能的原因包括药物早期的激活效应、精力恢复得比情绪快、以及抑郁本身的波动。这不是“你想不开”，是需要调整治疗和加强监护的信号。【指南】

典型表现：突然开始安排后事、送东西、写告别信；频繁说“活着没意思”“拖累你们”；搜索自杀方法；情绪从极度低落突然变得异常平静。

立即怎么做：立即呼叫 120 或去最近医院急诊，不要独处，把可能的自伤工具交给家人保管。也可以拨打 12356 心理援助热线。家属不要承诺保密，也不要把人单独留在家里。

药物性肝损伤：隐匿但可查

它是什么。 少数药物（阿戈美拉汀、部分 TCA、某些联合用药）可能引起肝酶升高，极少数发展为严重肝损伤。阿戈美拉汀在用药前和用药期间需要查肝功能，这是明确的监测要求。【指南】

典型表现：尿色像浓茶、眼白或皮肤发黄、右上腹隐痛、持续恶心呕吐、皮肤瘙痒、明显乏力。

立即怎么做：出现黄疸或深色尿→当天就医，查肝功能。不要自行停药或换药，由医生判断；同时把中药、保健品、饮酒情况一并告知。

家里可以提前准备的事

- ☐ 把 120、附近医院急诊、12356 存进手机并置顶
- ☐ 把正在吃的所有药名、剂量写在卡片上，放钱包里
- ☐ 家属知道药放在哪、吃的是什么、最近有没有调整
- ☐ 知道最近的急诊在哪、晚上怎么去
- ☐ 出现新症状时，拍下皮疹、记下体温和心率
- ☐ 复诊时主动说“最近有没有出现从没出现过的症状”

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快：**立即急诊**，警惕血清素综合征。
- 皮疹迅速扩散、起疱脱皮、面唇肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 意识模糊、走路不稳、抽搐，尤其老年人：**立即急诊**，排查低钠血症。
- 呕血、黑便、鼻血止不住、大片瘀斑：**立即急诊**。
- 晕厥、持续心悸、胸闷：**立即急诊**并做心电图。
- 睡眠骤减、话多、冲动消费、行为失控：当天联系精神科医生。
- 自杀念头、自伤行为、安排后事：**立即呼叫 120 或去急诊**，不要独处。

容易踩的坑

“症状像感冒，先吃点药看看。” 发热加肌肉僵硬加意识改变，不是感冒。不要用退烧药掩盖。

“皮疹不严重，等复诊再说。” 迅速扩散的皮疹可以在一两天内变成重症药疹，不要等。

“老人突然糊涂，是年纪大了。” 新用药后出现的意识模糊，首先要排低钠和感染。

“心情突然特别好，是病好了。” 睡眠需求骤减加话多冲动，更可能是转躁，不是康复。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.7 换药联合与增效

吃了两种药都没好，是不是没救了？不一定。这一页讲医生在“第一种药不够用”之后会走的三条路：换药、联合、增效。它说明每种做法在什么情况下考虑、证据有多硬、风险在哪，也说明为什么这些操作必须由医生安排，不能自己在家叠药。

先分清三件事：换药、联合、增效

这三个词经常被混着用，其实指向不同动作：

- **换药**：停掉现在的药，换成另一种。适合“这个药完全没效”或“副作用无法耐受”的情况。
- **联合**：同时用两种抗抑郁药。适合单药治疗部分有效、但差一口气的情况。
- **增效**：在抗抑郁药的基础上，加一种本身不是抗抑郁药的药（比如锂盐、非典型抗精神病药），用它来放大抗抑郁效果。

三条路没有绝对的先后。指南通常建议：先确认剂量和疗程是否足够、有没有漏服、有没有共病，再考虑换药或增效。【指南】换句话说，**在“加招”之前，先排除“假难治”**。

换药的三种方式

方式	大致做法	适合谁	要注意什么
直接换	停旧药，第二天开始新药	旧药疗效差、副作用轻、半衰期长	可能出现撤药反应或症状波动
交叉换	新药加上去，旧药逐步减，有一段重叠	多数情况，尤其旧药有撤药反应时	重叠期副作用和相互作用风险上升
洗脱后换	先完全停旧药，等一段时间再上新药	旧药风险高、或需要换 MAOI	症状可能反弹，必须有医生盯着

直接换最省事，但对半衰期短、撤药反应明显的药（比如帕罗西汀、文拉法辛）不太友好，可能几天内就出现头晕、电击感。

交叉换是临床上最常用的方式：新药从小剂量加上去，旧药慢慢减，两者有一段重叠。好处是症状波动小，坏处是重叠期等于“两种药一起在体内”，副作用和相互作用都会增加，需要更密切的观察。

洗脱是彻底停掉旧药、等它从体内清除，再开始新药。主要用于风险高的组合，尤其是涉及 MAOI 的换药。

MAOI 的特别提醒：MAOI 与其他抗抑郁药之间的换用，是最危险的换药场景之一。无论从 MAOI 换出去，还是从别的药换到 MAOI，都需要以周计的间隔；氟西汀这类在体内停留很久的药，需要的间隔更长。间隔不够，可能引发高血压危象或血清素综合征。【指南】这件事没有“我觉得差不多可以了”的空间，必须由医生安排时间表。

什么时候该考虑换药

- 足量足疗程后完全无应答（不是“好了一点点”，是几乎没有变化）
- 有效但副作用无法耐受，且调整后仍不改善
- 出现禁忌或严重的相互作用
- 病情特点发生变化，比如出现转躁、出现强迫症状
- 患者的生活处境变了，比如怀孕、要做手术、经济压力

如果只是“部分有效”，换药不一定是最优解。换掉一个已经起了一半作用的药，可能丢掉已有的收益；这时候联合或增效往往更合适。

联合两种抗抑郁药：证据有限，风险实在

联合抗抑郁药在临床上有使用，但整体证据不如换药和增效充分，属于“部分有效时可以考虑”的策略。【研究】

常见的组合思路包括：

- **SSRI 或 SNRI 加米氮平**：利用米氮平的镇静和改善睡眠、食欲的作用，抵消前者的失眠和食欲下降。这是研究相对较多的组合。【研究】
- **SSRI 加安非他酮**：用于改善乏力、注意力差和性功能副作用。证据中等，癫痫风险需要评估。【研究】
- **SNRI 加米氮平**：用于难治性抑郁，需注意血压和镇静叠加。

风险也很明确：血清素综合征、QT 延长、出血、癫痫阈值下降、相互作用导致血药浓度异常升高。**两种抗抑郁药叠加不是“1+1=2”，有时是“1+1=3 的副作用”。** 这也是为什么不能自己把家里剩下的药加上去。

增效药物：加的不是抗抑郁药

增效药物	证据强度	主要风险	需要监测什么
锂盐	较强，指南推荐	中毒、甲状腺功能异常、肾功能影响、体重增加	血锂浓度、甲状腺、肾功能、心电图
非典型抗精神病药（如阿立哌唑、喹硫平）	较强，指南推荐	代谢异常、体重增加、嗜睡、锥体外系反应	体重、血糖血脂、血压、运动症状
甲状腺素（T3）	中等	心悸、失眠、骨密度影响	甲状腺功能、心率
安非他酮	中等	失眠、焦虑、癫痫风险	癫痫史、进食障碍史
米氮平	中等	嗜睡、体重增加	体重、白天功能
丁螺环酮等	较弱	头晕、恶心	临床反应

锂盐是增效治疗里证据最扎实的一个，尤其对反复发作、有家族史的抑郁。【指南】但它的治疗窗窄，脱水、肾功能变化、合并用药都可能让浓度失控，所以必须定期抽血。它不是“随便加一点试试”的药。

非典型抗精神病药（如阿立哌唑、喹硫平）作为增效剂有较多研究支持，对焦虑、失眠、反复思考也有帮助。代价是代谢问题：体重、血糖、血脂都可能上升，长期使用要定期监测。【指南】

甲状腺素在难治性抑郁中有一定证据，尤其是亚临床甲减的人。它不能代替甲状腺疾病的规范治疗。

安非他酮加在 SSRI 上，常用来对抗性功能副作用和乏力，但它会降低癫痫阈值，有进食障碍史或癫痫史的人要特别谨慎。

一个常被忽略的前提：先排除“假难治”

在换药或加药之前，医生通常会先排查这些：

- 剂量是否真的够了（不是“吃了一片”，而是“在耐受范围内达到了有效剂量”）
- 疗程是否够了（四周、六周、八周，有没有做过正式评估）
- 有没有漏服（很多人实际服药率远低于自己以为的）
- 诊断是否正确（双相、甲状腺疾病、贫血、睡眠呼吸暂停都可能伪装成抑郁）
- 有没有未处理的共病（焦虑、PTSD、物质使用、慢性疼痛）
- 有没有影响吸收的问题（胃肠道疾病、减肥手术史）
- 有没有同时在用会干扰的药物或保健品

这些因素不排除，换多少种药都可能“无效”。具体见5.1 难治性抑郁的评估。

不要自己叠药：三个真实的场景

场景一：家里还有上次剩的药。 “这个没效，我把上次那个也吃上。”两种药可能都作用于 5-羟色胺，叠加后血清素综合征风险上升。

场景二：听朋友说某个药配着吃效果好。 别人的方案基于别人的诊断、代谢和合并用药，不能平移。

场景三：觉得效果慢，自己加量。 加量带来的往往不是更快起效，而是更集中的副作用。

同样，**也不要自己停掉其中一个**。突然撤掉一种药，可能引发撤药反应，也可能让原本被压住的症状反弹。

换药前可以问医生的问题

- ☐ 我们现在判断“这个药不够”的依据是什么？
- ☐ 剂量和疗程还有没有调整空间？
- ☐ 换药、联合、增效，三条路各自的利弊是什么？
- ☐ 换药采用哪种方式，中间会不会有重叠期？
- ☐ 重叠期我需要观察什么？

- ☐ 新方案多久评估一次，评估标准是什么？
- ☐ 需不需要查血、查心电图、查肝功能？
- ☐ 如果新方案也不行，下一步是什么？

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 换药或加药后出现高热、大汗、肌肉僵硬、抽搐、意识混乱：**立即急诊**。
- 出现自杀念头、自伤行为：**立即呼叫 120 或去急诊**，不要独处。
- 突然兴奋、话多、睡眠骤减、冲动消费：当天联系精神科医生。
- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 晕厥、持续心悸、抽搐：**立即急诊**。
- 换药后症状急剧反弹、整夜不眠、无法进食：尽快联系开药医生。

常见问题

“换药是不是说明前面的治疗白做了？” 不是。前面的治疗提供了重要信息：你对哪类药有反应、能耐受什么、需要避开什么。这些都是下一步的依据。

“两种药一起吃，是不是效果更好？” 不一定。联合增加的是副作用和相互作用的风险，收益只在特定人群里出现。

“增效药是不是越早加越好？” 不是。单药足量足疗程无效，才轮到增效。过早叠加会让方案越来越复杂，出了问题也难以判断是哪一种。

“锂盐是不是很危险？” 它需要监测，但不是“危险到不能用”。在规范监测下，它是增效治疗中证据最强的选项之一。

参考来源

- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.8 停药与撤药反应

“我感觉好了，能不能停？”“停了两天头晕得厉害，是复发还是撤药？”“为什么别人停药没事，我一停就难受？”这一页讲停药时会遇到什么、哪些药更难停、怎么把撤药反应和复发分开、以及一个合格的停药计划应该包含哪些内容。

先明确：停药是一个决定，不是一个动作

在规范治疗里，停药和开始用药一样，需要评估、计划和随访。需要考虑的因素包括：这次发作有多重、发作过几次、缓解持续了多久、有没有残留症状、生活里有没有即将到来的高压事件、有没有复发预警信号。

这些条件合适，医生会和你一起制定减量计划；条件不合适，继续维持治疗往往是更划算的选择。**停药不是“治疗结束”的仪式，而是治疗阶段之间的一次转换。**

撤药反应长什么样

撤药反应是身体对“药物浓度突然下降”的适应过程，通常出现在停药或减量后的几天内。常见表现可以分成几组：

- **神经和感觉**：头晕、眩晕、走路发飘、手脚发麻、像“脑子里有电流闪过”的触电感、耳鸣。
- **胃肠**：恶心、呕吐、食欲下降、腹泻。
- **全身**：乏力、流感样酸痛、出汗、心慌。
- **睡眠和情绪**：入睡困难、多梦、易怒、焦虑、情绪低落、坐立不安。
- **运动**：手抖、走路不稳、动作不协调。

这些症状的共同特点是：**来得快、以身体感觉为主、补回原来的药后很快缓解**。多数人在一两周内逐渐减轻，但有些人会拖得更久，尤其是减量过快或反复停药的人。

哪些药更容易出现撤药反应

药物	撤药反应风险	主要原因
帕罗西汀	较高	半衰期短，离开身体快
文拉法辛	较高	半衰期短，且同时影响两种递质
度洛西汀	中等偏高	半衰期较短
舍曲林、艾司西酞普兰	中等	个体差异大
氟西汀	较低	半衰期长，自行“缓慢减量”
米氮平、曲唑酮	中等	镇静作用反跳、睡眠反弹
TCA、MAOI	较高	长期使用后受体适应明显

表里的“半衰期”，指药物在体内浓度减少一半所需的时间；越短，停药后浓度掉得越快。这张表只能作为参考。**同样的药，有人停得毫无感觉，有人反应强烈**，和用药时间、剂量、减量速度、个人代谢都有关。氟西汀也不是“绝对安全”，只是它自己减得慢。

需要特别说明：撤药反应不是“成瘾”。它不具备成瘾的核心特征（渴求、失控、越用越多），而是身体对药物存在的适应。这个区别很重要，因为它决定了应对方式：不是“戒断”，而是“减速”。

撤药反应和复发怎么区分

这是停药期最实际的问题。两者可能同时发生，也可能互相掩盖。可以从四个角度分辨：

维度	撤药反应	复发
出现时间	停药或减量后数天内	数周内逐渐出现
主要表现	头晕、电击感、恶心、流感样、出汗	情绪低落、兴趣丧失、早醒、自责、无力
对补回药物的反应	几小时到一两天内明显缓解	需要重新治疗一段时间才缓解
持续时间	通常一两周，逐渐减轻	持续加重，不会自行消退

一个实用的判断：**如果你补回一点原来的药，症状在一天内明显好转，更像撤药反应；如果补回后仍持续低落、兴趣全无，更像复发。**

但不要自己做这个实验。补回药物、调整剂量都要问医生，因为“补一点看看”可能打乱整个计划。

减量原则：慢，而且越到后面越慢

抗抑郁药的减量不是“每周减一半”那么简单。药物在体内的作用与受体占用率不是直线关系：**在低剂量区间，同样的减量幅度，带来的生理变化可能更大。** 所以很多医生会采用“先快后慢”的方式：前期可以稍快，越接近停药，每一步越小、间隔越长。

具体的节奏因人而异，取决于：

- 你吃的是哪种药、吃了多久
- 之前有没有撤药反应史
- 减量过程中症状有没有波动
- 生活里有没有同时发生压力事件

原则性的话可以说三句：不要突然停；每一到两步都要观察；出现明显不适时，可以退回上一档稳定后再继续。具体的减量方案，必须由医生给。

突然停药的风险

第一，撤药反应更重。 浓度骤降，头晕、恶心、电击感集中出现，很多人因此以为“病又回来了”，慌乱中彻底停药。

第二，复发风险上升。 尤其是在缓解后不久、发作次数多、有残留症状的人身上。突然停掉维持治疗，等于撤掉了防止复发的支架。

第三，可能出现罕见但严重的反应。 突然停用某些药后，极少数人会出现明显的焦虑激越、失眠、甚至短暂的意识混乱，需要医疗处理。

第四，你会失去判断依据。 突然停药后症状一团乱，医生很难分清是撤药、复发还是新问题，下一步决策会变得更难。

一个合格的停药计划包含什么

- ☐ 停药的理由和时机：是缓解足够久，还是因为副作用、怀孕、费用
- ☐ 减量的步骤：每一步大概多久、减多少（由医生写清楚）
- ☐ 观察指标：睡眠、情绪、焦虑、身体症状，每天简单记一笔
- ☐ 复诊节点：减到哪一步回来复诊，出现问题找谁
- ☐ 撤药反应的处理预案：出现什么程度可以观察，什么程度要联系医生
- ☐ 复发的预警信号：你自己的前驱症状清单
- ☐ 恢复用药的条件：如果复发了，怎么快速回到治疗
- ☐ 非药物治疗的衔接：心理治疗、运动、睡眠、社会支持
- ☐ 家人或同伴知道计划，能帮你观察
- ☐ 生活事件的评估：接下来几个月有没有考试、搬家、换工作、丧亲

计划写得越具体，执行时越不容易慌。可以把它抄在纸上，和药盒放在一起。

停药之后：监测至少几个月

停药不等于结束。停药后的几个月是复发的高风险期，尤其是前半年。这段时间建议：

- 保持规律复诊，即使感觉很好
- 继续记录睡眠和情绪，关注早期信号
- 维持运动、社交、睡眠节律这些保护因素
- 知道复发的预警信号，并且知道找谁
- 如果出现持续两周以上的情绪低落、兴趣丧失、早醒，尽快复诊

常见问题

“感觉好了就可以停吗？” 症状消失是巩固期的开始。通常还需要继续一段时间，具体多长取决于发作次数和严重程度。【指南】

“隔天吃一次，是不是就算减量了？” 不建议自行采用这种方式。隔天服药会让血药浓度大幅波动，反而更容易出现撤药反应。

“停了以后难受，是不是说明我离不开药？” 更可能是撤药反应，不是“上瘾”。告诉医生，调整减量速度通常能解决。

“中药能不能替代西药来停药？” 目前没有证据支持用中药替代规范的维持治疗。突然替换可能带来撤药反应和复发风险。

“停药后怀孕可以吗？” 这是需要提前规划的事，不是停药就能解决。见6.3 孕产期抑郁。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 停药或减量后出现自杀念头、自伤行为：**立即呼叫 120 或去急诊**，不要独处。
- 出现严重头晕、无法站立、反复呕吐、心慌到无法休息：当天联系医生。
- 出现意识混乱、抽搐、高热：**立即急诊**。
- 情绪在两周内持续下滑、早醒、兴趣丧失：尽快复诊，不要自行加回原剂量。
- 出现兴奋、话多、睡眠骤减：当天联系精神科医生。
- 不确定是撤药还是复发：联系开药医生，不要自己试。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.9 药物相互作用与禁忌

抗抑郁药很少单独存在。你还可能吃降压药、止痛药、胃药、感冒药、中药、保健品，可能喝酒、喝咖啡、喝葡萄柚汁，可能要做手术、拔牙、做胃镜。这一页讲哪些组合需要小心、为什么、以及看医生前该交代什么。它不要求你记住所有药名，只要求你养成一个习惯：**加任何东西之前，先问一句。**

相互作用有四种常见机制

理解机制，比背药名有用。

第一种：作用叠加。 两种都提高 5-羟色胺的药一起吃，血清素综合征风险上升；两种都镇静的药一起吃，白天更困；两种都延长 QT 间期（心电图上的一个时间指标，延长会增加心律失常风险）的药一起吃，心脏风险上升。

第二种：影响代谢。 肝脏里的 CYP450 酶负责分解大多数药物。一种药抑制了某个酶，另一种药就分解变慢、血里浓度升高；一种药诱导了某个酶，另一种药就分解变快、浓度不足。这是最隐蔽的一类，因为你看不到浓度变化，只能看到结果。

第三种：影响吸收或排泄。 比如改变胃内酸碱度、影响肾脏排泄，或者像圣约翰草那样影响药物的转运。

第四种：药理对抗。 一种药升血压，另一种药降血压；一种药让心跳快，另一种让心跳慢。

需要特别小心的组合

组合	可能后果	怎么办
MAOI + SSRI/SNRI/曲马多/哌替啶	血清素综合征、高血压危象	属禁忌或需严格间隔，必须由医生安排
MAOI + 含酪胺食物	血压骤升、剧烈头痛	严格忌口，具体清单由医生给
SSRI/SNRI + 曲马多、曲普坦类、圣约翰草	血清素综合征	尽量避免；必须合用时密切观察
SSRI/SNRI + NSAIDs、阿司匹林、抗凝药	消化道出血、瘀斑	告知医生，必要时加胃保护药
多种延长 QT 的药物合用	心律失常、晕厥	查心电图、纠正低钾低镁
氟西汀/帕罗西汀 + 经 CYP2D6 代谢的药	后者浓度升高、副作用增加	由医生或药师核对
氟伏沙明 + 阿戈美拉汀	后者浓度大幅升高	属禁忌
安非他酮 + 降低癫痫阈值的药	癫痫风险上升	评估病史，避免叠加

这张表不是全部，只是最常见的高风险组合。**表中的“怎么办”不是让你自己执行，而是让你知道该去问谁。**

几类高风险药物与食物

MAOI：禁忌最多的一类

MAOI 通过抑制单胺氧化酶，让去甲肾上腺素、5-羟色胺、多巴胺分解变慢。问题是，酪胺（一种存在于发酵食物中的氨基酸）也靠这个酶分解。酶被抑制后，吃进去的酪胺会让血压骤升。

需要忌口的典型食物包括：陈年奶酪、腌肉腌鱼、发酵豆制品（腐乳、豆豉、豆瓣酱）、部分酱油、啤酒酵母、某些生啤和红酒、隔夜剩菜。具体清单在不同国家、不同医院略有差异，以开药医生给的为准。

需要避免的药物包括：含伪麻黄碱的感冒药、含麻黄碱的中成药、曲马多、哌替啶、右美沙芬、部分曲普坦类、部分抗帕金森药，以及其他抗抑郁药。

高血压危象的表现：突然剧烈头痛、后颈发硬、心悸、大汗、恶心呕吐、视力模糊、胸闷。这是急症，**立即急诊**，不要等它自己过去。

MAOI 在国内的可及性有限，用得不多，但一旦用上，饮食和用药纪律是治疗的一部分，不是“注意一下就好”。

曲马多、哌替啶、曲普坦类：止痛药里的坑

曲马多是常用的中等强度止痛药，它有 5-羟色胺能作用，和 SSRI、SNRI、MAOI 合用可能引发血清素综合征，也可能降低癫痫阈值。拔牙、骨科疼、术后镇痛都可能用到它，**开止痛药时要主动说你正在吃抗抑郁药**。

哌替啶（杜冷丁）同样有 5-羟色胺能作用，与 MAOI 合用是明确禁忌。

曲普坦类（治疗偏头痛，如舒马曲普坦）与 SSRI/SNRI 合用，血清素综合征风险虽低但确实存在，偏头痛患者尤其要注意，因为这两类药经常同时出现在一个人的药盒里。【研究】

右美沙芬是很多止咳药的主成分，也有 5-羟色胺能作用，容易被忽略。

SSRI/SNRI 与止痛、抗凝：出血风险

血小板要靠 5-羟色胺才能正常聚集。SSRI 和 SNRI 削弱了这个功能，单独使用时出血风险不高，但叠加以下药物时明显上升：

- **NSAIDs**：布洛芬、双氯芬酸、萘普生、塞来昔布等
- **阿司匹林**，尤其是小剂量长期服用
- **抗凝药**：华法林、利伐沙班、阿哌沙班等
- **抗血小板药**：氯吡格雷、替格瑞洛等

需要留意的不只是“会不会流血”，还有**黑便、呕血、不明原因的贫血、月经量突然增多**。如果必须合用，医生可能会加用胃黏膜保护剂，或选择对血小板影响小的止痛药。具体怎么选，问医生或药师。

圣约翰草：最容易被低估的“天然”产品

圣约翰草（贯叶金丝桃）是常见的抗抑郁草药，也是强效的肝药酶诱导剂。它会让很多药物分解加快、浓度下降，包括部分抗抑郁药、口服避孕药、抗凝药、抗排异药。同时它本身有 5-羟色胺能作用，与 SSRI 合用可能引发血清素综合征。

它不是“天然所以安全”。 很多中成药、复方制剂里含有贯叶金丝桃，成分表上不一定写得很显眼。加任何中成药前，把成分表拍给药师看。

酒精：不是绝对禁忌，但不划算

酒精和抗抑郁药的关系，可以从三个层面看：

- **药理学**：酒精加重镇静、影响平衡和判断，和镇静类抗抑郁药（米氮平、曲唑酮、TCA）叠加时尤其明显。
- **疾病层面**：酒精本身会加重抑郁、焦虑和失眠，也会干扰治疗效果。
- **器官层面**：长期饮酒影响肝功能，而肝功能影响药物代谢。

所以多数医生会建议治疗期间尽量不喝，或者严格限量。**不要用酒来助眠**，它会让后半夜的睡眠更碎。

CYP2D6 与 CYP3A4：两个最常被提到的酶

酶	常被它代谢的药	常抑制它的药或食物	常诱导它的药或食物
CYP2D6	部分抗抑郁药、部分抗精神病药、美托洛尔、可待因、他莫昔芬	帕罗西汀、氟西汀、安非他酮	一般较少
CYP3A4	部分抗抑郁药、部分他汀、部分钙拮抗剂、某些安眠药	氟伏沙明、葡萄柚汁、部分抗真菌药	圣约翰草、利福平、卡马西平

你不需要记住这张表。需要记住的是：**如果你同时在吃三种以上的药，或者要开始一种新药，值得让医生或药师做一次“相互作用核对”。** 很多医院有药学门诊，这项服务常常是免费的。

葡萄柚：影响没有传说中那么广，但确实存在

葡萄柚汁会抑制肠道里的 CYP3A4，让部分药物吸收增多、血药浓度升高。受影响的药物名单不长，但包括一些安眠药、部分他汀、部分降压药。对多数抗抑郁药影响有限，但**具体到你在吃的药，问一句药师最稳妥**。西柚、柚子、部分柑橘类果汁也建议一并问。

手术、麻醉、拔牙、胃镜之前

这是最容易被忽略的场景：要手术了，麻醉医生问“平时吃什么药”，你说“就一种抗抑郁药”，然后就没下文了。

需要主动交代的内容：

- ☐ 药名、剂量、每天什么时候吃、最后一次吃是什么时候
- ☐ 有没有吃过 MAOI（这类药与麻醉药的相互作用最复杂）
- ☐ 有没有抗凝药、抗血小板药、NSAIDs
- ☐ 有没有中药、保健品、圣约翰草
- ☐ 有没有出血倾向、瘀斑、鼻血
- ☐ 有没有心脏病史、心电图异常

不要自己决定手术前停药。 是否停、停多久、要不要桥接，需要精神科和麻醉/手术团队一起定。突然停用可能引发撤药反应，也可能让情绪在围手术期崩掉。

看病时的一句万能话

“我在吃抗抑郁药，药名在这里，麻烦帮我看一下会不会冲突。”

把药盒拍照存在手机里，或者写一张卡片放钱包。这比记住药名可靠得多。

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 服药后突发剧烈头痛、后颈发硬、心悸、大汗、视力模糊：**立即急诊**，警惕高血压危象。
- 高热、肌肉僵硬、抽搐、意识混乱：**立即急诊**，警惕血清素综合征。
- 呕血、黑便、鼻血止不住、大片瘀斑：**立即急诊**。
- 晕厥、持续心悸、胸闷：**立即急诊**并做心电图。
- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 刚加了一种新药或保健品后明显不适：停用新增的东西并联系医生。

常见问题

“中药和西药隔开两小时吃，是不是就不冲突了？” 隔开时间能减少一部分胃肠道层面的影响，但不能消除肝酶层面的相互作用。关键还是看成分。

“感冒药不是处方药，应该没关系吧？” 含伪麻黄碱、右美沙芬的感冒药恰恰是常出问题的一类。买之前问药师。

“偶尔喝一点酒没事吧？” 少量、偶尔，多数人不会有严重问题，但它会加重困倦、影响判断，也会拖慢恢复。治疗期能不喝就不喝。

“保健品天然，应该不会和药冲突。” 圣约翰草、银杏、大剂量鱼油都有明确的相互作用或出血风险。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

2.10 用药常见问题 30 问

这一页收集了诊室里、病友群里、深夜搜索框里出现频率最高的 30 个用药问题。每个问题给一个可以直接读懂的答案，不绕弯子，也不吓人。适合放在手边，遇到具体困惑时翻到对应那条。答案是一般规律，你的情况以面诊医生为准。

关于起效与疗效

1. **吃了三天没感觉，是不是药不对？**太早。前两周你感受到的多半是副作用，不是疗效。药物要先改变递质信号，再等大脑的受体和突触慢慢适应，这个过程以周计。给自己四周，再和医生一起评估。

2. **一般多久能起效？**多数人在 2–4 周开始感到松动，4–6 周出现比较明确的改善，6–12 周达到缓解。有人更早，有人更晚。睡眠和食欲常常比情绪先变。【指南】

3. **起效后是不是就“好了”？**不是。症状减轻叫“应答”，基本消失叫“缓解”，两者都还不是终点。缓解之后还需要巩固和维持，否则容易复发。这也是为什么医生总说“好了也要继续吃一段时间”。

4. **吃了四周还没效，是不是该换药？**四周是一个评估点，不是自动换药点。医生会先看剂量够不够、有没有漏服、诊断对不对、有没有共病，再决定加量、换药还是联合。别自己下结论。

5. **症状好转后能不能马上停？**不建议。症状刚消失时，大脑的调节功能还不稳，此时停药复发风险最高。通常还需要继续一段时间，具体多久由医生根据发作次数和严重程度决定。

关于身体与副作用

6. **抗抑郁药会不会让我“变傻”、记忆力下降？**抑郁本身就会损害注意力和记忆，很多人是“病让我变笨”，治疗后才慢慢恢复。抗抑郁药可能带来短暂的嗜睡、反应慢，但通常不是永久性的认知损害。如果持续几个月都迷糊，要和医生讨论，可能是药、剂量、睡眠或共病的问题。

7. **会不会伤肝？要不要定期查肝？**多数抗抑郁药对肝脏影响不大，但少数药（如阿戈美拉汀）需要用药前后查肝功能。出现尿色变深、眼白发黄、右上腹痛、持续恶心，要当天就医。平时喝酒多、有肝病史的人，提前告诉医生。

8. **会不会伤肾？**大多数 SSRI 对肾脏影响小。锂盐、部分药物需要关注肾功能和电解质。老年人、脱水、同时吃利尿剂的人风险更高。

9. **为什么会恶心？要不要空腹吃？**5-羟色胺在肠道里很多，药物一上来先刺激肠道。随餐吃、避免空腹、少量多餐通常能减轻。持续呕吐、吃不下东西要就医。

10. 吃了睡不着怎么办？先看药是偏激活还是偏镇静。偏激活的药放在早上吃（需医生确认），避免下午咖啡因，睡前减少屏幕。不要自己加安眠药或喝酒助眠。

11. 白天困得不行怎么办？偏镇静的药可以调到晚上吃；如果已经晚上吃还困，可能需要换药或减量。白天困到影响开车、上班，是要报告的事，不是“忍忍就好”。

12. 会不会发胖？有些药确实会增加食欲和体重（米氮平、部分 TCA 较明显），有些影响很小（安非他酮、阿戈美拉汀相对少）。体重变化通常是渐进的，建议每周固定称一次。真的困扰，可以和医生讨论换药。

13. 性功能受影响怎么办？能恢复吗？SSRI、SNRI 较常见，表现为性欲下降、延迟或难以高潮。多数在停药后恢复，但恢复需要时间。不要默默忍受或自行停药，医生有换药、调整、加辅助药等办法。

14. 出汗特别多正常吗？常见，尤其夜间和头面。穿透气衣物、避免酒精辛辣、补足水分。如果伴随心悸、乏力、体重下降，要查甲状腺和电解质。

常见担忧	更准确的说法
副作用重说明药效强	副作用和疗效没有可靠关系
没副作用说明药没用	很多人几乎无早期反应，照样有效
吃了会变傻	抑郁本身影响认知，治疗多会改善
伤肝是必然的	多数影响小，少数药需要监测

关于依赖、停药与漏服

15. 会不会上瘾？抗抑郁药不具备成瘾的核心特征：没有渴求、没有失控性使用、不会越吃越多。但身体会适应，突然停药可能出现撤药反应。这叫“身体依赖”，不叫“成瘾”。

16. 长期吃会不会把脑子吃坏？目前没有证据支持“长期规范使用抗抑郁药会造成永久性脑损伤”。相反，反复发作、长期不治疗对大脑和生活的损害更明确。真正需要担心的是不监测、乱搭配、自行加减。

17. 能不能自己减半？不建议。减半可能让浓度不足、疗效打折，也可能引发撤药反应。剂量调整要医生根据你的反应来定。

18. 漏服了一次怎么办？一般原则：想起来时如果离下次服药还很久，可以补；如果已经接近下次服药时间，就跳过，**不要一次吃双倍**。具体到你的药，按医生或说明书的说法做。经常漏服要找出原因，用闹钟、分装盒、和家人互相提醒。

19. 突然停药会怎样？可能出现头晕、恶心、电击感、失眠、焦虑加重等撤药反应，也会增加复发风险。少数人会出现明显的激越或意识混乱。不要突然停。

20. 停药后头晕、电击感，是复发吗？更像撤药反应：来得快、以身体感觉为主、补回药物后很快缓解。复发是情绪、兴趣、睡眠在数周内逐渐下滑。分不清就问医生，不要自己试。

关于日常生活

21. 喝酒可以吗？治疗期最好不喝。酒精会加重困倦、影响判断，也会加重抑郁和失眠。偶尔少量多数人不会出大事，但它不划算。

22. 咖啡、浓茶、能量饮料呢？咖啡因会放大焦虑、心悸、失眠，尤其在用药初期。建议限量，下午之后不喝。能量饮料含咖啡因和糖，尽量避免。

23. 吃药期间能开车吗？看反应。刚开始服药、加量、换药的头一两周，如果出现嗜睡、头晕、反应慢，不要开车。稳定后如果白天清醒、没有眩晕，多数人可以正常驾驶，但要以自己的实际状态为准。

24. 要做手术、拔牙，要不要停药？不要自己停。术前主动告诉麻醉医生和手术医生你在吃什么药，尤其是 MAOI、抗凝药、NSAIDs。停不停、停多久，由精神科和手术团队一起定。

25. 出门旅行怎么带药？带足全程的量，多带几天备用；药放在随身行李，不要托运；保留原包装和说明书；跨时区服药问医生怎么调；带上处方或诊断证明，过安检更顺利。

26. 中药、保健品能不能一起吃？要看成分。圣约翰草（贯叶金丝桃）会明显影响肝酶，还可能引发血清素综合征；银杏、大剂量鱼油会增加出血风险。加任何东西前，把成分表给医生或药师看。

关于特殊时期与共病

27. 怀孕了还能吃吗？需要个体化评估，不能一概而论。核心是比较“不治疗的风险”和“用药的风险”。突然停药可能引发复发，对母婴同样有风险。计划怀孕或已经怀孕，尽快同时找精神科和产科，不要自行停药。

28. 哺乳期能吃吗？部分药物进入乳汁的量较少，但需要选药并监测婴儿的反应。同样是精神科和儿科/产科一起评估，不要自己决定停或吃。

29. 双相障碍为什么不能单吃抗抑郁药？单用抗抑郁药可能诱发转躁或快速循环，让病情更不稳定。双相抑郁通常需要心境稳定剂打底，抗抑郁药是否使用、用多久，要非常谨慎。【指南】

30. 副作用太难受，能不能直接停？先联系医生，不要直接停。多数副作用有办法处理：调整服药时间、换同类药、换类别、短期辅助用药。直接停可能带来撤药反应和复发，反而更难受。

旅行与出差备药清单

- ☐ 按行程天数算好药量，再多带三到五天
- ☐ 药放在随身包里，不托运

- ☐ 保留原包装、说明书、处方照片
- ☐ 分装盒只装当次用量，避免整瓶丢失
- ☐ 跨时区前问医生怎么安排服药时间
- ☐ 带上医生联系方式，记下药名通用名
- ☐ 如果去高原、热带，提前问医生注意事项
- ☐ 同行的人知道你在吃什么药

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为：**立即呼叫 120 或去最近医院急诊**，不要独处。
- 高热、大汗、肌肉僵硬、意识混乱、心跳很快：**立即急诊**。
- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：**立即呼叫 120**。
- 呕血、黑便、晕厥、抽搐：**立即急诊**。
- 突然兴奋、话多、睡眠骤减、冲动消费：当天联系精神科医生。
- 副作用重到无法进食、无法入睡、无法工作：尽快联系开药医生，不要自行停药。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 3：心理治疗

心理治疗不是“聊聊天”，也不是药物的替补。这一模块讲清楚每种疗法在做什么、适合谁、怎么找到靠谱的治疗师。

3.1 心理治疗总览与证据

> 确诊抑郁症之后，人常会听到两种建议：一种是“赶紧吃药”，一种是“去做心理治疗”。真到要选的时候，问题往往更具体：CBT、行为激活、正念、人际治疗各指什么？一周去几次、要做多久、怎么判断自己做的是不是规范治疗？这一页把主流心理治疗的方法、适用人群、频率疗程和与药物的关系讲清楚，读完你可以带着具体问题去和医生讨论。

心理治疗不是“聊聊天”

先把一个误会拆掉。心理治疗确实靠说话进行，但“靠说话”不等于“聊天”。区别不在说得多不多，而在于有没有一套可以重复的结构。

维度	朋友开导	规范的心理治疗
目标	让你当下舒服一点	针对明确问题设定可评估的目标
方法	凭经验、善意和常识	有理论模型和操作步骤，治疗师受过系统训练
结构	随时开始、随时结束	固定时间、时长、地点，每次约 45–60 分钟
记录	一般不记录	会做评估、写个案概念化、定期复评

规范治疗的第一步是评估：现在最困扰的是什么、持续多久、以前治过没有、有没有自杀风险、睡眠和进食如何。评估之后，治疗师会和你一起形成“个案概念化”。用大白话说，就是**用一套解释把你眼下的困难串起来，再据此决定先动哪里**。它是一个可以修改的工作假设，不是给你贴标签。

所以，如果你坐在咨询室里，对方主要是在听、偶尔给点建议、从不布置练习、也说不清接下来几次要做什么，那很可能不是规范的心理治疗。这不代表对方是坏人，只代表它大概帮不到你。

七种主流方法，分别适合谁

下面这张表是全景。每一行在后面的小节里展开。

方法	核心在做什么	更适合谁	常见形式
认知行为治疗（CBT）	找出想法、行为里能改的环节，用记录和实验去检验	消极想法多、回避、拖延明显的人	个别，每周 1 次，常 12–20 次
行为激活（BA）	不等情绪好转，先按计划恢复活动	快感缺失、乏力、退缩、整天躺着的人	个别或团体，常 10–20 次
人际心理治疗（IPT）	聚焦四类人际问题，改善沟	抑郁与丧亲、换岗、冲突、	个别，经典设计 12–16 次

方法	核心在做什么	更适合谁	常见形式
	通与角色适应	孤立明显相关的人	
正念认知疗法（MBCT）	训练“注意到想法而不被卷走”	已缓解、反复发作、想预防复发的人	团体 8 周课程
问题解决治疗（PST）	把压倒性的问题拆成可执行的步骤	现实压力大、老年人、基层就诊者	个别，常 6–12 次
支持性心理治疗	稳住关系与情绪，协助现实应对	急性期、刚出院、合并躯体疾病的人	个别，频率弹性大
短程动力治疗（STPP）	看重复的关系模式与回避的情绪	问题反复出现、想理解“为什么总这样”的人	个别，十几次到几十次

认知与行为取向：CBT、行为激活、问题解决治疗

CBT 是研究积累最多的一种。它假设：让人难受的往往不只是事件本身，还有事件发生时脑子里闪过的解释。CBT 不要求你“想开”，而是教你把想法当成假设去检验——支持它的证据是什么，反对它的证据是什么，有没有另一种更贴近事实的解释。【指南】

行为激活更直接：抑郁时人会退缩，退缩让生活里的正反馈变少，情绪更低，于是更退缩。行为激活从“安排活动”入手打断这个循环。对说不出具体想法、但明显没劲和回避的人，它常常比追问认知更管用。【指南】

问题解决治疗把“我完蛋了”这种笼统感受，转成“这周有三件事，先处理哪件、第一步做什么”。它不追问童年，也不深挖认知，适合现实压力集中、时间精力有限的人。【指南】

人际与动力取向：IPT 与短程动力治疗

IPT 的假设是：抑郁常发生在人际关系变化之后或之中——丧亲、生育、换工作、退休、离婚、查出重病。它把工作焦点收在四个领域之一（悲伤、角色转换、人际冲突、社交困难），用沟通分析和角色扮演练新的应对方式。【指南】

短程动力治疗关注重复出现的关系模式和被回避的情绪，比 CBT 更在意“你为什么会变成这样”，疗程也更长一些。NICE 把短程动力治疗列为较轻抑郁可选的心理治疗之一。【指南】

正念与支持性：MBCT 与支持性心理治疗

MBCT 不是放松训练。它练的是在情绪刚开始下滑时，认出“我又在反刍了”，然后把注意力从想法里带出来。它最主要的证据在**预防复发**，尤其是三次以上发作、目前已经缓解的人；急性期症状很重时，它通常不是首选。【指南】

支持性心理治疗听起来最“普通”，但对急性期、刚出院、合并慢性病或认知功能下降的人很重要。它做的是稳住关系、减少混乱、协助现实问题，而不是挖根源。【临床经验】

频率、疗程与见效时间

- **频率**：多数个别治疗每周 1 次。稳定比密集更重要——每周固定出现，本身就是治疗的一部分。
- **时长**：每次约 45–60 分钟。首次会谈通常更长，用于评估。
- **疗程**：8–20 次是常见区间。指南描述的高强度 CBT 常是 16–20 次、历时 3–4 个月；12–20 次只是常见范围，不是标准答案。【指南】
- **团体**：MBCT 是固定的 8 周课程，不是“上到不想上为止”。
- **巩固**：症状缓解后，可以把频率从每周一次拉成两周一次、一月一次，用来巩固技能、预防复发。

关于见效时间，可以有一个大致预期：4–6 次之后，通常能看到一些具体变化——睡眠规律一点、出门次数多一点、回避少了、能把一件事说完。【临床经验】但“心情整体好起来”往往更晚，10 次以后才明显改善也很常见。如果 8–12 次后目标毫无移动，值得和治疗师一起复评：方法是否匹配、诊断是否需要重新看、有没有共病没被处理。

也要说另一面：心理治疗不是次数越多越好。没有目标、没有复评的长期谈话，容易变成昂贵的陪伴。

轻度可单用，中重度常联合药物

NICE 的分层用的是“较轻”和“较重”，不完全等于我们平时说的轻、中、重度，但大方向可以借用：

情况	心理治疗的位置	与药物的关系
较轻	可单独作为一线治疗	可以先不用药，4–8 周复评，无改善再讨论
中度	一线选择之一，也可与药物同时开始	联合通常优于单用其中一种
较重	常作为联合治疗的一部分	药物通常是基础，心理治疗并行
伴精神病性症状或高风险	不是主力	以药物和必要的物理治疗为主，稳定后再加心理治疗

联合治疗的研究结论比较一致：对中重度抑郁，药物加心理治疗的效果通常好于单用其中一种。【研究】【指南】原因不难理解——药物较快地减轻症状，让人有力气出门、做事、练习；心理治疗改善应对方式、减少回避、降低复发风险。两者不是替代关系。

两个常见错误。一个是“我要做心理治疗，所以把药停了”：减药停药要在医生指导下进行，突然停可能带来撤药反应和复发风险。另一个是“我在吃药，心理治疗没必要”：对反复发作、人际模式或思维方式明显卡住的人，心理治疗带来的复发预防是药物替代不了的。

怎么判断自己有没有在做“真正的心理治疗”

下面这份清单可以逐条对照。符合得越多，越可能是在做规范治疗。

- ☐ 开始前做过评估：问过症状、病程、既往治疗、风险
- ☐ 和你一起定过目标，而且写下来过
- ☐ 每次会谈有大致议程，不是想到哪说到哪
- ☐ 有家庭作业或练习，下次会回顾
- ☐ 治疗师解释过方法原理，你能说出“我们在练什么”
- ☐ 时间、时长、地点、费用固定，且事先说清
- ☐ 有保密说明，也说明了保密例外（自伤、伤人风险）
- ☐ 每隔一段时间复评进展（量表或目标回顾）
- ☐ 你可以直接说“我觉得这没用”，而不会被批评
- ☐ 不会要求你停药，也不会贬低你的医生
- ☐ 没有“保证治好”“包不复发”的承诺
- ☐ 边界清楚：没有私下频繁联系、借钱、送礼、暧昧

如果前六条大多不符合，值得考虑换一种形式或换一个人，不必先怪自己“不够配合”。

常见问题与容易踩的坑

“心理治疗就是劝我想开？” 不是。劝是单向的，治疗是双向的，而且治疗会要求你做事：记录、练习、实验、复盘。

“做心理治疗就不用吃药了吧？” 较轻和部分中度的人可能可以；中重度常常需要联合。是否用药由医生评估，“我在做心理治疗”不是自行停药的理由。

“做一两次就该有效果？” 前一两次多半是评估和建立关系。能感到“被听懂”已经有价值，但症状改善一般要看几周。

“越贵的治疗师越好？” 价格和效果没有稳定关系。受训背景、方法是否匹配、关系是否可信，比价格重要。

“一直做下去总没坏处？” 没有目标、没有复评的长期治疗，可能让人停在“被陪伴”里，也可能掩盖需要调整的诊断或用药问题。

家属常犯的错：替患者约好时间再通知、追问每次谈了什么、把治疗当成“修理”患者的工具。更有效的做法是负责接送和提醒、不追问内容，需要时自己也参加家庭会谈。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

出现以下情况，不要等到下次会谈

- 出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤：不要独处，立即呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。

- 治疗期间情绪明显恶化，连续多日几乎不进食、不睡，或无法照顾自己。
- 出现话多、睡得很少却不困、冲动消费、行为失控等转躁迹象。
- 治疗师出现越界行为：私下约会、借钱、要求你对治疗绝对保密、贬低你的医生、劝你停药。
- 规范治疗 8–12 次后目标毫无移动，或你开始怀疑“是不是我没救”。
- 创伤相关治疗中出现明显加重的闪回、解离或自伤冲动。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.2 认知行为治疗 CBT

> 很多人听说过 CBT，也大概知道它“跟想法有关”，但真做起来是什么样、一次会谈里发生什么、为什么总被布置作业，并不清楚。这一页讲认知模型怎么用、思维记录和行为实验具体怎么写、CBT 不是什么、做多久能见效，以及最常见的两个卡点：作业没做、想法找不到。读完你可以判断自己正在做的 CBT 是不是“真的在练”。

认知模型：事情不直接决定情绪

CBT 的起点是一句很朴素的话：**让你难受的，往往不是发生的事，而是你对这件事的解释。**用一条链子表示：

> 情境 → 想法 → 情绪 → 行为 →（结果反过来又强化了想法）

同一个情境，两种解释，会走出完全不同的路。给同事发消息，对方半天没回：

环节	解释 A	解释 B
想法	“他在忙，等下会回”	“他是不是讨厌我”
情绪	平静，有点着急	失落、焦虑、生气
行为	继续做自己的事	反复看手机，不敢再发，开始回避他
结果	第二天正常合作	对方觉得你冷淡，关系真的变远

解释 B 不是“事实”，是一个假设；但它带来的行为，最后真把关系推远了。这就是 CBT 关心的循环。

CBT 里常把想法分三层，从浅到深：

- **自动思维**：事情发生的一瞬间，脑子里自动蹦出来的那句话。“我搞砸了”“他们一定觉得我很蠢”。
- **中间信念**：规则和假设。“如果我出错，就会被看不起”“不能麻烦别人”。
- **核心信念**：关于自己、他人、世界的总判断。“我不够好”“别人靠不住”。

治疗通常从自动思维入手，因为最好抓；信念层面要等工作到中后段、有了工具再碰。

这里必须澄清一件事，否则很容易变成自责：**CBT 不认为抑郁是你“想错了”想出来的。**抑郁有生物学、躯体、社会多重原因，认知模型解释的是另一件事——抑郁一旦发生，那些消极解释会参与把低落**维持**下去。改变想法，是为了松开这个维持机制，不是追责。

一次会谈里发生什么

一次典型的 CBT 会谈约 45–50 分钟，结构相当固定：

1. **开头 5 分钟**：简短心境检查（这周 0–10 分打几分）、睡眠、用药、有没有风险。
2. **回顾作业**：上次布置的记录或练习，做了没有、发现了什么。这一段很重要，不是走过场。
3. **设定议程**：一起定 1–2 个议题。你也有发言权，可以要求“今天我想谈别的”。

4. **中段 25–30 分钟**：处理一个具体议题。可能是一条思维记录、一个行为实验的设计、一个决定的两难。
5. **结尾 10 分钟**：总结今天学到了什么、布置新作业、问你对这次会谈的反馈。

整个疗程大致分三段：

阶段	大致次数	主要工作
评估与目标	1–2 次	评估、风险、讲清模型、列出目标清单
技能训练	3–12 次	思维记录、行为实验、活动安排、解决问题
巩固与预防	最后 3–4 次	总结哪几件工具对你最有用，写复发应对卡，拉长间隔

你会发现它不像“聊到哪算哪”。但结构不等于僵化：如果你这周出了急事，议程可以改；如果你觉得某个练习没必要，也可以说出来，这本身就是治疗的一部分。

工具箱：思维记录、认知歪曲、行为实验、家庭作业

思维记录：把脑子里那句话抓出来

思维记录是 CBT 最核心的纸面工具，一张表五到七栏。第一次写通常要 20 分钟，写熟了 5 分钟。

栏目	写什么	例子
情境	何时、何地、和谁、发生了什么（只写事实）	周五会上，我的方案被否了
情绪	给情绪起名，并打分 0–100	羞耻 80，焦虑 60
自动思维	当时脑子里蹦出的原话，越原话越好	“我根本不适合这份工作”
证据	支持它的、反对它的，分开列	反对：上个月方案通过了两次
替代想法	更贴近事实的说法，不必“很积极”	“这次方案被否了，不代表我不适合”
结果	再给情绪打分，接下来做什么	羞耻降到 40，去问具体哪里不合适

几个要点。第一，在情绪最强烈的时刻写，事后再补容易失真。第二，一次只写一条，别想着一口气处理五个。第三，替代想法不需要“很阳光”，只需要**比原来更准确**；从“我是废物”到“我这次没做好”，已经是进步。

认知歪曲：一份“可能漏看了什么”的清单

认知歪曲指的是几种常见的、系统性偏离事实的思维方式。列出名字不是为了给想法判罪，而是提醒自己：这里可能还有别的信息没看到。

名称	长什么样	例子
全或无	只有满分和零分	“没做到最好就是失败”
以偏概全	一次经历推及全部	“他拒绝我一次，我这人没人会要”
心理过滤	只盯负面细节	十句表扬里只记住那一句批评
读心术	认定别人怎么想	“他没笑，肯定是对我有意见”
算命	把预测当结论	“面试肯定过不了，不用去了”

名称	长什么样	例子
灾难化	一路推到最坏结局	“出错就会被开除，然后全完了”
情绪化推理	把感觉当证据	“我觉得没希望，所以真的没希望”
应该式	用“必须”要求自己	“我必须一直坚强，不能让人看见我难受”

要提醒的是：**拿这张表骂自己“我又歪曲了”，是反效果。**它的用途是好奇，不是考核。

行为实验：去收集数据，而不是说服自己

思维记录是“在纸上检验”，行为实验是“在生活里检验”。它的关键区别是：不靠辩论，靠结果。

步骤大致是：

1. 写下一条具体、可检验的预测：“如果我拒绝同事的临时请求，他会觉得我不合作。”
2. 给相信程度打分（0–100）。
3. 设计一个**小、安全、本周能做**的实验，不要一次赌上工作和关系。
4. 记录真实发生了什么，包括对方的表情、原话、后续。
5. 重新给相信程度打分。
6. 写一句结论，哪怕只是“从 90 降到 70”，也算收获。

预测	实验	可能学到什么
“我说累，朋友就会觉得我敷衍”	对一次邀约说“这周太累，下周约”	对方通常只是回“好”，关系没有断
“一停下来就会崩”	周末半天不安排任何事	焦虑会升高，但会过去，人没崩

家庭作业：它是治疗的一半

CBT 的疗效很大程度来自会谈之间那六天。常见作业有：思维记录、活动安排、行为实验、渐进式暴露、阅读材料。

好的作业通常符合三个条件：具体、小（5–10 分钟能完成）、讲得清为什么做，而且布置前和你商量过。

CBT 不是什么

- **不是“正能量洗脑”**：不要求你每天对镜子说我很好，也不否认现实里确实有难处。
- **不是“你的病是你想出来的”**：抑郁有生物学基础，CBT 处理的是维持它的那部分。
- **不是只讲道理**：没有记录、没有练习、没有复盘，就只是上了几节心理学课。
- **不是“治标不治本”**：对复发预防有明确证据支持。【指南】
- **不是几次就能“根治”**：它教的是可带走的技能，不是一次性清除。

- **不是药物的替代品**：中重度抑郁常常需要药物与 CBT 并行。【指南】

做多久能见效

12–20 次是常见范围，但**这只是常见范围，不是标准答案**。指南描述的高强度 CBT 通常是 16–20 次、历时 3–4 个月。【指南】

一个可以参考的时间线：

- **4–6 次**：能认出自动思维，开始会写记录，知道自己在哪些时刻最容易下滑。
- **6–12 次**：能检验想法，活动量上升，回避减少，遇到事有第二反应。
- **12–20 次**：巩固技能，处理信念层面，做复发预防计划。

判断有没有效，别只看“我还难不难受”。更可靠的三个指标是：**功能**（能不能上班、出门、见人）、**趋势**（量表分数几周内的走向）、**技能**（遇到低落时你手上有没有工具）。

也有人 8 次就够了（问题比较局限），有人需要 30 次以上（慢性化、共病、人格层面的议题）。这不说明谁更“严重”，只说明问题的大小不同。

如果你正准备开始 CBT，可以先用这份清单问问治疗师：

- ☐ 我们打算先处理哪个目标，大概几次复评一次
- ☐ 每次会不会布置作业，作业占多少时间
- ☐ 如果某次没做作业，我们怎么处理
- ☐ 如果做了 8 次没变化，你会怎么调整
- ☐ 出现自杀念头时，我该按什么顺序联系谁

卡住的常见情况：作业没做、想法找不到

作业没做

这是最常见的，也非常正常。常见原因有几类：作业太大（“每天写三条”对已经没力气的人就是负担）、太模糊（“觉察一下自己的想法”无从下手）、忘了、怕写了更难受、觉得没用。

对应处理也不复杂：把作业缩到 5 分钟能完成；会谈里当场写半条，让治疗师看着你写；用手机闹钟或和家属互相提醒；把“没做”当成信息带回会谈，而不是当成失败藏起来。**一个能坚持的小作业，胜过一个完不成的完美计划。**

想法找不到

很多人坐下准备记录，发现脑子一片空白，只记得“很难受”。这通常不是你不会，而是缺一个入口。可以试这些：

- **从身体进**：当时胸口是什么感觉、肩膀是不是绷着，再问“这个感觉配的是哪句话”。
- **从行为倒推**：我当时做了什么、没做什么？逃避的背后通常有一句判断。

- **回放具体镜头**：不要想“这周”，只想“周三下午三点他说那句话的那十秒”。
- **用第三人称**：如果是朋友遇到这件事，你觉得他心里会想什么？
- **往下问三层**：这件事对你意味着什么？那又意味着什么？最怕的到底是什么？

还有两种常见的卡点。一种是“我知道了但做不到”——知道和熟练是两件事，CBT 靠重复，不靠顿悟。另一种是“越写越难受”——说明节奏太快或碰到敏感区域，要告诉治疗师，必要时放慢或换方式；如果有创伤经历，更要提前说明。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

出现以下情况，不要等到下次会谈

- 出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤：不要独处，立即呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 做行为实验或暴露练习时情绪失控、出现自伤冲动，先停下，联系治疗师和医生。
- 情绪明显恶化，连续多日几乎不睡、不吃，或无法照顾自己。
- 出现话多、睡得很少却不困、冲动消费等转躁迹象，尽快联系精神科医生。
- 写记录时反复出现强烈闪回、解离、身体麻木，暂停练习并告知治疗师。
- 规范练习 8–12 次后功能毫无改善，需要重新评估诊断、共病和方案。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.3 行为激活

> 抑郁最磨人的地方之一，是“什么都不想做”。很多人等着“有心情了再动”，结果越等越动不了。行为激活（Behavioural Activation，简称 BA）反过来：先把行动排进日程，让情绪慢慢跟上。这一页讲它的原理、四个步骤——活动监测、分级任务、价值清单、奖励与复盘——以及它和 CBT 的关系、适合谁、常见卡点。

抑郁把“做事”和“感觉好”的顺序弄反了

先看一个正常的小循环：

> 想做点什么 → 去做 → 过程中有愉快感或“我做到了”的感觉 → 更愿意做下一次

抑郁时，这个循环断了，而且断成一个向下的螺旋：

> 没劲、没兴趣 → 不做 → 生活里的愉快感和掌控感变少 → 更没劲、更没兴趣 → 更不做

这个循环在短期内是“有效”的：躺着确实比出门轻松，推掉聚会确实比硬撑舒服。问题在于代价延迟发生——一个月后，生活半径变小了，能做的事变少了，人也更确信“我不行了”。

行为激活的主张只有一句：**情绪没法靠意志直接调，但行为可以安排。**它不要求你先开心起来再行动，而是先把行动放回去，让情绪有机会被行动带动。这不是“逼自己开心”，也不是“假装正常”，而是重新接触那些本来会带来愉快感和掌控感的活动。

行为激活关心两类感受：

- **愉快感**：这件事本身让我舒服、有趣、放松。
- **掌控感**：做完这件事让我觉得“我还行”“我完成了一件事”。

抑郁时两者都会下降，但通常**掌控感恢复得早一些**。所以刚开始做的时候，“做完了”比“做得开心”更值得记。

它适合谁？主要是这几类人：

- 快感缺失明显：以前喜欢的事现在没感觉，什么都提不起兴趣。
- 乏力、起床困难、白天大部分时间躺着或刷手机。
- 退缩、回避社交、拖延到事情堆积。
- 说不出具体消极想法，做 CBT 的思维记录很吃力。
- 老年、青少年、产后人群（需要按情况调整强度）。

证据方面，行为激活既被视为 CBT 的核心有效成分，也被作为独立疗法验证过；NICE 把行为激活列为较轻抑郁可选的心理治疗之一，较重抑郁的指南推荐里更常点名 CBT 与 IPT。【指南】【研究】

第一步：活动监测，先看清一周是怎么过的

行为激活的第一件事不是“改”，是“看”。在不改变任何安排的前提下，记录 3–7 天，每小时或每半天记一格。

时间	活动	愉快感（0–10）	掌控感（0–10）
周一上午	躺着刷手机	2	1
周一下午	遛狗 20 分钟	6	4
周一晚上	给家人做了顿饭	5	7
周二上午	请假没出门	1	0

记录时有三个要点：

1. **只记事实，不评价。**不写“又浪费一天”，只写“上午在床上”。
2. **“什么都没做”也要记。**空白本身就是重要信息。
3. **分数凭第一感觉给。**不用反复琢磨，0–10 分足够。

记几天之后，通常能看出三件事：哪些活动之后分数明显高；一天里情绪最低的是哪一段；以及**哪些预期是错的**——以为会开心的刷手机只有 2 分，以为没意思的散步有 6 分。小 A 在记录一周后发现，自己唯一稳定在 6 分以上的时段是遛狗和做饭，而这两件事恰好是他生病后最先砍掉的。这个发现比任何劝说都有说服力。

第二步：分级任务，把“整理房间”拆到能开始

抑郁时最典型的一句话是“我知道该做，但我做不动”。问题往往不在意愿，而在任务颗粒度太大。“整理房间”这四个字，对一个精力只剩两成的人来说，等于“搬一座山”。

解决办法是把它拆到**小到不可能失败**。

想做到的事	从易到难的拆解
整理房间	把桌上的杯子拿到厨房 → 扔掉明显垃圾 → 衣服放进筐 → 擦桌面 → 铺床
恢复运动	穿好运动鞋在门口站 2 分钟 → 楼下走 5 分钟 → 走 10 分钟 → 快走 20 分钟
重新联系朋友	发一条“最近怎么样” → 回复对方的消息 → 约一次 20 分钟的咖啡

几条原则：

- **宁可小，不要大。**第一步最好是“五分钟能完成、几乎不可能失败”的动作。
- **完成比完美重要。**做到第三步就停下，也算完成，不扣分。
- **一次只加一档。**这周走 5 分钟，下周再走 10 分钟，别跳级。
- **做不到就退一档，不是放弃。**退档是调整参数，不是失败。

第三步：价值清单，给自己一个不只是“应该”的理由

只靠“医生说要多活动”，很难坚持。行为激活会用“价值”来提供理由。这里的价值指的是：**你想成为什么样的人、你看重什么**，不是必须达成的目标，也不是此刻的心情。

领域	可以问自己的一句话
关系	我希望在家人、朋友眼里是个什么样的人
工作与学习	我看重的是能力、稳定、创造，还是帮助别人
身体健康	我希望怎么对待自己的身体
兴趣与意义	什么事让我觉得活着不只是熬过去
自我照顾	我允许自己怎么被照顾

做法很简单：从上面选 3 个你在意的领域，各写一句“我在这个方向上想成为什么样的人”，再各写一个**这周能做的最小动作**。比如“我想做一个还愿意和朋友联系的人”，对应的动作是“周三给老同学发一条消息”。

价值清单的作用，是在“想不想”这个信号坏掉的时候，提供一个替代的决策依据。心情说“不想动”，价值说“这件事对我重要，先做五分钟”。

要小心的是，别把价值变成新的考核表。“我想做个好妈妈”很容易滑成“我必须每天陪孩子读书两小时”，然后又变成一次失败。**价值是方向，不是 KPI。**

第四步：奖励与复盘，让大脑重新学会“这件事值得”

行为激活要对抗的是一个已经学会“做什么都没用”的系统，所以“做完之后的反馈”很关键。

- **即时奖励**：完成之后给自己一点具体的小回报——一杯喜欢的饮料、十分钟音乐、在记录本上打一个勾。奖励要小、要当下、不要太依赖别人配合。
- **记“做到了”清单**：每天写下完成了什么，哪怕只是“洗了澡”“回了消息”。不要记“没做到”清单。
- **每周复盘 15 分钟**：这周做了哪些安排、愉快感和掌控感各几分、下周加什么减什么。可以自己复盘，也可以带去和治疗师一起看。

复盘的目的不是审判，是调参。分数低不代表你不行，可能只是这件事不适合现在的你，或者安排得太满。

一页可以照着做的清单：

- ☐ 连续记录 3 天活动，只记事实，不打分评价自己
- ☐ 圈出愉快感或掌控感最高的两件事
- ☐ 选一个在意的领域，写一句“我想成为什么样的人”
- ☐ 把这个方向拆成三步，第一步控制在 5 分钟内
- ☐ 本周只做第一步，写清具体哪天、几点、和谁

- ☐ 完成后打勾，给自己一个具体的小奖励
- ☐ 周末 15 分钟复盘，决定下周加一档还是减一档

行为激活和 CBT 是什么关系，它适合谁

行为激活本来就是 CBT 的一个组成部分——CBT 里的“活动安排”就是它。后来研究者发现，单把这一部分拿出来做，效果也不错，而且更简单、更容易培训，于是它成了独立疗法。

维度	行为激活	完整 CBT
主要改动的地方	日常行为与生活结构	行为加想法、信念
门槛	较低，不需要说清想法	需要一定反思和书写能力
典型疗程	常 10–20 次	常 12–20 次
形式	个别、团体、电话、自助都可行	多为个别，也有团体

两者不是“低配”和“高配”。对精力很差、注意力维持不了、说不出具体想法的人，行为激活往往比一上来就做思维记录更现实；对反复被某种信念困住的人，完整 CBT 更对症。很多人是先做行为激活，状态回升后再加认知部分。

常见困难与容易踩的坑

“我没心情做。” 这正是行为激活要处理的核心。心情是行动的结果之一，不是行动的前提。先从五分钟开始，不用等到想动。

“做了也不开心。” 这很常见，尤其是前两三周。此时把评价标准从“开不开心”换成“有没有完成”。愉快感的恢复通常比掌控感慢。

“计划排太满，又失败了。” 失败几乎总是因为排太多。把计划砍一半，砍到你觉得“这也太少了”为止。

“是家人逼我做的。” 别人安排的日程很难坚持。哪怕动作一样，也要由你自己选、自己定时间。家属更适合做提醒和陪伴，不适合做监工。

“这是不是自欺欺人？” 不是。自欺是假装问题不存在；行为激活是承认情绪还在，同时不让生活彻底停摆。

“做完更累了。” 先降强度，再看有没有躯体原因——贫血、甲状腺问题、睡眠呼吸暂停、药物副作用都可能表现为极度乏力，值得和医生讨论。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

出现以下情况，不要只靠自己调整活动量

- 出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤：不要独处，立即呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。

- 严重到连续多日起不了床、拒绝进食进水，需要尽快精神科评估，必要时住院。
- 稍微活动就胸痛、心悸明显、晕厥或呼吸困难，立即急诊，不要当成“缺乏锻炼”。
- 出现话多、睡得很少却不困、活动量突然暴增且停不下来，警惕转躁，尽快联系精神科医生。
- 规律练习 4–6 周，活动量和情绪都毫无变化，需要复评诊断、共病与用药方案。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.4 人际心理治疗 IPT

> 有些人的抑郁是和一段关系的变化一起到来的：亲人去世、孩子出生、工作调动、离婚、退休、查出病。人际心理治疗（Interpersonal Psychotherapy，简称 IPT）就是为这类情况设计的。这一页讲它的四个焦点、12–16 次的结构、适合谁、和 CBT 有什么不同，以及几个常见的误解。

IPT 的基本假设：抑郁发生在关系里

IPT 由 Klerman 和 Weissman 等人在上世纪七十年代发展出来，最初用于成人门诊抑郁，有完整手册、有时间限制、只聚焦当下。

它的假设不是“人际问题造成了抑郁”，而是更温和的一层：**抑郁往往发生在人际关系变化之中或之后，而人际状况会影响抑郁往哪个方向走。**关系持续恶化，抑郁容易拖长；关系有所修复，情绪也常跟着松动。

IPT 有一个很实用的开场概念，叫“病人角色”。用大白话说：治疗开始时会明确告诉你，**你现在是一名需要休养的病人，暂时可以降低对自己的要求，把“康复”当成眼下最重要的任务**。这不是纵容，而是把责任暂时卸下来——很多人抑郁加重，恰恰是因为一边病着一边逼自己“正常上班、正常带娃、正常笑”。

同时要说清楚 IPT 不做什么：它不挖童年，不做长期人格工作，也不要求你分析梦。它把时间花在“最近这段时间，你和谁之间发生了什么”。

四个焦点：悲伤、角色转换、人际冲突、社交困难

IPT 会在开始阶段和你一起，从下面四类问题里选出**一个**作为本次治疗的主焦点。

焦点	典型情境	工作重点
悲伤与丧失	亲人去世、流产、离婚、失去健康或工作	把没走完的哀悼走下去，重建兴趣和关系
角色转换	升学、换工作、退休、生育、搬家、患病	告别旧角色，学新角色要的技能和期待
人际冲突	与伴侣、父母、同事期待不一致并僵住	看清分歧到底在哪，能不能重新协商
社交困难	长期孤立、难建立关系、几乎没有可依靠的人	检视关系模式，创造练习机会

悲伤不等于“难过”。IPT 关心的是哀悼被卡住的情况：有人一年过去仍不能提逝者的名字，有人完全投入工作不给自己任何余地，有人反复自责“如果我当时……”。目标不是让你“放下”，而是让哀悼能继续流动，同时把生活一点点接回来。

角色转换的关键是“旧角色已经结束，新角色还没接上”的那段悬空期。退休的人失去“某总”“某工”的身份，新手妈妈失去原来的作息和自由，刚确诊的人失去“健康人”的自我认知。IPT 会帮你把“我失去了什么”说清楚，再谈“新角色需要什么”。

人际冲突不是“谁对谁错”的审判。治疗会看：双方各自期待什么、分歧具体卡在哪一句话、有没有没被说出口的诉求。很多争吵表面是“谁接孩子”，底下是“你根本不在乎我”。

社交困难的原文是 interpersonal deficits，直译“人际缺陷”，听起来像在说你有毛病。它的实际意思要平和得多：**长期缺少稳定的关系，也缺少练习沟通的机会**，于是遇到人更容易退缩、更容易觉得“没什么可说的”。这不是人格判决，是可以练的。

IPT 的结构与疗程

IPT 的经典设计是 12–16 次、每周一次、每次约 50 分钟。整个疗程分三段：

阶段	大致次数	主要工作
开始	1–3 次	评估抑郁严重度与风险、做人际清单、确定焦点
中间	4–12 次	围绕焦点工作：沟通分析、角色扮演、决策分析
结束	最后 3–4 次	处理分离、总结学到的东西、写复发预防计划

几个核心工具：

- **人际清单**：把重要的人、关系的变化、谁让你好受谁让你难受，一张纸画出来。很多人第一次看到自己的关系图会吃惊——原来“能说话的人”只有一两个。
- **沟通分析**：挑一段具体的对话，逐句看哪里断了：你想要什么、实际说了什么、对方听到的是什么。
- **角色扮演**：在会谈里把难说的话先演一遍，再去现实里说。
- **决策分析**：面对“要不要换工作”“要不要分开”这类决定，列出选项和后果，而不是替你做决定。

对反复发作的人，还有**维持性 IPT**：急性期结束后，把频率拉长到每月一次，持续数月甚至更久，用来巩固关系层面的改变、降低复发风险。【研究】

开始之前，可以先想清楚几件事：

- ☐ 我最想改善的是哪一段关系，或者哪一个角色
- ☐ 这段关系里，最近一次让我难受的具体场景是什么
- ☐ 我希望对方做什么不同的事，我自己能做什么不同的事
- ☐ 我愿意在会谈里做角色扮演吗（不愿意也可以直接说）
- ☐ 我现在的用药情况，需要让治疗师知道

适合什么情况、不适合什么情况

比较适合 IPT 的情况：

- 抑郁与明确的人际事件同时发生：丧亲、离婚、产后、退休、迁居、查出重病。
- 你清楚“是某段关系或某个角色让我变成这样”，也愿意谈关系。
- 青少年：IPT-A 是改编版，把焦点放在同伴、学校和家庭，通常次数更少。【研究】
- 老年人：退休、丧偶、子女离家、照护负担，都是典型焦点。
- 与人际相关的产后抑郁。【指南】
- 想和中度以上的药物治疗联合，但不想做认知记录的人。

需要谨慎或调整的情况：

- 有精神病性症状或躁狂发作：先以药物和必要的物理治疗为主。
- 严重物质使用：通常需要先处理或同步处理。
- 当前正处于家暴、虐待、控制关系中：安全优先，IPT 不是处理人身安全的第一步。
- 以长期人格议题为主诉：12–16 次可能不够，需要更长程的治疗。
- 完全不想谈关系、只想谈症状的人：不必勉强，CBT 或行为激活可能更合。

还要说一句：IPT 不要求你“会说话”“情商高”。内向、嘴笨、社交少的人同样能做，治疗里本来就有练习。

IPT 和 CBT 的区别

两种都是结构化、有时限、有作业的短程治疗，差别在“从哪儿切进去”。

维度	IPT	CBT
主要焦点	关系、角色、沟通	想法、解释、行为
假设	人际情境触发并维持抑郁	认知与回避维持抑郁
核心工具	人际清单、沟通分析、角色扮演	思维记录、行为实验
典型作业	观察和练习一次真实沟通	记录想法、完成一次实验
疗程	常 12–16 次	常 12–20 次

相同的地方也不少：都有评估和风险筛查，都有明确目标，都要求你在会谈之外做事，都在最后几次做复发预防。

至于哪个更好，目前没有可靠证据说某一种普遍优于另一种。【研究】更有意义的问题是：你的困难更像“想法卡住”还是“关系卡住”？治疗师对哪种方法更熟练？你能不能接受那种作业方式？这三点的匹配度，往往比疗法名字更影响结果。

常见误解

“IPT 就是找人倒苦水。” 它有焦点、有结构、有练习。倒苦水没有议程，IPT 每次会谈都围绕同一个焦点推进。

“IPT 只谈关系，不管症状。” 开始阶段会评估症状、严重度、风险，也会问用药。关系是主战场，不是唯一战场。

“只选一个焦点太窄了。” 12–16 次的长度只够做一件事。聚焦不是否认其他问题，而是先把最影响你的那一处撬动；一处松动，常常带动其他。

“社交困难是在说我人格有问题。” 不是。它描述的是“关系少、练习少”的现状，不是你的本质。

“IPT 不处理童年，所以治不好。” 童年当然重要，但 IPT 明确选择把有限的次数放在当下。想处理早年经历，可以之后再做长程治疗。

“关系问题解决了，抑郁就好了。” 抑郁有生物学因素。轻中度可能靠心理治疗改善，中重度通常需要联合药物。【指南】

“IPT 是女性才适合的疗法。” 没有依据。它最早的研究对象就包含男女两性。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

出现以下情况，不要等到下次会谈

- 出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤：不要独处，立即呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 正遭受家暴、威胁、跟踪或人身控制：安全优先，拨打 110，并联系当地妇联或庇护机构，再谈治疗。
- 丧亲后长期拒绝进食进水、无法入睡，或出现持续的幻听、被控制感，需要尽快精神科评估。
- 情绪明显恶化，或出现话多、睡得很少却不困、冲动行为等转躁迹象。
- 一个完整疗程（约 12–16 次）结束后仍无改善，需要复评诊断、共病与用药。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.5 正念认知疗法 MBCT

> 正念认知疗法（Mindfulness-Based Cognitive Therapy，简称 MBCT）最常被问到的是三个问题：8 周到底在练什么？为什么它能防复发？我这种情况能不能做？这一页按这三个问题讲清楚，也说明它不适合谁、练习时会遇到什么困难。它不是放松课，也不是“停药替代方案”。

MBCT 从哪里来，想解决什么问题

MBCT 诞生于上世纪九十年代，由 Segal、Williams、Teasdale 三位学者把正念减压课程（MBSR）和认知治疗结合起来，专门针对一件事：**抑郁反复发作**。

他们注意到一个现象。第一次发作时，抑郁往往由某件具体的事触发；但发作次数越多，触发它所需的条件越少。到后来，可能只是一晚没睡好、一句无心的话，就能启动一整套熟悉的东西：低落、自责、“我怎么又这样”、“我永远好不了”。这条通路被走得越熟，复发越容易。

所以 MBCT 的目标不是“让你开心”，而是**在你和低落之间留出一点空隙**：早一点认出来，少一点被卷走，不让一次低落滚成一次发作。

8 周课程在练什么

标准形式是团体课程：每周 1 次、每次约 2 小时，共 8 周，中间或结尾有一次较长的静修日；每天还有半小时左右的家庭练习。班级通常由一位受过专门训练的老师带领，有讲解、有练习、有分享。

八周的内容大致是这样一条线：

周次	主题	在练什么
第 1 周	自动导航	注意当下，发现“人在这里，心在别处”
第 2 周	活在自己的头脑里	区分“直接感受”和“对感受的解释”
第 3 周	聚拢散乱的心	正念呼吸，练习把注意力带回
第 4 周	认出厌恶	看见“我不想要这个”如何加重痛苦
第 5 周	允许如其所是	不急着改变，先与不适共处
第 6 周	想法只是想法	去中心化，看见想法不等于事实
第 7 周	怎样最好地照顾自己	把觉察带进日常，识别耗竭信号
第 8 周	维持与扩展	写下自己的复发预防计划

注意第 5 周。很多人以为正念就是“把不舒服赶走”，其实那一周练的恰恰相反：先不赶，先允许它在。这不是认命，而是发现“对抗本身也在消耗你”。

三个核心练习：正念呼吸、身体扫描、去中心化

正念呼吸

坐下来，把注意力放在呼吸带来的身体感觉上——鼻尖的气流、胸口的起伏、腹部的胀落。不用刻意呼吸得深，也不用数到十。

它唯一的技术要点是：**走神了，发现走神，带回来。**这个“发现—带回”的动作本身就是练习。一次坐十分钟走神二十次，只要带回来二十次，就是二十分钟的练习。走神不是失败，没发现才是。

身体扫描

躺下或坐着，把注意力从脚趾开始，一寸一寸移到头顶，感受每个部位当下的感觉——酸、麻、热、紧，或者“什么都感觉不到”。

要澄清两个误会。第一，它**不是放松训练**，目标不是让你睡着或舒服，而是练习“注意到”，哪怕注意到的是难受。第二，犯困、烦躁、想动、觉得无聊，都是常见反应，不是练错了。

身体扫描对某些人不合适：有创伤史、容易解离、对身体感觉特别警觉的人，闭眼静躺可能引发不适。这种情况要提前告诉老师，可以睁眼、只做手和脚、缩短时间，或者换成其他练习。

去中心化

这是 MBCT 最关键的技能。对比一下两句话：

- “我不行。”（想法就是事实，人被吞没）
- “我注意到，有一个‘我不行’的想法出现了。”（想法是心里发生的一件事）

第二句就是去中心化，也叫认知解离。它不否认想法的内容，也不强迫你反驳它，只是把你和想法之间拉开一点距离。距离一出现，你就有得选了：可以继续想，也可以先去做别的。

课程里还有一个很实用的小工具，叫“三分钟呼吸空间”：一分钟觉察现在有什么，一分钟把注意力收到呼吸上，一分钟扩展到全身。适合在情绪刚起来、没法安静坐下的时候用。

为什么能预防复发，尤其对三次以上发作的人

复发最常见的推手是**反刍**：情绪一低落，就开始追问“为什么是我”“我是不是永远这样”“我哪里做错了”。这些追问看起来像在解决问题，实际上是在反复给低落加燃料。

MBCT 的假设是：只要能在反刍刚启动时认出来——“哦，又开始了”——就有机会不跟着它走。不是把低落消灭，而是不让低落自动升级成一套完整的故事。

证据方面可以这样说：

- 对有过**3 次及以上**发作、目前状况较好的人，MBCT 能降低复发风险，NICE 明确推荐。【指南】
- 对有 2 次发作的人，证据相对弱一些，获益不如三次以上明确。【研究】

- 与维持用药的比较：有研究显示，在医生评估可以安全减药的人中，MBCT 配合有计划地减药，与继续服药相比复发率相近。【研究】但**这不等于可以自己停药**，减药必须在医生指导下进行。
- 对**当前正处于急性发作**的人，MBCT 不是一线选择，效果不如 CBT 或行为激活直接。【指南】
- 近年一些分析显示，MBCT 的实际效果可能小于早期研究，个体差异较大。【待验证】

一句话总结：MBCT 是**缓解期的防复发工具**，不是急性期的灭火器。

不适合谁

这一节很重要，因为“正念有益”常被说成万能。

- **当前急性重度发作**：注意力维持不了几分钟，坐下反而更焦虑、更自责。
- **有明确自杀计划或近期自伤**：先处理风险，正念不是危机干预。
- **解离、创伤后闪回未稳定**：闭眼静坐、身体扫描可能触发症状，需要先做稳定化工作。
- **有精神病性症状或处于躁狂期**。
- **严重躯体疾病**导致无法静坐或静躺。
- **把 MBCT 当成停药工具**：这是最常见的误用。
- **期待“被治疗”、不打算每天练习的人**：只上课不练，效果非常有限。
- **童年创伤史者**：现有研究结果不一致，有人获益，有人不适，需要个案评估。【待验证】

决定报名之前，可以先问自己，也问机构：

- ☐ 我现在是缓解期，还是正在发作（发作期优先考虑别的治疗）
- ☐ 我每周能固定留出 2 小时上课，加每天半小时练习吗
- ☐ 带课老师受过 MBCT 或 MBSR 的系统师资训练吗，有没有督导
- ☐ 课上有人出现强烈情绪反应时，老师会怎么处理
- ☐ 我有没有创伤史或解离经历，需要提前说明吗
- ☐ 我是否在服药，减药计划是否已和医生讨论过

练习常见困难

“静不下来，越坐越焦虑。” 很常见。把时间缩到 3 分钟，睁着眼，或者改成走路时注意脚底。焦虑升高本身也可以是观察对象，但不必硬扛。

“一坐下来就睡着。” 多半是睡眠债太多。改成白天、坐姿、开窗，或者先做身体活动再坐。睡着了不算失败，只是需要调整条件。

“没时间练。” 家庭练习不必都是正式静坐。吃饭时注意味道，走路时注意脚感，洗澡时注意水温，都算。但正式练习仍建议保留，哪怕每天十分钟。

“我总觉得自己做得不对。” 正念没有“做得对”。唯一的评判标准是：你有没有注意到当下正在发生什么。带着“我做得不对”的念头坐完十分钟，也是练习。

“身体扫描让我不舒服，甚至想起一些事。” 立刻睁眼、坐起来、只做手部或脚部，必要时停止，并告诉老师。不要为了“坚持”硬撑。

“听别人分享，我更焦虑了。” 团体里容易比较。可以只听不说，也可以课后和老师单独谈。

“上完 8 周，好像没什么变化。” 变化常常在结束后几个月才显出来，尤其是复发的时候。也可能这门课不适合你，这不算你的失败。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

出现以下情况，不要自己扛着继续练

- 练习中反复出现强烈闪回、解离、身体麻木或自伤冲动：暂停练习，联系老师和精神科医生。
- 出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤：不要独处，立即呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。
- 情绪持续恶化，连续多日无法起床、进食、入睡。
- 出现话多、睡得很少却不困、冲动行为等转躁迹象。
- 想减药或停药：先找开药医生评估，不要用“我在练正念”作为自行减药的理由。
- 出现幻听、被控制感、思维紊乱，尽快精神科就诊。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

3.6 其他疗法与如何找治疗师

> 除了 CBT、行为激活、IPT、MBCT，还有几类常被问到的治疗：ACT、短程动力、支持性心理治疗、家庭与伴侣治疗。这一页先简单介绍它们，再把重点放在更实际的问题上：谁能算合格的治疗师、频率和设置怎么看、怎么判断这个人是否适合你、哪些行为是明确的红旗，以及为什么换治疗师不是背叛。

先认识另外四种疗法

疗法	核心在做什么	更适合谁	大致疗程
接纳承诺疗法（ACT）	不跟想法辩论，练习接纳体验、按价值行动	长期与想法纠缠、反复回避的人	常 8–16 次
短程动力治疗（STPP）	看重复的关系模式和被回避的情绪	问题反复出现、想理解“为什么总这样”	十几次到几十次
支持性心理治疗	稳住关系与情绪，协助现实应对	急性期、老年、合并躯体疾病	频率弹性大
家庭 / 伴侣治疗	把抑郁放回关系里处理	关系冲突明显、青少年、照护负担重	视情况而定

接纳承诺疗法（ACT）

ACT 属于“第三代行为疗法”，和 CBT 是亲戚，但着力点不同。CBT 会去检验“我不行”这个想法是否准确；ACT 不太争论内容，而是练两件事：**接纳**（不再花力气赶走不舒服的体验）和**按价值行动**（即使难受，也朝在意的事情走一步）。

它常被概括成六个过程：接纳、认知解离、关注当下、以己为景、澄清价值、承诺行动。听起来抽象，落到操作上很像这样：注意到“我又在跟自己讲道理了”，把这句话放到一边，然后问“如果这次不逃避，我会做什么”。

ACT 在抑郁中有随机对照研究支持，但多数指南还没有把它列为一线的首选心理治疗，证据积累不如 CBT 厚。【研究】它常被用在多次治疗无效、慢性化、以及“越想解决越陷进去”的人身上。

要澄清一点：ACT 里的“接纳”不是认命，也不是放弃治疗。它接纳的是**此刻的感受已经在了**，不接纳的是**让感受决定你接下来做什么**。

短程动力治疗（STPP）

动力取向的治疗关注那些反复出现却说不清的模式：为什么总在关系变近时推开对方，为什么被批评时立刻道歉，为什么明明想要却先拒绝。它假设这些模式与早期经历有关，并且在治疗关系里会重演——治疗师会把这些“重演”指出来，和你一起看。

短程动力治疗通常有明确次数（十几次到几十次）、有焦点、有结束日期，不是“做到想停为止”。NICE 把短程动力治疗列为较轻抑郁可选的心理治疗之一。【指南】

它适合想理解“我为什么会变成这样”、问题反复出现、对纯技能训练不满足的人。它不承诺“挖出童年就好了”，也不会要求你相信某种解释——解释要能对上你的体验才有用。

支持性心理治疗

支持性心理治疗听起来最普通，但它在几个场景里不可替代：急性期症状重、刚出院、合并严重躯体疾病、认知功能下降、暂时做不了结构化治疗的人。

它做的是：稳定而持续的关系、情绪上的承接、现实问题的协助、鼓励按医嘱治疗。它不深挖童年，也不做系统的技能训练。这不等于“低配”——对某些人，先能稳定地活下来、按时复诊，就是最重要的目标。它常与药物联合使用。【临床经验】

家庭与伴侣治疗

抑郁会改变关系：人变得易怒、沉默、拒绝外出，伴侣和父母容易感到被推开，于是加紧追问或干脆回避，关系进一步紧张。家庭和伴侣治疗把这一环纳入工作。

- **伴侣治疗**：适合关系冲突明显、抑郁与关系问题互相加重的情况。研究显示，对这类人群，伴侣治疗对抑郁和关系满意度都有帮助。【研究】
- **家庭治疗**：常用于青少年抑郁，也用于照护负担重的家庭。重点是调整沟通方式与边界，不是追究谁的责任。

有一个例外必须说清：**如果关系中存在家暴、威胁或人身控制，不做伴侣联合治疗。**安全优先，先分别处理，必要时报警。

资质与受训背景：谁是合格的治疗师

在中国，能提供心理服务的人有好几类，权限不同。

身份	能做什么	不能做什么
精神科医师	诊断、开药、做心理治疗	——
心理治疗师（卫生系统职称）	在医疗机构内开展心理治疗	不能开药
心理咨询师	一般心理困扰的咨询	不得从事心理治疗或精神障碍的诊断、治疗
学校心理老师、社工	支持、筛查、转介	不能诊断、不能治疗

需要知道一个背景：2017 年以后，人力资源社会保障部不再统一组织心理咨询师职业资格鉴定，市面上的证书种类很多，培训时长和考核标准差异很大。**一张证书不能说明水平**，更不能说明他能治抑郁症。

按《中华人民共和国精神卫生法》，心理咨询人员不得从事心理治疗或者精神障碍的诊断、治疗；发现来访者可能患有精神障碍的，应当建议其到医疗机构就诊。也就是说，**确诊抑郁症之后的“心理治疗”，应当在医疗机构内、由有相应资质的人提供**。

挑选时，比头衔更值得看的是这几样：

- 有没有系统的、为期数月以上的受训经历（不是三五天的培训班）。
- 有没有接受过督导，督导是谁、多久一次。
- 有没有自己的被治疗经历（很多流派要求）。
- 在什么机构执业，出了危机能不能转诊。
- 愿不愿意主动说明自己的方法、限制和不擅长的情况。

频率、费用与“设置”

频率：多数治疗每周 1 次，固定在同一天、同一时间。稳定比密集重要——每周固定出现，本身就是安全感的来源。

时长：每次约 45 - 60 分钟。准时开始、准时结束，不是冷漠，而是让会谈有边界。

费用：因城市、机构性质（公立医院、私立机构、个人执业）和治疗师资历差异很大，从公立医院心理治疗门诊到私人执业，跨度可能相当大。这里不写具体数字，因为写出来很快就会过时，也容易误导。可以问清楚：怎么计费、多久付一次、请假或取消怎么算、有没有低价号或团体形式。

设置指那些看起来琐碎、其实很重要的约定：固定时间地点、费用与取消规则、保密范围与例外（自伤、伤人风险、依法报告的情形）、治疗师休假时怎么办、危机时怎么联系。**一个愿意在开始就把这些说清楚的人，通常更可靠。**

远程治疗：视频形式对轻中度抑郁有研究支持，也方便异地和行动困难的人。【研究】但要考虑隐私（有没有独立空间）、网络稳定，以及出现危机时怎么办。风险较高的人，通常更适合线下。

怎么判断治疗师是否合适

匹配度不是玄学，可以看这些具体信号：

- ☐ 3 - 5 次之后，你能说出“我们在做什么、为什么这样做”
- ☐ 你感到被听懂，而不是被评价、被教育
- ☐ 你可以说“不”“我不想谈这个”，对方不会生气或施压
- ☐ 时间稳定，准时开始和结束
- ☐ 对方会主动问睡眠、用药、风险，而不只是听你讲情绪
- ☐ 保密范围和例外，一开始就讲清楚了
- ☐ 你愿意再去下一次，而不是每次出门都后悔
- ☐ 如果是家庭治疗，家属也感到被尊重，而不是被审问

前 3 - 5 次可以看作“试用期”。不匹配很常见，**不匹配不等于你有问题**，也不等于治疗没用——可能只是方法和人不搭。

不靠谱治疗师的红旗

以下行为出现任何一条，都值得停下来认真对待：

- ☐ 承诺“包治”“永不复发”“几次就能断根”
- ☐ 贬低精神科医生和药物，劝你停药或“别信西医”
- ☐ 越界：私下约会、暧昧、不必要的身体接触、送贵重礼物、向你借钱
- ☐ 索要与治疗无关的隐私，比如社交账号密码、要求查看你全部聊天记录
- ☐ 双重关系：同时是你的客户、合伙人、亲戚、微商或课程代理
- ☐ 收费不透明、临时加价、向你推销课程、保健品或“能量产品”
- ☐ 要求你对治疗内容绝对保密，包括对你的医生
- ☐ 用羞辱、威胁、“你就是不够努力”来推动改变
- ☐ 没有危机处理方案，你出事时找不到人
- ☐ 做了很久仍说不清目标，也从不复评进展

遇到越界或侵害，可以这样做：先停止预约，保留聊天记录、转账记录等证据，向所在机构投诉；涉及性骚扰、性侵害或诈骗，拨打 110 报警；涉及医疗机构和执业人员，可向当地卫生健康部门反映。

换治疗师不是背叛

很多人明知不合适也不敢换，怕伤人心，怕“前功尽弃”，怕被说成“难搞的病人”。需要明确一点：**治疗是为你的康复服务的，不是为维持一段关系服务的。**

常见的换人理由都很正当：方法不匹配、目标方向不同、搬家或时间冲突、费用承担不了、关系里总觉得不舒服、治疗师休假或离职。

可以这样开口：“我觉得现在的方法对我帮助有限，想和你讨论一下转介。”一个合格的治疗师会协助转介，而不是让你内疚。如果对方用“你这是在逃避”“换了谁都一样”来阻止你，这本身就是信息。

两点平衡：一方面，别因为“他人很好、很耐心”就留下——善意不等于有效；另一方面，也别在 3 次以内频繁更换，那时还看不出什么。换之前，把自己做过什么、什么有效、什么无效、接下来的目标、目前的用药整理成一页，带到下一次会谈，这样不必从零开始。

什么时候需要联系医生 / 寻求额外帮助

出现以下情况，请优先处理安全与权益

- 出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤：不要独处，立即呼叫 120 或去最近医院急诊，也可拨打 12356 心理援助热线。

- 治疗师有性暗示、身体接触、私下约会、借钱等越界行为：立即停止预约，保留证据，向机构投诉；涉及侵害请拨打 110。
- 被要求停药、被推销高价课程或保健品：暂停付费，向机构或当地卫生健康部门反映。
- 治疗期间情绪明显恶化，连续多日无法进食、入睡或照顾自己。
- 出现话多、睡得很少却不困、冲动消费等转躁迹象，尽快联系精神科医生。
- 换了两次以上治疗师仍毫无进展，建议复评诊断、共病和用药方案，而不只是继续换人。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 《中华人民共和国精神卫生法》（2013 年 5 月 1 日施行）. https://flk.npc.gov.cn/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 4：物理治疗与辅助治疗

当药物和心理治疗不够，或者不能耐受时，物理治疗是重要的补充。这一模块也讲运动、营养、睡眠这些“看似普通但有证据”的辅助手段。

4.1 重复经颅磁刺激 rTMS

这一页讲清楚 rTMS 是什么、哪些人适合、一次治疗和整个疗程是什么样、有哪些副作用和禁忌，以及为什么它和“电击”完全不是一回事。如果你吃药效果不理想，或因为副作用没法继续加量，正在考虑物理治疗，这一页可以帮你把问题问到点上。

一、rTMS 是什么：在头皮外“敲门”，不打开颅骨

rTMS 的英文全称是重复经颅磁刺激（repetitive transcranial magnetic stimulation）。做法是把一个线圈放在头皮上，通入快速变化的电流，线圈周围产生磁场；磁场穿过颅骨几乎不衰减，在大脑表层（医学上叫“皮层”）引起一小股电流，让那一小片区域的神经细胞变得更容易或更不容易兴奋。

可以把它想成“隔着门敲墙”：门（颅骨）没打开，墙（大脑）也没碰，但敲击的震动传进去了。治疗结束后，被“敲”过的区域，其兴奋性会在一定时间内保持在改变后的状态，这正是治疗想要的效果。

rTMS 和抑郁的关系，建立在一个相对稳定的观察上：抑郁的人，左侧前额叶（背外侧前额叶）的活动往往偏低，这个区域参与情绪调节、动机和“做决定”。所以常见做法是刺激左侧前额叶，试图把这块区域“叫醒”；也有刺激右侧或其他部位、采用不同模式的方案，由医生根据病情和中心条件决定。【研究】

需要强调：rTMS 不是“磁疗”。市面上磁石手环、磁疗床垫那类产品，磁场强度极低，穿透不了颅骨，也没有可靠证据能治疗抑郁。名字里都有“磁”，但完全不是同一件事。【指南】

为什么它不是“电击”。 很多人一听“刺激大脑”，立刻想到电影里被绑在床上、全身抽搐的场面。那是旧式电休克留下的印象。两者的区别可以看这张表：

对比项	rTMS	无抽搐电休克（MECT）
是否麻醉	不需要，人是清醒的	需要全身麻醉和肌松
是否通电	线圈产生磁场，不向头皮送电	短暂电流诱发一次受控发作
是否引起抽搐	不引起，癫痫是需避免的并发症	治疗目的就是诱发发作
对记忆的影响	一般不明显	可能出现记忆减退，需重点评估
治疗后的状态	休息后即可离开	需复苏观察，当天不宜独处

简单说：rTMS 是“用磁场在门外敲”，MECT 是“在麻醉下按一次重启键”。两者各有适应证和风险，不能互相替代。关于 MECT，可以看 4.2 无抽搐电休克 MECT。

二、谁适合，谁暂时不适合

多部指南把 rTMS 列为抗抑郁药效果不理想时可以考虑的治疗之一，通常在精神专科医院或专门的治疗中心、由受过训练的团队实施。【指南】它不是“所有人都该先做”的首选，也不是“最后没办法了才试”的兜底。

比较适合考虑的情况：诊断明确的中度到重度抑郁，已经用过至少一种（临床上常见是两种）抗抑郁药，足量、足疗程，效果仍不理想；因为恶心、性功能受影响、体重增加、出汗等副作用，没法耐受足够剂量的人——rTMS 不经过肝肾代谢，不与其他药物发生代谢层面的相互作用，这对同时吃很多药的人有意义【临床经验】；孕期、哺乳期希望“尽量少用药”的人，但孕期做 rTMS 的研究并不多，必须由产科和精神科一起评估【待验证】；老年人，需额外评估听力、脑血管状况和是否长期卧床【临床经验】。

还有一个很实际的条件：**能配合**。每次几十分钟要坐着或半躺着，头部保持相对不动，能听懂指令、能戴耳塞、能坚持每周多次、连续数周。严重激动、谵妄、无法静坐、理解配合困难的人，做起来会很困难，效果也难以保证。

需要谨慎、或通常不建议做的情况：头部或颈部有金属植入物（动脉瘤夹、脑深部刺激器电极、人工耳蜗、某些颅内支架、金属碎片残留），这类金属可能在磁场中发热或移位；心脏起搏器、植入式除颤器、胰岛素泵等电子植入设备，属于相对禁忌，需要心脏科和设备厂商信息共同确认；有癫痫病史或家族史，或正在用会降低癫痫阈值的药物（部分抗精神病药、某些抗生素、茶碱等），或近期大量饮酒、严重缺觉；颅内压增高、脑肿瘤、近期脑卒中或严重头部外伤；严重听力障碍或对噪音特别敏感；处于急性谵妄、严重兴奋状态。

你的情况	通常怎么处理
头部有金属夹、人工耳蜗、脑深部电极	一般不做，除非专科评估确认设备兼容
心脏起搏器	相对禁忌，需心脏科与设备信息确认
有癫痫史，但目前控制稳定	可能可以做，需调整方案并加强观察
牙龈有金属补牙材料、腿上有钢板	多数不影响，但仍要如实告知
怀孕	需产科与精神科共同评估，线圈远离腹部

绝对禁忌和相对禁忌的界线，必须由医生画，不是由患者自己对照网上的清单画。你要做的是“如实交代”：体内有什么植入物、以前有没有抽搐、最近在吃什么药和保健品、睡眠和饮酒情况。隐瞒这些，是把风险留给自己。

三、一次治疗是什么样：流程与疗程

第一次去，通常先做评估，不是直接上机：确认诊断、回顾既往用过的药和疗程、筛查禁忌（金属植入物、癫痫史、心脏设备、听力）、必要时做头部影像或听力检查、测量血压。有的中心还会用问卷评估抑郁严重程度，作为治疗前后的对照。

接着是定位。医生要确定线圈放在头皮的哪个位置。简单的方法是根据头部测量定位，精确的方法是用你自己的磁共振影像做导航。定位准不准，直接影响效果，这也是“在正规中心做”和“随便找地方做”的差别之一。然后可能做一次“运动阈值”测定：用单次磁刺激找到能让拇指轻微抽动的最小强度，用来个体化设定治疗强度。这个过程有点奇怪，但不疼。

正式治疗时，你坐在治疗椅上或半躺着，戴上耳塞，线圈贴着头皮。机器启动后你会听到连续的“哒哒”声，同时感觉头皮被轻轻敲击，有时面部或下颌的肌肉会跟着抽动。整个过程人是清醒的，不需要麻醉、不需要禁食，做完休息一会儿就能自己回家。

疗程通常是每个工作日做一次，持续四到六周，总共二十到三十次。【指南】有些中心采用单次时间更短的模式（比如间歇性 θ 爆发刺激，iTBS），对上班上学的人更友好，但不是每个中心都有。【研究】

起效时间因人而异。有人两三周开始感觉变化，也有人要做完整个疗程才能判断。所以医生通常会在疗程中途和结束时各评估一次，而不是做三五次没感觉就停。如果有效，后面往往还需要维持治疗——把频率逐渐拉长，或按需再做一段时间，否则效果可能在几个月内减退。【临床经验】

四、副作用、禁忌与效果预期

rTMS 的副作用整体上是物理治疗里比较轻的，但“轻”不等于“没有”。最常见的是头痛和头皮不适：头痛多在治疗当天出现，几小时内缓解，性质像紧张性头痛；头皮可能有刺痛、发麻、紧箍感或轻微红肿。面部、下颌、眼周的肌肉抽动也很常见，是刺激波及浅表肌肉，不代表“伤到神经”。

治疗时的响声是实打实的。不戴耳塞，长期下来可能影响听力，所以耳塞不是可选项。少数人会短暂觉得耳朵闷、耳鸣加重，出现这种情况要告诉治疗团队。

比较少见但需要认真对待的是癫痫发作。它的发生率很低，但不是零。风险在有癫痫史、脑损伤、颅内病变、同时使用某些药物、酒精戒断、严重缺觉的人身上更高。正规治疗室会配备急救设备和受过训练的人员，这也是 rTMS 不该在美容院、健身房、家里做的原因。

反应	多常见	怎么办
头痛、头皮发麻、紧箍感	很常见	多可自行缓解，必要时问医生能否用止痛药
面部或下颌肌肉抽动	常见	属刺激波及肌肉，告诉治疗师调整位置
耳鸣、耳朵闷	少见	检查耳塞是否戴好，持续不缓解要评估听力

反应	多常见	怎么办
癫痫发作	罕见	立即停止治疗、急救、呼叫 120

关于效果，研究里 rTMS 确实能让一部分人明显改善，也有一部分人改善有限，还有人对完全缓解没有反应。【研究】研究之间的差异很大，和人群、方案、疗程长短、是否继续原药物都有关系。所以任何“百分之多少有效”的说法，都要打个折扣听。

可以期待的是：如果有效，通常在疗程中后段开始出现，表现为睡眠、兴趣、精力、思维速度中的某一项先松动，而不是“突然开心”；效果通常在疗程结束后维持一段时间，但可能逐渐减退；副作用多数可耐受，不影响日常生活。

不该期待的是：做完立刻好、一次见效；做完就一辈子不复发（rTMS 不改变复发的底层风险，后续维持治疗、心理治疗、生活调整仍然重要）；可以替代药物（多数情况下 rTMS 是在原有药物基础上叠加）；一定比药“高级”（它对有些人有效、对有些人无效，和药物一样是概率问题）。

还有两个现实问题值得提前想清楚：一是费用，rTMS 在不少地区需要自费或部分自费，一个疗程总花费不低；二是时间，每周多次、连续数周，对上班、上学、带孩子的人都是不小的负担。这两点不解决，疗程很容易做到一半就断掉，而中断本身会影响判断效果。

五、决定之前问清楚，出现什么要就医

- ☐ 我的诊断是否明确？有没有排除双相、甲状腺问题、睡眠呼吸暂停？
- ☐ 我之前用过的药，剂量和疗程够不够？有没有可能是“假难治”？
- ☐ 这个中心做 rTMS 的医生和治疗师是什么资质？一年做多少例？
- ☐ 用的是什么设备、什么刺激模式？为什么给我选这个？
- ☐ 总共要做多少次、持续几周？中途怎么评估有效没效？
- ☐ 全部费用多少？医保或商业保险能不能报？
- ☐ 如果有效，维持治疗怎么安排？如果无效，下一步是什么？
- ☐ 我体内的植入物、癫痫史、正在吃的药，需不需要先调整？
- ☐ 治疗期间我要观察什么？出现什么情况必须马上联系？

> **立即呼叫 120 或去急诊**：治疗中或治疗后出现抽搐、意识丧失、口吐白沫、双眼上翻、大小便失禁；剧烈头痛伴反复呕吐；视物模糊或重影；一侧肢体无力或麻木、说话含糊、嘴角歪斜；胸痛、心悸伴晕厥。
>
> **当天联系治疗团队或精神科医生**：治疗部位皮肤红肿、起疱、破溃；持续耳鸣或听力下降；头痛越来越重、止痛药无效；情绪明显恶化，出现自伤或自杀念头（此时不要独处，让家人陪着，必要时拨 120 或 12356）；治疗后极度疲倦、意识模糊。
>
> 如果拿不准算不算严重，按严重处理。宁可多跑一趟，不要赌。

“做完能自己开车回家吗？” 大多数人可以。第一次治疗、或出现头晕疲劳时，建议有人陪同，当天不要安排需要高度集中注意力的工作。

“会不会改变性格？” 没有可靠证据支持 rTMS 会改变性格。治疗期间可能出现短暂的情绪波动、易激惹或疲倦，通常随疗程减轻；持续加重要报告。

“能不能只做 rTMS，把药停了？” 不建议自己停。rTMS 多数是叠加治疗，突然停抗抑郁药会带来撤药反应和复发风险。是否减药、什么时候减，由医生决定。

“做一次没效果，是不是就没希望了？” 一次治疗本来就不是用来判断疗效的。要看完整疗程，通常还要看疗程结束后几周的状态。即使 rTMS 无效，也不代表 MECT、氯胺酮、换药、心理治疗都无效。

容易踩的坑：把 rTMS 当保健品，症状一好就频繁加做；在非医疗机构、由没有资质的人操作；隐瞒金属植入物、癫痫史、正在吃的药，觉得“说了就不让做了”；疗程做到一半因为“没感觉”自行中断；只做 rTMS，不处理睡眠、饮酒、心理社会问题，效果被这些因素抵消。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.2 无抽搐电休克 MECT

一听到“电休克”，很多人脑子里立刻出现电影里被按在床上、全身抽搐的画面，于是本能地拒绝，哪怕医生已经反复解释。这一页想把 MECT 讲清楚：它现在到底是怎么做的、哪些情况应该优先考虑、记忆会受什么影响、恐惧从哪里来、同意书意味着什么。读完你未必会选择它，但至少可以在信息完整的情况下做决定，而不是被一个词吓退。

一、“电击”这个词，为什么让人害怕

这种恐惧不是凭空来的，它有三层来源。

第一层是历史。早期的电休克治疗没有麻醉、没有肌松，患者被电流诱发全身剧烈抽搐，可能造成骨折、牙齿断裂，场面确实可怕。那也是“电击”这个叫法留下的印象。今天的 MECT 前面多了“无抽搐”和“改良”两个限定：全身麻醉让人睡着，肌松药让肌肉不剧烈收缩，供氧、心电、血压、血氧、脑电全程监测。人不会感到电流，也不会看到全身抽搐，最多是手指或脚趾轻微抽动。

第二层是影视和传闻。电影需要冲突，于是治疗被拍成惩罚、被拍成“把人电傻”。这些画面传播得比医学解释快得多，很多人的拒绝其实来自这些画面，而不是来自对治疗本身的了解。

第三层是对“失去控制”的恐惧。被麻醉、醒来后记不清事情、不知道别人对自己做了什么——这些恐惧是真实的，也值得被认真对待。它们不该被一句“你想多了”打发掉，而应该由医生一条条解释清楚。

需要说明的是：MECT 不是惩罚，不是“电击疗法”那种民间说法，也不是对“不听话”的处置。它是一种有明确适应证、有操作规范、有知情同意程序的医疗技术，在重度抑郁、精神病性抑郁、紧张症等情况下，常常是起效最快的手段之一。【指南】

二、哪些情况应该优先考虑 MECT

MECT 不是“所有药都试过之后的最后一招”。在一些情况下，它应该被更早地摆到桌面上，因为等不起。

情况	为什么优先考虑
重度抑郁，明显消瘦、卧床、生活不能自理	起效相对快，能在营养和体力进一步恶化前打断病程
伴精神病性症状（幻觉、妄想、坚信自己罪不可赦）	对精神病性抑郁的效果通常较好，单靠抗抑郁药往往不够
紧张症（木僵、缄默、拒食、蜡样屈曲、违拗）	紧张症本身可能危及生命，MECT 是重要治疗手段
拒食、几乎不喝水，有脱水或电解质紊乱	药物起效慢，且拒食时无法保证服药，MECT 可不依赖胃肠吸收
高自杀风险，有明确计划或近期尝试	需要尽快降低风险，为后续治疗争取时间
难治性抑郁，多种药物足量足疗程无效	是指南列出的选项之一，尤其当症状严重、功能受损明显时
孕期重度抑郁且需要快速控制	需产科、麻醉、精神科共同评估，权衡利弊后个别考虑

反过来说，如果抑郁是轻中度、功能基本保留、药物治疗还有调整空间，通常不会首选 MECT。它不是“更高级的药”，而是一种强度更高、需要麻醉和监护、有特定风险的治疗。用不用，取决于“病情有多重、有多急、还有没有更温和的等效选择”。

三、一次治疗的全过程

治疗前。 医生会做评估：诊断、既往治疗史、目前用药、躯体状况。通常要查心电图、血液化验，评估牙齿（松动牙齿可能在操作中受损）、颈椎、有无胃食管反流，以及麻醉风险。有心脏病、高血压、动脉瘤、颅内压增高、严重肺部疾病的人，需要相关科室一起评估。治疗当天要按麻醉要求禁食禁水，这一点必须严格执行，否则有误吸风险。

治疗中。 你躺在治疗床上，麻醉医生通过静脉给药，几秒钟内入睡。接着给肌松药，肌肉放松。医生用放置在头皮上的电极给予短暂电流，诱发一次受控的癫痫发作，同时用脑电图确认发作是否达到治疗所需，用药物和给氧控制发作的幅度与时长。全程有人盯着心电、血压、血氧。整个过程通常十几分钟，发作本身只有几十秒。

治疗后。 几分钟到十几分钟后醒来，可能有一段时间迷糊、不知道自己在哪、说话重复。这是麻醉和发作后的正常反应，通常几十分钟到几小时内恢复。当天可能有头痛、肌肉酸痛、恶心、乏力。因为用了麻醉，当天不能自己开车、不能操作机器、不能独自照顾孩子，最好有人陪同。

疗程。 通常每周两到三次，一个疗程六到十二次，病情严重或起效较慢的人可能更多。【指南】有些人做几次就有明显改善；有些人要接近疗程结束才看得出。医生会在过程中评估疗效和认知变化，决定是否继续。

四、记忆影响：说清楚，不回避

这是 MECT 最需要诚实对待的部分，也是最容易被两派说法扭曲的部分。一派说“完全没影响”，一派说“做了就变傻”。这两种说法都不准确。

MECT 常见的记忆影响有两类：

- **顺行性遗忘**：治疗期间记不住新发生的事情。比如做了几次治疗，回想那几周，会觉得空白、断续。
- **逆行性遗忘**：对治疗前后一段时间的事情回忆变差，越靠近治疗的时间段越明显。有人会忘记治疗前几天说过的话、见过的人。

多数人的这些变化在治疗结束后几周到几个月内逐渐改善。但“多数人改善”不等于“所有人完全恢复”。有一部分人会说，某些时间段的记忆就是缺了一块，尤其是治疗期间发生的事；也有人主观觉得记忆力不如从前，而客观测验未见明显下降。这种主观感受是真实的，不该被否定。【研究】

影响程度的因素包括：治疗次数、电极放置方式（双侧通常比单侧影响大）、年龄、治疗前已有的认知状况、是否同时使用影响认知的药物。医生能做的，是在保证疗效的前提下用尽可能少的次数、选择合适的方式，并在治疗前后做认知评估。

有几件事可以降低影响：治疗前把重要的事情（密码、安排、想说的话）写下来或告诉家人；治疗期间不要做重大决定、不要签重要合同；让家人知道你这段时间可能记不住事，帮你记；治疗后如果发现记性明显变差，及时告诉医生，而不是自己扛着。

需要区分的是：抑郁本身就会损害注意力和记忆。很多人治疗前就觉得“脑子转不动、什么都记不住”，抑郁缓解后反而好转。所以判断 MECT 的记忆影响，不能只看治疗后的那几周，要看治疗前是什么状态。

五、知情同意：你有权知道什么

MECT 需要书面知情同意。这不是走形式，而是法律和伦理的要求。你有权在签字之前知道：

- 医生为什么建议 MECT，而不是继续调整药物或做其他治疗。
- 有哪些替代方案，各自的利弊是什么。
- 可能的风险：记忆影响、头痛、肌肉酸痛、恶心、意识模糊，以及麻醉风险、心血管风险（治疗时血压心率会一过性升高）。
- 大概要做几次，怎么判断有效没效，无效怎么办。
- 谁来做、在什么条件下做、治疗中怎么监护。
- 你可以随时提问、可以要求第二意见、可以在非紧急情况下改变主意。

如果患者本人无法表达意见（比如木僵、谵妄、严重精神病性症状），法律规定由监护人签署同意，并需符合相应的程序要求，具体由医院按《中华人民共和国精神卫生法》执行。家属在这种情况下容易两头为难：既怕做错决定，又怕不做耽误病情。可以做的，是把医生的解释问透，把患者病前表达过的意愿考虑进去，必要时寻求第二意见，而不是在信息不足时被推着签字。

六、疗程之后：维持治疗才是长期战场

MECT 最大的局限不是副作用，而是“做完会退”。一个疗程结束后，如果什么都不做，复发并不少见，尤其是疗程结束后最初几个月。【指南】所以正规做法是：MECT 结束后立刻接上维持治疗。

常见的维持方式包括：继续用抗抑郁药（有时会调整种类或联合用药）、继续做一段时间的 MECT 但把间隔逐渐拉长、改用 rTMS 做维持、配合心理治疗和规律复诊。具体选哪种，取决于这次 MECT 的效果、耐受性、既往复发次数、有没有精神病性症状、躯体状况和可及性。

对家属来说，疗程结束后那几个月要特别留意：睡眠变差、兴趣减退、又开始说“没意思”、不愿出门，这些可能是复发的早期信号，不要等到明显恶化才复诊。

七、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即呼叫 120 或去急诊**：治疗后持续意识不清、叫不醒；抽搐持续不停或反复发作；胸痛、胸闷、心悸伴大汗；呼吸困难、嘴唇发紫；剧烈头痛伴呕吐、视物模糊、一侧肢体无力或说话不清；高热。
>
> **当天联系治疗团队**：头痛越来越重、止痛药无效；持续恶心呕吐、吃不下东西；明显肌肉酸痛影响活动；治疗后几天仍然迷糊、找不到回家的路；记忆问题严重到影响安全（忘记关火、忘记吃药、出门迷路）。
>
> **尽快联系精神科医生**：情绪在治疗后明显恶化，出现自伤或自杀念头（此时不要独处，让家人陪着，必要时拨 120 或 12356）；出现兴奋、话多、睡得少却不困等转躁迹象。

八、常见问题与容易踩的坑

“做 MECT 是不是因为我已经没救了？” 不是。恰恰相反，它常常是因为病情重、需要快速控制才被选择。很多人在做完后能重新接受药物和心理治疗，而不是“走到终点”。

“会不会做了就变傻、再也恢复不了？” 记忆影响是真实的，多数会改善，少数人会有较长时间的困扰。把“可能影响记忆”如实说出来，比承诺“绝对不影响”更负责。如果医生一口咬定“完全没影响”，反而值得警惕。

“能不能只做两次就停？” 疗程和次数由病情决定。做几次感觉好了就自行中断，复发风险会上升。要停，和医生一起定计划。

“听说 MECT 会让人失去自我。” 没有证据支持这种说法。治疗期间可能情绪平淡、记忆断续，但人格不会被“抹掉”。如果治疗后长期情感迟钝，需要评估是抑郁残留、药物影响还是其他原因。

容易踩的坑：

- 因为“电击”两个字直接拒绝，连评估都不做，错过了对某些人最有效的选择。
- 相反，把 MECT 当成“快速见效的捷径”，不做维持治疗，几个月后又回到原点。
- 隐瞒心脏病、高血压、颅内病变、正在吃的药，增加麻醉和治疗风险。
- 治疗当天没有家属陪同，自己开车或独自带孩子。
- 把治疗后的正常迷糊当成“治坏了”，或者把持续的意识障碍当成“正常反应”而拖延。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.3 经颅直流电刺激与光照治疗

经颅直流电刺激（tDCS）和光照治疗，是两种常被放在一起讨论的“温和”物理治疗。它们的共同点是：看起来门槛不高、副作用相对轻、网上很容易买到设备，也因此最容易被夸大，甚至被当成“在家自己治抑郁”的办法。这一页想把两件事分开说清楚：各自的证据到底有多硬、适合谁、家里用有什么风险、什么情况下不该用。

一、经颅直流电刺激：温和，但证据没那么硬

tDCS 的做法是：把两个电极（一个带正电、一个带负电）贴在头皮上，通入非常微弱的直流电。电流小到什么程度？小到多数人只感觉轻微发麻或刺痛，甚至没什么感觉。它不引起神经放电，而是让电极下方那片脑区的“兴奋门槛”轻微升高或降低，从而在治疗结束后的一段时间里改变这块区域的活动水平。

因为这个原理，tDCS 被拿来尝试治疗抑郁：把“提高兴奋性”的电极放在活动偏低的左侧前额叶，理论上和 rTMS 的思路相似，只是手段更弱、更便宜、更便携。

问题在于证据。已有多项研究和汇总分析显示，tDCS 对抑郁可能有一点效果，但总体效应偏小，研究之间的结果不一致，样本量普遍不大，疗程、电极位置、电流强度也各不相同。【研究】更关键的是，大多数研究是在“已经吃药”的基础上加做 tDCS，很难分清改善有多少来自 tDCS。对于“难治性抑郁”，证据更有限。【待验证】

一些国家的卫生技术评估机构认为，现有证据的质量和数量还不足以把 tDCS 列为常规治疗，建议只在研究条件或严格评估下使用。【指南】这句话的分量是：它不是“已经被证明有效、只是还没普及”，而是“有可能有效，但还没到能拍胸脯的程度”。

和 rTMS 比，tDCS 的家庭化程度高得多，这也是它风险的主要来源。医用设备有电流限制、阻抗监测、故障保护；网上买的“家用抑郁治疗仪”，未必有这些。更常见的问题是用法：电极贴错位置、盐水太多导致电流分布异常、接触不良造成局部电流集中、治疗时睡着无人看管、每天做很多次、和别的电刺激设备一起用。这些都可能造成皮肤灼伤、刺痛、头晕，甚至诱发抽搐（尤其在有癫痫倾向或同时用某些药物的人身上）。

风险	怎么发生	怎么避免
皮肤灼伤、发红起疱	电极接触不良、盐水过多或过少、电流集中	只用有资质的设备，按说明贴附，出现刺痛立即停止
头晕、头痛、恶心	强度过高、时间过长、频繁使用	从低强度短时间开始，不在疲劳、缺觉时做
诱发抽搐	有癫痫倾向、合用降低癫痫阈值的药	有癫痫史者先做评估，不自行尝试
延误正规治疗	把 tDCS 当成替代药物和心理治疗	明确它是辅助，不自行减停药物
转躁	双相患者、或有躁狂史的人	双相患者必须在医生指导下使用

哪些人可以考虑？在专科评估后、作为药物治疗的辅助、并且愿意接受“效果可能有限”这个前提的人。哪些人不适合？有癫痫史或脑部病变的人、头部有金属植入物或电子植入设备的人、孕妇、双相障碍患者（可能诱发转躁）、有严重皮肤病或头皮破损的人、以及无法配合、无法准确描述感受的人。儿童青少年尤其要谨慎，相关研究很少。【待验证】

二、光照治疗：从“季节性抑郁”扩展到一般抑郁的辅助

光照治疗的思路很朴素：抑郁症常伴随生物钟紊乱——睡得晚、早上起不来、白天没精神、晚上反而清醒。早晨接受足够亮的光照，可以“校准”生物钟，让褪黑素的分泌节律前移，人也更容易在白天清醒、晚上入睡。

它在季节性情感障碍（就是每年秋冬固定发作、春夏缓解的那类抑郁）里证据最扎实，被多部指南列为一线治疗。【指南】对非季节性抑郁，光照治疗作为辅助手段也有研究支持，但效应不如季节性抑郁那么稳定，研究质量参差。【研究】换句话说：如果你每年冬天情绪明显下滑，光照治疗值得认真考虑；如果你是全年都有抑郁，它可以作为“加一点”的手段，但不要指望它替代药物或心理治疗。

怎么做。 使用专门的光照箱，不是普通的台灯、浴霸或手机屏幕。时间是早晨，起床后不久开始，越晚做越可能影响当晚睡眠。人坐在光照箱前，距离大约一臂，光线照到脸上、眼睛余光能接收到，但不要直视光源。期间可以吃早饭、看书、用电脑，不需要盯着灯看。时长通常从较短开始，比如二三十分钟，根据反应调整；不同设备的亮度标注方式不一样，不要照搬别人的设置，按设备说明和医生建议来。【指南】

什么时候做最合适。 如果你习惯凌晨才睡、中午才起，光照时间要相应后移，否则可能让你更早醒、更难受。这类“睡眠相位延迟”的情况，最好先和医生讨论时间安排，而不是自己硬套“起床后马上照”。

副作用。 常见的是眼睛干涩、流泪、视疲劳、头痛、烦躁、坐不住。少数人会失眠（尤其是傍晚做）、轻度兴奋甚至转躁。这些通常调整时间或缩短时长后缓解。

哪些人要慎用。 双相障碍患者——光照可能诱发躁狂或混合发作，必须在医生指导下使用，并配合心境稳定剂。【指南】有视网膜疾病、青光眼、白内障术后、严重干眼的人，先看眼科。正在服用增加光敏感性的药物（某些抗生素、维 A 酸类、圣约翰草等）的人，要告诉医生。偏头痛患者可能被亮光诱发。服用光敏药物期间，不要在强光下长时间停留。

三、三种物理治疗放在一起看

项目	证据强度	是否需到院	主要风险
rTMS	指南列为难治性抑郁的选项，研究支持较多	需要，通常每工作日一次	头痛、头皮不适、罕见癫痫
tDCS	研究结果不一致，效应偏	家用设备可自购，医用需到	灼伤、头晕、诱发抽搐、延

项目	证据强度	是否需到院	主要风险
	小，指南多持保留态度	院	误治疗
光照治疗	季节性抑郁证据较强，非季节性为辅助	可在家用，需选对设备	眼干头痛、失眠、诱发转躁

这张表想说的不是“哪个更好”，而是“哪个更确定”。确定性不同，期待就该不同，风险防控的重点也不同。

四、家用设备：便宜方便，但别把它当成“自己当医生”

tDCS 和光照箱都能在网上买到，价格从几百到几千不等。方便是好事，但方便也意味着“没有人在旁边看着”。如果你打算在家用，至少做到这几条：

- ☐ 先让精神科医生知道，并确认自己没有禁忌（癫痫、脑部病变、植入物、双相、孕产期）。
- ☐ 买有明确生产资质、说明书完整的设备，不用“三无”产品，不用自己改电源、改电极。
- ☐ 严格按说明书使用，不擅自加长时间、增加次数、调高强度。
- ☐ 不在疲劳、缺觉、饮酒后使用，不在使用时睡觉。
- ☐ 头皮有破损、皮疹、伤口时暂停。
- ☐ 出现刺痛、灼热、头晕、心慌，立即停止，不要“忍一忍就过去了”。
- ☐ 记录使用时间、感受、情绪变化，复诊时带给医生看。
- ☐ 不因为用了设备就自行减药、停药，也不因为“感觉好了”就不再复诊。

光照箱的选择还要多一条：确认它过滤了紫外线。长期接受未过滤紫外线的强光，对眼睛和皮肤都不利。

五、效果预期：别被“无副作用”“自然疗法”这类说法带走

这两种治疗的共同吸引力是“不像药那样伤身体”。这个说法有一半是真的：它们确实不经过肝肾代谢，不会带来体重增加、性功能障碍这类药物副作用。但“没有药物副作用”不等于“没有风险”，也不等于“有效”。

对 tDCS，比较诚实的表述是：可能对一部分人有轻度到中度的帮助，效果不如 rTMS 稳定，家庭使用的疗效和安全性都缺乏监管，不应作为中重度抑郁的主要治疗。【待验证】

对光照治疗，比较诚实的表述是：对季节性抑郁是明确的一线选择；对非季节性抑郁，作为辅助可能有帮助，起效通常要一两周，效果因人而异；它不能替代药物和心理治疗，也不能防止复发。【研究】

还有一个容易被忽略的成本：时间。光照治疗要每天固定时间做，连续几周甚至整个冬天；tDCS 也要每天做、连续数周。坚持不下来，效果就无从谈起。开始之前，先想清楚自己能不能做到。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即停止并就医**：使用 tDCS 时出现剧烈头痛、抽搐、意识丧失、心慌伴晕厥；头皮灼伤起疱、破溃、流液；使用光照后出现视物模糊、眼痛、视野缺损。
>
> **当天联系医生**：持续头晕、恶心、失眠加重；情绪明显高涨、话多、精力旺盛、睡得少却不困、冲动消费或冒险行为（可能是转躁）；焦虑、烦躁明显加重；皮肤持续发红不退。
>
> **尽快联系精神科医生**：抑郁症状加重，出现自伤或自杀念头——此时不要独处，让家人陪着，必要时拨 120 或 12356；用了设备后觉得“反正没用”，打算自行停药。

七、常见问题与容易踩的坑

“tDCS 是不是没有副作用，可以随便用？” 不是。它副作用相对轻，但有灼伤、诱发抽搐、转躁的风险，家庭使用还多了一层“用错没人纠正”的风险。

“光照箱越亮越好吗？” 不是。亮度和时长要匹配设备和个体反应，过亮、过久会增加眼干、头痛、失眠和转躁的风险。不同设备的标注方式不同，不能照搬别人的参数。

“能不能用台灯、浴霸代替光照箱？” 不建议。普通灯具的亮度、光谱、紫外线过滤都达不到治疗要求，靠得太近还有灼伤和眼睛损伤的风险。

“用了光照治疗，是不是就不用吃药了？” 不是。对季节性抑郁，光照可能作为主要治疗之一；对非季节性抑郁，它通常是辅助。是否减药由医生决定。

容易踩的坑：

- 把“物理治疗”当成“没有副作用”，忽略禁忌和监测。
- 在电商详情页、病友群里照搬别人的电极位置、时长、亮度。
- 一边用设备一边自行减药，出问题时分不清是哪个环节的原因。
- 双相患者自行做光照或 tDCS，诱发转躁。
- 期待“一两周根治”，没效果就彻底否定所有物理治疗。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.4 氯胺酮与艾司氯胺酮

氯胺酮是这几年抑郁症治疗里最受关注、也最容易被误读的药物。一方面，它被说成“几小时就能让抑郁消失的神药”；另一方面，它又是被管制的精神活性物质，滥用会伤膀胱、伤认知。这两种说法都抓住了部分事实，但都省略了关键前提：它用在谁身上、在什么条件下用、用完之后怎么办。这一页想把这几件事讲清楚，尤其是监测和滥用风险。

一、为什么它能“快”

传统抗抑郁药主要作用于 serotonin（血清素）、norepinephrine（去甲肾上腺素）、dopamine（多巴胺）这些单胺类递质，起效通常要两到四周，机制像是“慢慢改变神经系统的状态”。

氯胺酮走的是另一条路。它主要作用于谷氨酸系统里的 NMDA 受体，阻断之后会引起一连串变化，其中被讨论最多的是：它可能促进神经细胞之间连接（突触）的快速形成，让前额叶重新获得对情绪的调节能力。【研究】这个机制和单胺类抗抑郁药不同，所以起效快得多——有研究观察到，一次给药后几小时到一天内，抑郁评分就明显下降。

这也解释了一个现象：有些人用了多种抗抑郁药都没反应，用氯胺酮却有效。它不是在“同一条路上加大力度”，而是换了一条路。【研究】

但“起效快”不等于“治好了”。它更像是在一堵墙上临时开了一扇门，门能开多久、门后面能不能修好，是另外的问题。

二、效果能维持多久

这是最需要现实预期的地方。

单次给药后，效果通常在几小时到一天内出现，维持几天到一两周，然后逐渐消退。不同人差异很大：有人一次能维持两周，有人三五天就开始回落。【研究】

所以临床上的做法不是“打一次就完事”，而是在起效后安排重复给药，把效果“接住”，再逐步过渡到维持治疗。艾司氯胺酮鼻喷剂在一些国家被批准用于难治性抑郁，通常需要每周一到两次的维持给药，具体频率由医生根据反应调整。【指南】

关键的一点是：氯胺酮本身不是“根治”手段。停药后复发并不少见，尤其是没有一个稳定的后续方案时。它更像是“争取时间”——在症状最重、最危险、其他治疗还没起效的时候，先把人从谷底拉出来，然后利用这段时间把药物、心理治疗、生活调整跟上。

三、解离反应：那种“飘起来”的感觉

很多人第一次用完氯胺酮，会经历一种难以描述的状态：感觉自己飘起来、身体不是自己的、周围不真实、时间变慢、看到的东西变形、说话变慢、有点晕、有点恶心。这在医学上叫“解离反应”，是氯胺酮的药理作用之一，不是“疯了”，也不是“治坏了”。

解离通常在给药后几分钟到几十分钟内出现，一两个小时内逐渐消退。有人觉得放松，有人觉得害怕，有人几乎没感觉。它和疗效之间的关系，目前还没有定论——不是“飘得越厉害效果越好”。【待验证】

需要有人在场，是因为解离期间人可能站不稳、恶心呕吐、血压升高、判断力下降。这也是为什么它必须在医疗机构内给药、给药后观察足够长的时间，而不是“拿回家自己用”。

四、监测：为什么必须在医院做

氯胺酮会引起血压和心率升高，多数是短暂的、轻度的，但在有高血压、心脏病、脑血管病的人身上可能很危险。所以正规流程包括：

- 治疗前测血压、心率，评估心血管病史，必要时做心电图。
- 给药过程中和给药后定时测血压、心率、血氧，观察意识状态和解离程度。
- 给药后留在观察区，直到血压稳定、解离消退、能正常行走和进食。
- 当天不能开车、不能操作机器、不能独自照顾孩子，最好有人陪同。
- 有精神病性症状或双相障碍的人，要格外注意是否诱发幻觉、妄想或转躁。

观察项	为什么看	出现什么要处理
血压、心率	氯胺酮会一过性升高血压心率	明显升高、胸痛、剧烈头痛
意识与解离	判断反应程度和恢复情况	意识模糊持续不退、极度恐惧
精神症状	可能诱发幻觉、妄想、躁狂	听到不存在的声音、坚信被害、异常兴奋
排尿情况（长期使用）	长期滥用可致膀胱损害	尿频、尿急、尿痛、血尿

五、滥用与依赖：这是必须讲清的一条

氯胺酮是受管制的精神活性物质。在中国，它被列入第一类精神药品管理，非法持有、贩卖、吸食都涉及法律责任。它在娱乐场所被当作“K 粉”使用，这不是“治疗”，是药物滥用。

长期、反复、大剂量使用氯胺酮的人，可能出现：

- **膀胱损害**：尿频、尿急、尿痛、血尿，严重时膀胱容量缩小，生活质量严重受损。这是氯胺酮滥用最典型的躯体后果之一，而且可能是不可逆的。
- **认知损害**：注意力、记忆力、执行力下降，情绪变得迟钝或易激惹。
- **耐受与依赖**：越用越多，停不下来，停了就难受。

- **精神症状**：幻觉、妄想、惊恐发作。

医疗使用和滥用是两件事，区别在于：是否有明确适应证、是否在医生监督下、是否用标准制剂和规范剂量、是否有随访。医疗使用也可能出现耐受（效果越来越短），但正规方案会通过调整频率、联合其他治疗来管理，而不是“越用越多”。

有物质使用障碍史（包括酒精、大麻、阿片类、兴奋剂）的人，使用氯胺酮要格外谨慎，需要医生评估风险。

六、不是一线，也不适合所有人

氯胺酮不是“抑郁了就可以用”的药。多部指南把它放在难治性抑郁的位置：至少两种抗抑郁药足量足疗程效果不佳，症状严重、功能受损明显，或者有迫切的自杀风险需要快速缓解。【指南】

不适合或需要非常谨慎的情况包括：

- 未控制的高血压、动脉瘤、脑血管畸形、近期脑出血。
- 心力衰竭、严重心律失常、未稳定的冠心病。
- 当前有精神病性症状，或双相障碍未稳定控制（可能诱发躁狂）。
- 有物质使用障碍史。
- 妊娠期、哺乳期。
- 严重肝功能损害。
- 颅内压增高。
- 对氯胺酮或辅料过敏。

七、费用与可及性

这是很现实的一关。氯胺酮治疗通常需要在有条件的医院、由麻醉科或精神科团队合作完成，涉及药物、监护、观察床位和人力，费用不低，且在很多地区需要自费。艾司氯胺酮鼻喷剂在部分国家获批用于难治性抑郁，国内的可及性因地区和医院而异；氯胺酮用于抑郁治疗在不少地方属于超说明书使用或临床研究范畴。具体能不能做、在哪里做、花多少钱、医保能不能报，必须向当地医院问清楚，不要根据网上的“攻略”跨省求医。

对比项	传统抗抑郁药	氯胺酮（静脉）	艾司氯胺酮（鼻喷）
起效速度	通常两到四周	几小时到一天	数小时到一天
给药地点	在家	医疗机构，需监护	医疗机构，需监护
效果维持	持续用药维持	数天到两周，需重复	需定期维持给药
主要风险	副作用、相互作用	血压升高、解离、滥用	解离、血压升高、镇静

八、接受治疗前，把这几件事确认清楚

- ☐ 我是否符合难治性抑郁的标准？之前的药是否足量足疗程？
- ☐ 有没有做过心血管评估？血压控制得怎么样？
- ☐ 有没有精神病性症状、双相病史、物质使用史？
- ☐ 治疗在哪里做？谁给药、谁监护？观察多久？
- ☐ 一次治疗多少钱？一个完整疗程（含维持）大概多少？医保能否报销？
- ☐ 如果有效，维持方案是什么？多久一次？要持续多久？
- ☐ 如果无效，下一步是什么？
- ☐ 治疗当天谁来陪我？我能不能自己回家？
- ☐ 出现什么情况必须马上联系你们？

九、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即呼叫 120 或去急诊**：给药后胸痛、胸闷、心悸伴大汗；血压明显升高伴剧烈头痛、视物模糊、呕吐；意识不清、叫不醒、抽搐；呼吸困难、嘴唇发紫；晕厥；出现持续的幻觉、极度兴奋、行为失控，可能伤人或自伤。
>
> **当天联系治疗团队**：解离反应超过预期时间仍不缓解；持续恶心呕吐、站不稳；头痛越来越重；情绪异常高涨、话多、睡得少却不困（转躁）；排尿疼痛、血尿。
>
> **尽快联系精神科医生**：治疗后情绪再次明显下滑，出现自伤或自杀念头——不要独处，让家人陪着，必要时拨 120 或 12356；出现“想再用一次”的强烈冲动，或自行寻找非法渠道获取氯胺酮。

十、常见问题与容易踩的坑

“氯胺酮是不是比抗抑郁药更有效？” 在难治性人群中，它可能对一部分人有效，起效更快，但长期效果、复发率、安全性都还在积累证据。它不是“更高级的一线药”。【研究】

“做完一次就好了，能不能不维持？” 单次效果通常只能维持几天到两周。不接维持治疗，复发很常见。

“解离是不是说明药起效了？” 不是。解离是副作用的一部分，和疗效没有确定的对应关系。

“能不能自己买来用？” 不能。它是管制药品，非法购买和使用有法律风险；没有监护的使用有血压、意识、跌倒、滥用等风险。

容易踩的坑：

- 把氯胺酮当成“快速治愈”，忽略后续的维持和心理社会康复。
- 在没有监护条件的地方（酒店、家里）使用。
- 隐瞒高血压、心脏病、精神病性症状、物质使用史。
- 因为一次效果不好就否定它，或因为一次效果好就要求频繁加做。

- 用“氯胺酮能治抑郁”为娱乐性使用找理由。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

4.5 运动营养与睡眠

这一页讲的是三件看起来“不像治疗”的事：运动、吃饭、睡觉。它们没有药物那么强的证据，也没有物理治疗那么“高科技”，但在抑郁的康复里，它们的作用被反复验证过，而且几乎没有严重副作用。问题是，网上关于它们的说法一半被夸大、一半被误解——有人说“跑步能治好抑郁”，也有人说“吃什么都没用”。这一页想给你一个不夸大的版本：哪些值得做、怎么做、能期待什么。

一、运动：证据最硬的辅助手段之一

在轻中度抑郁里，规律运动的效果有相当多的研究支持，效应量中等，和部分心理治疗、药物治疗相比不算弱；在重度抑郁里，它更多是“辅助”——帮助改善睡眠、精力、食欲、自我效能感，但不能替代药物或心理治疗。【指南】多部指南把运动列为抑郁症综合治疗的一部分，尤其是轻中度患者和康复期患者。【研究】

机制不止一条：运动会影响脑源性神经营养因子（BDNF，可以理解为“帮助神经细胞连接和存活的养料”）、炎症水平、睡眠结构、生物钟，也会通过“我做到了一件难事”的体验改善自我评价。这些机制不是单独起作用，也很难说哪一条最重要。【待验证】

处方怎么写。 关键不是“练到累”，而是“规律、可持续、逐步加量”。

类型	频率	强度	注意
有氧（快走、慢跑、骑车、游泳）	每周多数天，累计约两个半小时中等强度	能说话但唱不了歌	从每次十分钟开始，每两周加一点
力量（自重、弹力带、器械）	每周两到三次	每个动作做到略吃力	覆盖大肌群，隔天做，避免憋气
伸展与平衡（瑜伽、太极）	每周两到三次	轻到中等	对老年人和躯体疾病患者更友好

如果你现在连起床都困难，不要从“每周两个半小时”开始，那只会让你更挫败。从“每天出门走五分钟”开始，做到一周，再谈加量。这里可以借用行为激活的思路：先行动，情绪跟上得慢一些，这是正常的。

几个现实问题。 一是启动难。抑郁时最缺的就是“开始”的那点力气，所以要把门槛降到荒谬的低——鞋穿好、门打开、走三分钟，也算完成。二是运动后短暂的情绪低落。少数人运动后会更累、更空，这不代表运动有害，可以缩短时间、降低强度、换到白天。三是有躯体疾病的人（心脏病、严重关节病、未控制的高血压）要先问医生能做什么，不要照搬网上的计划。四是不要用运动“惩罚”自己——没完成计划不等于失败，第二天继续就行。

二、地中海饮食：方向对，但别神化

地中海饮食的模式是：蔬菜、水果、全谷物、豆类、坚果、橄榄油为主；鱼和海鲜每周几次；适量奶制品和蛋；红肉、加工肉、甜食、精制碳水少。它本来是为心血管健康研究的，后来发现遵循程度高的人，抑郁风险较低、抑郁症状较轻。【研究】

但要讲清楚证据的性质：大部分是观察性研究，只能说明“相关”，不能证明“吃这个能治抑郁”。真正把地中海饮食作为干预的随机对照试验很少，样本也不大，结果有希望但不够硬。【研究】所以合理的说法是：这种饮食模式对整体健康有明确好处，对情绪可能有帮助，值得作为辅助，但不能替代治疗。

实际怎么做，不需要买“抗抑郁食谱”，也不需要顿顿沙拉。可以从三个替换开始：把一部分精制主食换成全谷物；把一部分红肉换成鱼或豆制品；把零食换成坚果和水果。再加上“规律吃饭”——抑郁的人常常不吃早饭、晚上暴食，血糖忽高忽低本身就会影响情绪和睡眠。

三、睡眠：CBT-I 为什么是一线

失眠和抑郁是双向的：失眠可以是抑郁的症状，也可以是抑郁的诱因，还会增加复发风险。很多人抑郁好了，失眠还在，而残留的失眠是复发的危险因素之一。【指南】

对失眠，一线的治疗不是安眠药，而是失眠的认知行为治疗（CBT-I）。它包含几个部分：睡眠限制（把卧床时间压缩到接近实际睡着的时间，提高睡眠效率）、刺激控制（床只用来睡觉，睡不着就起来）、认知调整（拆掉“今晚肯定又睡不着”的灾难化想法）、放松训练。CBT-I 通常做四到八次，效果和安眠药相当，但更持久，停药后不容易反弹。【指南】现在也有数字化的 CBT-I 课程，对不方便到院的人是个选择。

睡眠卫生是基础，但不是全部。它包括：固定起床时间（比固定睡觉时间更重要）、白天见光、白天活动、下午后少咖啡因、睡前减少强光和屏幕、卧室凉暗安静、不把床当办公桌。这些做到了，不等于失眠就好了，但做不到，CBT-I 的效果会打折扣。

几个常见误区值得点出来：

- **喝酒助眠**：酒精让人更快入睡，但会破坏后半夜的睡眠结构，加重早醒和打鼾，长期看让失眠更糟。
- **躺床上硬睡**：越躺越焦虑，形成“床＝清醒＋焦虑”的条件反射。睡不着超过一段时间就起来，做点无聊的事，有困意再回床。
- **周末补觉**：把生物钟往后推，周一更难起，形成“社会时差”。
- **必须睡够八小时**：睡眠需求因人而异，盯着手环上的数字反而增加焦虑。
- **白天补长觉**：超过半小时的午睡，尤其傍晚的补觉，会削弱晚上的睡意。

如果打鼾严重、白天嗜睡、晨起头痛、体重增加，要排查睡眠呼吸暂停——它既会加重抑郁，也会让抗抑郁药效果变差。这个在 5.1 难治性抑郁的评估里还会提到。

四、常见补充剂：证据到底如何

这是最容易被带货文案带偏的部分。下面这张表只讲证据分量和风险，不构成推荐。

补充剂	证据分量	需要注意
Omega-3（鱼油）	作为辅助有一定研究支持，效果不大，结果不一致	高剂量可能增加出血风险，用抗凝药者先问医生
维生素 D	缺乏者补充有益；不缺乏时单用对抑郁效果不明显	先查血，不缺不必大剂量长期补
叶酸 / L-甲基叶酸	作为增效辅助有研究，结果不一	不要自行与药物叠加，需医生评估
维生素 B12	缺乏（尤其老年人、素食者）会加重抑郁样症状	查血后再补，不缺则意义有限
圣约翰草	对轻中度抑郁有一定研究支持	与多种药物严重相互作用，禁止与 SSRI 同用
SAMe、5-HTP 等	证据有限，质量参差	可能与抗抑郁药叠加导致血清素综合征

几条原则：

第一，**先查再补**。维生素 D、B12、铁、叶酸缺乏都会影响情绪和精力，抽血查一下比盲目买补剂划算。

第二，**补充剂不是“天然所以安全”**。圣约翰草是典型的例子：它影响肝脏药物代谢酶，会让避孕药失效、让抗凝药和抗抑郁药的血药浓度乱掉。5-HTP、色氨酸与 SSRI 叠加，有血清素综合征的风险。

第三，**不要用补充剂替代药物**。对中重度抑郁，没有任何一种补充剂被证明可以替代抗抑郁药或心理治疗。

第四，**告诉医生你在吃什么**。包括中药、保健品、代餐、减肥药。很多相互作用就藏在这些“不算药”的东西里。

五、把三件事放进同一张周计划

- ☐ 固定起床时间，误差不超过一小时，包括周末
- ☐ 起床后一小时内见到自然光，哪怕只是阳台站十分钟
- ☐ 每周三次“低门槛运动”，每次十分钟起步，做完打勾
- ☐ 每周两餐把红肉换成鱼或豆制品，每天加一份蔬菜
- ☐ 下午两点后不喝咖啡、浓茶、奶茶
- ☐ 睡前半小时调暗灯光，手机放远一点
- ☐ 睡不着超过一段时间就起床，不在床上硬躺

☐ 每周记录一次睡眠时间、运动次数、情绪大致水平，复诊时带上

这张清单不是“做到就能好”，而是“做到能让治疗更顺”。抑郁发作时，能做到其中两三条就已经不错，不要用整张表来责备自己。

六、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即呼叫 120 或去急诊：**运动时胸痛、胸闷、心悸伴大汗、晕厥；严重脱水（几乎不喝水、尿很少、头晕站不稳）；持续拒食伴明显消瘦、虚弱。
>
> **当天联系医生：**运动后出现持续心悸、头晕；失眠突然加重，连续多日几乎不睡却精力旺盛、话多、冲动（可能是转躁）；服用补充剂后出现发热、大汗、肌肉僵硬、颤抖、意识混乱（警惕血清素综合征）；皮疹、面唇肿胀、呼吸困难（过敏）。
>
> **尽快联系精神科医生：**情绪持续恶化，出现自伤或自杀念头——不要独处，让家人陪着，必要时拨 120 或 12356。

七、常见问题与容易踩的坑

“运动能不能代替吃药？” 轻中度抑郁、医生评估后，运动可以作为方案的一部分；中重度抑郁，运动是辅助，不能替代药物和心理治疗。自行停药的风险远大于运动带来的好处。

“吃什么能最快改善抑郁？” 没有哪种食物能“快速改善抑郁”。饮食模式是长期背景，不是急救手段。

“安眠药是不是绝对不能吃？” 不是。CBT-I 是一线，但在急性期、严重失眠影响安全时，医生可能短期使用助眠药。关键是不要长期依赖，也不要自行加量。

“补充剂多吃几种，总有一种有用吧？” 叠加不等于有效，反而增加相互作用和肝损伤风险。

容易踩的坑：

- 一开始就定“每天跑五公里”的目标，三天后放弃，然后认定“运动对我没用”。
- 用运动替代复诊和服药。
- 靠喝酒、刷手机、白天补觉来对付失眠，越搞越乱。
- 相信“某明星靠吃某某补剂治好抑郁”的软文。
- 把“睡得少但很精神”当成好转，忽略转躁的可能。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.

- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 5：难治性抑郁与联合策略

“吃了两种药都没好”不等于没救了。这一模块先帮你排除“假难治”，再看换药、增效、物理治疗和综合康复怎么组合。

5.1 难治性抑郁的评估

“两种药都吃过了，还是不好”——这句话背后，可能是真正的难治性抑郁，也可能是剂量不够、药没吃对、诊断偏了，或者有别的问题在拖着。这两者的处理方向完全不同：前者需要升级治疗，后者需要先纠正那些“看起来像难治”的原因。这一页讲怎么定义难治性抑郁、哪些因素会造成“假难治”、以及一次系统复评应该包含什么。读完你可以带着一张清单去和医生讨论，而不是只带着“我没救了”的感觉。

一、什么叫“难治”：一个有用但不精确的概念

难治性抑郁（treatment-resistant depression，TRD）不是一个有统一标准的诊断，而是对“治疗反应不够”的描述。临床上最常用的定义是：**经过两种不同类别的抗抑郁药，足量、足疗程治疗，症状仍然没有明显改善。**

这句话里有三个关键词需要拆开：

- **足量**：指剂量达到了治疗剂量范围，通常是说明书推荐的上限附近，或者你能耐受的最大剂量。吃了半片、吃了“最小有效量”就判断无效，不算。
- **足疗程**：指在足量前提下持续足够长的时间。多数抗抑郁药需要四到八周才能判断是否有效；只吃两周就说“没用”，往往太早。
- **不同类别**：两种同类的药（比如两种 SSRI）先后使用，证据上不如换到不同机制的药。

还要区分“应答”和“缓解”。症状评分下降一半左右叫“应答”，症状基本消失、功能恢复叫“缓解”。有些人从“很重”变成“中等”，算应答但没缓解，这种情况仍然需要继续调整，不能因为“好了一点”就停在这里。

难治性抑郁还有轻重之分：试过两种药无效，和试过四种药、做过物理治疗仍无效，不是一回事。医生有时会用“阶段”来描述——第几次足量足疗程失败，对应不同的治疗强度。这不是给你贴标签，而是帮助判断下一步该走多远。

说法	大致含义	容易误解的地方
应答	症状减轻约一半	减轻一半不等于好了，功能可能仍受损
缓解	症状基本消失，接近病前状态	缓解后仍需维持治疗防复发
难治	两种不同类别药物足量足疗程无效	不是“永远治不好”，也不是“必须试

说法	大致含义	容易误解的地方
		遍所有药”
假难治	因为剂量、依从、诊断等问题造成的“看起来无效”	纠正后可能对原来的药有反应

二、先排除“假难治”：最常见也最容易被忽略

在把一个人归入“难治”之前，负责任的医生会先问一句：**有没有可能，之前那些治疗根本不算“足量足疗程”？**

这不是苛责患者，而是临床上非常常见的现实。原因包括：

剂量不够。 有些人因为担心副作用，一直停在低剂量；有些医生为了“安全起见”，加量很慢；有些人吃到中等剂量觉得“好了一点”就不再往上调。剂量不足时判断无效，等于没试。

疗程不够。 抗抑郁药起效慢，四到六周才开始显现是常态。吃了十天半月就换药，可能把本来会有效的药换掉了。反过来，吃了三个月一点变化都没有，也不该无限期等下去。

依从性差。 这是最隐蔽的一条。漏服、隔天吃、感觉好了就停、因为副作用自行减量、把药藏在舌下吐掉——这些情况家属和医生都未必知道。抑郁本身会损害执行功能，让人记不住、懒得吃；副作用又让人不想吃。询问依从性时，直接问“最近一周有几天没吃”比问“你按时吃药了吗”更容易得到真实答案。

诊断不对。 这是最需要警惕的一条：

- **双相障碍**。被当成单相抑郁治疗了很多年，只用抗抑郁药，效果自然不好，还可能诱发转躁。要问：有没有过一段时间睡得很少却精力旺盛、话多、思维奔逸、冲动消费、特别自信？家族里有没有双相或躁狂史？【指南】
- **甲状腺问题**。甲减（包括亚临床甲减）会表现为乏力、情绪低、反应慢、怕冷、便秘、体重增加，和抑郁高度重叠。查一次促甲状腺激素（TSH）就能发现大部分问题。
- **贫血、维生素 B12 或叶酸缺乏**。会带来乏力、注意力差、情绪低落。
- **睡眠呼吸暂停**。打鼾严重、白天嗜睡、晨起头痛、夜间憋醒的人，抑郁症状可能主要是缺氧和睡眠碎片化造成的，抗抑郁药效果自然有限。
- **药物或物质引起**。某些降压药、激素、干扰素、部分止痛药可能引起抑郁样症状；长期饮酒、使用大麻或其他物质也会干扰治疗。
- **早期痴呆、帕金森病等神经系统疾病**。老年人出现“抑郁”伴记忆下降、走路变慢、手抖，需要进一步评估。
- **人格特质、创伤史、长期应激**。这些不是“诊断错误”，但会影响治疗效果，需要心理治疗同步介入。

药物相互作用与吸收问题。 有些药会让抗抑郁药的血药浓度下降（比如某些抗癫痫药、利福平、圣约翰草），有些会影响吸收（胃肠手术后、慢性腹泻、乳糜泻）。吸烟也会影响某些药物的代谢。这些需要医生逐条核对，不是患者自己能判断的。

心理社会维持因素。 如果一个人每天都在遭受家暴、被裁员、照顾重病家人、住在没有隐私的环境里，药物很难单独对抗这些现实压力。这不是“想开点”能解决的，但需要被看见、被纳入计划。

三、一次系统复评应该包含什么

如果你已经试过两种以上的药，效果不理想，可以主动要求一次“系统复评”，而不是直接在原有方案上再加一种药。复评通常包括：

- ☐ **诊断复核**：重新确认是不是抑郁症，有没有双相、精神病性症状、紧张症、物质使用、躯体疾病。
- ☐ **用药时间线**：把每一种药用过多久、多大剂量、有没有加到足量、效果如何、副作用如何、为什么停，一条条列出来。
- ☐ **依从性评估**：最近一个月漏服几次？有没有自行减量？有没有因为副作用偷偷停？
- ☐ **实验室检查**：甲状腺功能、血常规、铁蛋白、维生素 B12、叶酸、电解质、肝肾功能，必要时查维生素 D、血糖、心电图。
- ☐ **睡眠评估**：有没有打鼾、憋醒、白天嗜睡；必要时做睡眠监测。
- ☐ **物质使用**：酒精、烟草、大麻、镇静催眠药、咖啡因。
- ☐ **药物相互作用审查**：把所有在吃的东西（包括中药、保健品）列给医生。
- ☐ **心理社会评估**：近期重大生活事件、家庭关系、工作状况、经济压力、社会支持。
- ☐ **症状与功能评估**：用标准化量表（如 PHQ-9）和功能评估，而不是只凭“感觉好点没”。
- ☐ **自杀风险评估**：直接问，不要回避。

“假难治”原因	常见线索	怎么查
剂量或疗程不足	一直吃低剂量、几周就换药	核对用药时间线
依从性差	家里剩药多、复诊时说不清	直接问漏服天数、让家属参与
双相障碍	有过兴奋少眠、冲动、家族史	详细追问、用筛查工具
甲状腺问题	怕冷、便秘、体重增加、反应慢	查 TSH、必要时查抗体
睡眠呼吸暂停	打鼾、憋醒、白天嗜睡、晨起头痛	睡眠监测
药物相互作用	同时用抗癫痫药、圣约翰草、吸烟	逐条核对用药清单
心理社会压力	持续冲突、贫困、照护负担	面谈、社会支持评估

这张表不是让你自己诊断，而是让你知道：**“两种药无效”这句话，值得被拆开来看。** 很多时候，纠正其中一个环节，治疗反应就变了。

四、复评之后，怎么理解“难治”这个标签

如果系统复评做完了，确实排除了上述问题，两种不同类别的药都足量足疗程用过，效果仍不理想，那么“难治性抑郁”这个描述是成立的。但它描述的是一段治疗史，不是一个人的本质。

有几件事值得记住：

- 难治性抑郁仍然可以治疗。换药、增效、rTMS、MECT、氯胺酮、心理治疗、康复支持，都还有空间。具体怎么组合，可以看 5.3 难治性抑郁的综合路径。
- “难治”不等于“对所有治疗都无效”。很多人是在第五种、第六种方案，或者第一次物理治疗时才好转的。
- 反复失败会带来习得性无助，这种无助本身会让人觉得“没必要再试”。这时候，家属和医生的态度很重要：不空喊“会好的”，也不附和“确实没救了”，而是一起看“下一个具体选项是什么”。
- 复评本身就有治疗意义。把混乱的用药史理清楚、把没查的检查补上、把没说出口的压力说出来，很多人会发现，自己并不是“无药可救”，而是“一直没被完整地评估过”。

五、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即呼叫 120 或去急诊**：出现自杀计划或准备行为、已经自伤；拒绝进食进水、明显脱水；意识模糊、高热、肌肉僵硬（警惕严重药物反应）；抽搐、晕厥、胸痛。
>
> **尽快联系精神科医生**：情绪在调整方案后明显恶化；出现转躁迹象（睡得少却精力旺盛、话多、冲动）；副作用严重到影响生活；连续多日几乎不睡。
>
> 有自杀念头时不要独处，让家人陪着，把可能用于自伤的物品交给他人保管，拨打 120 或 12356 心理援助热线。

六、常见问题与容易踩的坑

“我吃了两种药都没好，是不是没救了？” 不一定。先确认这两种药是不是足量足疗程、是不是不同类别、有没有漏服、有没有被误诊。很多“难治”在复评后会发现可以纠正的因素。

“是不是药吃得越多越好？” 不是。加药要有理由，也要有监测。叠加多种药会增加副作用和相互作用，未必提高缓解率。

“我自己要求换药行不行？” 可以提出，但不要自行换。换药涉及撤药反应、交叉耐受、复发风险，需要医生根据你的情况安排。

“查甲状腺、查血有必要吗？” 有必要。这些检查便宜、容易做，能排除一批可纠正的原因。

容易踩的坑：

- 把“感觉好一点”当成“够了”，停在不足的剂量上。
- 因为早期副作用自行减量，却告诉医生“我一直在按你说的吃”。

- 只看情绪，不看睡眠、体重、怕冷、打鼾这些线索。
- 频繁换医生、换医院，每次从头开始，没人看到完整的治疗史。
- 把“难治”当成身份，停止尝试；或者反过来，拒绝承认困难，不停加药。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.2 换药还是增效

当第一种抗抑郁药效果不理想时，下一个决定往往卡在这里：是把药换掉，还是在原来的基础上加一种？这两个选择没有绝对的优劣，答案取决于你之前用了什么、反应如何、副作用能不能忍、有没有共病、经济和时间上能不能支撑。这一页把两种策略的证据、适用场景和风险摊开讲，帮你在诊室里问出关键的那几个问题。

一、两种策略分别在做什么

换药（switch），是把现在这种药停掉或逐渐减掉，换成另一种。换的药可以是同一类里的另一种（比如一种 SSRI 换成另一种 SSRI），也可以是不同机制（比如 SSRI 换成 SNRI、安非他酮、米氮平），还可以换到更老的类别（三环类、单胺氧化酶抑制剂）。思路是：既然这条路走不通，换一条路试试。

增效（augment），是在保留原来抗抑郁药的基础上，加一种本身通常不算抗抑郁药的药物，或者加第二种抗抑郁药。思路是：原来的药可能已经起了一部分作用，只是不够，加一个“帮手”把效果推上去。

两者的根本区别在于：换药是“替换”，增效是“叠加”。这决定了它们在风险、费用、起效时间和适用人群上的差异。

二、证据：谁更占优

到目前为止，没有哪一项研究能证明“换药一定优于增效”或反过来。多部指南的建议是：两种策略都可以，根据具体情况选。【指南】

被引用最多的是 STAR*D 研究。它分四步治疗难治性抑郁：第一步用一种 SSRI，无效的人第二步随机分到“换药”或“增效”，第三步、第四步继续调整。研究结果显示，每一步都有一部分人达到缓解，但缓解的比例逐步下降；四步累积下来，大约三分之二的人在某一步缓解。【研究】

这个结果常被这样解读：“只要坚持试，大多数人最终会好。”这话有一部分道理，但需要补充几点：

STAR*D 说明了什么：

- 难治性抑郁不是“试一种药无效就结束”，多步调整是有意义的。
- 换药和增效在第二步的缓解率接近，没有哪一种是明显更优的默认选项。
- 每一步都需要足够的时间和剂量，频繁更换反而浪费机会。
- 即便达到缓解，后续复发也不少见，维持治疗很重要。

STAR*D 不能说明什么：

- 它不能告诉你“哪一种药对你最合适”。它比较的是策略，不是个体。
- 它是开放标签研究，没有安慰剂对照，医生和患者都知道在用什么，期望效应难以排除。
- 脱落率很高，中途退出的人可能恰恰是效果最差的，结果可能被高估。
- 它用的是当时的药物和剂量策略，和现在的临床实践有差距。
- 它不适用于双相抑郁、精神病性抑郁、紧张症，这些人需要另外的路径。
- 它不能证明“所有治疗都差不多”，也不能证明“只要一直试就一定能好”。

所以，STARD 的正确用法是：它告诉你“多步治疗是合理的”，而不是“照着它的顺序走”。具体到个人，还要看既往反应、副作用、共病和偏好。

三、什么情况优先换药，什么情况优先增效

情况	更倾向	理由
一点效果都没有，副作用也明显	换药	既无效又难受，没必要继续叠加
有效果但只好了部分，副作用可耐受	增效	保住已有的疗效，再加一把力
第一次发作、希望方案简单	换药	减少用药种类，依从性更好，费用更低
既往对某类药有明确疗效	换同类或换回	个人反应史比群体数据更有参考价值
共病多、已在吃多种药	谨慎增效或换药	叠加越多，相互作用和副作用越难管理
有转躁风险、双相可能	先评估双相	单用抗抑郁药可能加重病情，需心境稳定剂
孕期、哺乳期	个体化评估	换药和增效都涉及胎儿暴露，需专科会诊
经济压力大	换药（仿制药）	增效往往意味着两种药加更多监测

还有一条常被忽略：**换药不一定比增效“轻”**。换药要经历旧药减量、新药起效的空窗期，这段时间症状可能反复，撤药反应也可能很难受。增效则要承担两种药的副作用叠加、相互作用和更复杂的服药方案。没有免费的选项。

四、换药：怎么换，风险在哪

换药有几种方式：直接换（停一种、马上开始另一种）、交叉换（旧药逐渐减、新药逐渐加，两者有一段时间重叠）、以及经过清洗期的换（先停旧药一段时间再上新药）。具体用哪种，取决于药物的半衰期、相互作用、撤药反应的强弱。**这一步必须由医生安排，不要自己操作。**

换药的风险包括：

- **撤药反应**：头晕、恶心、失眠、电击感、焦虑加重，尤其在短半衰期的药突然停用时。
- **空窗期复发**：旧药停了、新药还没起效，症状可能反弹。
- **新药的副作用**：每种药的副作用谱不同，换药不等于“没有副作用”。
- **失去已有的部分疗效**：有些人换药后反而怀念原来那种“虽然不够好但还能过”的状态。

- **相互作用**：某些换药组合（尤其是涉及 MAOI、三环类）需要严格的清洗期和监测，处理不当有严重风险。

换药的优点是方案简单、费用通常更低、依从性更好。缺点是可能把已有的部分效果丢掉，而且下一次起效仍要等几周。

五、增效：加什么，代价是什么

增效的选项不少，证据强弱差别很大。下面按证据分量大致排一下，具体用哪个由医生决定。

增效药物	证据分量	主要代价
非典型抗精神病药（如阿立哌唑、喹硫平）	研究支持较多，部分有适应证	体重增加、代谢异常、嗜睡、静坐不能
锂盐	经典增效方案，研究支持较早	需定期查血药浓度、甲状腺和肾功能
甲状腺素（T3）	有一定研究支持	心悸、失眠、长期对骨骼和心脏的影响
安非他酮联合	临床常用，研究支持中等	失眠、焦虑、降低癫痫阈值
丁螺环酮等	证据较弱，效果有限	头晕、恶心，起效慢

增效的共性风险是：**药越多，相互作用和副作用越难归因**。出现一个新症状时，很难判断是哪种药引起的；服药方案变复杂，漏服和吃错的概率上升；费用和复诊次数增加。有些增效药物（如锂盐、部分抗精神病药）需要定期抽血监测，这对偏远地区、行动不便的人是实际的门槛。

增效的优点是：不用放弃已经起效的那部分，避免换药空窗期的风险；对“部分应答”的人，往往比彻底换药更划算。

六、怎么根据既往反应和副作用选

这是最个体化的一部分，也是指南给不出标准答案的地方。可以沿着几条线索想：

既往哪种药有效过？ 不管是这次还是几年前，只要有过明确的疗效，同类药或同一机制的药再次有效的概率更高。家族里有人对某种药反应好，也可以作为参考，但证据不强。

哪种副作用你最不能接受？ 如果上一种药让你体重增加很多、性功能受影响、整天犯困，那么换药时要优先避开同类副作用；增效时也要考虑新加的药的副作用会不会叠加。有人宁愿情绪差一点也不要发胖，有人宁愿嗜睡也不要焦虑加重——这是价值判断，没有对错。

你更怕“反复”还是更怕“复杂”？ 怕反复的人，可能更愿意增效保底；怕吃太多药、怕相互作用的人，可能更愿意换药。

现实条件允许什么？ 增效可能需要更频繁的复诊和抽血；某些药价格高、医保不覆盖；换药可能需要请假度过调整期。

有没有必须先处理的问题？ 如果还没查甲状腺、还没排除双相、还在大量饮酒、还在失眠，那么先处理这些，比急着换药或加药更有效。

七、共同决策：把这些问题带回诊室

- ☐ 我之前用过的药，剂量和疗程够不够？有没有可能其实没试到位？
- ☐ 我现在是“完全没效”还是“好了一部分”？这决定换还是加。
- ☐ 换药的话，选哪一种？为什么？怎么换？空窗期怎么处理？
- ☐ 增效的话，加哪一种？证据有多强？需要监测什么？
- ☐ 两种方案各自的风险、费用、起效时间大概是什么样？
- ☐ 如果这个方案无效，下一步是什么？有没有一个大致的时间表？
- ☐ 我现在的其他药、保健品、饮酒习惯，会不会有相互作用？
- ☐ 我需要观察哪些副作用？出现什么要马上联系你？

把这些问清楚，不是为了“考医生”，而是为了让决定是两个人一起做的。共同决策不等于“患者说了算”，也不等于“医生说了算”，而是把双方掌握的信息放在一起，选一个都能接受、也能执行的方案。

八、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即呼叫 120 或去急诊：**服用锂盐后出现持续呕吐、腹泻、手抖明显加重、走路不稳、意识模糊、抽搐（警惕锂中毒）；服用抗精神病药后出现高热、肌肉僵硬、意识改变、大汗（警惕恶性综合征）；出现转躁伴冲动伤人、极度兴奋、连续多日不睡；出现自杀计划或自伤行为。
>
> **当天联系医生：**换药后出现严重撤药反应（剧烈头晕、电击感、恶心呕吐、焦虑失控）；新药引起皮疹、面唇肿胀、呼吸困难；心悸、胸痛；情绪急剧恶化。
>
> 有自杀念头时不要独处，让家人陪着，拨打 120 或 12356 心理援助热线。

九、常见问题与容易踩的坑

“换药是不是说明之前的药白吃了？” 不是。每种药对每个人的效果不同，试错是治疗的一部分。重要的是把每次用药的反应记录下来，让下一次选择更有依据。

“增效是不是药越吃越多，以后更难停？” 增效确实会增加用药种类，但不等于“停不下来”。很多人在缓解后可以逐步简化方案，关键是不要在最不稳定的时候自行减药。

“能不能两种一起上，好得快？” 换药和增效同时进行，会让副作用和相互作用难以判断，通常不建议在没有明确理由时这么做。

“医生说换药，我在网上查到另一种更好，能不能要求换那种？” 可以讨论，但“别人说好”不等于“对你好”。把查到的信息带给医生，让医生解释为什么选这个、不选那个。

容易踩的坑：

- 因为一次换药失败，就认定“所有药都没用”。
- 自己把两种药叠着吃，或把旧药停得太快。

- 只盯着情绪，不记录睡眠、体重、性功能、排便这些副作用，复诊时说不清。
- 在还没排除双相、甲状腺问题、物质使用时，就急着升级治疗。
- 把 STAR*D 的“三分之二能缓解”当成对自己的承诺。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

5.3 难治性抑郁的综合路径

走到“难治性抑郁”这一步，人很容易陷入两种极端：一种是不断加药、换药，希望某一种组合能一击命中；另一种是彻底放弃，觉得所有治疗都是白费。真实的难治性抑郁，往往不是靠“再加一种药”解决的，而是靠几条线同时推进：药物、心理、物理治疗、康复与个案管理。这一页讲这四条线各自做什么、怎么组合、什么时候该转到更专门的中心，以及家属能帮上什么忙。

一、为什么难治性抑郁需要“组合”，而不是“再换一种药”

难治性抑郁不是一个单一的问题，而是一组问题的集合：有人主要是生物学因素（遗传、炎症、内分泌），有人主要是心理社会因素（创伤、长期压力、人际冲突），有人是两者交织，还有人被睡眠呼吸暂停、慢性疼痛、物质使用拖着。**用一种手段去解决一组异质的问题，本来就不容易奏效。**

组合治疗的意义在于：不同手段作用于不同的环节，彼此补位。药物改善睡眠、食欲、精力这些生理基础；心理治疗处理“我不行”“没意义”的认知和回避行为；物理治疗在药物起效慢或无效时提供另一条通路；康复和个案管理解决“怎么回到工作、怎么维持治疗、怎么不让生活彻底停摆”这些现实问题。

组合也不是“越多越好”。每加一种治疗，就多一份时间、费用、副作用和管理负担。好的组合是有目标的：这个阶段最想解决什么，用哪种手段最直接，什么时候评估、什么时候撤。

二、四条线：各自做什么

线	具体做什么	谁来负责	什么时候加
药物	优化剂量、换药、增效、处理副作用和相互作用	精神科医生	全程，每次复评后调整
心理	CBT、行为激活、IPT、MBCT、支持性治疗	心理治疗师、精神科	越早越好，与药物并行
物理	rTMS、MECT、氯胺酮	专科治疗团队	两种药物无效、症状重、需快速控制时
康复与个案管理	睡眠、运动、营养、逐步复工、家庭协调、随访提醒	康复师、社工、护士、家属	急性期后尽早介入，贯穿全程

药物线。 难治性抑郁的药物治疗不是“不断加药”，而是“有理由地调整”：确认剂量和疗程是否到位、是否需要换机制、增效药物的证据和风险、副作用能不能耐受、相互作用有没有被忽略。具体怎么换、怎么加，可以看 5.2 换药还是增效。

心理线。 很多人以为“都难治了，心理治疗肯定没用”，这是误解。心理治疗在难治性抑郁里仍有位置，尤其是当症状与回避、反刍、人际冲突、创伤、无价值感密切相关时。行为激活对“什么都不想做”的状态尤其直接：不等情绪好了再行动，而是用小的、可完成的活动把生活重新启动。CBT 处

理“我永远好不了”这类想法，IPT 处理角色转换和人际冲突。心理治疗不是“聊聊天”，它需要结构、练习和稳定的频率，具体可以看 3.1 心理治疗总览与证据。

物理线。 rTMS 适合能配合、需要非药物选项、药物效果不佳的人；MECT 适合症状重、有精神病性症状、紧张症、拒食、高自杀风险、需要快速控制的人；氯胺酮适合部分难治性患者，起效快但需要严格监测和维持。三者不是互相替代的关系，而是不同场景下的不同工具。分别见 4.1 重复经颅磁刺激 rTMS、4.2 无抽搐电休克 MECT、4.4 氯胺酮与艾司氯胺酮。

康复与个案管理线。 这是最容易被忽略、却最影响长期结果的一条。它包括：把睡眠和作息稳定下来、从每天十分钟的运动开始、处理饮酒和吸烟、逐步恢复工作和社交、协调家庭分工、提醒复诊和取药、在复发早期识别信号。对反复住院、独居、家庭关系紧张、经济困难的人，个案管理（由护士、社工或个案管理员跟进）能显著减少“治疗断档”。

三、一个可能的顺序（不是标准答案）

真实世界的顺序往往是这样，但每个人都不一样：

1. **先复评。** 确认诊断、用药史、依从性、共病、心理社会因素。这一步做不扎实，后面的升级都是建在沙子上。见 5.1 难治性抑郁的评估。
2. **优化现有治疗。** 把剂量和疗程补到位，处理副作用，纠正相互作用，治疗共病（甲状腺、睡眠呼吸暂停、疼痛、焦虑、物质使用）。
3. **换药或增效。** 根据既往反应、副作用、共病和偏好选，给足时间评估。
4. **引入物理治疗。** 症状重、需要快速控制，或药物调整效果有限时，考虑 rTMS、MECT、氯胺酮。
5. **心理治疗全程并行。** 不要等到“药都试完了”才开始。
6. **康复与个案管理。** 从急性期后就开始，而不是“好了再说”。
7. **维持与复发预防。** 缓解后继续治疗足够长时间，建立个人化的预警清单和安全计划。

这个顺序不是铁律。有人需要先做 MECT 把命保住，再谈其他；有人一上来就应该处理创伤；有人最紧迫的是戒酒。顺序由“当前最危险、最可改变的问题”决定。

四、什么时候该转到难治性抑郁中心

大多数难治性抑郁可以在当地精神专科处理。但有些情况，转到有难治性抑郁门诊、物理治疗中心或教学医院，会更合适：

- 已经两种以上不同类别抗抑郁药足量足疗程无效，当地没有 rTMS、MECT 或氯胺酮条件。
- 诊断不确定：怀疑双相、精神病性抑郁、紧张症、神经科疾病、复杂共病。
- 高自杀风险、反复住院、反复自伤，需要更密集的评估和安全计划。
- 孕期、产后、老年、青少年等特殊人群，需要多学科会诊。
- 需要复杂联合用药（多种增效药、锂盐、MAOI），当地监测条件不足。

- 治疗依从性极差、家庭支持系统薄弱，需要个案管理。
- 已经尝试多种方案仍无改善，需要重新做系统性评估，而不是继续“试下一种”。

转诊不是“被放弃”，也不是“当地医生不行”。它更像是把复杂病例交给更专门的团队，同时把当地的随访、取药、家庭支持接上。转诊前，把既往用药时间线、检查结果、心理治疗记录整理好，能省掉很多重复。

五、家属能做什么，别做什么

家属的作用被低估得厉害。做得对，能显著提高治疗连续性和安全性；做得不对，好心也会变成压力。

可以做的：

- ☐ 陪就诊，帮忙记医嘱，提醒复诊和取药。
- ☐ 观察并记录睡眠、食欲、情绪、活动的变化，复诊时带给医生。
- ☐ 在患者不想说话时，安静地陪着，不逼问“你到底怎么了”。
- ☐ 把“你怎么又这样”换成“我看到你很累，我能帮你做哪一件小事”。
- ☐ 协助管理药物：分装药盒、设置提醒，但不擅自增减。
- ☐ 留意危险信号：提到不想活、交代后事、突然“平静”、囤药、告别。
- ☐ 把家里的危险物品（多余药物、利器、绳索）暂时收好。
- ☐ 自己也要有支持：找亲友、加入家属互助、必要时看医生。

别做的：

- 不要说“想开点”“比你惨的人多了”“你就是太闲”。
- 不要用“加油”“振作”代替具体的帮助。
- 不要偷偷把药换掉、减掉，或把药藏在饭里。
- 不要因为一次治疗没效就说“这医院不行”，频繁换医生。
- 不要把所有生活重心都放在患者身上，家属垮了，支持系统就断了。
- 不要在患者面前讨论“要不要放弃”，这类话题需要和专业团队一起谈。

六、现实预期：不放弃，但不承诺

难治性抑郁的结局不是二元的“治好”或“治不好”。更现实的图景是：

- 一部分人能达到缓解，恢复正常生活；
- 一部分人达到部分缓解，症状减轻但仍有残留，需要长期管理；
- 一部分人症状反复，需要在不同方案之间调整；
- 几乎所有人都需要维持治疗和复发预防，而不是“好了就停”。

“不放弃”不等于“保证能好”。它更准确的意思是：**还有选项，还可以调整，还可以把目标从“彻底没有症状”换成“能睡、能吃、能出门、能工作几小时、不再想死”。** 功能和生活质量的改善，本身就是治疗的成功，不必等到“完全正常”才算数。

对家属来说，最难的往往是接受“可能长期如此”。这不是消极，而是把力气用在能改变的地方：稳定的随访、规律的生活、减少冲突、识别复发信号、保住患者的社会角色。很多时候，正是这些“不起眼”的事，让人熬过了最难的几年。

七、什么时候需要联系医生 / 去急诊

> **立即呼叫 120 或去急诊**：有自杀计划、准备行为或已经自伤；拒绝进食进水、明显脱水、意识模糊；高热、肌肉僵硬、抽搐；胸痛、晕厥、呼吸困难；出现命令性幻听（听到声音命令自己做危险的事）。
>
> **尽快联系精神科医生**：情绪在几天内急剧恶化；出现转躁迹象（睡得极少却精力旺盛、话多、冲动）；药物副作用严重到无法忍受；连续多日几乎不睡；家属发现患者开始囤药、告别、交代后事。
>
> 危机时不要独处，让家人陪着，把危险物品交给他人保管，拨打 120 或 12356 心理援助热线。可以提前和家人一起填好 9.2 安全计划模板。

八、常见问题与容易踩的坑

“综合治疗是不是要花很多钱？” 组合治疗确实可能增加费用，但不是每一条线都要同时上。可以和医生讨论优先级：哪些是现在必须的，哪些可以等，哪些有便宜但等效的替代。医保、门诊慢特病、公益资源都值得了解。

“心理治疗对难治性抑郁真的有用吗？” 有用，但不是“做了就不复发”。它更多是帮助改变回避、反刍、人际模式和应对方式，效果需要时间和练习。

“是不是一定要去大城市的大医院？” 不一定。稳定的随访、正确的诊断、规范的用药，在多数精神专科都能做到。需要转诊的是那些本地条件确实不够的情况。

“家属要不要辞掉工作照顾？” 这是很现实的问题，没有标准答案。长期照护需要可持续的安排，短期高强度陪伴之后往往需要轮换和支持。家属先保住自己的生活和健康，才可能长期支持别人。

容易踩的坑：

- 把所有希望押在“下一种药”上，忽略心理、康复和现实问题。
- 频繁更换医生和医院，每次从头开始，治疗史断裂。
- 家属过度包办，患者的社会功能进一步退化。
- 把“部分缓解”当成失败，放弃已经有效的治疗。
- 在患者最糟糕的时候讨论“以后怎么办”，而不是先处理当下安全。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 6：特殊人群与特殊时期

同一套治疗原则，放到青少年、老人、孕产妇、躯体疾病患者身上，重点完全不同。这一模块讲“需要额外注意什么”，不替代专科面诊。

6.1 青少年抑郁

青少年抑郁最容易被两句话耽误：一句是“这就是青春期”，一句是“他就是不想上学”。这一页写给青少年患者本人，也写给不知道该怎么帮的家长和老师。读完你能分清“青春期的正常起伏”和“需要就医的抑郁”，知道家庭和学校具体能做什么、心理治疗和药物各自站在什么位置，以及哪些信号必须当天找医生。

一、青少年的抑郁，常常不长成“难过”的样子

很多家长以为抑郁就是整天哭、说“活着没意思”。青少年更常见的却是另一套表现，有时连本人也说不清哪里不对。

- **易激惹**：为小事爆发，摔门、顶嘴、跟同学起冲突，事后自己也莫名其妙。青少年抑郁可以表现为“脾气变大”，而不只是“情绪低落”。
- **躯体不适**：反复头痛、肚子痛、恶心、胸闷、乏力、腿软。查了血、做了检查没发现问题，但难受是真实的。身体不适常常是青少年表达痛苦的入口。
- **成绩下降**：不是单纯“不努力”，而是注意力散、记不住、作业启动困难、考试时大脑空白。这些是抑郁影响认知的常见结果。
- **退缩**：退出原来的朋友圈、不再参加喜欢的活动、把自己关在房间里、饭桌上不说话。
- **睡眠与食欲改变**：入睡困难、早醒、白天睡很久；吃不下或暴食。青少年睡眠本身偏晚，所以要对比“他自己的基线”有没有明显变化。
- **自伤**：划手臂、掐自己、撞头。自伤常是“想把难受压下去”，不等于自杀企图，但确实是需要认真对待的信号。
- **网络使用明显增多**：往往不是原因，而是结果——逃避、麻痹、寻找同类；也可能反过来加重失眠和自我否定。

这些表现单独看都不特殊，青春期也会有。区别在四个地方：**持续时间**（大多数日子、连续两周以上）、**跨场景**（家里和学校都不对）、**功能损害**（成绩、朋友、日常自理明显退步）、**有没有快感缺失和无价值感**（以前喜欢的事现在一点意思都没有；觉得自己是负担）。

方面	成人更常见	青少年更常见	容易被误认为
主要情绪	低落、想哭、无望	易激惹、烦躁、发脾气	叛逆、没礼貌

方面	成人更常见	青少年更常见	容易被误认为
身体	疲乏、疼痛	头痛、腹痛、恶心、乏力	装病、逃避上学
学习	效率下降	成绩骤降、拒绝上学	懒、不想读书
表达	主动说“我很难受”	说“烦”“别管我”或干脆不说	不愿沟通、青春期

【指南】以上差异在诊断标准里有体现：青少年抑郁可以表现为持续性易激惹，而不必是典型的心情低落。

二、“青春期”不是解释，而是一个需要排除的假设

把变化归给“青春期”，最大的风险不是判断错，而是**延误**。情绪问题拖过一两年，学业、同伴关系、自我认同都会跟着受损，而这些损失又会反过来加重抑郁。

需要一起区分的，至少有五类情况：

1. **青春期的正常起伏**：情绪有高有低，但愉快体验还在，睡一觉或过几天能缓过来，学习和朋友基本维持。
2. **适应反应**：转学、分手、父母冲突、被排挤之后出现，通常几周内逐渐缓解，支持到位时不需要用药。
3. **抑郁发作**：持续两周以上、跨场景、功能受损，符合上一节的四个特征。
4. **其他精神障碍**：焦虑障碍、社交恐惧、ADHD、创伤后应激、强迫、双相。尤其双相，青少年首次发作常是抑郁，如果只按单相抑郁治，可能诱发转躁。
5. **躯体原因**：甲状腺功能异常、贫血、慢性感染、睡眠呼吸暂停、药物或物质影响。持续疲乏、体重下降、月经紊乱，都要查一查身体。

所以一次靠谱的评估，通常要问：什么时候开始、中间有没有好过、在家和在学校是否一样、有没有轻躁狂的表现（一段时间睡得很少却不困、话特别多、想法飞快、花钱冲动）、家族史、自伤和自杀念头、有没有被霸凌或创伤。这些不是“多问”，而是决定治疗方向的关键。

三、家庭和学校：能做和不该做的

青少年抑郁的治疗，很少只发生在诊室里。家庭氛围和学校安排，直接决定治疗能不能落地。

家庭可以做的（可以照着勾）：

- ☐ 先处理安全，再谈成绩。明确问过“有没有想过伤害自己”，并把家里的危险物品收好。
- ☐ 把“你怎么又不……”换成描述事实：“我看到你这周有三天没去上课，我有点担心。”
- ☐ 药物由家长保管、按医嘱给，不把药交给孩子自己管，也不把药当成“听话的奖赏”。
- ☐ 和学校指定**一个**固定联络人（班主任或心理老师），避免多头沟通、反复解释。
- ☐ 和学校谈阶段性减负：弹性作业、暂缓排名、允许在医务室或心理室短暂休息。

- ☐ 复学要分级：先每天去一两节课，再半天，再全天，允许反复。
- ☐ 减少家里的高情绪表达——频繁批评、争吵、冷暴力，与抑郁复发相关。
- ☐ 家长自己找支持：亲友、家长团体、心理咨询。家长垮了，孩子会更没有安全感。

容易帮倒忙的做法：

常见做法	可能后果	可以换成
“别人都能扛，就你矫情”	孩子学会隐瞒，风险升高	“你现在很难，这不是你的错”
偷看日记、查手机	信任破裂，彻底闭口	提前说明担心什么，约定边界
“吃药就是脑子有病”	拒绝治疗，延误病情	把药说成“帮大脑恢复的工具”
只要成绩恢复就停药	复发率高，前功尽弃	疗程由医生定，不随心情改

学校这一端，最重要的是**别把抑郁当成纪律问题**。频繁迟到、上课睡觉、不交作业，可能是症状而不是挑衅。学校能做的包括：允许短期请假、安排补考、制止霸凌、提供心理老师会谈、在危机时启动预案（联系家长、陪同到医务室、必要时送医）。

四、心理治疗和药物：两条主线，不是二选一

心理治疗：CBT 与 IPT-A

CBT（认知行为治疗） 适合能进行一定反思、愿意做练习的青少年。它做三件事：识别“我一无是处”“考不好就完了”这类自动化想法；用行为实验去检验；通过行为激活把“等有动力再做”改成“先做一点”。通常每周一次，持续十几次，中间有家庭作业。【指南】

IPT-A（青少年人际心理治疗） 把抑郁放回人际关系里看，焦点通常是四类：角色转换（升学、搬家、父母离异、分手）、人际冲突、丧失、社交上的孤单。青少年版会安排家长参与部分会谈，一起练习沟通。【指南】

此外，家庭治疗适合冲突激烈的家庭；DBT-A（辩证行为治疗青少年版）对反复自伤、情绪剧烈波动的青少年更有针对性。【研究】

一个常见误解是“孩子进去谈，家长在外面等结果”。青少年治疗里，家长参与往往直接提高效果——不是监督孩子说了什么，而是一起改互动方式。

药物：为什么医生开得格外谨慎

轻中度青少年抑郁，指南一般建议先做心理治疗；中重度、心理治疗无效、功能严重受损（不能上学、持续自伤、明显拒食）时，才会考虑药物。【指南】

在青少年中研究证据最多的是氟西汀，部分国家的审批允许用于青少年；其他抗抑郁药也有使用，但证据强度和审批范围不同。**具体用不用、用哪一种，必须由儿童青少年精神科医生评估决定**，普通成人精神科或儿科医生的经验也很重要。

关于**黑框警告**，需要说清楚它到底在说什么：在 25 岁以下人群中，起始抗抑郁药后，自杀念头和自杀行为的风险可能轻度升高，尤其在用药最初几周以及调整剂量之后。它不是说“药会让人自杀”，而是说“这段时间必须有人盯着”。【指南】

监测要具体到人和动作：

- 谁观察：最好是一位固定的家长，另一位老师知情。
- 观察什么：坐立不安、激越、失眠加重、话变多、冲动、异常兴奋、自伤念头、说“活着没意思”。
- 多久联系一次：起始和加量阶段通常需要更密的随访，具体频率听医生的。
- 出现什么立刻打电话：出现新的自伤行为、说不想活、行为明显反常。

三条底线：不自行加量，不自行减量，不自行停药。突然停用可能出现头晕、恶心、失眠、电击感等撤药反应，也会抬高复发风险。

也不要因为怕“伤脑子”而拒绝治疗。目前没有证据支持规范使用抗抑郁药会损害智力；相比之下，未经治疗的抑郁对学习、记忆、社交发展的影响要实在得多。

五、拒绝上学、自伤与网络使用

拒绝上学不是懒，也不是单纯对抗。背后常见的是焦虑（离开家就恐慌、怕在同学面前出丑）、被霸凌、抑郁导致的动力缺失，或睡眠节律彻底颠倒。处理原则是三件事同时做：治疗（药物和/或心理治疗）、分级复学（从一两节课开始，允许反复）、学校配合（减负、指定安全的人、处理霸凌）。两个极端都要避免：强行押送去学校，会把学校变成恐惧源；长期默认不去，则会让回避越来越牢固。

自伤在青少年中并不少见，功能常常是“把汹涌的情绪压下去”或“让自己感觉还活着”。它不等于自杀企图，但确实是未来自杀风险的重要预测因素。回应方式：不指责、不追问“你为什么这样”；清理家里的危险物品；尽快安排专业评估；不承诺“绝对保密”——涉及安全时，保密必须让位。

网络使用不要用“没收手机”一招解决。先看它在承担什么功能：是逃避、是找同伴、是熬夜刷视频，还是被网暴。然后一起定规则：卧室不放充电器、睡前留出一段无屏幕时间、约定夜间断网，家长自己也要做到。如果孩子在网上被威胁、被敲诈、被诱导，这属于安全问题，要留证据、找学校、必要时报警。

容易踩的坑

- **“长大就好了”**：有一部分确实会缓解，但无法提前知道是哪一个。功能已经受损时，等待的代价太大。
- **“吃药会上瘾、会变傻”**：抗抑郁药不属于成瘾物质，规范使用没有证据支持损伤智力。真正的风险是不监测、不复诊。

- **“心理咨询就是聊天，不如补课”**：CBT 和 IPT-A 是有结构、有作业、有疗程的治疗，和补课解决的是不同问题。
- **“成绩上去了病就好了”**：成绩是结果，不是原因。只抓成绩，常常把孩子的自我价值彻底绑在分数上。
- **“问了自杀会不会教他”**：不会。直接、平静地问，通常让青少年松一口气。
- **家长之间互相指责**：谁基因不好、谁管得太严。这对孩子没有任何帮助，只会让他觉得自己是家里的麻烦。

六、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 已经自伤且出血不止、意识不清、吞服了药物或其他物品；
- 明确说“我要去死”，或有计划、有准备行为（攒药、查方法、告别）；
- 出现高热、肌肉僵硬、抽动、大汗、意识混乱（可能是严重的药物不良反应）；
- 突然极度兴奋、几乎不睡、话多到停不下来、冲动到无法控制（可能是转躁）；
- 拒食、几乎不喝水超过一天，或出现晕厥。

当天联系开药医生或精神科：

- 新出现自伤行为，或自伤频率明显增加；
- 用药后出现坐立不安、激越、失眠突然加重、行为反常；
- 连续多日几乎不上学，或完全不出房门；
- 出现“我不在了对大家都好”这类表达。

一周内复诊或加约一次： 情绪、睡眠、食欲持续变差超过两周；学校已无法维持，需要开证明或调整安排；家长不知道怎么开口，希望医生帮忙沟通。

不确定算不算严重时，按严重处理。也可以拨打 12356 心理援助热线，先听听专业人员的判断。

参考来源

- NICE. Depression in children and young people: identification and management (NG134). https://www.nice.org.uk/guidance/ng134
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；青少年用药与心理治疗方案须由儿童青少年精神科专科医生面诊后决定，具体方案以面诊医生为准。

6.2 老年抑郁

老年抑郁最容易被漏掉，因为它常常不表现为“难过”，而表现为“浑身不舒服”“记性变差”“不想动”。家属以为是老了，医生先查身体，一拖就是一两年。这一页写给 60 岁以上患者的家属和本人，讲清楚老年抑郁长什么样、为什么用药要格外小心、照护者能做什么，以及哪些情况必须马上送医。

一、老年抑郁常常“不说难过，只说难受”

很多老年人不承认自己情绪低落。在他们的成长经验里，“心情不好”不是病，说出来像矫情。于是痛苦从别的地方冒出来：

- **躯体化**：反复说头晕、心慌、胃不舒服、后背疼、没力气、吃不下。检查做过一轮，没发现能解释全部症状的病变，但人确实瘦了、弱了。
- **认知下降**：记不住事、算不清账、话变少、反应慢。家属第一反应是“是不是痴呆”。抑郁本身就会拖累注意力和记忆，医学上常说的“抑郁性假性痴呆”指的就是这种情况——治疗后能明显好转。
- **淡漠**：不悲伤，也不高兴；不想出门、不想说话、对儿孙的事没兴趣。这种“没劲”比哭泣更常见，也更难被识别。
- **焦虑与激越**：坐不住、反复走动、担心身体、反复要求子女保证“我没事”。
- **睡眠与食欲改变**：早醒（凌晨三四点醒来再也睡不着）在老年抑郁里相当典型；体重下降常被当成“消化不好”。
- **否认与轻描淡写**：问“心情怎么样”，回答“还行”；问“有没有不想活”，回答“活这么大岁数了，无所谓”。这类回答需要进一步追问。

老人说/表现	家属容易理解成	可能是什么
“浑身疼、没力气”	风湿、缺钙、老了	抑郁的躯体表现，也可能两者并存
“记性越来越差”	痴呆	抑郁相关认知下降，需治疗后再评估
“什么都不想干”	性格变孤僻	兴趣丧失、淡漠
“睡不着，早早就醒”	年纪大了觉少	抑郁的睡眠特征
“活着没意思”	随口一说	需要认真评估自杀风险

【指南】老年抑郁的识别率偏低，指南建议对高风险老年人主动筛查，而不是等他自己开口。

二、先排除“不是抑郁”的原因

老年人出现情绪和精力问题时，第一件事不是急着下诊断，而是把能查的原因查掉。这不是“过度检查”，因为有些原因纠正之后，抑郁样表现会明显减轻。

- **甲状腺功能异常**：甲减可以表现为乏力、怕冷、反应慢、情绪低落，和抑郁几乎分不开。

- **贫血、维生素 B12 缺乏、电解质紊乱**：乏力、注意力差、情绪低落都可能是结果。
- **慢性疼痛、便秘、尿路感染**：持续不适会拖垮情绪；老年人感染有时不以发热起病，而是以“突然糊涂、没精神”起病。
- **药物影响**：激素、某些降压药、镇静催眠药、抗胆碱能药物、部分止痛药，都可能引起情绪低落、嗜睡或意识模糊。
- **痴呆早期**：阿尔茨海默病早期可以有淡漠、兴趣减退、易怒。关键区别是：抑郁起病相对快、有明确的时间点、治疗后改善；痴呆更多是持续、单向的进展。
- **谵妄**：突然出现的糊涂、注意力涣散、昼夜颠倒，是急症，不是“抑郁加重”。

如果认知问题在抑郁治疗后仍不改善，或者还在继续变差，就需要做正式的认知评估，而不是一直当成“心情不好”。

三、共病与多重用药：风险常常来自叠加

老年人往往同时有高血压、糖尿病、冠心病、骨质疏松、前列腺增生、青光眼，手里有五六种药。抗抑郁药加进去，问题很少是“这一种药有毒”，而是**几种药的作用叠在一起**。

需要重点盯的五类风险：

1. **跌倒**：镇静作用强的药、降压药、降糖药、抗胆碱能药同时使用，起床时头晕、腿软，一次跌倒可能就是髋部骨折，之后卧床、肺炎、功能急转直下。
2. **低钠血症**：部分抗抑郁药可引起血钠降低，老年人更敏感。表现为乏力、恶心、头痛、反应迟钝、走路不稳，严重时会抽搐、昏迷。开始用药后几周内尤其要留意。【指南】
3. **出血**：合并阿司匹林、氯吡格雷、华法林等抗栓药物时，消化道出血和皮下淤青的风险升高。
4. **QT 间期延长**：心电图上的一个指标，延长到一定程度会增加恶性心律失常风险。合并某些抗心律失常药、抗生素、抗精神病药时要特别小心。
5. **抗胆碱能负担**：口干、便秘、排尿困难、视物模糊、心跳快、记忆变差。三环类抗抑郁药、部分抗精神病药、抗组胺药、膀胱药都有这种作用。负担越重，认知下降和谵妄的风险越高。

风险	早期表现	就诊时要主动说什么
跌倒	起身头晕、走路不稳、夜间频繁起夜	最近有没有摔倒、家里有没有扶手
低钠	乏力、恶心、反应慢、抽搐	有没有查过电解质、最近有没有大量喝水
出血	牙龈出血、黑便、大片淤青	正在吃哪些抗栓药、有没有胃病史
QT 延长	心慌、眼前发黑、晕厥	有没有心脏病、家族猝死史、合并用药
抗胆碱能	便秘、排尿困难、口干、糊涂	青光眼、前列腺增生、便秘史

【临床经验】老年人用药常有一个误区：每个专科各开各的，没有人统看全局。复诊时最好固定一位医生或药师做“用药整理”，把所有药（包括中成药、保健品）列成一张纸带去。

四、治疗：心理治疗、药物与物理治疗各自的位置

心理治疗在老年人身上同样有效，而且常常被低估。CBT 适合愿意谈、能完成简单作业的老人；问题解决治疗结构更简单，聚焦“眼下这件麻烦事怎么办”；人际心理治疗适合丧偶、退休、角色转变后的抑郁；行为激活则从“每天做一件小事”开始，不需要先想通。【指南】对行动不便的老人，上门服务、电话或视频随访都能提高完成率。

药物治疗的原则是：起始更低、加得更慢、复评更勤、药越少越好。【指南】医生通常会避开抗胆碱能作用强的药，优先考虑相互作用少、半衰期相对温和的选择；具体用哪种、用多久，需要结合肝肾功能、心脏情况、合并用药来定，没有统一答案。开始用药后的前几周，家属要帮着观察：有没有变得更糊涂、有没有摔倒、有没有异常困倦。

物理治疗方面，无抽搐电休克（MECT）对老年重性抑郁有明确位置，尤其是伴有精神病性症状（坚信自己得了绝症、罪孽深重）、拒食、或自杀风险很高的情况。【指南】它需要在麻醉下进行，治疗前要评估心脏、血压和认知；常见的记忆影响多数在治疗后逐渐恢复，但需要医生和家属一起权衡。

家属可以照着做的清单：

- ☐ 把全部药物列成一张表：药名、早晚、由谁提醒、吃了多久。
- ☐ 买一个分格药盒，按天分装，避免漏服和重复服。
- ☐ 记录睡眠、食欲、体重、出门次数，复诊时带给医生。
- ☐ 家里加夜灯、卫生间扶手、防滑垫，撤掉松动的地毯。
- ☐ 明确一位“主要联络人”，避免子女之间互相转述走样。
- ☐ 问过一次自杀念头，不要因为“怕晦气”就跳过。
- ☐ 保留老人的社交：老友、棋牌、社区活动、接送孙辈，能做的都让他做。
- ☐ 照顾者自己安排轮班，长期睡不好的照护者也会抑郁。

五、照护者支持与安全

照护是消耗品。一个人长期照顾情绪低落的老人，很容易出现睡眠不足、易怒、无力感，然后开始内疚。这不是不孝，是负荷超限。可以做的：把任务拆开分给家人；申请社区的居家养老服务或喘息服务；加入照护者团体；必要时自己去看医生。

安全方面，几件常被忽略的事：

- **药物管理**：安眠药、止痛药、抗凝药分开存放并上锁；不要让老人自己决定“今天多吃一片”。
- **自杀风险**：老年男性的自杀风险尤其高，而且手段更决绝、成功率高。独居、丧偶、久病、经济压力、觉得自己是负担，都是要盯的信号。【研究】
- **驾驶与用火**：反应变慢、注意力差时，开车和做饭都有风险，需要具体评估，而不是一句“小心点”。

- **诈骗与财务**：抑郁的老人更容易被电话诈骗盯上，也可能做出冲动的财务决定。
- **饮酒**：用酒助眠很常见，但酒精会加重抑郁、增加跌倒和药物相互作用的风险。

容易踩的坑

- **“人老了都这样”**：衰老会带来体能下降，但持续的绝望、兴趣丧失、早醒不是正常衰老。
- **“吃药会变傻”**：真正让认知变差的是未治疗的抑郁、抗胆碱能负担和谵妄，不是规范使用的抗抑郁药。
- **“别告诉他诊断，怕他受不了”**：多数老人能承受，被瞒着反而更孤立。怎么说是技巧问题，不是隐瞒的理由。
- **“多吃几种补品总没坏处”**：保健品会和药物相互作用，也可能含未标明的成分，看医生时要一并交代。
- **一次就诊就想“调好”**：老年抑郁的起效和恢复往往更慢，需要按月看，而不是按天看。

六、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 突然糊涂、说胡话、昼夜颠倒、认不出人（可能是谵妄或低钠）；
- 抽搐、意识丧失、晕厥、摔倒后头部着地；
- 明确说不想活、有具体计划，或已经采取了行动；
- 胸痛、呼吸困难、心跳极快或极慢；
- 高热伴肌肉僵硬、大汗（可能是严重的药物不良反应）；
- 连续几天几乎不吃不喝。

当天联系开药医生：

- 新出现的嗜睡、走路不稳、频繁跌倒；
- 明显的乏力、恶心、反应变慢（要查电解质）；
- 黑便、呕血、大片淤青；
- 情绪突然从低落变得异常兴奋、话多、夜里不睡。

一两周内复诊：

- 体重持续下降、饭量明显减少；
- 记忆问题加重，或家属觉得“越来越不像他”；
- 照顾者已经撑不住。

判断不了严重程度时，按严重处理。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222

- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；老年人的用药、剂量与物理治疗须由精神科与内科医生联合面诊评估，具体方案以面诊医生为准。

6.3 孕产期抑郁

怀孕和产后是抑郁最容易发生、也最容易被“喜事”掩盖的时期。周围人都在说“当妈妈多幸福”，于是很多女性把难受咽下去，怕被说“不知足”“不配当妈”。这一页写给正在备孕、怀孕或产后的女性及其伴侣，讲清楚什么时候该提前规划、治疗与不治疗各自要承担什么、产后哪些信号是急症。所有原则都必须放到精神科与产科联合面诊里，才能变成你自己的方案。

一、孕前就值得谈的一件事

如果已经在服用抗抑郁药，又打算怀孕，最理想的时间点是**备孕之前**，而不是验出两条杠之后。原因很实际：突然停药带来的撤药反应和复发风险，往往比“继续用药再和医生一起调整”更难处理。

孕前该谈的内容：

- 目前的诊断是否明确，是否可能是双相障碍（这直接决定用药方向）；
- 过去停药后有没有复发过，复发时有多严重；
- 现在用的是什么药、为什么用、能不能换、换了要观察多久；
- 有没有其他需要一起考虑的问题：甲状腺、贫血、癫痫、高血压、糖尿病；
- 伴侣和家庭的支持情况，产后由谁帮忙；
- 如果孕期复发，预案是什么。

要特别提醒：**部分心境稳定剂有明确的致畸风险**（例如丙戊酸盐），备孕前必须由精神科医生评估并调整，不能等到怀孕后再处理。【指南】这类决定必须由精神科和产科一起做，不能靠网上查资料自行判断。

备孕阶段可以照着做的清单：

- ☐ 提前一次精神科复诊，明确说“我打算怀孕”，而不是只说“最近还好”。
- ☐ 把正在吃的所有药（包括中成药、保健品）列成清单交给医生。
- ☐ 问清楚：如果怀孕，现在的方案要不要改；如果不改，需要监测什么。
- ☐ 记录自己近半年的情绪、睡眠和月经周期，作为基线。
- ☐ 和伴侣明确分工：夜间喂奶、白天补觉、复诊陪同。
- ☐ 了解本地产科与精神科的联合门诊或围产期心理门诊。
- ☐ 把“复发预警信号”写下来，交给伴侣一份。
- ☐ 不自行减量、隔天吃或停药来“试试看”。

二、治疗与不治疗，各自有什么风险

这是孕产期最难的抉择，因为两边都不是“零风险”。把风险摊开看，比在“吃药伤孩子”和“硬扛对孩子好”之间二选一要清楚得多。

选择	可能的风险	需要一起考虑的因素
不治疗或中断治疗	抑郁加重、拒食、失眠、自伤自杀风险；产检依从性下降；早产、低出生体重与产后抑郁风险升高；母婴互动受影响	既往严重程度、停药后是否复发、目前症状、有没有自杀念头
继续药物治疗	药物通过胎盘或乳汁的暴露；部分药物与少数先天畸形、新生儿适应不良的关联（绝对风险通常较低，研究结果不完全一致）；产后出血风险可能略增	药物种类与剂量、孕周、母亲的病情稳定性、能否密切随访

需要说清楚几件事：

1. **“绝对安全”的药不存在。** 任何药物在孕期的研究都受伦理限制，证据多来自观察性研究，所以只能说“现有数据下风险较低”，不能说“完全没影响”。
2. **不治疗本身也是暴露。** 严重抑郁带来的营养不良、睡眠剥夺、自伤行为、不按时产检，对胎儿的影响是确定的。
3. **风险不是均匀分布的。** 孕早期主要看器官形成，孕晚期主要看新生儿适应和分娩，产后主要看哺乳和照护能力。不同阶段关注点不同。
4. **决定可以调整。** 孕前定的方案，孕中期可以改，产后还可以再改。不是签一次字就锁死。

【指南】指南的共识是：孕期抑郁的治疗应个体化，由精神科与产科共同评估，重度抑郁、有自杀风险或既往严重复发史者，通常不建议贸然停药。

三、药物与哺乳的一般原则

这一节只讲原则，不推荐具体药名。原因很简单：选哪一种，取决于你的病史、孕周、合并用药、肝肾功能和当地可及性，这些只有面诊医生能判断。

孕期用药的一般原则：

- 医生通常会优先考虑**在孕期使用经验较多、数据相对充分**的药物类别（例如 SSRI 类中的部分药物），而不是“最新”或“广告最多”的药。
- 采用**最低有效剂量**的思路：不是越低越好，而是“能控制病情的最低量”。剂量过低导致复发，反而更麻烦。
- 尽量**单一用药**，减少不必要的联合，尤其是镇静类、抗精神病药的叠加。
- **不自行停药、换药、减量**。突然停用可能出现头晕、恶心、失眠、焦虑加重等撤药反应，也会抬高复发风险。
- 分娩时让产科知道你在用什么药，以便观察新生儿。
- 新生儿可能出现短暂的适应不良：易激惹、呼吸偏快、吃奶差、睡得多或哭闹多，多数在几天内缓解，但需要儿科评估。【研究】

哺乳期决策的要点：

- 药物会进入乳汁，但**量通常远小于母体剂量**；真正需要看的是“婴儿实际吃进去多少”和“婴儿能不能代谢”。
- 影响决策的因素：药物在乳汁中的相对量、婴儿是足月还是早产、月龄多大、有没有黄疸或喂养问题、母亲是否必须用这个药。
- 常见做法是：选择入乳量相对低、婴儿使用经验较多的药；在**喂完奶后立即服药**，让下次喂奶时血药浓度相对低一些；观察婴儿有没有异常嗜睡、烦躁、吃奶变差、体重不长。【临床经验】
- **不哺乳也是一个正当选择。** 如果母亲病情重、需要多种药物，或哺乳让她严重睡眠不足，配方奶喂养是合理方案，不需要内疚。
- 如果哺乳期间需要停药或换药，同样要医生指导，不能自己突然停。

容易踩的坑

- **“怀孕不能吃任何药”**：这句话把很多女性推向了更危险的境地。真正的原则是“权衡”，不是“一律禁止”。
- **“生完就好了”**：产后激素骤变、睡眠剥夺、照护压力叠加，恰恰是复发高峰。
- **“哺乳期吃药就必须断奶”**：很多情况下可以在医生指导下继续哺乳，需要的是评估，不是一刀切。
- **“为了孩子我自己扛”**：母亲的严重抑郁会影响喂养、互动和安全感，这不是“牺牲”，是双重风险。
- **“月子里不能出门、不能看医生”**：产后复诊和产科随访同样重要，情绪问题不是“矫情”，需要看。
- **只听产科或只听精神科**：这两个科室必须通信息，否则容易各说各话。

四、产后抑郁：筛查、识别与支持

产后抑郁不是“产后情绪低落”（baby blues）。后者在产后三四天出现，爱哭、敏感、焦虑，通常两周内自行缓解；产后抑郁持续时间更长、程度更重，会影响照料婴儿的能力。

常用筛查工具是 **EPDS（爱丁堡产后抑郁量表）**，共 10 个条目，请产妇按最近 7 天的感受自评。【指南】

- 总分达到常用界值（国内多采用 10 分左右）提示可能存在产后抑郁，需要进一步评估，**但量表不是诊断**。
- **第 10 条问的是自伤念头**。这一条只要不为零，就需要当天由专业人员评估，不能等到“下次随访”。
- 筛查应该在产后访视、产后 42 天复查时进行，孕期也可以做，以便早发现。
- 量表会被“报喜不报忧”影响。如果产妇在有人陪同时作答，可能刻意选低分，所以医护观察和家属描述同样重要。

产后抑郁的表现和普通抑郁相似：持续低落、兴趣丧失、爱哭、易怒、失眠或嗜睡、食欲改变、觉得自己带不好孩子、过度自责、反复担心伤害孩子。区别在于，它会直接冲击母婴互动：不敢抱、不想喂、听到哭声就崩溃，然后又因为“我怎么会这样”而更加自责。

支持上，几件事最有用：保证产妇的连续睡眠（夜间由伴侣或家人承担一两次喂奶）；减少“你应该怎样当妈”的评价；安排具体的帮手，而不是一句“有事叫我”；伴侣自己也筛查一次——父亲产后抑郁并不罕见。【研究】

五、产后精神病：必须当急症处理

这是整篇里最需要记住的一段。**产后精神病是精神科急症**，发生在大约每一千次分娩中的一到两例，多在产后两周内起病，起病常常很急。【指南】

它的表现不是“抑郁”，而是：

- 幻觉：听到不存在的声音，尤其是命令她伤害自己或孩子的声音；
- 妄想：坚信孩子被掉包、被诅咒、必须“献出去”；坚信自己要受到惩罚；
- 思维混乱：说话跳脱、答非所问、认不清时间地点；
- 极度兴奋或极度混乱：整夜不睡、来回走动、行为古怪；
- 情绪在几天内剧烈摆动，从绝望到亢奋。

对比项	产后抑郁	产后精神病
起病时间	产后数周到数月，较缓	多在产后两周内，很急
核心表现	低落、兴趣丧失、自责、焦虑	幻觉、妄想、思维混乱、行为异常
现实检验	基本保留	明显受损
风险	自伤、照料困难	自杀与伤害婴儿的风险，属于急症
处理	门诊治疗、心理治疗、家庭支持	立即急诊，通常需要住院

如果怀疑产后精神病，不要让她独自待着，不要和她争辩幻觉的内容，立刻送急诊或呼叫 120，并同时保证婴儿处于另一位成年人的看护下。 这不是“想多了”，也不是“月子没坐好”，是大脑的急性病变，需要药物和住院治疗，绝大多数可以恢复。

六、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊（并确保有人看护婴儿）：

- 听到命令伤害自己或孩子的声音，或坚信孩子必须被“处理”；
- 出现幻觉、妄想、说话混乱、认不清人和地方；
- 有明确的自杀计划，或已经采取行动；
- 连续多日几乎不睡、极度兴奋、行为失控；
- 产后大出血、剧烈头痛、发热、抽搐、意识模糊（可能是产科急症）；

- 完全拒绝进食饮水，或出现晕厥。

当天联系产科或精神科：

- EPDS 第 10 条不为零；
- 出现伤害自己或孩子的念头，哪怕只是一闪而过；
- 无法入睡、无法照顾自己或婴儿；
- 情绪在几天内剧烈波动，家人觉得“像变了个人”。

一两周内复诊：

- 情绪低落、爱哭、焦虑持续超过两周；
- 对婴儿没有感觉，或过度害怕与婴儿独处；
- 伴侣出现持续的情绪问题。

拿不准时，按严重处理。也可以拨打 12356 心理援助热线先咨询。

参考来源

- NICE. Antenatal and postnatal mental health: clinical management and service guidance (CG192). https://www.nice.org.uk/guidance/cg192
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；孕产期用药与哺乳方案必须由精神科与产科医生联合面诊评估，具体方案以面诊医生为准。

6.4 躯体疾病共病抑郁

得了心脏病、糖尿病、肿瘤、卒中之后，人变得没力气、睡不着、什么都不想干——这到底是病本身，还是抑郁？这个问题很重要，因为两种情况的处理方式不同。这一页写给有慢性躯体疾病、同时被诊断抑郁的患者和家属，讲清楚怎么区分、不同疾病下用药要避开什么、协作医疗是什么，以及哪些变化必须马上查。

一、躯体疾病与抑郁是双向的

不是“想开点身体就好了”，也不是“身体不好心情当然差”。两个方向都有明确的相互影响。

从躯体疾病到抑郁：长期疼痛、活动受限、反复住院、失去工作和收入、对未来的不确定、照护依赖，都会消耗心理资源。此外还有生物学路径：炎症因子升高、睡眠被打断、甲状腺功能改变、某些药物本身引起情绪低落。【研究】

从抑郁到躯体疾病：抑郁会降低服药的规律性（降糖药、降压药、抗凝药漏服很常见）、减少活动、影响饮食与睡眠、削弱康复训练的动力。抑郁本身也与炎症水平升高、心率变异性下降相关，可能影响心血管预后。【研究】

这解释了一个常被忽略的事实：**治疗抑郁不是“额外的事”，它本身就是慢性病管理的一部分。**抑郁改善之后，血糖、血压、康复训练的完成度往往一起变好。

二、不要把所有躯体症状都归给抑郁

反向的错误同样常见：把所有不舒服都说成“抑郁的躯体化”，结果漏掉了真正的躯体问题。

一条实用的判断线：**抑郁可以解释“程度”，但不能解释“新出现的、进展的、有体征的”异常。**

- 体重在几个月内明显下降、持续低热、夜间盗汗、淋巴结肿大——需要查因。
- 新出现的局部疼痛、肿块、出血、黄疸、排便习惯改变——需要查因。
- 突然加重的乏力、气短、水肿、意识改变——需要当天评估。
- 与既往模式不同的头痛、胸痛、腹痛——不要默认是“老毛病”。
- 吃药之后新出现的症状——先怀疑药物副作用，再考虑抑郁。

同时要排除这些常见的“伪装者”：甲状腺功能异常、贫血、维生素 B12 缺乏、电解质紊乱、慢性感染、睡眠呼吸暂停、未控制的疼痛、酒精或镇静药的影响。这些查起来不复杂，漏掉却会让抗抑郁治疗怎么调都不见效。

反过来，也不要把抑郁的躯体表现当成“装病”。乏力、食欲差、胸闷、心慌在抑郁中是真实存在的，只是检查找不到结构性病变。这不等于“没事”，而是“需要换一种方式治”。

三、不同躯体疾病，关注点不一样

疾病	需要同时处理的事	用药时要特别提醒医生
冠心病、心衰、心梗后	控制疼痛与缺氧、康复训练、戒烟、睡眠	部分抗抑郁药对心脏传导有影响；合并抗栓药时出血风险升高
糖尿病	血糖波动本身会引起乏力、情绪差；查甲功、肾功能	部分药物影响体重与血糖；合并神经痛时方案要一起考虑
肿瘤	疼痛、疲乏、贫血、激素治疗、担心复发	某些抗抑郁药会降低他莫昔芬等药物的疗效，需肿瘤科知情
卒中后	卒中位置与认知、吞咽、康复进度	出血风险、低钠、癫痫阈值；与抗栓药同用要评估
帕金森病	运动症状波动、睡眠、便秘、冲动控制	与抗帕金森药合用需防血清素综合征；ECT 需评估认知
甲状腺疾病	先纠正甲功，再评估情绪	甲功异常时情绪评估不可靠；锂盐需监测甲状腺
慢性肾病、肝病	药物清除变慢、电解质紊乱、贫血、肝性脑病	起始剂量通常更低、复查更密；透析会清除部分药物

几点展开说明：

心血管病：心梗后出现抑郁很常见，而且与再梗死、死亡风险升高相关。【指南】医生一般会优先选择对心脏传导影响小的药物，避免三环类；同时要盯心率和体位性低血压。合并阿司匹林、氯吡格雷、华法林时，出血风险要一起算——部分抗抑郁药会影响氯吡格雷的活化，可能削弱其抗血小板作用，这需要心内科和精神科通气。

糖尿病：抑郁与血糖控制是互相拖累的。要提醒的是，部分抗抑郁药会引起体重增加或影响血糖，而体重增加又会影响患者坚持治疗的意愿。这不是“不能用药”，而是“选药和监测要一起做”。

肿瘤：疲乏、食欲差、睡眠乱，在肿瘤患者中太常见，抑郁很容易被“正常化”。同时，他莫昔芬（用于部分乳腺癌）需要经肝脏某种酶转化为活性成分，而某些抗抑郁药会强烈抑制这个酶，可能降低疗效。把用药清单交给肿瘤科医生，是必须做的一步。

卒中后：卒中后抑郁发生率不低，治疗它有助于康复参与度和生活质量。【指南】但卒中患者常合并抗栓治疗，出血风险、低钠、跌倒都要一起考虑。关于某些抗抑郁药是否能促进运动功能恢复，研究结果并不一致，不宜当作确定结论。【待验证】

帕金森病：抑郁可以出现在运动症状之前很多年，也可能被误认为“帕金森病人本来就面无表情”。用药上要特别注意与其他作用于血清素的药（包括某些抗帕金森药）叠加的风险。

甲状腺：甲减的乏力、怕冷、反应慢、情绪低落，和抑郁几乎无法靠感觉区分。**先查甲功，再谈抗抑郁药**，是最省事的顺序。

慢性肾病与肝病：药物清除能力下降，常规剂量可能变成“过量”；透析还会带走一部分药。通常需要更低的起始、更慢的调整、更勤的复查。肝病患者还要注意镇静药物的蓄积和肝性脑病的早期表现。

四、药物安全：几个必须盯住的点

躯体疾病患者的用药安全，很少是“这个药不好”，而是“这个药在这个人身上、和这些药一起用，会出问题”。需要盯的六件事：

1. **代谢与清除**：肝功能、肾功能决定药物在体内停留多久。查过肝肾功能再定方案，比“凭经验”可靠。
2. **药物相互作用**：很多抗抑郁药通过肝脏的 CYP 酶代谢，会“抢占”其他药的代谢通道，让对方的血药浓度升高或降低。抗凝药、抗心律失常药、部分降压药、他莫昔芬、氯吡格雷都在这个名单上。
3. **出血**：合并抗血小板或抗凝治疗时，淤青、牙龈出血、黑便都要报告。
4. **低钠**：老年人、利尿剂使用者、SIADH 高风险者要定期查电解质。
5. **QT 间期延长**：合并某些抗心律失常药、抗生素、抗精神病药时，可能需要复查心电图。
6. **体位性低血压与跌倒**：合并降压药、α 受体阻滞剂、利尿剂时，起身头晕、夜间起夜摔倒都要当回事。

【指南】共识性的做法是：起始剂量偏低、加量更慢、尽量单一用药、定期复查肝肾功能与电解质，必要时查心电图。

就诊前可以照着准备的清单：

- ☐ 一份完整的用药清单：药名、剂量、一天几次、哪个科开的。
- ☐ 最近三个月的化验单：肝肾功能、电解质、血糖、甲功、血常规。
- ☐ 最近的影像和心电图报告。
- ☐ 症状时间线：哪个症状先出现，和换药、住院、手术有没有时间关系。
- ☐ 疼痛评分和止痛药使用情况。
- ☐ 睡眠、体重、食欲的变化。
- ☐ 想问的问题写下来，避免一进诊室就忘。

五、协作医疗：不是“多挂几个科”

躯体疾病共病抑郁的最大现实困难是：心内科开心脏的药，内分泌科管血糖，精神科管情绪，三方互不知情，患者成了传话人。

协作医疗（collaborative care） 就是针对这个问题的模式：由一位主管医生牵头，配一名个案管理师（护士或社工）负责定期随访和量表评估，精神科医生作为顾问提供用药建议，三方共享同一份记录，按“阶梯”调整治疗强度。【指南】

研究显示，这种模式能明显提高抑郁的缓解率，也能改善血糖、疼痛和功能状态，尤其在老年人和慢性病患者中。【研究】

对患者和家属来说，可以主动做的事：

- 问清楚“谁是我的主管医生”，让所有科室的病历能互相看到。
- 每次复诊带上同一份用药清单和情绪记录，减少信息丢失。
- 如果医院有“心身医学科”“联络会诊精神科”“双心门诊”，优先选择。
- 允许个案管理师或护士定期电话随访，这通常比“有问题再来”更有效。
- 出现科室之间意见不一致时，请主管医生协调，不要自己在中间做取舍。

容易踩的坑

- **“身体病好了，心情自然就好”**：很多躯体疾病是不可逆的，等“好了再说”往往等不到。
- **“这些症状都是抑郁引起的”**：新发、进展、有体征的变化必须先查因。
- **“多做检查总没坏处”**：反复检查而不接受心理治疗，既花钱又拖延，还会强化“我肯定有大病”的恐惧。
- **“中药和保健品不用告诉医生”**：成分不明、相互作用不明，恰恰是最危险的部分。
- **“症状好了就停抗抑郁药”**：躯体疾病患者的复发代价更高，停药要按疗程和医生计划来。

六、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 胸痛、胸闷持续不缓解，伴大汗、恶心、呼吸困难；
- 突然一侧肢体无力、口角歪斜、说话不清（卒中征象）；
- 意识模糊、嗜睡叫不醒、抽搐；
- 呕血、黑便、大量皮下出血；
- 呼吸急促、嘴唇发紫、心跳极快或极慢；
- 明确的自杀计划或已采取行动。

当天联系主管医生：

- 新出现的发热、体重骤降、夜间盗汗；
- 浮肿加重、尿量明显减少、黄疸；
- 起身头晕、晕厥、频繁跌倒；
- 加药后出现坐立不安、心慌、出汗、手抖、腹泻（需排除血清素综合征）；
- 血糖忽高忽低，找不到饮食或用药原因。

一两周内复诊：

- 情绪持续低落超过两周，影响康复训练和服药；
- 疼痛加重、止痛药越用越多；
- 睡眠长期紊乱，白天困倦到无法活动。

躯体疾病合并抑郁的判断，最忌讳“二选一”。拿不准时，先联系主管医生，让他决定先查哪一头。

参考来源

- NICE. Depression in adults with a chronic physical health problem: recognition and management (CG91). https://www.nice.org.uk/guidance/cg91
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；合并躯体疾病时的用药选择与剂量调整，须由精神科与相应专科医生联合面诊决定，具体方案以面诊医生为准。

6.5 双相抑郁的识别与禁忌

有一类“抑郁症”吃了两三年抗抑郁药，始终好不彻底，还时不时突然变得精力旺盛、话多、整夜不睡。这很可能不是单相抑郁，而是双相障碍的抑郁相。这一页讲清楚两者怎么区分、为什么双相抑郁不能单用抗抑郁药、筛查工具能做什么不能做什么，以及家属该盯住哪些信号。诊断必须由精神科医生做出，这一页只帮你把问题问对。

一、单相与双相：差的不只是“有没有高兴过”

先解释两个词。

- **单相抑郁**：只有抑郁发作，没有躁狂或轻躁狂。
- **双相障碍**：既有抑郁发作，也有躁狂或轻躁狂发作。“双相”指情绪在两个极端之间摆动。

躁狂与轻躁狂的区别在程度上：

对比项	躁狂发作	轻躁狂发作
持续时间	至少一周，或严重到需要住院	至少四天
功能影响	明显受损，可能无法工作、人际关系破裂	变化可被他人察觉，但通常不至于完全垮掉
现实检验	可能出现精神病性症状（夸大、被害）	一般没有
常见表现	极度兴奋、话多、睡眠需求减少、冲动冒险	精力旺盛、思维快、话多、爱花钱、易怒

双相抑郁发作本身，和单相抑郁长得几乎一样：低落、兴趣丧失、乏力、自责、想死。差别不在“抑郁这一面”，而在“有没有另一面”的历史。所以只问“最近心情怎么样”，永远问不出来。

双相抑郁还有一些平均而言更常见的特征：起病年龄更早、发作更频繁、抑郁发作次数多而每次持续时间相对短、睡眠增多和食欲增加（而不是失眠和食欲下降）、四肢沉重像灌了铅（“铅样麻痹”）、产后起病、伴精神病性症状、有明确的双相家族史、以及**吃抗抑郁药后出现转躁**。【指南】

二、哪些线索提示“可能不是单相”

下面这些线索，单独一条都不足以定论，但凑在一起就值得让医生重新评估。

- **起病早**：十几岁就有第一次严重抑郁，尤其是首发就伴精神病性症状或需要住院。
- **发作频繁**：一年内多次发作，或“好了没多久又犯”。
- **非典型特征**：睡得比平时多、吃得比平时多、体重增加、肢体沉重。
- **抗抑郁药后“变了一个人”**：用药或加量后几天到几周内，突然话多、兴奋、睡得少却不困、冲动消费、脾气暴涨。这是最重要的线索之一。
- **停药后迅速复发**：尤其停抗抑郁药后很快出现兴奋或激越。
- **家族史**：一级亲属中有双相、躁狂或自杀史。

- **共病多**：焦虑、物质使用、ADHD、边缘型人格特征同时存在，且治疗效果差。
- **季节性**：每年固定季节出现情绪高涨或低落。

线索	更像单相抑郁	更像双相抑郁
首次发病年龄	成年后较多	青少年期、20 岁前较多
睡眠	失眠、早醒	抑郁期嗜睡，或有“睡得少也不困”的时期
食欲体重	下降	抑郁期可能增加
发作特点	发作较长、逐渐起病	起病急、发作较频繁、恢复较快
抗抑郁药反应	逐渐改善	无效、部分有效，或出现兴奋激越
家族史	抑郁为主	双相、躁狂、自杀

【指南】指南普遍建议：对所有抑郁患者，都应主动询问既往是否有过持续数天的“精力异常旺盛、睡眠需求明显减少、话多、思维奔逸、冲动行为”的时期，而不是等患者自己提。

三、筛查工具：MDQ 只是筛查

MDQ（心境障碍问卷） 是最常用的双相筛查工具，共 13 个“是/否”问题，加上“这些情况是否同时出现”“是否造成中度或重度功能问题”两个追问。【研究】

需要说清楚它的边界：

- 它**不是诊断**。阳性只代表“需要进一步评估”，阴性也不能排除双相。
- 它在精神科门诊里的敏感性尚可，但特异性有限；放到普通人群里，假阳性会明显增多。
- 它高度依赖回忆和自我觉察。轻躁狂常常被当事人体验为“状态特别好”，不觉得是病，所以容易漏报。
- 因此，好的评估会同时问**知情者**（伴侣、父母、老友）：“他有没有过一段时间像换了个人？”
- 另一个常用工具是 HCL-32（32 项轻躁狂清单），同样只用于筛查。

真正的诊断靠的是结构化的临床访谈：什么时候起病、持续多久、有没有功能损害、有没有精神病性症状、有没有药物或物质诱发、有没有躯体疾病（甲亢、激素使用）可以解释。

四、为什么双相抑郁不能单用抗抑郁药

这是整篇最核心的一条。原因有四层。

第一，会诱发转躁。 抗抑郁药提升单胺能传导，对双相患者可能直接把情绪推上另一个极端。三环类风险最高，SSRI 和 SNRI 相对低，但不是零。转躁不只是“心情变好”，它可能表现为冲动消费、危险驾驶、性行为失控、伤人，甚至出现精神病性症状。

第二，会诱发混合状态。 有些人不会变得欣快，而是变得“又烦又燥”：坐立不安、思维飞快却全是消极内容、失眠、激越、自杀念头强烈。混合状态是自杀风险最高的时相之一，也最容易被误认为“抑郁加重”，于是医生加抗抑郁药，越加越糟。

第三，会加快循环。 反复的转躁与抑郁交替，可能让发作越来越密，形成快速循环（一年内四次以上发作），此后治疗难度明显上升。【指南】

第四，疗效本身不可靠。 对双相抑郁，单用抗抑郁药的证据一直不强：短期可能有一点改善，长期看复发和转躁的代价更大。因此主流指南不推荐单用抗抑郁药治疗双相抑郁。【指南】

需要强调的是：这不是说“抗抑郁药是坏药”，对单相抑郁它仍然是主力。问题在于**用错了人**。

五、处理原则：心境稳定剂为主，必须精神科评估

双相抑郁的治疗方向与单相抑郁相反：**以心境稳定剂为骨架**，抗抑郁药只在特定情况下短期、联合使用。

- **心境稳定剂**是基础，包括锂盐、丙戊酸盐、拉莫三嗪等，以及部分具有心境稳定作用的非典型抗精神病药。选哪个、用多久、怎么监测血药浓度和甲状腺肾功能，由精神科医生决定。【指南】
- **抗抑郁药**不是绝对禁用，但通常需要满足几个条件：已经用上心境稳定剂、抑郁发作严重、短期使用、密切随访。是否使用、用多久，是需要和医生明确讨论并记录的决定。
- **不要自行停心境稳定剂**。锂盐突然停用与复发和自杀风险升高相关，通常需要缓慢减量。【指南】
- **心理治疗是辅助而不是替代**：规律作息与社会节律治疗、家庭聚焦治疗、CBT、辩证行为治疗都有证据，重点是识别早期预警、减少冲突、稳定睡眠。【研究】
- **生活方式**：固定起床时间、避免通宵、限制酒精和咖啡因、慎用兴奋剂类减肥药和感冒药中的伪麻黄碱。

就诊前可以照着准备的清单：

- ☐ 把每一次“状态特别好”的时期写下来：持续几天、做了什么、别人怎么评价。
- ☐ 记录每次用药与情绪变化的时间关系（加药后几天开始变）。
- ☐ 列出家族中确诊或疑似双相、躁狂、自杀的亲属。
- ☐ 请一位知情者陪同就诊，或写一段他/她的观察。
- ☐ 带上既往所有处方，尤其是抗抑郁药的种类和疗程。
- ☐ 记录睡眠时长曲线，比“睡得好不好”更有用。
- ☐ 明确问医生：我的诊断是单相还是双相？依据是什么？

容易踩的坑

- **“我以前高兴过，所以我是双相”**：正常的开心、应激后的振奋，和轻躁狂不是一回事。判断要看持续时间、功能改变和他人观察。
- **“抗抑郁药吃了兴奋，说明药效好”**：在双相患者身上，这可能是转躁的开始。
- **“情绪稳定剂是治癫痫/精神病的人才吃的”**：锂盐和丙戊酸盐确实也用于其他疾病，但在双相中是核心治疗。

- **“既然是双相，抗抑郁药一点都不能碰”**：过于绝对。是否联合使用是个体化决策，关键在于有没有稳定剂保护、有没有密切随访。
- **“诊断变了，说明之前的医生是庸医”**：双相常在抑郁发作数次后才显现，诊断修正是医学常态，不是谁的错。
- **自己上网买锂盐或停掉所有药**：锂盐的治疗窗口很窄，过量会中毒，必须监测血药浓度。

六、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 出现伤人、砸东西、无法控制的冲动行为；
- 明确的自杀计划，或已经采取行动；
- 连续多日几乎不睡、极度兴奋、说话别人插不进、行为失控；
- 出现幻觉、妄想、认不清人和地方；
- 高热、肌肉僵硬、意识模糊、大汗（可能是严重药物反应）；
- 锂盐过量后出现呕吐、腹泻、手抖加重、走路不稳、意识改变。

当天联系精神科医生：

- 用药后突然话多、睡得少却不困、花钱冲动；
- 情绪从低落突然转为烦躁、坐立不安、思维飞快；
- 出现混合状态：又抑郁又亢奋，自杀念头强烈；
- 自行停了心境稳定剂。

一两周内复诊：

- 抑郁反复发作，抗抑郁药效果始终不理想；
- 想确认诊断，或想讨论是否调整方案；
- 计划怀孕，需要重新评估用药。

双相的判断需要时间，也需要知情者提供信息。拿不准时，先别自己调药，把观察记录下来带给医生。

参考来源

- NICE. Bipolar disorder: assessment and management (CG185). https://www.nice.org.uk/guidance/cg185
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；双相障碍的诊断与用药必须由精神科医生面诊确定，具体方案以面诊医生为准。

模块 7：风险管理与副作用监测

治疗不是“吃上药就交给医生”。这一模块讲清楚哪些风险需要你主动观察、哪些症状必须当天报告、复诊时该查什么。

7.1 自杀风险评估与沟通

这一页写给两类人：自己反复冒出“活着没意思”的念头、不确定该不该说出口的人；以及发现家人状态不对、想问又不敢问的家属。读完你会知道：为什么直接问不会“把人问出事”、一次完整的评估要问到哪些方面、风险高低大致怎么分，以及在家里最实在的两件事——安全计划和手段限制——具体怎么做。

为什么可以直接问

很多人不敢开口，是怕“本来没想，被一问反倒想起来了”。这个担心很自然，但它和目前的专业认识相反。**询问自杀念头不会诱发自杀**，这是精神科评估里反复验证过的一条基本原则，也是 NICE 指南和国内抑郁障碍防治指南共同要求的常规动作：只要在评估抑郁，就应该直接问自杀相关的想法【指南】。

反过来，不问的代价更大。很多人在诊室里不会主动说，因为怕被贴标签、怕被送住院、怕家人知道；但如果医生或家属平静地问一句，他们常常会松一口气，把憋了很久的话讲出来。**沉默不等于没有风险，只等于风险没被看见。**

开口时注意三件事：

1. **场合**：找一个能坐下说话、不会被别人打断的地方，不要在饭桌上顺口一提，也不要在亲戚面前问。
2. **语气**：平静、具体、不惊讶、不评判。像问“最近胃还疼吗”一样问。
3. **位置**：先说明你为什么问——“我最近看你晚上都睡不着，我有点担心”，再问具体的问题。

需要先解释两个词。**自杀意念**，就是“想死、不想活了、希望睡着不再醒”这类念头，它可以是偶尔一闪，也可以是每天都在。**自杀计划**，是指脑子里已经出现了“怎么做”的具体想法。两者不是一回事，评估时要分开问。

问什么：从想法到准备的五个层次

评估不是问一句“你想不开吗”就结束。有效的询问是从轻到重一层层往下走，每一层都问清楚。下面这张表可以直接照着用。

层次	可以怎么问	听到“有”之后先做什么
1. 想法	“最近有没有觉得活着没意思，或者不如死了算了？”	别急着劝，先让他把话说完
2. 频率与强度	“这种念头多久来一次？来的时候有多强烈，能撑过去吗？”	记下来，作为复诊时要讲的信息
3. 计划	“有没有想过具体会怎么做？”	回答“想过”，风险等级就要往上提
4. 准备	“有没有为这个做过什么准备，比如攒药、查方法、写过东西？”	当天联系医生，同时开始做手段限制
5. 既往尝试	“以前有没有做过伤害自己的事？最近一次是什么时候？”	既往尝试是最强的风险因素之一，必须告诉医生

除了这五层，还有几项信息同样重要，很多人会漏掉：

- **保护因素**：有没有放不下的人、有没有还没做完的事、有没有明确的求助意愿、家里有没有人可以陪着。保护因素不是“免死金牌”，但它决定了接下来能怎么安排。
- **冲动性**：是长期反复想，还是一气之下就做。冲动性高的人，风险窗口很短，需要更密集的看护。
- **酒精和药物**：喝酒、混用镇静药、自行加量，都会让判断力和控制力在短时间内明显下降。
- **睡眠**：连续多日几乎不睡，本身就是风险升高的信号，也会加重冲动。
- **近期的丧失**：分手、失业、亲人去世、被羞辱、经济崩盘，这类事件之后的几周是高风险期。
- **独居与手段可及**：一个人住、家里有大量药物或其他危险物品，都会影响安全安排。

问的时候不必一次问完。可以分几次，也可以先问最重的那一层：“你现在有没有想过要结束自己的生命？”如果对方回避，可以换个说法再问一次，不要因为一次“没有”就彻底放下。

风险分级：把“想死”分成几档

分级不是为了给谁贴标签，而是为了决定**下一步做什么、由谁来做、多快做**。临床上会综合上面所有信息判断，不存在一个能精确算出分数的公式；下面这张表是帮助理解的粗略框架【临床经验】。

等级	常见表现	大致处置方向
低	偶发念头，没有计划，没有既往尝试，能明确说出“我不会去做”，身边有人	门诊随访，把安全计划和求助电话写下来，缩短复诊间隔
中	反复出现念头，有模糊计划，或有过既往尝试，或近期重大丧失，或经常饮酒	尽快联系医生（当天到数日内），加强陪护，做手段限制，考虑增加复诊频率
高	有具体计划并有准备行为，或近期尝试过，或处于极度激动、绝望、无法保证安全的状态	立即急诊评估，不独处，必要时住院；途中由人全程陪同

有几种情况，无论自评是几档，都按高风险处理：

- 出现**命令性幻听**（听到有声音命令自己去死），或坚信自己已经没救了、罪不可赦；
- 已经写好遗书、把东西送人、突然异常平静地道别；
- 刚刚经历过一次尝试，或从医院回来后短时间内念头再次出现；
- 处于极度激越、坐立不安、无法入睡的状态。

最后一条常被忽略：**“突然变平静”不一定是好转**。如果一个人在长期痛苦之后突然安静下来，还开始交代事情，要当作危险信号，而不是放心。

安全计划与手段限制

安全计划是一张写下来的纸，不是一句“有事给我打电话”。它的作用是：在脑子最不清楚的时候，替你做决定。

一份可用的安全计划至少包含六步（详细模板见 9.2 安全计划模板）：

1. **我的预警信号**：连续几晚睡不着、开始躲人、反复说“没意义”。
2. **我自己能做的事**：洗热水澡、出门走十分钟、听固定的歌单。
3. **能让我分心的人和地方**：可以去的朋友家、24 小时便利店、客厅。
4. **可以求助的人**：写下两三个名字和电话，不要只写“家人”。
5. **专业渠道**：开药医生的电话、医院急诊地址、12356 心理援助热线。
6. **让环境变安全**：这一步最具体，也最常被跳过。

手段限制是指减少身边能造成伤害的东西。指南明确把它列为自杀预防的重要措施【指南】。它不需要讲道理，只需要动手：

- ☐ 家中药物由家人保管，按次给，不把整瓶放在患者房间
- ☐ 不在家里囤积过量药物，过期的及时处理
- ☐ 刀具、利器、绳索、农药等收进上锁的柜子或放到别处
- ☐ 高层住所注意窗户和阳台，必要时加装限位
- ☐ 不让患者独自长时间待在封闭空间，尤其是夜间
- ☐ 家中有人轮流陪护，交接时说清楚“今晚谁在”
- ☐ 把急诊地址、路线、电话写在冰箱上或手机备忘录置顶
- ☐ 家人之间约定：一旦出现计划或准备行为，不争论、不劝说，直接陪同就医

清单里的第 7 条和第 8 条看起来琐碎，但在真正慌乱的时刻，人想不起地址，也容易在争执中耽误时间。

需要提醒的是：**手段限制不应该变成监视**。翻手机、跟踪出门、把门反锁，短期可能有安全感，长期会让患者学会隐瞒。比较好的做法是事先一起商量——“哪些东西你愿意交给我保管，哪些我们放在公共区域”，让患者参与决定。

家属怎么接话

家属最常问的问题是：“我到底该说什么？”答案不是准备好一套说辞，而是先做到两件事：**不打断，不评价**。

比较有用的话	容易伤人、也容易让对话结束的话
“你愿意跟我说这些，我很在意。”	“你想开点，多大点事。”
“我不会因为你说这些就觉得你矫情。”	“别人比你惨多了，你怎么不想想父母。”
“现在不用解决所有问题，我先陪你把今晚过完。”	“你要是敢做，我就不认你这个孩子。”
“我不知道该说什么，但我不想走开。”	“你保证以后再也不许想这些。”
“要不要我陪你去看医生，我陪你进去。”	“你就是太闲了，找点事做就好了。”

右边这些话之所以伤人，不是因为家属坏，而是因为它们把责任推回给了已经没力气的人。抑郁发作时，“想开一点”不是不愿意，而是暂时做不到——就像让一个腿骨折的人“跑两步就好了”。

还有几个具体动作，比说话更管用：

- **陪着，但不逼着聊**。坐在同一个房间各做各的事，也是一种有效的陪伴。
- **把“随时找我”换成具体的约定**：“今晚十一点我给你发消息，你回我一个字就行。”
- **不要承诺保密**。如果涉及生命危险，必须告诉医生和能帮忙的家人；事先说明这一点，比事后背叛信任好。
- **照顾者也要有人接手**。长期陪护的人本身会耗竭，情绪耗竭的照顾者容易说出伤人的话。

不要用“保证不自杀”的承诺代替评估

“你答应我，不管怎么样都不能做傻事。”这句话几乎每个家属都说过。它的出发点是爱，但它不能替代评估，原因有三个：

第一，**承诺在症状面前不可靠**。自杀念头受睡眠、酒精、冲动、疼痛、药物调整影响，会在一夜之间变化。一个人上午真心答应，凌晨三点可能完全做不到。这不是不守信用，而是症状本身的特点。

第二，**要求承诺会让真话消失**。当患者发现“说实话会被要求保证、会被盯着”，下一次就会选择不说。风险不会因此降低，只会转入地下。

第三，**承诺把责任放错了地方**。它暗示“你不做，就是你对得起我们；你做了，就是你辜负我们”。这会让本就自责的人更自责。

更有效的替代做法，是把“保证”换成“计划”：

- 今晚谁陪你，睡哪个房间；
- 药放在谁那里，每次给几片；
- 难受时按什么顺序打电话（先打给谁，打不通再打给谁）；
- 什么情况下不再商量，直接去医院；
- 下一次复诊是哪天，由谁陪。

能落实的安排，比一句誓言可靠。

什么时候需要联系医生或去急诊

> **出现以下任何一种情况，不要等、不要劝、不要独自留守：立即拨打 120 或前往最近医院急诊。** 途中由人全程陪同，暂时收起家中可能造成伤害的物品。

- 已经做出准备行为（攒药、查看方法、写遗书、道别、送东西）；
- 刚刚发生过自伤或服药，哪怕看起来“没事”；
- 出现命令性幻听，或坚信自己罪不可赦、已经没救；
- 极度激越、无法入睡、行为失控，家人无法保证其安全。

> **出现以下情况，当天联系开药医生或精神科门诊，不要拖到下次复诊：**

- 自杀念头从“偶尔一闪”变成“每天都在”，或强度明显加重；
- 新出现具体计划，但还没有行动；
- 近期有过尝试，最近念头再次出现；
- 开始大量饮酒、自行加药或停药；
- 连续多日几乎不睡，情绪突然变得异常平静。

如果不确定算不算严重，按严重处理。也可以拨打 **12356** 心理援助热线，先把当下这一刻撑过去，再谈后面的安排。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.2 抗抑郁药与自杀风险

很多人拿到药盒，第一眼看到说明书上那段加框的黑字，就再也不敢吃了；也有家属在网上一搜“抗抑郁药 自杀”，当晚就把药收了起来。这一页把这件事讲清楚：黑框警告到底写了什么、为什么强调 25 岁以下、哪几个时间点风险相对高、出现异常该怎么做，以及为什么“因为害怕而拒绝治疗”往往比吃药更危险。

黑框警告到底说了什么

“黑框警告”是药品说明书上最醒目的一种安全提示，用方框圈出，意思是“这个风险足够重要，开药的人和吃药的人都必须知道”。它不是“禁用”标记，也不是“这药会让人自杀”的判决书。

以 SSRI、SNRI 这类常用抗抑郁药为例，黑框警告的核心内容大致是三层意思：

1. **在儿童、青少年和年轻成人（大致 18–24 岁）中，用药早期出现自杀念头和自杀相关行为的风险会有所增加。** 注意，是“念头和行为”，不是“自杀死亡”。
2. **这种风险主要出现在治疗早期**，尤其是开始用药和调整剂量之后的一段时间。
3. **因此需要密切监测**：医生、患者、家属要一起盯着情绪和行为的变化，尤其是最初几周和每次调量之后。

各国监管机构后来多次复核这批数据，结论并没有变成“禁用”，而是维持“**获益大于风险，但必须监测**”的判断【指南】。原因很直白：未经治疗的中重度抑郁，本身的自杀风险远高于药物带来的那点增量风险。

还有一点常被误读：黑框警告里写的是“自杀念头和行为增加”，而不是“自杀死亡率上升”。在大样本的观察研究里，抗抑郁药与自杀死亡的关系一直没有出现一致的上升信号，部分年龄组甚至更低【研究】。这不是说可以掉以轻心，而是说：**该防的是早期的那段波动，不是把药当成毒药。**

为什么 25 岁以下起始治疗要密切监测

“25 岁”这个数字不是随便定的，它来自对不同年龄段临床试验数据的合并分析：把受试者按年龄分组后，研究者发现自杀相关事件的风险增加主要集中在 25 岁以下，25 岁到 64 岁大致持平，65 岁以上反而下降【研究】。监管机构据此把监测的重点放在了年轻人身上。

理解这个数字，要注意三点：

- **它是群体统计，不是个人命运**。绝大多数 25 岁以下的患者吃药后不会出现自杀念头增加；这个提醒的意义是“提高警惕”，不是“你一定会出事”。
- **25 岁不是一道悬崖**。24 岁和 26 岁的生物学差别没有那么大，界线是为了制定规则方便。刚过 25 岁、首次用药、病情很重的人，同样值得认真监测。

- **年龄只是因素之一**。既往有过自杀尝试、合并物质使用、冲动性高、独居、近期遭遇重大丧失、共病边缘型人格特征的人，无论几岁都需要更密的看护。

  青少年和老年人的情况另有专门考虑，分别见 6.1 青少年抑郁 和 6.2 老年抑郁。

哪几个时间点风险相对高

风险不是均匀分布的。下面这些节点，是临床上会特别留意的窗口【指南】【临床经验】。

时间点	需要留意什么	为什么这个时间点特殊
开始用药的第 1–2 周	焦虑、坐立不安、失眠是否加重，有没有新出现的消极念头	药物还在起效前，副作用先到，人容易觉得“更难受了”
每次加量后的几天	情绪是否突然变得烦躁、易怒、控制不住	剂量变化会带来一段适应期
换药期间	旧药减、新药加的重叠阶段	两种药交替，情绪和睡眠容易波动
症状开始好转的头几周	有没有突然的平静、交代后事、送东西	精力先恢复、情绪还没跟上，行动力变强而绝望感仍在
减药或停药阶段	情绪回落、失眠、焦虑反弹	可能是撤药反应，也可能是复发，需要医生分辨
合并饮酒、熬夜、感染、手术、重大应激时	冲动性升高、判断力下降	这些因素本身就会推高风险

表格里第四行最容易被忽略，也最需要家属记住：**“看起来好一点”不等于安全**。一个连起床都困难的人，突然有力气出门了，如果同时情绪仍然绝望，这个阶段反而要看得更紧。这不是说好转是假的，而是说好转有它的节奏，动力先回来，希望后回来。

出现激越、失眠加重、行为改变、自杀念头增加怎么办

这四种变化，是黑框警告里最需要落到具体行动的部分。先分清它们可能是什么：

- **激越（坐立不安）**：心里像有东西在烧，坐不住，来回走，腿抖，想撕东西。医学上有一类叫“静坐不能”，是某些药物可能引起的不良反应，和“病情加重”不是一回事，但非常难受，也会推高冲动风险。
- **失眠加重**：入睡更难、半夜频繁醒、早醒更早。睡眠是情绪的风向标，连续几天睡不好，情绪通常跟着往下走。
- **行为改变**：突然变得特别外向或特别沉默、开始乱花钱、说话停不下来、对什么都无所谓、把自己关起来。
- **自杀念头增加**：从“偶尔想”变成“经常想”，从“想想而已”变成“开始想怎么做”。

处理的原则可以概括成一句话：**先保证安全，再联系医生，不要自己停药。**

很多人第一反应是“这药有问题，我马上停”。突然停药本身就可能引起头晕、恶心、失眠、焦虑反弹，甚至撤药反应，让局面更乱，也让医生失去判断依据。正确的顺序是：

1. **当天联系开药医生**，说明变化从哪天开始、和加量有没有时间关系、具体表现是什么。说不清就照着记录念。
2. **不要独处**。当晚找人陪着，把药物和危险物品交给他人保管。
3. **不要自行加减量**，也不要拿酒来“压一压”。
4. **如果出现计划、准备行为，或完全无法保证安全**，不要等门诊，直接去急诊。
5. **把这次反应记下来**。它对医生下一步选药非常有用——同样的反应再次出现时，可以提前避开。

家庭监测清单

药物起效前的这段时间，靠“你自己注意点”是不够的，需要有具体的人、具体的事。下面这张清单可以打印出来贴在冰箱上。

- ☐ 知道药名、每天吃几次、每次几片，由谁负责提醒
- ☐ 药由家人保管或分装，避免一次拿到过多
- ☐ 每天问一句具体的：“昨晚睡了几个小时？”“今天有没有那种念头？”
- ☐ 记录睡眠时长、情绪（0–10 分即可）、有没有新的烦躁或坐不住
- ☐ 留意“突然变平静”“开始交代事情”“把东西送人”这类信号
- ☐ 前两周每天有一次不少于十分钟的面对面交流，不只发微信
- ☐ 把开药医生电话、急诊地址、12356 存在手机里并置顶
- ☐ 复诊时带上记录，重点说“从哪天开始、什么变化、和调量有没有关系”
- ☐ 家里暂时不囤酒，不在患者房间放大量药物

清单不需要全部做到，但**“有人每天看见他”这一条不能省**。

不要因为恐惧而拒绝治疗

这是这一页最想说的话。

未经治疗的中重度抑郁，自杀风险是实实在在的：绝望感、失眠、冲动、社会隔离会互相叠加，越拖越难走出来。抗抑郁药带来的早期风险增量，在群体层面很小，而且**是可以被监测、被干预的**——这也正是黑框警告存在的意义：把“需要盯着”这件事写进说明书，而不是把药撤下货架。

把两边放在一起看：

选择	主要风险	可以做的应对
规范用药并密切监测	早期可能出现激越、失眠、念头波动	缩短复诊间隔、家人陪护、手段限制、及时报告
因为害怕而不治疗	抑郁迁延、功能受损、自杀风险持续存在	这些风险不会因为“不吃药”而消失

【指南】NICE 与国内指南都建议：对中重度抑郁，药物治疗是主要选择之一；对青少年和年轻成人，用药同时要安排更密切的随访。也就是说，**监测是用药方案的一部分，不是可选项**。

如果你或家人实在不放心，可以做三件事，而不是把药停掉：

- 把担心直接告诉医生，问清楚“这个药在我这种情况下，最需要观察什么”；
- 请医生把复诊间隔缩短，或约定一个中间的联系方式；
- 让家属参与前几次复诊，把观察到的变化当面讲。

容易踩的坑

坑一：把“吃药后难受”当成“药在害我”。 早期副作用很常见，多数会随时间减轻；但“难受”里也有一部分是需要报告的信号。区别方法不是自己判断，而是打电话问医生。

坑二：把“加量后更焦虑”当成“剂量不够”。 加量后短期焦虑加重并不少见，自行再加量会让情况更复杂。

坑三：症状一好就停。 早期好转常常不稳定，突然停药会让风险在没有任何保护的时候回来。停药要按计划来，见 8.3 停药计划与撤药管理。

坑四：只盯着“自杀”两个字，忽略激越和失眠。 这两者常常是风险升高的前哨，也是最好观察到、最容易干预的部分。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去最近医院急诊，不要独处、不要等门诊：

- 出现自杀计划或准备行为（攒药、查方法、写遗书、道别）；
- 已经自伤或服药，哪怕表面看不出异常；
- 极度坐立不安、来回走动停不下来，伴强烈冲动；
- 出现命令性幻听，或坚信自己已经没救；
- 意识模糊、高热、肌肉僵硬或抽动、大汗——可能是严重药物不良反应。

当天联系开药医生（不要拖到下次复诊）：

- 用药或加量后新出现自杀念头，或原有念头明显加重；
- 明显激越、失眠连续加重超过数天；
- 情绪突然异常平静，开始交代后事；
- 出现冲动消费、话多停不下来、睡得很少却不困（可能是转躁，见 7.3 转躁与双相转换）；
- 想自行停药或减量。

拿不准的时候，先按严重处理，或拨打 12356 心理援助热线。**宁可多打一个电话，不要赌一个晚上。**

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.3 转躁与双相转换

有些人在抑郁治疗过程中，会突然滑到另一头：睡三四个小时也不困，脑子转得飞快，话多到停不下来，觉得自己什么都能做成。这不是“病情好了”，很可能是转躁。这一页讲清楚转躁的早期信号、哪些人风险更高、家里第一时间该做什么，以及怎么把它和“药物起效”区分开。

转躁是什么：从抑郁滑到另一头

先解释三个词。

躁狂是一种状态：情绪异常高涨或异常易怒，精力明显变多，睡得很少也不觉得累，说话又快又多，想法一个接一个，容易冲动，做出平时不会做的决定。**轻躁狂**是同样性质的改变，但程度轻一些，不至于严重影响工作生活，也不出现幻觉妄想，所以常被本人和家属当成“状态特别好”。

双相障碍，就是抑郁发作和（轻）躁狂发作交替出现的一类疾病。很多人第一次发作是抑郁，医生也只能看到抑郁，于是按抑郁症治疗；直到某次用药后“转躁”，或家属回想起几年前有过一段“特别亢奋”的时期，才把拼图拼完整。这种情况在临床上并不少见，国内指南也把“系统筛查双相”列为抑郁症评估的常规内容【指南】。

需要强调的是：**转躁不等于医生治错了**。它可能是疾病本身的下一次发作，也可能是药物把潜在的倾向提前暴露出来。这两种情况处理方式不同，但都不该由患者自己下结论。

还有一种情况叫**混合特征**：抑郁和躁狂的表现同时存在——情绪低落、想死，同时坐立不安、话多、思维飞快。这种状态格外危险，因为绝望感和冲动性叠在一起。如果出现，按急症处理。

早期信号：睡眠需求减少是最灵的风向标

转躁的早期信号里，最可靠、也最容易被家属发现的，是睡眠的变化——但不是“睡不着”，而是“不需要睡”。

失眠是躺在床上翻来覆去，白天累、困、没精神。**睡眠需求减少**是只睡三四个小时，第二天照样精力充沛、眼睛发亮、说话有劲。前者让人痛苦，后者常常让人感觉良好，所以本人往往不觉得有问题，家属才看得出不对劲。

其余信号可以对照下表观察。

信号	具体是什么样子	家属可以怎么描述给医生听
睡眠需求减少	只睡三四小时，不困不乏，甚至更精神	“他这几天每天只睡三小时，白天还很有劲”
话多、语速快	说话停不下来，别人插不上嘴，话题跳得很快	“从早说到晚，我一句话都插不进去”
思维奔逸	想法一个接一个，自己说“脑子转得太快”	“他说脑子里同时有十件事在跑”

信号	具体是什么样子	家属可以怎么描述给医生听
夸大	觉得自己有特殊能力、要大干一场、要投一大笔钱	“他突然说要辞职创业，谁劝都不听”
冲动	大额消费、借贷、赌博、危险驾驶、轻率的性行为	“三天花了平时半年的钱”
易激惹	一点小事就爆发，摔东西、骂人、和家人冲突	“最近特别暴躁，完全不像他”
目标性活动增多	同时开很多项目，熬夜干活不觉得累	“同时报了三门课、接了四个活”
注意力跳转	一件事没做完就换下一件，坐不住	“十分钟换八件事”
社交异常	突然特别爱交际、到处约人、给陌生人打电话	“半夜给多年不联系的人发长消息”

不需要等到“全都会”才警觉。**睡眠需求减少 + 话明显变多 + 花钱变冲**这三样里出现两样，就值得当天联系医生。

哪些人风险更高

不是所有人吃抗抑郁药都会转躁。风险高低和几个因素有关，下面这些情况需要在治疗开始前就告诉医生【指南】【研究】。

- **双相家族史**：一级亲属（父母、兄弟姐妹、子女）中有双相障碍，风险会升高。这里说的不只是“确诊过”的，也包括“有过一段特别亢奋、后来自己好了”的家人。
- **本人既往有过轻躁狂或躁狂**：哪怕只有几天，哪怕当时觉得“状态很好”，都要说。这一条最容易被漏掉，因为当事人不认为那是病。
- **既往抗抑郁药治疗后转躁**：上一次吃药后出现过类似状态，这次风险更高。
- **起病年龄早**：青少年期就出现第一次抑郁发作的人，双相的可能性相对更高。
- **快速循环**：一年内情绪高低起伏四次以上。
- **发作特点**：抑郁发作很频繁、很短、突然开始又突然结束；或伴有明显的易激惹、精神运动性迟滞。
- **共病**：注意力缺陷多动障碍（ADHD）、物质使用、边缘型人格特征，都会让评估更复杂。
- **特殊时期**：产后、季节性情绪变化明显的人，也需要额外留意。

除了药物，还有几个“点火器”会独立诱发转躁，和吃不吃药无关：**连续熬夜或睡眠剥夺、跨时区飞行、大量饮酒或使用兴奋类物质、甲状腺功能异常、分娩、强烈的情感事件**。这也是为什么治疗期间要把“规律睡眠”当成处方的一部分。

处理原则：联系医生，不要自己动药

发现转躁信号，家里最常见的两种反应都不太合适：一种是“终于好了，赶紧把抗抑郁药加量巩固一下”，另一种是“这药有问题，立刻全停”。前者可能把躁推得更高，后者可能带来撤药不适和情绪急转。

比较稳妥的顺序是这样：

1. **当天联系开药医生**，把睡眠时长、话多不多、花钱有没有失控、有没有说大话，一条条讲清楚。能拍照、能记录更好。
2. **不要自行加抗抑郁药，也不要自行停药**。是否调整、怎么调整，由医生判断；有时需要减抗抑郁药、加心境稳定剂或非典型抗精神病药，这些都属于处方决定。
3. **优先保睡眠**。固定上床时间，睡前不刷手机、不喝咖啡和酒，白天不补长觉。睡眠是成本最低、效果最直接的一道闸。
4. **减少刺激**：暂缓重大决定，不签合同、不投资、不辞职、不长途自驾。
5. **管住钱和钥匙**：信用卡、支付密码、车钥匙可以暂时交给家人保管。这不是不信任，是替处在冲动期的人踩一脚刹车。
6. **有人陪**。轻躁狂阶段人往往自我感觉良好、不愿就医，家属的陪同和坚持很关键。
7. **记录这次发作**。时间、诱因、用了什么药、多久缓解，对以后每一次选药都有价值。

如果医生判断需要调整诊断，也不必恐慌。双相障碍有成熟的治疗路径，关键是把“抗抑郁药单打独斗”换成“以心境稳定为基础的综合方案”。这一点在 6.5 双相抑郁的识别与禁忌 里有更详细的说明。

清单：家里可以提前做好的事

- ☐ 治疗开始前，主动告诉医生家族里有没有“特别亢奋”的时期
- ☐ 家里约定一个“睡眠观察员”，每天记录入睡和起床时间
- ☐ 手机里存一个情绪记录表，每天一行：睡眠、精力、话多程度、花钱
- ☐ 提前说好“如果连续两晚只睡三四小时还很精神，就一起去医院”
- ☐ 大额支出设置家属提醒或双人确认
- ☐ 车钥匙、信用卡的保管方式提前商量，不要等到冲突时再抢
- ☐ 把“最近有没有特别亢奋的时期”写进复诊问题清单，每次问一遍
- ☐ 家里不囤酒，治疗期间尽量不熬夜赶工

怎么和“药物起效”区分

这是最容易混淆的地方。抗抑郁药起效时，人确实会变好：愿意说话、愿意出门、开始做事。转躁看起来也像“变好”，但方向不一样。下面这张表可以帮助分辨。

维度	药物起效（好转）	转躁
睡眠	睡得踏实一些，白天精力回升但仍会累	睡得明显变少，却完全不觉得累
情绪	平稳地往上走，能感到轻松，也会疲惫	异常高涨或异常易怒，像踩了油门
说话	愿意交流，语速正常	话明显变多、变快，别人插不上嘴
花钱	恢复正常消费	突然大额消费、借贷、送人贵重东西
自我评价	从“我不行”回到“我还行”	从“我不行”跳到“我无所不能”

维度	药物起效（好转）	转躁
判断力	基本正常	明显变差，听不进劝
别人怎么看	家人觉得“慢慢好起来了”	家人觉得“不太对劲，像换了个人”

一个简单的判断句：**好转是“回到自己”，转躁是“不像自己”。** 如果家属心里冒出“他最近怎么这么亢奋”的疑问，这个疑问本身就该带去给医生。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊，不要等门诊：

- 出现幻觉、妄想（比如坚信自己有特殊使命、被人迫害），或说话已经无法听懂；
- 极度兴奋、整夜不睡、行为失控，家人完全拦不住；
- 有伤害自己或他人的言语、动作；
- 连续多日几乎不吃不喝，出现脱水、虚弱、意识模糊；
- 混合状态下出现自杀念头，同时坐立不安、冲动明显。

当天联系精神科医生：

- 睡眠需求明显减少，连续两晚只睡三四小时仍精力充沛；
- 话明显变多、思维飞快、坐不住；
- 出现大额消费、借贷、危险驾驶、轻率性行为；
- 情绪突然从低落转为异常高涨或异常易怒；
- 开始想自行加抗抑郁药或自行停药。

拿不准时按严重处理。**躁狂本身是可以伤人的急症**，越早干预，恢复越快，对大脑和生活的损耗越小。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.4 性功能体重与代谢

抑郁治疗里，有两件事最容易被咽回去：一是性方面的变化，二是体重和腰围。它们不致命，却实实在在影响一个人要不要继续吃药。这一页讲清楚：哪些药更容易带来这些问题、怎么开口和医生说、等待/减量/换药/加药各自要付出什么代价，以及体重、腰围、血糖血脂该怎么盯。

为什么这两件事总被忍着不说

很多人宁可偷偷把药减半，也不愿在诊室里说“我最近那方面不太行”。原因大致有三种：

- **说不出口**。性在中国人的日常对话里本身就是隐私，何况是对着医生讲细节。
- **怕被当成挑剔**。觉得医生已经很忙，自己为了“不影响生命”的事去调整方案，好像不识好歹。
- **以为只能二选一**。要么忍着副作用吃下去，要么停药让抑郁回来。

这三种想法都能理解，但都会让治疗吃亏。**性功能和体重是依从性最强的预测因素之一**——一个人可以忍受恶心两周，却很难忍受半年性生活消失，也很难忍受裤子一条条穿不上。忍到最后往往是“自己悄悄停了”，而医生完全不知道原因。

需要先说清楚一个前提：**抑郁本身就会影响性欲和体重**。抑郁发作时性欲下降很常见，食欲可能减退也可能增加，活动量下降会让人发胖。所以判断“是不是药的问题”，最好有治疗前的基线——这也是为什么第一次就诊时如实讲这些，是有用的。

性功能：哪些药更常见，具体是什么

抗抑郁药对性功能的影响，主要集中在几个方面：性欲下降、勃起或润滑困难、射精延迟、高潮困难或快感减弱。不同类别差别不小，但**个体差异很大，同类药也不是都一样**【指南】【研究】。

药物类别	性功能影响的大致特点	常见具体表现
SSRI（如舍曲林、帕罗西汀、氟西汀、西酞普兰、艾司西酞普兰）	最常见，尤其是射精延迟	性欲下降、高潮延迟或难以达到、快感变淡
SNRI（如文拉法辛、度洛西汀）	较常见，通常略低于 SSRI	性欲下降、射精延迟、勃起困难
米氮平（NaSSA）	相对较少	性欲下降报告较少，但可能体重增加
安非他酮（NDRI）	相对最少，常被用来改善	少数人反而性欲增强
TCA（如阿米替林、氯米帕明）	较常见	性欲下降、勃起困难、射精障碍
曲唑酮	影响较小，但可能引起异常勃起（罕见急症）	需立即就医

这张表只说明“群体趋势”，不能用来给自己选药。有人吃 SSRI 完全没影响，也有人吃所谓“影响最小”的药照样出问题。

关于“会不会永久坏掉”，这是最让人害怕的问题。目前的认识是：**大多数人在停药或换药后，性功能会逐步恢复**；少数人报告症状持续较久，相关研究质量有限，还没有定论【待验证】。把这个不确定性如实说出来，比拍胸脯保证“肯定没事”更负责，也比吓唬人“会毁掉一辈子”更接近事实。

怎么开口和医生谈

不用组织语言，也不用铺垫。最有效的方式是**具体、简短、说影响**。下面这张表可以直接借用。

不太好开口的说法	更容易被接住的表达
“那个……最近有点那个……”	“吃药以后性生活有变化，我想说一下。”
“没什么事。”（其实有事）	“有一件事影响我继续吃药，我想解决。”
“是不是这药把我弄废了？”	“这个变化大概什么时候能恢复？需要调方案吗？”
“我能不能自己减一半试试？”	“有没有可能在不影响疗效的前提下调整？”

三个信息点，说清楚就够了：

1. **什么时候开始的**：吃药前有没有、加量后有没有变。
2. **具体是什么**：性欲、勃起、润滑、射精、高潮，哪一环。
3. **影响有多大**：用 0–10 分打分，或直接说“影响到我不太想继续吃药了”。

如果当面实在说不出口，可以提前写在纸上、写在手机备忘录里递给医生，或者在复诊前发给门诊护士。很多医院的门诊记录里有一栏专门问这个，填了医生就会看到。

重要的是让医生知道“这件事对你有多重要”。同样是性功能受影响，有人觉得可以接受，有人觉得必须处理。医生不会读心，说出来才会被纳入考量。

体重与代谢：不是“意志力”问题

体重增加是抗抑郁药最影响长期坚持的副作用之一，也是“病耻感”最重的一个——很多人把它理解成自己管不住嘴，其实不完全是。

常见机制有三条：**食欲增加**（尤其对甜食和碳水）、**镇静和疲倦导致活动量下降**、**部分药物对糖脂代谢的直接影响**。三条叠加，几个月下来体重上一个台阶并不奇怪。

不同药物的大致倾向如下（同样只是群体趋势，个体差异大）：

药物类别	体重影响的大致倾向
米氮平	增加较常见，早期尤其明显
帕罗西汀等部分 SSRI	中长期增加较常见
TCA	增加较常见
舍曲林、氟西汀、西酞普兰等	短期多中性，长期部分人增加
文拉法辛、度洛西汀	多中性，部分人初期下降
安非他酮	多中性或轻度下降

监测不需要复杂设备。家里有一台体重秤、一根软尺就够了：

- ☐ 治疗开始前称一次体重、量一次腰围，记下来当基线
- ☐ 之后每 2–4 周固定时间称一次（晨起、空腹、同一件衣服）
- ☐ 腰围每 1–3 个月量一次（男性 ≥90 cm、女性 ≥85 cm 需要留意，中国人群标准）
- ☐ 有糖尿病、高血压、高血脂、多囊卵巢的人，治疗前后查血糖、血脂
- ☐ 记录食欲变化：是不是特别想吃甜食、夜里想吃东西
- ☐ 记录活动量：每天走路多少分钟，是否比治疗前明显减少
- ☐ 体重短期内快速上升（比如一个月内明显增加）要报告医生

体重上升本身不可怕，可怕的是它带来的一系列代谢变化。**腰围比体重更能反映内脏脂肪**，所以量腰围这件事，比每天称体重更有意义。

四条路的取舍：等待、减量、换药、加药

发现问题后，能走的路大致四条。每一条都有代价，没有“只有好处”的选项。

选择	可能得到什么	要付出什么
等待观察	部分副作用在数周内减轻，尤其是恶心、头晕	性功能问题往往不会自行消失，拖着可能让人悄悄停药
减量	副作用可能减轻	疗效可能下降，复发风险上升；必须由医生决定
换药	换成影响较小的药，问题可能明显改善	需要经历换药期的不适，新药可能带来新副作用，情绪可能波动
加药（如加安非他酮）	有研究支持可改善部分人的性功能	多吃一种药、多一层相互作用风险，可能引起焦虑、失眠，双相倾向者需谨慎

关于“加安非他酮”这条路，需要多说两句。安非他酮属于 NDRI，主要作用于多巴胺和去甲肾上腺素，和 SSRI 的机制不同。有研究显示，在 SSRI 基础上加用它，可以改善一部分人的性功能【研究】。但它不是万能钥匙：可能加重焦虑和失眠，降低癫痫阈值（有癫痫史的人要特别说明），也可能和多种药物发生相互作用。**是否加、加多少，必须由医生决定。**

关于“减量”，还有一个常被忽略的点：**很多人是在疗效刚稳定时自行减量的**，结果副作用轻了一点，情绪却又滑下去，最后分不清是副作用难受还是病难受。这也是为什么调整要在有随访的情况下做。

常见坑

坑一：以为“忍过去就好了”。 恶心、头晕多半会过去，性功能障碍常常不会。忍不是策略。

坑二：把体重增加全算在自己头上。 药物改变食欲和活动量是真实的生理作用，不是意志力薄弱。自责只会让人更不想面对。

坑三：为了性生活自行停药。 突然停药带来的情绪反弹，往往比副作用本身更影响关系和生活。

坑四：用减肥药、保健品“对冲”。 很多减肥产品成分不明，和抗抑郁药同服可能增加心血管和肝脏风险。

坑五：只和伴侣吵，不和医生说。 伴侣之间的误解（“你是不是不爱我了”）很常见，把药物因素讲清楚，关系压力会小很多。

什么时候需要联系医生或去急诊

出现以下情况，尽快（当天到数日内）联系开药医生：

- 性功能变化已经影响到是否愿意继续服药；
- 体重在短期内明显上升，或腰围快速增长；
- 食欲失控、暴食，尤其集中在夜间；
- 出现明显口渴、多尿、乏力（可能提示血糖问题）；
- 已经在考虑自行减量或停药。

出现以下情况，立即去急诊或拨打 120：

- 阴茎异常勃起（持续数小时、疼痛、与性刺激无关）——这是泌尿科急症，延误可能造成永久损伤；
- 胸痛、晕厥、心跳异常加快或不规则；
- 严重过敏：皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难；
- 高热、意识模糊、肌肉僵硬或抽动、大汗。

拿不准时，先联系开药医生；联系不上又明显不对劲，直接去急诊。也可以拨打 **12356** 心理援助热线，先缓解“说不出口”的焦虑。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.5 出血低钠与心脏风险

抗抑郁药里，有三类风险不常发生，但一旦发生可能很凶险：出血、低钠血症、心电图 QT 延长。它们的共同点是——早期症状很不典型，容易被当成“抑郁本身”“年纪大了”“最近太累”。这一页讲清楚它们分别是什么、哪些人风险更高、出现什么必须当天就医、什么情况要立刻打 120。

为什么这三种风险放在一起讲

因为它们有三个共同点。

第一，**单独看都不常见，但被“放大”的条件很具体**。合并某种止痛药、上了年纪、同时吃利尿剂、本身有心脏病——这些条件一叠加，风险就不是原来的量级。

第二，**早期表现都不像“药物问题”**。出血可能只是牙龈老出血；低钠可能只是没劲、反应慢；QT 延长可能只是偶尔心慌一下。人不会因为这些去挂急诊，往往拖到出事。

第三，**它们都靠“提前知道 + 提前查”来防**，而不是靠感觉。所以这一页的重点不是吓人，是把“该查什么、该说什么”讲具体。

先解释两个词。**电解质**是血液里的钠、钾、氯等矿物质，它们维持神经和肌肉的正常工作。**QT 间期**是心电图上的一个时间段，反映心脏每次跳动后“充电”的过程；这个时间段过长，心脏可能出现危险的心律失常。

出血：SSRI 与 SNRI 的消化道风险

血小板是我们血液里负责“止血”的细胞碎片。血小板要正常工作，需要从血液里摄取一种叫 5-羟色胺（血清素）的物质，而 SSRI 和 SNRI 正好会阻断这个过程。结果就是：**血小板的“黏性”下降，止血变慢**。

单独吃 SSRI，出血风险只是轻度升高，绝大多数人不会有任何感觉。真正需要警惕的是**合并用药**——这时候风险会成倍放大【指南】【研究】。

合并的药物	为什么危险
非甾体抗炎药（NSAIDs）：布洛芬、双氯芬酸、萘普生、塞来昔布等	本身刺激胃黏膜、损伤胃屏障，再叠加血小板功能下降
阿司匹林、氯吡格雷等抗血小板药	两条止血通路同时被削弱
华法林、利伐沙班、达比加群等抗凝药	出血风险显著上升，需要医生评估是否调整监测
糖皮质激素（如泼尼松）	增加胃肠道损伤
酒精	刺激胃黏膜、影响血小板功能

除了药物，这些情况也会放大风险：**既往有胃溃疡或消化道出血史、年龄较大、肝病、血小板偏低、酗酒**。

需要留意的症状：

- **黑便**：大便像柏油一样又黑又亮，有腥臭味——这是消化道出血最典型的表现，不要当成“吃了猪血”；
- **呕血**：吐出咖啡色或鲜红色东西；
- **牙龈出血、鼻出血**止不住，或刷牙时出血明显比以前多；
- **皮肤瘀斑**变多，轻轻一碰就青；
- **月经量明显增多**；
- **头晕、心慌、乏力、站起来眼前发黑**——可能已经失血。

> **出现呕血、黑便、晕厥、明显头晕乏力，立即拨打 120 或去急诊。** 不要自己开车，不要等到“明天看看”。

有一个非常常见的错误要特别提醒：**不要因为担心出血就自行停掉阿司匹林或抗凝药**。这些药往往是为了防心梗、防脑梗、防血栓，突然停掉可能带来更严重的后果。正确做法是把“我在吃抗抑郁药”告诉开抗凝药的医生，由两位医生一起权衡。

低钠血症：老年人尤其要当心

低钠血症是血液里的钠浓度过低。抗抑郁药引起低钠，主要机制是药物让身体分泌了过多的抗利尿激素（一种让肾脏“留住水”的激素），结果血液被稀释，钠相对变低。医学上叫“抗利尿激素分泌不当综合征”。

它有几个特点：

- **多见于老年人**，尤其是老年女性、体重较轻的人；
- **多在开始用药或加量后的前几周出现**，不是吃了几年才突然发生；
- **合并利尿剂（尤其是噻嗪类降压药）、卡马西平、某些止痛药时风险更高**；
- SSRI 和 SNRI 都可能引起，其中部分药物报告更多，但个体差异大【指南】。

症状从轻到重是这样的：

程度	可能的表现
轻度	没劲、疲倦、没胃口、恶心、头痛、注意力差
中度	反应变慢、走路不稳、容易跌倒、情绪异常低落或烦躁、手脚发麻
重度	意识模糊、说话不清、抽搐、昏迷

低钠最麻烦的地方在于：**轻中度症状和抑郁本身几乎分不出来**。“没劲、没胃口、反应慢、情绪差”——这些既是抑郁的表现，也是低钠的表现。家属如果发现老人最近“格外糊涂”“走路发飘”“突然特别没精神”，而且是在开始用药或加量之后，就要想到查电解质。

对老年人，比较稳妥的做法是：**开始用药前查一次电解质，用药后几周复查一次**，之后根据情况定期查。有跌倒、意识变化、反复呕吐腹泻时，随时加查【指南】。

> **出现抽搐、意识模糊或叫不醒、摔倒后精神明显异常，立即拨打 120。** 严重低钠可以在很短时间内危及生命。

QT 延长：心脏的“充电时间”变长

QT 间期是心电图上的一段。它变长时，心脏可能出现一种叫“尖端扭转型室速”的危险心律失常，表现为突然晕厥、抽搐，甚至猝死。

哪些抗抑郁药更需要注意？

- **西酞普兰和艾司西酞普兰**：QT 相关风险与剂量有关，说明书对剂量有上限规定，具体以处方为准；有心脏病、电解质紊乱的人要格外谨慎【指南】。
- **三环类抗抑郁药（TCA）**：如阿米替林、氯米帕明、多塞平，过量时心脏毒性很强，是这类药如今较少作为首选的原因之一。**TCA 过量是急症，必须立即就医。**
- 其他药物也有报告，但风险相对低。

让 QT 更容易延长的因素：

- **女性、年龄较大**；
- **低钾、低镁**（比如长期腹泻、呕吐、用利尿剂、不好好吃饭）；
- **本身有心脏病**：心衰、冠心病、心律失常、先天性长 QT 综合征；
- **同时用其他延长 QT 的药**：某些抗精神病药（如氟哌啶醇、喹硫平）、某些抗生素（大环内酯类、喹诺酮类）、某些抗真菌药、昂丹司琼等止吐药；
- **肝功能受损**：影响药物代谢，血药浓度可能升高。

症状往往很短暂：**一阵心慌、心跳漏一拍、眼前发黑、突然晕倒**。很多人晕一下就缓过来，就不当回事——这恰恰是最危险的，因为下一次可能是更严重的心律失常。

> **出现晕厥（哪怕几秒钟）、抽搐、持续心悸伴头晕胸闷，立即拨打 120 或去急诊，并告诉医生你在吃什么精神科药物。**

三类风险自查：对照表、清单与常见坑

风险	高危人群	早期信号	关键监测
出血	合并 NSAIDs、抗凝/抗血小板药、有溃疡史、老年人、酗酒	黑便、牙龈鼻出血不止、瘀斑增多、月经量多	血常规、大便潜血（有症状时）、用药核对
低钠	老年人、低体重、女性、合用利尿剂	没劲、没胃口、反应慢、走路不稳、意识变化	血钠（用药前及用药后数周）
QT 延长	女性、老年人、心脏病、低钾低镁、合用多种延长 QT 药	心悸、眼前发黑、晕厥、抽搐	心电图、血钾血镁（按需）

清单：就诊时主动交代的合并用药

这张清单建议拍照存在手机里，每次看医生（包括牙科、骨科、心内科、急诊）都拿出来。

- ☐ 所有处方药：降压药、降糖药、抗凝药、抗血小板药、激素、抗癫痫药
- ☐ 所有非处方止痛药：布洛芬、双氯芬酸、萘普生、阿司匹林、感冒药里的复方成分
- ☐ 中成药和保健品：尤其是含圣约翰草、银杏、丹参、当归的产品
- ☐ 胃药：尤其是抑酸药，可能影响部分药物吸收
- ☐ 饮酒情况：每周几次、每次多少，如实说
- ☐ 既往病史：胃溃疡、消化道出血、心脏病、心律失常、肾病、肝病、甲状腺病
- ☐ 家族史：有没有人年轻时猝死、晕厥、先天性心脏病
- ☐ 最近有没有腹泻、呕吐、吃不下饭（会影响电解质）

清单里最容易漏的是“感冒药”和“中成药”。很多复方感冒药含 NSAIDs 或其他成分，吃的时候不觉得是“药”。

常见坑

坑一：把黑便当成“上火”或“吃了深色食物”。 柏油样黑便和食物染色的黑便不一样，前者发亮、有腥臭、成形。拿不准就拍下来给医生看。

坑二：老人突然变糊涂，只想到“痴呆”或“老了”。 如果在开始用药或加量后几周内出现，先查电解质。

坑三：心慌一下就过去，不当回事。 晕厥是 QT 延长最重要的红灯，哪怕只有几秒。

坑四：自己停抗凝药“避免出血”。 这可能诱发血栓，必须由医生决定。

坑五：觉得“查过心电图就万事大吉”。 心电图是当时的快照，电解质紊乱、加量、新加药物都会改变结果，需要按医生要求复查。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 呕血、黑便、晕厥；
- 抽搐、意识模糊、叫不醒；
- 突然晕倒，哪怕几秒后清醒；
- 持续心悸伴胸闷、头晕、大汗；
- 误服过量药物（尤其是 TCA），无论有没有症状。

当天联系开药医生：

- 牙龈、鼻子出血明显比以前多，或皮肤瘀斑增多；

> - 老人新出现没劲、没胃口、走路不稳、反应变慢；
> - 心悸、心跳不规律，但没有晕倒；
> - 准备开始吃新的止痛药、抗生素、抗真菌药或中成药；
> - 近期反复呕吐、腹泻、吃不下饭。

不确定时按严重处理。可以拨打 **12356** 心理援助热线先稳住情绪，但躯体症状的急症判断，还是要走急诊。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

7.6 实验室检查与监测计划

“我来看情绪问题，为什么要抽血、做心电图？”这是精神科门诊里很常见的疑问。答案是：有些身体疾病会伪装成抑郁，有些药物需要看肝肾功能才能安全使用，有些副作用只有化验才能早期发现。这一页讲清楚基线该查什么、复诊多久一次、什么情况要加查，以及拿到报告后该怎么看——既不漏查，也不过度检查。

为什么精神科也要抽血

大致有四个理由。

第一，排除“伪装成抑郁”的躯体疾病。 甲状腺功能减退、贫血、维生素 B12 缺乏、慢性感染、电解质紊乱，都可能表现为乏力、情绪低落、注意力差、睡眠紊乱。不查就按抑郁治，可能治了很久没效果。

第二，建立基线。 吃药前先知道肝肾功能、电解质、血常规是什么水平，后面出现异常时才知道“是药引起的”还是“本来就那样”。

第三，监测已知风险。 低钠、出血倾向、血糖血脂变化、肝功能损伤，早期往往没有感觉，只能靠化验发现。

第四，指导用药安全。 肝功能、肾功能会影响药物在体内的代谢和清除；心电图能发现 QT 延长的高危者。这些信息决定了“能不能用、要不要更密切地看”。

国内指南和 NICE 都建议：在开始抗抑郁治疗前做基本评估，包括必要的实验室检查，尤其对有躯体共病、老年人、多重用药的人【指南】。

基线查什么

不是每个人都要查全套。查什么，取决于年龄、既往病史、合并用药和准备用的药物。下表是常见的项目和大致的适用情况。

检查项目	主要为了看什么	哪些人尤其需要
血常规	贫血、血小板数量（影响出血风险判断）	几乎所有人；有出血倾向、老年人
肝功能	药物代谢能力、有无肝炎或脂肪肝	几乎所有人；饮酒、肥胖、肝病史
肾功能	药物清除能力、电解质平衡	老年人、糖尿病、高血压、肾病史
电解质（钠、钾、氯）	低钠的基线；钾镁与心脏风险相关	老年人、合用利尿剂、有呕吐腹泻
甲状腺功能（TSH 等）	甲减或甲亢都可能导致情绪症状	几乎所有人，尤其女性、老年人
空腹血糖、血脂	代谢基线；部分药物会影响	肥胖、糖尿病家族史、40 岁以上
心电图	QT 间期、有无心律失常、缺血	心脏病史、老年人、用 TCA 或西酞普兰类、合用多种药物
妊娠试验	是否怀孕，直接影响用药选择	育龄女性，尤其月经推迟时
维生素 B12、叶酸	缺乏可导致乏力、认知下降、情绪低落	素食、老年人、胃肠手术后、长期饮酒

检查项目	主要为了看什么	哪些人尤其需要
乙肝、梅毒等筛查	部分情况需要，视病史而定	有相关风险因素时

几点说明：

- **心电图不是人人都必须做**，但对老年人、有心脏病、准备用 TCA 或西酞普兰类、同时用其他可能延长 QT 的药物的人，通常建议做【指南】。
- **妊娠试验很重要**。怀孕早期用药和没怀孕时的选择完全不同，育龄女性月经推迟时一定要先排除。见 6.3 孕产期抑郁。
- **药物基因检测**近年被讨论得很多，目前证据有限、价格差别大，多数指南还没有把它列为常规【待验证】。可以作为和医生讨论的选项，但不建议因此推迟治疗。
- **不必追求“查得越全越好”**。没有指征的检查会增加费用、假阳性带来的焦虑，以及不必要的后续检查。

复诊频率：不同阶段不一样

复诊不是“有空就去”，频率本身是治疗的一部分。国内指南和 NICE 的建议大致如下【指南】。

阶段	大致频率	复诊重点
开始用药的前 4 周	每 1–2 周一次，或至少有一次电话/线上随访	副作用、睡眠、激越、自杀念头、能不能坚持吃
急性期（约前 6–12 周）	每 2–4 周一次	症状变化、剂量是否合适、是否需要调整方案
巩固期（症状缓解后 4–9 个月）	每 1–2 个月一次	是否稳定、有没有残留症状、副作用是否影响生活
维持期	每 2–3 个月一次；稳定多年后可延长	复发预警信号、代谢指标、生活事件、停药计划
减药或停药阶段	比稳定期更密，减量后数周内应有随访	撤药反应、复发信号、睡眠变化

现实中门诊资源紧张，不一定能做到这么密。如果约不到，可以用电话、互联网医院、社区随访补上；关键是**前四周别断联**。

什么情况要加查

下面这些情况，即使还没到复查时间，也值得主动要求加查。

- ☐ 新加一种药，或明显加量（尤其是可能影响心电图、电解质、肝功能的药）
- ☐ 开始合用利尿剂、降压药、抗凝药、抗血小板药、NSAIDs 止痛药
- ☐ 老年人首次用药，或近期出现跌倒、意识变化
- ☐ 连续呕吐、腹泻、吃不下饭、大量出汗（电解质容易乱）
- ☐ 出现心悸、晕厥、抽搐、明显乏力

- ☐ 出现黑便、呕血、异常瘀斑、出血不止
- ☐ 发热、黄疸、尿色变深、右上腹不适（警惕肝损伤）
- ☐ 明显口渴、多尿、体重快速下降（警惕血糖问题）
- ☐ 怀孕或准备怀孕
- ☐ 长期饮酒或近期大量饮酒
- ☐ 疗效一直不好，需要排查“假难治”（见 5.1 难治性抑郁的评估）

怎么看懂报告

拿到化验单，先看三件事：**哪些项目有箭头、箭头偏离多少、和上次比变化多大**。不要只盯着箭头。

常见项目	大致看什么	容易误会的地方
血钠	低于参考范围要重视，尤其在用药早期	轻度偏低可能没症状，但需要复查；不要自己猛喝盐水
血钾	过低会增加心律失常风险	腹泻、利尿剂、吃太少都会低
转氨酶（ALT/AST）	升高提示肝细胞受损	轻度升高很常见，可能和脂肪肝、饮酒、剧烈运动有关
肌酐	反映肾功能	肌肉量大的人可能偏高，不代表肾坏
血红蛋白	贫血	女性生理期后可能偏低
TSH	甲状腺功能	边缘升高需要复查，不一定要立刻吃药
心电图 QTc	是否延长	机器自动读数常不准，需要医生人工判读

几个原则：

1. **参考范围是群体的，不是个人的。** 略高于或略低于上限，不等于生病。
2. **单次异常不如趋势重要。** 一次转氨酶轻度升高，和连续三次逐步上升，意义完全不同。
3. **不要拿报告自己下诊断，也不要自己买药“纠正”。** 比如看到血钠低就大量喝盐水，可能适得其反。
4. **报告要给开药医生看，不要只看化验科的解释。** 同一个数值，在不同药物背景下处理方式不同。

一份可以照抄的监测记录

把每次检查结果记在一张纸上，复诊时直接给医生看，比翻手机相册有效得多。

- ☐ 日期、医院、检查项目
- ☐ 关键数值：血钠、血钾、转氨酶、肌酐、血红蛋白、TSH、空腹血糖、血脂
- ☐ 心电图结论（QTc 数值，如有）
- ☐ 当时的用药清单（药名、每天几次、每次几片）
- ☐ 当时有没有症状（乏力、心悸、出血、水肿等）
- ☐ 医生的处理意见和下次复查时间

不要过度检查，也不要漏查

这句话听起来像废话，但两头都常见。

过度检查的样子：每次复诊都要求查全套、反复做心电图、花大钱做各种“营养评估”“基因检测”，结果报告一堆箭头，越看越焦虑，反而不敢吃药。检查是为了回答具体问题，没有问题就没有必要查。

漏查的样子：吃了几年药从没查过电解质；老人开始用药前没查过血钠；同时吃布洛芬和 SSRI 却没人提过出血风险；心悸晕厥过一次但没做心电图。这些漏掉的项目，往往正是最容易出问题的地方。

一条实用原则：**治疗开始前查一次基线，之后按风险定期复查，出现症状随时加查。** 具体查什么、多久查一次，由医生根据你的情况决定。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 晕厥、抽搐、意识模糊；
- 呕血、黑便；
- 胸痛、持续心悸伴头晕大汗；
- 高热伴肌肉僵硬、意识改变；
- 皮肤或眼白发黄并迅速加重。

当天联系开药医生：

- 化验报告出现明显异常（血钠低、血钾低、转氨酶明显升高、QTc 延长）；
- 新出现出血倾向、明显乏力、水肿、尿量减少；
- 准备开始吃新的处方药、非处方止痛药或中成药；
- 怀孕或怀疑怀孕；
- 连续呕吐腹泻、吃不下饭超过一两天。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 8：疗程、依从性与停药

抑郁症治疗最容易被低估的部分，是“好了之后还要走多久”。这一模块讲足疗程、漏服、停药和维持治疗。

8.1 为什么要足疗程

很多人有过这样的经历：吃药两个月，终于觉得“活过来了”，于是把剩下的药收进抽屉，觉得没必要再吃。几个月后，同样的疲惫、失眠、绝望又回来了，而且这次来得更快。这一页讲清楚：应答、缓解、复发分别是什么，三个阶段各要多长，为什么“好了就停”代价很高，以及维持治疗到底是不是“多吃几年”。

三个词：应答、缓解、康复

治疗有效果，不等于治好了。医学上把“好”分成几层，每一层的含义和后续安排都不一样。

说法	大致含义	判断方式	接下来做什么
应答	症状减轻了相当一部分，但还明显存在	量表分数下降约一半，或自己感觉“好了一些”	继续当前治疗，别急着改
缓解	症状基本消失，接近病前状态	量表分数降到很低，且持续数周	进入巩固期，防止反弹
康复	缓解持续足够久，功能也恢复了	症状、功能、生活质量都回到正常范围	考虑维持或讨论停药
复燃	在缓解期内、还没停药时症状又回来	缓解后几个月内重新出现	恢复或加强治疗
复发	康复之后又出现一次新的发作	通常指康复后数月到数年再次发作	重新评估，往往需要更长的疗程

两个容易被忽略的点：

第一，“应答”不是终点。 只达到应答就停下来，等于在房子刚打好框架时撤走工人。临床上大量“治疗效果不好”的案例，其实是“有效但没治够”。

第二，复燃和复发不一样。 复燃发生在治疗的巩固期，说明治疗还不够；复发发生在康复之后，说明这个人本身有反复发作的倾向。两者的处理不同，但都指向同一件事：**疗程不能凭感觉决定。**

在 1.1 治疗目标与缓解标准 里，对这几个概念有更细的说明。

三个阶段的时间框架

抑郁症的治疗通常分三期。时间只是大致范围，具体要看发作次数、严重程度、残留症状和个体反应【指南】。

阶段	大致时长	主要目标	常见做法
急性期	约 6–12 周	把症状压下去，达到应答甚至缓解	用药、心理治疗、必要时物理治疗；较密的复诊
巩固期	缓解后 4–9 个月	守住成果，防止复燃	维持同样的有效方案，不轻易减量、换药
维持期	因人而异，首次发作通常至少 6–12 个月；多次复发者常需 2 年以上甚至更久	预防新的发作	继续有效剂量，拉长复诊间隔，做复发预警和生活方式管理

几点说明：

- **“急性期 6–12 周”不是“吃 12 周就能停”**。它指的是症状控制所需的时间，后面还有巩固和维持。
- **巩固期的核心是“不动”**。这个阶段最常见的问题是“感觉好了就自己减量”，而它恰恰是复燃风险最高的时期。
- **维持期长短取决于复发史**。首次发作、缓解彻底、功能恢复好的人，维持时间可以短一些；有过多次发作、有残留症状、起病早、家族史明显的人，往往需要更久。这个决定要和医生一起做。

过早停药的代价

“过早停药”是抑郁症治疗里最常见、也最可惜的一种失败。它的代价不在于“白吃了几个月”，而在于几件更麻烦的事。

第一，复燃风险在停药后的几个月内最高。 缓解后不久就停药的人，短期内的复燃率明显高于继续治疗的人【指南】【研究】。这不是说每个人都会反弹，而是概率被显著抬高了。

第二，每一次复发都可能让下一次更难治。 反复发作的人，往往出现“发作间隔越来越短、每次持续时间更长、残留症状更多”的趋势。有一种解释叫“敏感化”——每经历一次发作，大脑对下一次应激的反应阈值就低一点【待验证】。这个机制还在研究中，但临床观察到的趋势是清楚的。

第三，复发会带来实际的损失。 工作、学业、关系、经济、自尊，都会因为一次发作被打断。很多人事后回想，最后悔的不是“多吃了一年药”，而是“那次停太早，把刚恢复的生活又推回去了”。

第四，反复停药会让医生难以判断。 每次都在不同阶段中断，医生看不到完整的治疗反应，选药只能靠猜。

需要说清楚的是：**这不是在吓唬人必须终身服药。** 很多人可以在规范治疗一段时间后顺利停药，关键在“什么时候停、怎么停、停了之后怎么监测”，见 8.3 停药计划与撤药管理。

症状好了，功能还没恢复

这是最容易被忽略的一层。心情好转、能睡着、愿意出门，不等于“恢复到病前”。

功能包括很多方面：

- **工作与学习**：能不能维持注意力、按时完成任务、处理复杂问题；
- **社交**：能不能主动联系人、参加聚会、处理冲突；
- **家务与自我照顾**：做饭、打扫、按时吃饭洗澡；
- **认知**：记忆、专注、决策速度——抑郁发作后这部分常常恢复得最慢；
- **睡眠与精力**：是不是还需要比平时更多的休息。

很多人复诊时说“我好多了”，医生再问“能上班吗”，才发现只能上半天，或者一加班就崩。**这不是“矫情”，是功能还没恢复。**

残留症状尤其值得警惕。常见的残留包括：**疲劳、失眠、焦虑、注意力差、兴趣减退、身体不适**。这些症状即使很轻，也会明显抬高复发风险【研究】。所以复诊时不要只说“心情”，要把功能讲具体：

- 这一周上了几天班 / 上了几节课？
- 有没有做家务、见朋友？
- 有没有因为注意力差而出错？
- 睡眠几个小时，白天要不要补觉？

功能恢复是疗程的重要判断依据，也是“能不能考虑停药”的关键条件之一。

维持治疗不是“多吃几年”

很多人对维持治疗有误解，觉得是“医生保守”“药厂想多卖药”。其实维持治疗做的事很具体：

常见误解	实际情况
“维持治疗就是加大剂量”	通常维持的是**已经有效的剂量**，不是越吃越多
“维持期要一直频繁复诊”	稳定后复诊间隔可以拉长到 2–3 个月甚至更久
“维持期什么都不能做”	正是做心理治疗、运动、睡眠管理、复发预警的时期
“吃了就停不下来”	多数人可以在计划下逐步减停；需要长期治疗的是反复发作的那部分人
“维持治疗等于终身服药”	两者不是一回事，疗程由复发风险和反应决定

维持期真正要做的事：

- **保持有效剂量**，不因为“感觉好了”就自行减量；
- **继续监测副作用**，尤其是体重、代谢、性功能（见 7.4 性功能体重与代谢）；
- **建立复发预警清单**，知道自己最早的信号是什么（见 9.1 复发预警信号清单）；
- **把生活节律固定下来**：睡眠、运动、社交、日照；
- **处理残留症状**，不要觉得“差不多就行”。

清单：判断自己在哪个阶段

☐ 我知道自己现在处于急性期、巩固期还是维持期

- ☐ 我知道医生给我定的下一个评估时间
- ☐ 我能说出自己“缓解”的判断标准（不只是“感觉好点”）
- ☐ 我记录睡眠、情绪、功能（工作/学习/家务）三项
- ☐ 我知道自己有哪些残留症状
- ☐ 我知道自己的复发预警信号前三条
- ☐ 我没有因为“好了”自行减量或停药
- ☐ 我知道如果要停药，应该先和谁讨论

常见坑

坑一：把“能上班了”当成“可以停药了”。 能上班是功能恢复的开始，不是终点。

坑二：把“副作用难受”当成“该停药了”。 副作用有调整空间，未必需要停药，见 2.5 常见副作用与应对。

坑三：把“这次是轻的”当成“不用治”。 轻度发作也可能迁延，反复发作的判定看的是次数和影响，不是单次严重程度。

坑四：只和医生聊情绪，不聊功能。 医生看不到你的生活，你不说，他就只能按量表判断。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 出现自杀计划、准备行为或自伤；
- 意识模糊、高热、肌肉僵硬、抽搐；
- 晕厥、胸痛、严重过敏。

尽快联系开药医生（当天到数日内）：

- 症状在好转后再次明显加重；
- 自行停药或减量后出现失眠、焦虑、头晕、情绪低落；
- 功能明显退步（上不了班、出不了门）；
- 副作用影响到是否愿意继续治疗；
- 想讨论停药计划。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.

- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.2 漏服忘服与自行减量

几乎每个长期服药的人都漏过药。有人漏了一次就焦虑一整天，有人漏了几天觉得“反正也没事”，还有人干脆把一片掰成两半、或者改成隔天吃一次，想着“少吃点总归安全些”。这一页讲清楚：漏服之后到底该怎么处理、为什么不能盲目补双倍、自行减量会带来什么、怎么把漏服降到最低，以及怎么和医生开口说这件事。

漏服很常见，先别自责

长期吃药这件事，比想象中难。要记时间、要记得有没有吃、要应付出差和加班、要面对“今天感觉挺好，是不是可以不吃了”的念头。漏服不是意志力问题，它更像一个设计问题——流程没设计好，谁都可能漏。

需要先区分两种“没吃”：

- **漏服**：该吃的时候忘了，事后想起来。这是偶发的。
- **自行减量**：有意识地少吃、掰半片、隔天吃、或者干脆停掉。这是主动的。

两者的处理完全不同。漏服是补不补的技术问题；自行减量是需要和医生讨论的方案问题。很多人把第二种伪装成第一种，跟医生说“我有时候会忘”，其实是自己拿的主意——这会让医生按错误的信息调整治疗。

漏服后的通用原则

先记三句话：

1. **想起来了，如果离下次服药时间还早，就补上。**
2. **如果已经接近下次服药时间，就跳过这次，按原时间吃下一次。**
3. **任何情况下都不要一次吃两倍。**

“还早”怎么算？一个粗略的通用说法是：如果距离下次该吃药还有大半天，通常可以补；如果只剩几个小时，就跳过。但这条规则**不能套用到所有药**，因为不同药物在体内停留的时间差别很大。

药物特点	代表药物（仅举例）	漏服后的大致倾向
半衰期较长，体内停留久	氟西汀	漏一两次影响相对小，通常不必补服，按原计划继续
半衰期较短	帕罗西汀、文拉法辛、舍曲林等	漏服后容易出现头晕、恶心、电击感，补服要更谨慎，接近下次时间就跳过
需要稳定血药浓度	大多数抗抑郁药	频繁漏服会直接影响疗效判断

这里要解释一个词：**半衰期**，指药物在体内浓度下降一半所需要的时间。半衰期长的药，漏一次后体内还剩不少；半衰期短的药，漏一次就可能出现明显的“断档感”，也就是撤药反应。

具体到你自己吃的药，请以说明书和医生的说法为准。 上面这张表只是帮你理解“为什么不能一刀切”，不是操作指南。

为什么不能“加倍补”

这是最需要说清楚的一条。很多人觉得“少吃了一顿，补回来就扯平了”，实际上不是。

第一，血药浓度不是线性的。 一次吃两倍，体内浓度会出现一个明显的高峰，而不是“把缺口填平”。高峰带来的是副作用叠加：恶心、头晕、出汗、心慌、坐立不安。

第二，部分药物过量有特定风险。 比如三环类（TCA）过量对心脏有毒性和致死风险；SSRI 与 SNRI 过量可能诱发血清素综合征（表现为高热、肌肉僵硬或抽动、意识改变、心跳快）；某些药物过量会加重 QT 延长。**误服过量本身就是需要急诊处理的情况。**

第三，补双倍会让后面几天更乱。 浓度高了之后又代谢掉，情绪和睡眠跟着波动，你更难判断“到底是药的问题还是病的问题”。

所以记住一句话：**漏了就漏了，宁可少一次，不要多一倍。**

自行减半、隔天吃的风险

“我自己减一点”看起来温和，实际上是几种风险叠在一起。

风险一：撤药反应。 尤其是半衰期短的药，减量或漏服后容易出现头晕、恶心、乏力、焦虑、失眠，还有一种很典型的“电击感”——像脑子里突然闪过一道电流，或者转头时眼前一晃。这些不是“病情加重”，但非常难受，也容易让人误以为“我不能停药”。

风险二：疗效不足，慢慢滑回去。 减量后血药浓度下降，可能还够“撑着”，但不够“治病”。表现是：没有明显崩溃，只是越来越累、越来越没兴趣、越来越容易烦。这种缓慢的下滑最容易被忽略，等发现时已经复燃了。

风险三：医生判断失误。 医生以为你在按方案吃药，看到效果不好，可能会加量、换药、甚至加第二种药。你实际上是“剂量不足”，却可能被当成“难治”——这是 5.1 难治性抑郁的评估 里说的“假难治”的常见原因之一。

风险四：隔天吃并不等于“减半”。 隔天吃会让浓度忽高忽低，波动比每天半片更大，撤药反应和情绪波动都可能更明显。

风险五：有些药不能随便停。 比如部分药物突然停用会引起较明显的撤药综合征；有双相倾向的人，不规律用药还可能诱发情绪波动。具体哪些药需要特别小心，见 8.3 停药计划与撤药管理。

如果副作用实在难受，正确的做法不是自己减，而是**联系医生，说明“难受到想减量”**。医生可以换药、调整服药时间、处理副作用，或在你知情的情况下减量——这些都比你自己试要安全。

怎么把漏服降到最低，以及怎么和医生谈

漏服是流程问题，就用流程解决。下面这份清单可以挑几条适合自己的。

- ☐ 用一周分装药盒，提前分好，看格子就知道今天吃没吃
- ☐ 手机设两个闹钟：一个提醒吃，一个在 30 分钟后确认
- ☐ 把吃药和固定动作绑定：刷牙后、早饭最后一口、睡前关灯前
- ☐ 药放在每天必经之处，但避开潮湿的卫生间和阳光直射
- ☐ 包里、办公室各放一份“应急量”，用密封袋装好并标注药名
- ☐ 出差、旅行前按天数算好，多带两三天
- ☐ 让一位家人知道你的服药时间，必要时提醒
- ☐ 用日历或 App 打勾，连续记录比记忆可靠
- ☐ 出现漏服就在记录上写一笔，复诊时如实说
- ☐ 换药、加量、减量时重新设提醒（旧习惯容易沿用错误的量）

最后一条常被忽略：每次方案变化，都要重新检查一遍流程，因为很多漏服发生在“刚换药”的那几周。

和医生沟通的模板

很多人不是不想说，是不知道怎么开口。下面这几句可以直接用。

情形一：偶尔漏服

> “上周有两次忘了吃，一次是晚上加班，一次是周末出门没带药。这两天有点头晕，不知道和这个有没有关系。”

情形二：经常漏服

> “我最近一个月大概有一半的日子会漏，主要是早上太赶。有没有可能把服药时间调到晚上？或者有没有别的办法？”

情形三：自己减量了

> “有件事我要如实说：最近两周我自己把药减半了，因为副作用让我很难受。减了之后情绪有点往下走，我想和你商量怎么调整。”

情形四：想减量但还没做

> “我最近状态不错，想了解减量的条件和风险。如果现在不适合减，我想知道需要满足什么条件。”

情形五：漏服后不确定怎么办

> “我昨晚漏了一次，今天早上想起来，就补吃了。这样对不对？以后遇到这种情况该怎么处理？”

如实说不会挨骂，反而能让医生把方案调对。**隐瞒漏服，等于让医生在错误的信息上做决定。**

常见坑

坑一：把“今天感觉好”当成“可以不吃”。 感觉好往往是因为药在起作用，不是因为病自己走了。

坑二：把漏服后的头晕当成“病情加重”。 短半衰期药物漏服后的头晕、电击感更像撤药反应，补上或按计划继续通常能缓解。持续不缓解要联系医生。

坑三：把“隔天吃”当成“温和减量”。 波动更大，风险更高。

坑四：一次漏服后紧张到不敢再吃。 漏一次不会毁掉治疗，按原则处理就行。

坑五：让别人替你决定吃不吃。 家人可以提醒、可以保管药物，但“今天吃不吃、吃多少”应该由你和医生决定。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即去急诊或拨打 120：

- 误服过量（多吃了一次、一次吃了两倍甚至更多），无论有没有症状；
- 出现高热、肌肉僵硬或抽动、大汗、意识模糊、心跳很快——可能是血清素综合征；
- 严重头晕、晕厥、心悸、抽搐；
- 儿童误服。

尽快联系开药医生（当天到数日内）：

- 连续多日漏服，或已经自行减量、停药；
- 漏服后出现明显头晕、恶心、电击感、焦虑加重，持续不缓解；
- 情绪在漏服或减量后明显下滑；
- 副作用难受到想自行调整；
- 需要出差、旅行、手术、怀孕，可能影响服药安排。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.3 停药计划与撤药管理

停药是治疗的一部分，不是治疗的失败。但“停药”这两个字里藏着两件完全不同的事：一件是**有计划地慢慢减**，另一件是**某天突然不吃了**。前者大多顺利，后者常常以头晕、电击感、失眠、情绪反弹收场，甚至把好不容易稳住的病情推回去。这一页讲清楚什么时候可以考虑停、怎么慢减、撤药反应和复发怎么分，以及停药后几个月该盯什么。

什么时候可以考虑停

停药不是凭“感觉好了”决定的，它有几个前提条件。国内指南和 NICE 的建议大体一致：**在缓解并稳定足够长的时间后，结合复发风险、功能恢复和患者意愿，共同决定**【指南】。

可以考虑	建议暂缓
症状缓解，且已维持足够长时间（首次发作通常至少 6–12 个月，具体由医生判断）	刚缓解几个月，或症状时好时坏
功能基本恢复：能工作/学习、能社交、能照顾自己	能上班但一加班就崩，或仍有明显残留症状
生活相对稳定，近期没有重大变动	正面临换工作、搬家、考试、丧亲、离婚等重大应激
知道自己的复发预警信号，也有应对计划	说不清自己最早会有什么变化
副作用明显影响生活，且已尝试过其他办法	因为“不想吃药”“觉得丢人”而想停
有医生参与，能定期随访	独自在外、复诊不方便、联系不上医生

有几类人通常需要更长的维持治疗，甚至长期治疗：

- **多次复发**（一般认为三次及以上，或两次但间隔很短）；
- **有残留症状**：疲劳、失眠、焦虑、注意力差；
- **慢性化**：一次发作持续两年以上；
- **起病年龄早**、有明确家族史；
- **共病**：焦虑障碍、物质使用、人格障碍、慢性躯体疾病；
- **既往停药后很快复发**。

这些不是“永远不能停”，而是“停之前要更谨慎、停之后要更密地看”。

缓慢减量的原则

减量的核心不是“快”，而是**让身体有时间适应**。具体怎么减、减多快，必须由医生定；这里只说原则。

原则一：医生主导，不自己动手。 减量方案要考虑药物半衰期、用了多久、剂量多大、既往有没有撤药反应。同样的药，不同人的减法可能完全不同。

原则二：一步一步来，每步之间留观察期。 通常以周为单位，越到后面减得越慢。原因是：剂量越低，同样的减量幅度对血药浓度的影响比例越大。

原则三：一次只改一件事。 减药期间不要同时换工作、搬家、开始节食、戒咖啡、尝试新的保健品。变量太多，出了状况分不清原因。

原则四：最后一段最需要耐心。 很多人减到最后一点时觉得“都到最后了，干脆停掉”，结果撤药反应恰恰出现在这一步。

原则五：减量期要记录。 每天记睡眠、情绪、有没有头晕/电击感/恶心。这份记录是判断“撤药反应还是复发”的关键。

原则六：选一个相对平稳的时间窗口。 避开考试、项目截止、家庭重大事件、长途旅行。

关于“减到多少可以停”，没有通用答案。有的人减到很小的量后顺利停掉，有的人需要在很小的量上再维持一段时间。这不是“意志力”问题，是药物代谢的个体差异。

撤药反应和复发怎么分

这是停药阶段最实际的问题。两者看起来都像“又不舒服了”，但性质完全不同，处理方式也相反。

维度	撤药反应	复发
出现时间	减量或停药后数小时到数天内	通常数周到数月，逐步出现
典型表现	头晕、走路发飘、恶心、乏力、流感样感觉、电击感、失眠、焦虑、易激惹、多梦	原来抑郁的那套症状回来：情绪低落、兴趣丧失、自责、绝望
变化速度	来得快，也可能去得快	逐步加重，不会自己好转
对补服的反应	恢复原剂量后很快缓解	补回剂量只能部分缓解，仍往下走
持续时间	一般数天到数周，逐渐减轻	持续加重，超过两周不缓解要重视
伴随想法	多为身体不适，不一定有绝望感	常伴无望感、自责、自杀念头

“电击感”值得单独解释一下：很多人描述为“脑子里突然闪过一道电流”“转头时眼前一晃”“像被静电打了一下”。它听起来吓人，但通常是良性的撤药反应，恢复用药或减量慢一点就会缓解。

最需要注意的一种情况：撤药反应和复发同时发生。比如减量后出现失眠和焦虑，几周后情绪也开始往下走——这时候不能只当成撤药反应硬扛，要联系医生。

哪些药更容易出现撤药反应？一般来说，**半衰期短的药**（如帕罗西汀、文拉法辛）更明显；**半衰期长的药**（如氟西汀）相对轻；三环类、米氮平也有各自的撤药表现（米氮平常见失眠反弹）。这只是群体规律，个体差异很大。

一个常见的错误判断：把撤药反应当成“我果然不能停药，一停就犯”，于是彻底放弃停药的可能。实际上，多数撤药反应可以通过“减得更慢”来解决。

停药后前几个月怎么监测

停药不是终点，是另一个观察期的开始。复发风险在停药后的几个月内相对集中，所以这段时间反而要看得更紧【指南】。

- **前 1–2 个月**：每 1–2 周做一次简单自评（睡眠、情绪、兴趣、精力），每 2–4 周联系一次医生或复诊。
- **第 3–6 个月**：每月自评一次，每 1–2 个月复诊一次。
- **6 个月以后**：如果稳定，可以拉长到 2–3 个月，但至少每半年复盘一次。
- **任何时候**出现预警信号，不等预约，直接联系。

盯什么？按重要性排序：

1. **睡眠**：入睡时间、早醒、总时长。睡眠往往是最早变化的指标。
2. **兴趣**：对原本喜欢的事还有没有感觉。
3. **精力**：是不是又出现“做什么都要很大力气”。
4. **思维**：注意力、决策、自责频率。
5. **身体**：食欲、体重、疼痛、胃肠不适。

如果这几项里有两项连续两周变差，就该联系医生，而不是“再观察观察”。

怀孕、备孕时的调整必须提前讨论

这是最不能自作主张的一类情况。

很多人一发现怀孕就立刻把药停掉，觉得“为了孩子好”。但**停药本身也有风险**：孕期抑郁复发会影响睡眠、营养、产检配合，严重时危及母婴安全。而药物在孕期的风险，也和孕周、剂量、具体药物有关——这些必须由产科和精神科一起评估。

需要提前做的事：

- **计划怀孕前就开始讨论**，不要等怀上了再问。理想情况是提前几个月，让医生有时间调整方案。
- **不要自行停药或减量**。突然停药带来的撤药反应和情绪波动，对孕早期并不友好。
- **告诉医生你已经在吃的所有药**，包括保健品和中成药。
- **产后要格外留意**。产后是情绪问题的高发期，也是用药需要重新评估的节点。
- 具体原则见 6.3 孕产期抑郁。

哺乳期同理。很多药物在哺乳期是可以用的，但需要医生根据药物特性和婴儿情况判断，不能凭“吃药就不能喂奶”一刀切。

清单：停药前要问医生的七个问题

☐ 我现在满足停药的条件吗？如果不满足，还差什么？

- ☐ 我属于复发风险较高的那一类吗？依据是什么？
- ☐ 减量大概分几步、每步间隔多久？
- ☐ 出现哪些症状算撤药反应，哪些算复发？
- ☐ 如果减到一半就难受，是退回去还是继续？
- ☐ 停药后多久复诊一次？出现什么要提前来？
- ☐ 如果将来再次发作，之前的方案还能不能用？

把这七个问题的答案记下来。**“医生同意了”不等于“我听懂了”**，写下来才算数。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 出现自杀念头、计划或准备行为；
- 停药后出现严重焦虑、极度激越、无法入睡，伴失控感；
- 晕厥、抽搐、意识模糊；
- 高热、肌肉僵硬、意识改变。

尽快联系开药医生（当天到数日内）：

- 减量后出现明显头晕、电击感、恶心，影响生活；
- 停药后情绪持续下滑超过两周；
- 失眠连续一周以上，且越来越重；
- 出现复发预警信号（见 9.1 复发预警信号清单）；
- 发现怀孕或计划怀孕；
- 想加快减量进度。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

8.4 维持治疗与依从性

治疗到一定阶段，问题会从“这药有没有效”变成“我还要吃多久”和“我怎么才能一直吃下去”。这两件事其实是一件事：维持治疗的时间越长，越需要一套能运转的日常系统；而系统能不能运转，又取决于副作用、花费、病耻感和身边人的态度。这一页讲清楚维持多久、哪些人需要更长、依从性为什么会掉，以及家属怎么帮而不变成控制。

维持多久：没有一个数字适合所有人

维持治疗的目的不是“多吃几年”，而是**把复发的概率压下来**。时间长短取决于复发风险，而复发风险由几件事决定：发作过几次、缓解得彻不彻底、有没有残留症状、起病早晚、家族史、共病、生活是否长期高压。

情况	维持治疗的大致方向
首次发作，缓解彻底，功能恢复好	通常至少 6–12 个月，之后可讨论逐步减停
两次发作，或首次发作但有明显残留症状	一般建议更长，常以年计
三次及以上发作	通常建议长期维持，部分人需要多年甚至“不确定期限”的长期治疗
慢性化（一次发作持续两年以上）	往往需要长期维持，重点转向功能康复
合并焦虑、物质使用、慢性躯体疾病	需要更长，且要同时处理共病
既往停药后很快复发	再次维持的时间通常要比上次更长

“indefinite”这个词在指南里常被译成“长期”或“不确定期限”，意思是**没有预设的停药时间点，定期评估、能减则减，但不强求停**。这不是“一辈子被困住”，而是“把复发风险控制在一个可接受的范围内”。

剂量的原则比较简单：**维持期通常沿用急性期有效的剂量**，不是“好了就减半”。这一点在 8.1 为什么要足疗程 里有更详细的说明。

哪些人需要更长

把上一节的判断标准说得更具体一些，下面这些人通常属于“需要更长”的那一类【指南】【研究】。

- **多次复发**：发作次数越多，下一次越容易来，间隔也可能越短。
- **有残留症状**：疲劳、失眠、焦虑、注意力差，即使很轻，也会抬高复发风险。
- **慢性化**：症状持续两年以上，恢复往往更慢，需要更长的维持。
- **共病**：焦虑障碍、物质使用、人格障碍、慢性疼痛、糖尿病、心血管病，都会让治疗更复杂。
- **起病年龄早**：青少年期起病的人，复发风险通常更高。
- **家族史明显**：一级亲属中有抑郁症或双相障碍。
- **既往停药后复发**：这是最直接的信号——上一次的教训值得参考。

- **长期高压的生活处境**：照护重病家人、长期夜班、贫困、持续的人际冲突。这些不是“想开点”能解决的，需要社会支持和现实调整。
- **老年人和孕产期女性**：生理和社会因素都更复杂，需要个体化评估。

需要强调的是：**“需要更长”不等于“永远不能停”**。它意味着停药要更慢、监测要更密、决定要更谨慎。

依从性差的常见原因

“不听话”是最没用的解释。人不会无缘无故放弃对自己有好处的事，掉队背后通常有具体原因。下面这张表把常见原因和对应的解法放在一起。

原因	常见表现	可以怎么处理
副作用	性功能、体重、嗜睡、恶心、出汗	见 7.4 性功能体重与代谢，和医生谈调整，不要自己停
病耻感	不想让人看见吃药，把药装进维生素瓶	换一个中性药盒；只告诉必要的人；理解“吃药”和“糖尿病打胰岛素”没有本质区别
感觉好了	“我已经好了，不用吃了”	把维持治疗的理由讲清楚；设定下一个评估时间点，而不是“无限期吃”
费用	自费压力大、进口药贵	问医生有没有同类可及的选择；了解门诊慢特病、医保报销
忘记	作息不固定、出差多	分装盒、闹钟、和固定动作绑定（见 8.2 漏服忘服与自行减量）
信息混乱	网上说“伤肝”“上瘾”“吃傻”，与医生说法冲突	把疑问带给医生，而不是自己停药验证；见 12.1 常见治疗误区 40 条
害怕依赖	“是不是要吃一辈子”	区分“依赖”和“维持治疗”；成瘾是另一回事
没有反馈	觉得“吃了也没用”	用记录看趋势；和医生讨论疗效评估的时间点
酒精或物质使用	吃药时喝酒、用其他物质	如实告诉医生，这会影响方案和风险评估
治疗关系	觉得医生不重视自己、沟通不畅	可以换医生，但不要停治疗；见 1.3 共同决策与治疗联盟

有一点值得单独说：**副作用是依从性最强的预测因素之一**。很多人不是“不想治”，而是“受不了”。如果医生不知道你受不了什么，他就没法帮你调整。

把“坚持”变成系统

靠意志力坚持一件要做几百次的事，成功率很低。更可靠的办法是把决定“外包”给流程。

- ☐ 固定一个服药时间，和每天必做的事绑定（刷牙、早饭、睡前）
- ☐ 一周分装一次药盒，看格子就知道吃没吃
- ☐ 手机设两个闹钟，第二个用来确认

- ☐ 包里放一份应急量，用密封袋标注药名
- ☐ 每次复诊结束，当场约好下一次的时间
- ☐ 把复诊日写进日历，提前一天设提醒
- ☐ 记录睡眠、情绪、副作用三行，复诊时带上
- ☐ 算好取药周期，提前一周去开药，别等到断药
- ☐ 出差、旅行、节假日提前备药
- ☐ 把“我为什么吃这个药”写在纸上，状态差的时候拿出来看

最后一条常被低估。人在抑郁状态下会丧失“为什么要做这件事”的记忆，一张自己写的纸条，比当下的判断更可靠。

还有一个实用策略：**把“坚持”换成“再吃一周”**。不要想“我还要吃两年”，只想“这一周我按时吃”。长期目标太大，短期承诺更容易兑现。

家属怎么帮而不控制

家属的参与对依从性影响很大，但“帮”和“控制”只有一线之隔。区别在于：**帮是把选择权留给对方，控制是把选择权拿走。**

帮忙的样子	控制的样子
“今天的药吃了吗？我帮你倒了水。”	每天翻包、数药片、查手机
“这次复诊我陪你去，需要我进去吗？”	不经同意就替对方跟医生说话
“你不想说也没关系，我在客厅。”	逼问“你到底怎么想的”
“我们提前说好，如果连续几天睡不着就去医院。”	一出问题就没收药物、限制出门
“这个月药费我先垫，你方便再还。”	用钱来要求“必须听我的”
提醒一次，然后交给对方	反复叮嘱，直到对方发火

几条具体建议：

- **把提醒变成约定**：一起商定“谁在什么时候提醒、提醒几次”，而不是随时监督。
- **接受“对方有权拒绝”**：成年人有权对自己的治疗做决定，包括决定暂时不减量、决定换医生。
- **不要替对方保密到危险的程度**：涉及自杀风险时，保密要让位于安全，但要事先说清楚这个边界。
- **照顾好自己的情绪**：长期照护的人容易耗竭，耗竭之后的“帮”往往变成指责。
- **在稳定期谈规则**：不要等到吵起来才定规矩，平静时商量好的方案才执行得下去。

常见坑

坑一：把“维持治疗”理解成“医生想多开药”。 维持治疗针对的是复发风险，不是药厂利益。

坑二：把“感觉好了”当成“可以停了”。 感觉好常常是药在起作用。

坑三：把“副作用”忍到底。 忍到最后往往是突然停药，比一开始就沟通更糟。

坑四：把“依从性差”当成道德问题。 它通常是流程问题、信息问题或副作用问题。

坑五：家属用“我都是为你好”压过对方。 短期可能有效，长期会让人学会隐瞒。

什么时候需要联系医生或去急诊

立即拨打 120 或去急诊：

- 出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤；
- 意识模糊、高热、肌肉僵硬或抽动、大汗；
- 晕厥、胸痛、抽搐、严重过敏。

尽快联系开药医生（当天到数日内）：

- 已经停药或减量，情绪开始下滑；
- 副作用已经影响到是否愿意继续治疗；
- 连续两周以上睡不好、兴趣下降、精力变差；
- 因为费用问题打算自行减量或停药；
- 需要调整维持治疗的时长或剂量。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 9：复发预防与危机干预

这一模块是“救命模块”。平时可以不用，但建议每个患者和家属都提前读一遍，把安全计划填好。

9.1 复发预警信号清单

> 抑郁症缓解之后，很多人最怕的一句话是“又来了”。这一页把“又来了”拆成可以观察的具体变化：睡眠、兴趣、精力、思维、躯体、行为、人际七个方面各有哪些早期信号，怎么把它们变成一份属于你自己的清单，家属能看见什么，以及看到信号后当天该做什么。适合已经进入巩固期、维持期或已经停药的人，也适合想帮忙但不知道往哪里看的家属。读完你可以带走一份写着自己名字的预警清单，和一张三级行动表。

复发很少是“一夜之间”发生的

临床上更常见的情况是：在明显发作前的一到四周，人已经“有点不对”了——睡不好、提不起劲、开始躲人、脑子里冒出熟悉的消极念头。这一段常被叫作前驱期。前驱期的信号每个人不一样，同一个人两次发作也可能不一样，所以任何一份通用清单都只是起点，真正管用的是“你的版本”【研究】【临床经验】。

先说清一个容易混淆的地方：**症状波动不等于复发**。治疗过程中有一两天睡不好、情绪低落很常见，通常和具体事件、月经周期、连续加班、感冒、换季有关，几天内会回到原来的水平。复发信号的特点通常是三条：**持续**（不是一两天，而是一周以上）、**成串**（几个方面同时变）、**越来越重**（自己会往下走，不会自己回来）。

还有一条经验值得记住：情绪往往不是最早变的那个。很多人是先睡不好、先不想动、先觉得“什么都没意思”，过一两周才明显情绪低落。只盯“心情好不好”，容易错过更早的窗口【临床经验】。

七类早期信号对照表

下表左边是“和平时比，变了什么”，右边是常见误解。看的时候不要对照打分，只看有没有“中了好几条，而且持续”。

方面	早期信号（和平时比“变了”）	容易被误认为
睡眠	入睡比平时晚一小时以上；凌晨三四点醒后睡不着；早醒；总睡眠变短但白天不困；周末补觉也缓不过来	“最近压力大”“年纪大了觉少”
兴趣	以前固定做的事开始找借口不做（游戏、追剧、遛狗、做饭）；不是没时间，是“没意思”	“玩腻了”“成熟了”
精力	起床到出门要花很久；简单家务要分几次做完；说话变慢、句子变短、回复变短	“懒”“摆烂”

方面	早期信号（和平时比“变了”）	容易被误认为
思维	注意力涣散，看两页书就串行；做小决定困难；自我评价下降，“我没用”的念头回来；对未来只剩绝望	“想太多”“钻牛角尖”
躯体	头痛、胃部不适、食欲明显变差或变好、体重变化；晨起身体沉重；原有疼痛加重但查不出原因	“身体虚”“亚健康”
行为	不回消息、请假变多、迟到增多、拖延；酒精或助眠药使用增加；反复搜索自杀相关信息；突然整理物品、送东西、交代后事	“最近忙”“懂事了”
人际	因小事发火或哭；拒绝聚会邀请；和伴侣争吵变多；对批评异常敏感；觉得“谁都不需要我”	“脾气变差”“青春期”

其中有两类需要单独提高警惕：一是**突然的平静**。一个长期痛苦的人忽然变得异常平静、把重要东西送人、反复说“以后你们要好好的”，这可能不是好转，而是已经做了决定【临床经验】。二是**睡眠需求明显减少却精力旺盛、话多、花钱冲动**，这更像转躁而不是抑郁复发，处理方式完全不同，需要尽快看医生，不要自行加抗抑郁药。

做一份属于你自己的预警清单

通用清单最大的问题是太长。危机时人记不住二十条，所以要把清单压缩到五条以内，并且写成可观察的动作，而不是形容词。

照着下面六步做，半小时能完成：

- ☐ **第一步：回忆上一次发作前两到四周**，写下最早变化的三个具体事情。不要写“心情不好”，要写“连续三天凌晨四点醒”“一周没打开游戏”“开始不接我妈电话”。
- ☐ **第二步：压缩成五条**，每条不超过一行。宁可少，不要多。
- ☐ **第三步：给每条加一个阈值**，例如“连续三晚超过一点才睡”“连续五天没出门”。
- ☐ **第四步：写下你的基线**。缓解期的你本来是什么样：几点睡、一周运动几次、周末做什么。没有基线，“变了”就无从判断。
- ☐ **第五步：请一位家属独立写五条**“他/她变了的样子”，写完后和你那份对照。两份重合的部分，往往就是最可靠的信号。
- ☐ **第六步：放在看得见的地方**。手机备忘录第一屏、钱包里一张卡片、冰箱上贴一份；每次复诊带着；每半年和医生一起更新一次。

清单示例（一位虚构患者的版本，仅示意写法）：

1. 连续三晚超过两点才睡，或凌晨四点醒后睡不着。
2. 一周内没有碰过吉他。
3. 开始觉得“我拖累了家里”，一天出现三次以上。

4. 连续两天不洗澡、不出门。
5. 把工资卡密码告诉家人、整理旧照片。

这五条里没有一条是“情绪低落”。这不是说情绪不重要，而是情绪太笼统，等到自己能清楚说出“我很低落”时，往往已经过了最早的窗口。

家属能观察到什么

患者常常是最后一个知道自己状态变差的人——判断力、自知力本身会受病情影响。家属的优势不是“更懂”，而是**看得见行为**。以下这些是家属通常比患者更早发现的：

- 话变少，回家就进房间，饭桌上不接话。
- 房间变乱、外卖盒堆积、衣服不洗，个人卫生下降。
- 凌晨房间还亮着灯，白天睡到中午。
- 反复说“没事”“我很好”，但明显在回避。
- 突然把孩子送走、把宠物送人、把工作交接掉。
- 突然异常平静，或突然开始大量喝酒。

怎么开口，效果差别很大：

容易起反作用	更可能被接受
“你是不是又犯病了？”	“我注意到你这周都没去打球，是身体不舒服，还是提不起劲？”
“你要想开点，比你惨的人多了。”	“我不知道你现在具体什么感觉，但我在，你说不说都行。”
“你必须马上去医院。”	“我有点担心，要不要这周一起去趟门诊，我陪你挂号。”
当着孩子、亲戚的面问	单独、平静、不赶时间的时候问

家属还要守住一条边界：**观察不等于监控**。翻手机、查行踪、全天盯着，短期能让人安心，长期会让患者学会隐瞒。更好的做法是约定“哪些变化由谁来提醒”——比如由患者自己报睡眠，由家属报“三天没出门”。

出现信号后：三级行动分级

看到信号后最糟的处理是“再看看”。下面这张表把“看看”换成具体动作。级别由信号的**数量、持续时间、功能影响**共同决定，不只看某一条有多重。

级别	判断标准	二十四小时内做什么	主要执行人
黄色：观察级	一到两条信号，持续三天以上，吃饭上班基本正常	恢复睡眠和情绪记录；把非必要的加班、聚会减掉；把情况写进复诊单；告诉一位家人“我最近有点不对”	本人为主，家属知情
橙色：联系医生级	三条以上信号，或持续一周，或工作学习明显受影响	预约或加号精神科门诊，不必等到原定复诊；带上用药	本人加一位家属

级别	判断标准	二十四小时内做什么	主要执行人
	（请假、旷课、交不出活）	清单和睡眠记录；暂停任何自行减药的打算；增加陪伴时间	
红色：当天求助级	出现自杀念头、计划或准备行为；自伤；几乎不睡且话多冲动；拒食、不喝水；无法自理	不独处；先做手段限制（药物、利器交由他人保管）；拨打 120 或去最近医院急诊；拨打 12356；同时通知开药医生	家属主导，本人配合

这张表有两个使用要点。**第一，就高不就低。** 分不清黄还是橙，按橙处理；分不清橙还是红，按红处理。多跑一趟门诊的代价，远小于错过一次窗口。**第二，分级要和医生对过。** 你写的阈值医生可能不同意，正好在复诊时改。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> **当天联系精神科医生（或加号门诊）**：预警清单里同时中了三条以上；连续一周睡眠明显变差；出现“活着没意思”但还没有计划；工作学习已经受影响；正在减药或刚停药。
>
> **立即去急诊或拨打 120**：有自杀计划或已经开始准备（攒药、查方法、写告别信）；已经自伤；几乎不睡且兴奋话多、行为失控；拒食、不喝水超过一天；出现意识模糊、高热、肌肉僵硬、抽搐。
>
> **随时可打的电话**：12356 心理援助热线（全国推行，具体接通时段以当地公布为准）；110 报警（当有人身危险、需要现场处置时）；120 急救（当需要医疗转运时）。地方热线号码以当地卫健委公布为准，不要轻信群里转发的号码。

六个容易踩的坑

1. **把信号解释成“矫情”“懒”“想不开”。** 这些词会让患者学会不说，而隐瞒比症状本身更危险。
2. **等“确定复发”再行动。** 复发没有一条清晰的起跑线，等到能确诊时，往往已经错过调整方案最省力的阶段。
3. **只盯情绪，不盯睡眠和兴趣。** 情绪通常是最后变的，睡眠和“不想做事”往往早一到两周。
4. **缓解期自行停药，“观察看看”。** 停药要在医生指导下缓慢进行，停药后本身就需要更密的监测。停药计划见 8.3 停药计划与撤药管理。
5. **家属全天盯着。** 过度监控会换来隐瞒和对抗。约定“谁观察哪一项”，比二十四小时看守有效。
6. **清单写得像诊断标准。** 二十条全占的清单，等于没有清单。五条以内，能背下来，才有用。

还有一点值得提前说：预警清单不是“复发的证据”，也不是用来给自己下诊断的。它的作用只有一个——**让行动提前，而不是让焦虑提前**。看到信号，做表里那一格的事，然后继续生活。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022

- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.2 安全计划模板

> 安全计划是一张提前写好的纸：当自杀念头变强、脑子转不动的时候，你不需要临场想办法，只要照着上面写的做。这一页给你一份可以打印、可以拍照存手机的六步模板，也讲清楚每一步该填什么、怎么和家里人一起填、危机来的时候按什么顺序做。建议在状态还稳定的时候就填完，不要等到最糟的那天。

安全计划是什么，不是什么

安全计划（safety plan）是一份**由本人参与制定、写给自己看的行动清单**。它假设最坏的情况可能发生，所以提前把“那时候找谁、做什么、把什么东西先收起来”固定下来。国际上常用的六步版本最早由 Stanley 和 Brown 提出，之后被大量危机干预服务采用，NICE 指南也建议对有自杀风险的人提供类似的安全计划与随访【指南】。

它和几样东西容易混淆，区别值得说清：

容易混淆的	区别
不自杀承诺书	承诺书是让患者向别人保证“我不自杀”，研究并不支持它有效，还可能让人不敢说出真实念头【研究】。安全计划是患者为自己写的行动步骤，允许写“我可能会有这个念头”。
遗书或告别信	安全计划指向活下去的动作，不回顾、不交代后事。
医生的治疗方案	安全计划不替代治疗，它管的是“念头最强的那个小时”。
一份签完就完的文件	它需要随着季节、住址、联系人变化而更新，通常建议每三个月到半年复核一次【临床经验】。

还有一条原则：**安全计划的第一作者是本人，不是家属，也不是医生**。家属可以帮忙回忆、补充、提醒，但不能替写。被替写出来的计划，危机时本人不会用。

六步：每一格该填什么

六步的顺序本身有讲究：先识别，再从轻到重地找人。轻的动作在前，是因为危机时人往往没有力气直接打电话给医生，但可能还做得到“去洗个脸”“抱起猫”。

步骤	填什么	合格的样子	不合格的样子
1 识别预警	念头、画面、身体感觉、行为冲动	“凌晨醒来，脑子里出现‘不如算了’这句话”	“心情不好”
2 内部应对	不需要别人的、五分钟内能做完的事	“冲冷水脸”“抱狗坐十分钟”“听固定的三首歌”	“想开点”“积极思考”
3 外部应对	去某个地方、做某件事，转移注意力	“去楼下便利店买瓶水”“去客厅和室友一起看电视”	“出去走走”
4 联系人	两到三个具体的人名和电话	“姐姐 138xxxx”“老同学阿哲，微信”	“家人”“朋友”
5 专业资源	医生、医院、热线、急诊地址	“某某医院精神科，周三上午”“12356”	“去医院”

步骤	填什么	合格的样子	不合格的样子
6 环境安全	哪些东西要移走、交给谁、锁在哪里	“安眠药由我妈锁在抽屉，钥匙她带”	“注意安全”

几个填写要点：

第一步要写“原话”。 危机时脑子里出现的往往是一句固定的话或一个画面，比如“我死了对大家都好”“看见楼下的空地”。写原话比写“消极念头”更容易被自己认出来。

第二步必须是“做过、有效、不需要意志力”的事。 如果一项应对方式需要“先有力气”，它就不适合放在这里。音乐、冷水、宠物、数呼吸、捏冰块、把感受写三行，这些都比“运动半小时”更现实。

第三步的关键是“换空间”。 一个人待在房间里，念头会反复；换到有人的地方，哪怕不说话，风险也会下降。所以第三步要写成具体地点：客厅、便利店、24 小时快餐店、朋友家沙发。

第四步的人数要够，但不能太多。 两到三个足够，最好包含一个“不评判、不会追问到底”的人。危机时最怕的是打过去被教育一顿，所以要在计划里写一句“如果他开始讲道理，我就换下一位”。

第五步要写清“怎么去”。 医院的地址、急诊入口在几号楼、白天和夜间分别走哪个门、打车大概多久。这些细节平时不值一提，危机时能省下最宝贵的十几分钟。

第六步单独在后面讲，因为它最容易被跳过，却往往是六步里最救命的一步。

可打印模板

下面这份可以直接抄在 A4 纸上，或者照着重画到本子里。留白要够，字写大一点。

```
_____
我的安全计划                填写日期：____
下次复核：____              填写人：_____
_____

【1】当这些出现，说明我进入危险区
 · 脑子里的那句话：_____
 · 身体的感觉：_____
 · 我会做的事：_____

【2】我可以自己做的五件事（不用找人）
 ①_____  ②_____
 ③_____  ④_____
 ⑤_____

【3】换个地方，换件事做
 · 去哪里：_____（多久能到：____）
 · 做什么：_____

【4】我可以打电话的人
 ①姓名_____ 电话_____ 他/她适合在什么时候打：_____
 ②姓名_____ 电话_____
 ③姓名_____ 电话_____
 （打过去只说一句也行：“我现在不太好，你能陪我说会儿话吗？”）

【5】专业资源
 · 我的医生：_____ 医院/科室：_____
```

```
· 门诊时间：_____ 怎么挂号：_____
· 24 小时急诊：_____ 医院，地址：_____
· 心理援助热线：12356
· 需要救护车/警察：120 / 110

【6】把危险的东西先移开
· 药物：交给_____，放在_____，钥匙由_____保管
· 利器：_____
· 其他：_____
· 酒精：_____

【7】如果我已经在路上
 我答应自己：先做完【6】，再打【4】的第一个人，
 再去【5】的急诊。三件事做完之前，不做任何决定。
_____
```

打印两份：一份贴在自己常待的房间，一份给主要家属。手机里再拍一张，设成收藏。**不要只存在一个地方**——手机可能没电，抽屉可能打不开。

怎么和家人一起填

一起填的时候，最容易变成“家属审问、患者敷衍”。可以按下面的顺序来，一次不超过四十分钟，累了就停：

1. **先各自写，再对照。** 患者写自己的六步，家属写“我猜你会需要什么”。写完交换，只讨论不一样的地方。
2. **家属只问“这一条对你有用吗”，不问“你为什么需要这个”。** 追问原因会变成质疑。
3. **联系人由患者自己选，家属不指定。** 如果患者选的人让家属不放心，可以加一位，但不要删掉患者选的那位。
4. **第六步要当场做，不要写“以后再说”。** 谈完就一起把药收进盒子、把钥匙交给指定的人。做完这一步，计划才算真的开始。
5. **约定一个“暗号”。** 比如发一个固定的表情、说一句“今天不太行”。暗号的好处是不用解释，家属收到就知道该启动哪一步。
6. **家属也要写自己那一份。** 家属需要知道：如果患者半夜打电话说“我撑不住了”，自己第一步做什么、打给谁、要不要叫 120。这些也提前写下来。

填完之后，把它放进复诊的袋子里，下次见医生时带过去。医生可以帮你判断某些步骤是否可行，也能把计划写进病历。

危机时按什么顺序做

顺序不是从第一步顺着往下走。真到那一刻，**先做保命的两件事，再做安抚的事**：

1. **先做第六步（环境安全）。** 把药、刀、酒精移开，或者离开有危险的地方。这一步不需要力气，也不依赖别人同意。
2. **再做第四步（打给人）。** 不必等到“想清楚要说什么”。一句话就够：“我现在很不好，你能来吗？”如果第一个人没接，打第二个，不要停在那里反复想“他是不是嫌我烦”。

3. **第三步和第二步用来“熬时间”。** 在等人来的十几分钟里，换到有人的地方，做一件不需要动脑的事。目标不是变好，是把这段时间熬过去。
4. **第五步兜底。** 如果身边没有人、或者念头已经变成计划，直接去急诊或打 120，不要先尝试自己扛过去。扛不过去的风险，比白跑一趟大得多。
5. **事后补记。** 危机过去后，和医生、家属一起回看：哪一步有用，哪一步根本做不到，然后改掉。安全计划是被改出来的，不是一次写对的。

手段限制：最容易被跳过的一步

“手段限制”（lethal means safety）指的是：把自杀手段变得不那么容易拿到、不那么致命。它不是“把家里变成监狱”，而是**在危险期把“一时冲动”和“不可逆后果”之间的距离拉长**。很多自杀发生在念头最强的几十分钟里，如果那几十分钟里拿不到东西，人往往就活下来了【研究】。

具体可以做的事：

- **药物**：由家属保管，按次发放；或者放进上锁的盒子，钥匙不在患者手里。家里不留大量存货，包括普通止痛药、感冒药、助眠药。
- **利器**：刀具、刀片、剪刀收进锁柜；不用的旧药、旧刀片及时丢弃。
- **高处与密闭空间**：危险期锁好阳台门、窗户限位；车钥匙由他人保管。
- **酒精**：家里不存酒。酒精会削弱控制力，也会和药物相互作用。
- **其他**：农药、碳、绳索等，按家里实际情况处理，不必写进清单，但要真的处理。

执行时有三个原则。**第一，协商而不是突袭。** 突然把患者房间翻一遍、把所有东西拿走，会破坏信任，也会让人更隐秘地准备。更好的说法是：“这阵子我帮你保管，等好一点我们再商量。”**第二，写清“谁保管、放哪、什么时候还”。** 没有归还条件的保管，会被体验成永久剥夺。**第三，定期复核。** 状态好转后逐步归还，并在复诊时和医生确认。

如果家属自己拿不准该收什么，可以在就诊时直接问医生：“家里现在有哪些东西需要先收起来？”这属于很常规的问题，医生不会觉得奇怪。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> **当天联系医生**：安全计划里的预警信号出现，且第二步、第三步都压不住；睡眠连续几天明显变差；开始出现“活着没意思”的想法但还没有计划。
>
> **立即去急诊或拨打 120**：已经有自杀计划或开始准备（攒药、查方法、写告别信、去某个地点）；已经自伤；念头强到无法执行安全计划里的任何一步；同时大量饮酒或服药。
>
> **随时可打**：12356 心理援助热线；110（现场有危险、需要立即处置时）；120（需要医疗转运时）。地方热线号码以当地卫健委公布为准。

三个常见错误

1. **填完就锁进抽屉。** 安全计划的价值在于“危机时能被找到”。贴在冰箱上、拍照存手机、给家属一份，比写得漂亮重要。
2. **只写“打 120”，不写具体的人。** 危机时人没有能力做选择，只会执行。写“打给姐姐”比写“联系家人”有效十倍。
3. **把它当成“我已经答应不死了”。** 安全计划允许你失败、允许你临时做不到。它的作用是多一点时间，不是给自己加一条“我又没做到”的罪名。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet
- 国家法律法规数据库.《中华人民共和国精神卫生法》

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.3 紧急求助渠道

> 危机发生时，最难的不是“要不要求助”，而是“打哪个电话、第一句说什么”。这一页把 120、110、12356 和医院急诊各自管什么、什么情况打哪个、接通后怎么描述、陪护者在等待救援的那段时间做什么，写成可以直接照做的步骤。适合患者本人提前读，也适合家属在慌乱时翻开来照着做。

三个号码，各管什么

先把分工记住。打错电话不会有人责怪你，但会耽误时间。

号码	主要管什么	什么时候打	局限
120	医疗急救与转运：意识不清、服药过量、自伤出血、抽搐、高热、胸痛、晕厥	需要救护车、需要马上有医疗处置、患者无法自行走动	不负责现场制服与破门；接线员需要你给出准确地址
110	正在发生的危险：持械、站在高处或桥边、反锁房间、失联、有人阻止救治	现场有即时人身危险、需要警察到场或破门、需要协助送医	不做医疗判断；到场后通常会联动 120
12356	心理援助热线：情绪支持、危机干预、转介信息	念头很强但还没有行动、需要有人陪着说话、不知道该去哪看	不能派车、不能开药；高峰期可能占线，需要重拨或换渠道

12356 是国家卫生健康委自 2025 年起推行的全国心理援助热线，各地接通时段和坐席数量不同，以当地卫健委公布为准。**它不是急救电话**，如果已经在准备行动，先打 120 或去急诊，再打热线。

除了这三个号码，还有两类地方资源值得提前存在手机里：

- **精神专科医院的急诊**。不是每家精神专科医院都有 24 小时急诊，提前查清楚哪家开、怎么走、夜间从哪个门进。
- **区县级精神卫生中心（疾控精神卫生科）**。它们通常承担社区随访，能提供转介和危机处置信息，电话以当地卫健委公布为准。

什么时候打哪个：三种场景

场景	先做什么	再做什么
已经有行动：吞药、割伤、站在高处	直接打 120；同时让身边的人做手段限制	不要试图自己开车送，路上可能恶化；把药盒、空药板带上
有明确计划但还没行动：攒了药、写了信、反复说“今晚就结束”	不让其独处；先移走药物和利器；打 120 或直接去急诊	同时打 12356 让专业人员介入通话；通知开药医生
念头很强、极度痛苦、但无计划	打 12356；联系家属或朋友来陪伴	当天加号看精神科；不要独自过夜

判断不了的时候，按最重的那一档处理。多叫一次救护车不会有人追究你“浪费资源”，但少叫一次可能是不可逆的。

电话接通后怎么说

接线员需要的是**事实**，不是情绪描述。慌的时候容易说成“我朋友不行了，你们快来”，对方无法判断轻重，也无法定位。可以按下面五句话的顺序讲，甚至照着念：

1. **谁**：“我是他姐姐，患者是我弟弟，男性，29 岁，有抑郁症，正在吃药。”
2. **在哪**：“我们在某某区某某路某小区 3 号楼 2 单元 501，门牌清楚，楼下有便利店。”
3. **发生了什么**：“半小时前他把自己反锁在房间里，说吃了不少安眠药，现在门打不开，说话开始含糊。”
4. **现在是否安全**：“房间里有刀，门是木门，我们已经打了 110。他还在说话，但越来越慢。”
5. **联系方式与配合**：“我的手机是 138xxxxxxxx，我在门口等，楼下有人接你们。”

如果不知道吃了什么药，把药盒、药板、空瓶全部收好带去医院——**药盒比描述有用**。如果喝了酒，一定要说，酒精会改变很多药物的作用和预后。

有几句话尽量不要说，它们会让接线员误判：

- “他心情不好”“他有点想不开”——太模糊，容易被当成非紧急。
- “你们快点”但不给地址。
- “别告诉他是我们叫的”——先救命，再谈感受。
- “他以前也这样，没事的”——每一次都可能是例外。

去急诊：从出门到见到医生

出门前五分钟：带上医保卡、身份证、正在服用的所有药（或药盒照片）、既往病历和检查单、一部电量足够的手机、少量现金。留一个人在家收拾危险物品，或者把患者带离有危险物品的环境。**不要**让患者单独去洗手间或回房间“拿东西”。

路上：如果患者还能走，坐后排，靠车门一侧，由一名家属同侧陪同。如果已经意识不清、抽搐、呕吐，不要强行喂水、催吐，侧卧位，等救护车。

到急诊后：先分诊，直接说“有自杀行为/计划”这几个字。分诊护士会据此分级，隐瞒这一句可能意味着等更久。就诊时如实说三件事：吃了什么、吃了多少、什么时候吃的；最近在吃什么药；最近喝没喝酒。不要因为怕“被贴标签”而少说。

可能需要等。综合医院急诊夜里很忙，精神科会诊可能要等几小时。等待期间不要离开，不要留患者一个人在走廊椅子上。可以问护士：“大概还要多久？我们现在能做哪项检查？”把能提前做的检查先做掉，往往能省时间。

陪护者：该做什么、不该做什么

陪护者的状态会直接影响患者的状态。慌是正常的，但可以按下面的清单行事。

该做的：

- ☐ 保持语速慢、声音低、句子短。一次只说一件事。
- ☐ 坐在患者的侧前方，不要堵住门口，也不要站在其正前方俯视。
- ☐ 直接问：“你现在有伤害自己的打算吗？”问出来不会让人去死，反而常常让人松一口气【指南】。
- ☐ 把药物、利器、酒精移走，动作平静，说明“先放我这儿，等好一点再给你”。
- ☐ 记录时间：最后一次见到人、最后一次服药、最后一次喝酒、说了什么。
- ☐ 对医生说实话，包括患者不想让说的部分（正在准备、藏了药、写过东西）。生命安全优先于“替他保密”。
- ☐ 给自己找一个替补。危机可能持续几天，一个人扛不住。

不该做的：

常见做法	为什么可能有害
“你想开点，比你惨的人多了”	等于告诉对方“你的痛苦不算数”，会让人闭嘴
反复追问“你为什么这样”	当事人往往说不出原因，追问会变成审讯
“我保证不告诉任何人”	一旦需要叫救护车，这个承诺必然被打破，信任反而崩得更彻底
抢手机、夺刀、强行拖拽	容易激化，造成二次伤害；需要处置时打 110，让专业的人来
让患者“一个人静一静”	危机期独处是最危险的状态，哪怕只有十分钟
在患者面前哭诉、崩溃	不是不许你难过，而是先找一个不在场的人承接你的情绪

等待救援的那段时间怎么保证安全

从打完电话到人真正被接走，可能是十分钟，也可能是两小时。这段时间最需要具体动作：

1. **把人留在视线内。** 同处一室，不锁门，不背对。上厕所也请另一位家人陪同或在门外说话。
2. **改变位置。** 从窗边、阳台、厨房、车库移开，去客厅或门口这类“不好实施”的地方。住高层的，先把窗户关好、阳台门锁上。
3. **继续说话，但聊小事。** “你上次说的那个游戏更新了吗”“猫今天又打翻水了”。不要谈人生意义，也不要分析病情。目的是让对方的注意力留在对话里。
4. **不要争辩“你该不该这样想”。** 可以说“我不知道你有多难受，但我在这儿”，这句话比任何道理都稳。
5. **准备好交接。** 身份证、医保卡、药盒放在一个袋子里；门禁卡、电梯卡提前拿好；把宠物关进房间，方便救护人员进出。
6. **如果情况突然变化**——突然安静、突然起身、走向某个房间——立刻跟上去，同时再打一次 120 或 110，说明“情况恶化”。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**

> **不要等，立即拨打 120 或去最近医院急诊**：已经吞药、割伤、坠落；有明确的自杀计划并开始准备；意识模糊、抽搐、高热、呼吸异常；拒绝喝水进食超过一天；出现冲动伤人的行为。
>
> **当天联系精神科医生**：自杀念头反复出现但能自我控制；安全计划失效；睡眠连续多日几乎为零；刚换药或加药后情绪急剧恶化。
>
> **随时可打**：12356 心理援助热线；110（现场有即时危险）；120（需要医疗转运）。地方热线号码以当地卫健委公布为准，不要拨打来源不明的“危机干预”号码。

五个容易踩的坑

1. **怕留下记录，不敢打 120。** 急救记录不会进入你的档案、不会通知单位。犹豫的每一分钟都在放大风险。
2. **热线占线就放弃。** 占线很常见，隔几分钟重拨，或者换一个渠道；同时让身边的人继续陪着，不要因为“没打通”就认为没办法。
3. **只打热线，不打 120。** 热线能陪你说话，但不能派车。已经有行动时，热线不是第一选择。
4. **送到医院又带回家。** 急诊评估后如果医生建议留观或住院，尽量配合。觉得被冒犯可以事后投诉，但不要在当下赌气离院。
5. **危机过去就当没发生。** 事后 48 小时内是再次尝试的高风险期，需要有人陪、需要复诊、需要把这次的经过告诉医生并修改安全计划。

还有一件事值得提前做：把 120、110、12356、开药医生、两位紧急联系人，存进手机“紧急联系人”并写一张卡片放钱包。危机时找不到号码，比没有号码更常见。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 国家法律法规数据库.《中华人民共和国精神卫生法》

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

9.4 住院治疗与家属应对

> 提到“住院”，很多人的第一反应是害怕：是不是被关起来、会不会被绑、出来会不会被贴标签。这一页讲清楚四件事：什么情况医生会建议住院，自愿住院和非自愿住院在法律上分别是什么条件，病房里一天到底怎么过，家属在探视、送东西、出院安排上能做什么。适用于正在被建议住院、或者家里有人已经住院的人。读完你应该能判断“这次该不该住”，以及住进去之后怎么把这段经历变成康复的一部分。

什么情况需要住院

住院不是为了“惩罚”或者“让你反省”，它解决的是门诊解决不了的问题：**安全、观察、强度**。门诊一次二十分钟，看不出整夜的睡眠和全天的波动；家里只有一两个家属，挡不住持续的自伤冲动；药物需要几天内密切调整时，也需要有人在旁边看着。

情形	为什么通常需要住院	一般处理方向
有自杀计划或近期有自杀行为，家中无法保证安全	需要 24 小时看护与手段限制；门诊无法覆盖夜间	封闭或半封闭病房，严密观察，调整治疗
自伤频繁、拒食、拒水、木僵、生活不能自理	存在躯体并发症风险，需要医疗监护	补液、营养支持、药物调整，必要时物理治疗
精神病性症状：幻觉、妄想、严重激越、伤人风险	需要快速控制症状并排除器质性原因	抗精神病药治疗，环境管理
药物调整期需要密切观察（如难治性抑郁换方案、MECT 疗程）	副作用与疗效都需要每日评估	住院完成调整，稳定后转门诊
共病严重躯体疾病、孕产期、老年多重用药	需要多科协作	综合医院精神科或会诊联络病房
门诊治疗无效且功能严重受损	需要结构化环境与强化治疗	评估后转介专科中心

反过来说，下面这些情况**不一定**需要住院：只是情绪低落但无自伤风险、门诊能规律复诊、家里有人能陪、睡眠虽差但还能维持基本生活。住院本身也有代价——中断工作学业、离开熟悉环境、费用、以及“被贴上标签”的感受。是否住院，是医生评估与患者、家属共同讨论的结果，不是单方面“通知”。

如果医生建议住院而你犹豫，可以直接问三个问题：**不住院的话，回家需要满足什么条件？出现什么情况必须马上回来？有没有日间病房或强化门诊这类替代方案？** 这三个问题问出来，讨论才有实质内容。

自愿住院与非自愿住院：法律怎么规定

《中华人民共和国精神卫生法》确立了一个基本前提：**精神障碍的住院治疗实行自愿原则**。也就是说，能门诊就门诊，住院原则上要本人同意。下面这段只讲原则，不构成法律意见；具体条文以官方公布文本为准，各地执行细节以当地卫健部门和医疗机构的规定为准。

非自愿住院不是“医生说了算”，法律设了两类情形，且都要求先满足“严重精神障碍患者”这一诊断与评估前提：

情形	法律表述（大意）	谁来决定
伤害自身	已经发生伤害自身的行为，或者有伤害自身的危险	需经监护人同意，医疗机构方可实施住院治疗；监护人不同意的，不得强制住院，但应做好在家看护
危害他人安全	已经发生危害他人安全的行为，或者有危害他人安全的危险	应当实施住院治疗；监护人阻碍或患者擅自离院时，可由公安机关协助采取措施

还有几条常被忽略的程序性权利：

- **再次诊断与鉴定。** 患者或监护人对“需要住院”的诊断结论有异议、不同意住院的，可以要求再次诊断；对再次诊断结论仍有异议的，可以依法委托鉴定。这是法律给的救济渠道，不是“闹事”。
- **告知义务。** 医疗机构应当把患者在治疗中享有的权利告知患者或监护人。
- **约束与隔离的条件。** 只有在患者发生或即将发生伤害自身、危害他人、严重扰乱医疗秩序的行为，且没有其他可替代措施时，才可以实施保护性医疗措施，并应记录在病历中；禁止用约束、隔离惩罚患者。
- **通讯与探视。** 患者有通讯和会见探访者的权利，除急性发病期或为避免妨碍治疗可暂时限制外，不得随意剥夺。

需要说明的是：**“非自愿”不等于“没有权利”**。非自愿住院期间，患者仍然有知情同意（除法定例外）、隐私、申诉、通讯探视等权利。如果你觉得程序有问题，可以要求复印病历、向医院医务科或当地卫健部门反映，也可以咨询法律援助。这类事情超出科普范围，建议找专业人士。

病房里会发生什么

第一次住院的人，最难受的往往不是治疗，而是“不知道接下来会发生什么”。下面按时间线说。

入院当天：办手续、测生命体征、问病史（会问得很细，包括喝酒、用药、月经、既往自伤）。随身物品要清点，危险物品（刀具、打火机、绳子、玻璃制品、大量现金、部分电子产品）由护士站暂存，出院时归还。会换病号服，做安全检查，包括口袋和行李。这个过程会让人觉得被冒犯，但它是病房的常规流程，不是针对某个人。

头三天：以观察为主。医生会安排抽血、心电图等检查，排除躯体原因；护士会记录睡眠、进食、排便、情绪和风险等级。这几天药效通常还没起来，人可能更烦躁，这是常见的。

日常节奏：起床、吃药、查房、活动、吃饭、熄灯。多数病房有工娱治疗（手工、绘画、阅读、体能活动）、团体心理活动、个别谈话。查房是家属了解情况最重要的窗口，尽量参加。

关于约束：如果出现冲动、自伤、攻击行为，医护人员可能实施短暂的保护性约束或隔离。合规的做法是有医嘱、有时间记录、有巡视、解除后记录。家属看到这一幕会很受冲击，可以事后向主管医生询问原因和记录情况，但当场争执通常无助于患者。

出院：由医生评估后办理。如果本人没有能力办理，监护人应当为其办理。出院不是“治好了”，而是“风险降到可以在门诊管理”。

探视、物品与通讯

探视对恢复有帮助，但探视也可能带来刺激。去之前先想清楚：这次见面是让对方安心，还是让自己安心。

类别	具体物品	说明
可以带	换洗衣物（无绳带、无金属件）、软底拖鞋、洗漱用品（非玻璃瓶）、纸笔、书籍	先问护士站，各病房规定不同
通常不可以带	刀具、剪刀、打火机、火柴、绳子、腰带、玻璃容器、酒精、大量现金、自备药品	自备药一律交护士站，不能自己吃
需要商量	手机、充电器、电脑、零食、化妆品、指甲刀	多数病房限时使用手机；指甲刀常需代管
不建议带	大量补品、成箱饮料、贵重物品	占地方、易丢失、可能引发纠纷

探视时的几条经验：

- **不要问“他们有没有欺负你”。** 这句话会把患者推向警惕和对抗，也会让家属自己越问越焦虑。
- **不要承诺“我马上带你出去”。** 做不到的承诺会变成第二次伤害。
- **带一件具体的东西。** 家里的毯子、一只玩偶、几张照片，比十句“你要坚强”有用。
- **控制人数和时间。** 一次两三个人、半小时左右，比一屋子人围着更舒服。
- **和护士聊两句。** 问睡眠、吃饭、吃药后有没有不舒服，比问“今天怎么样”得到的信息多。

通讯方面，多数病房允许在固定时段使用手机，但可能限制拍摄。如果患者想联系外界而受限，可以问清是治疗性限制还是常规管理，并要求说明依据。

出院计划：从入院第一周就开始

出院后前两周是复发和再次自伤的高风险期，很多问题出在“出院那天才开始想”。建议在入院第一周就和医生谈出院计划，把下面这份清单逐项落实：

- ☐ **出院日期与条件**：什么情况下可以出院，谁来判断。
- ☐ **出院诊断与药物方案**：药名、剂量、吃法、可能副作用，写在纸上带回家。
- ☐ **复诊时间**：出院后多久复诊，挂谁的号，怎么加号。
- ☐ **病假与手续**：出院小结、病假证明、报销材料一次开齐（见 11.3 费用医保病假与权益）。

- ☐ **危险期安排**：出院后第一周谁陪着、能不能请假、夜里谁值守。
- ☐ **药物保管**：由谁保管、按次发放还是自取、什么时候评估归还。
- ☐ **危机预案**：复发预警信号是什么、打给谁、去哪家急诊（把9.2 安全计划模板更新一遍）。
- ☐ **生活安排**：睡眠、吃饭、活动、暂时不接的工作或课程。
- ☐ **家属分工**：谁陪同复诊、谁负责药、谁负责和单位学校沟通。

出院后一个月内，尽量做到“三不”：不自行减药、不立刻恢复满负荷、不取消复诊。这三件事是再入院最常见的诱因【临床经验】。

患者权益与隐私

住院期间的权利，可以记成下面这张表。遇到问题时，先找主管医生，再找医务科，仍无法解决再向当地卫健部门反映。

权利	具体含义	遇到问题找谁
人格尊严	不被侮辱、打骂、嘲笑；不被当作“案例”在无关人员面前讨论	主管医生、护士长、医务科
知情同意	知道诊断、治疗方案、主要风险和替代方案；特殊治疗需书面同意	主管医生
隐私	病历、病情属于敏感信息，未经同意不得向单位、学校、亲友泄露	医务科、病案室
查阅病历	有权查阅、复制病历资料（具体范围按现行规定）	病案室
通讯与探视	除法定情形外不得限制	护士长、医务科
申诉与救济	对诊断、住院有异议可要求再次诊断、鉴定；可投诉	医务科、当地卫健部门、法律援助
不受歧视	入学、就业、医疗等合法权益受法律保护	单位工会、人社部门、法律援助

关于隐私，有两点实务提醒。**第一，住院信息可能被单位知道**，如果涉及医保报销、病假，人事部门通常会看到就诊类别。想尽量避免扩散，可以在请假时只提供必要的证明，并书面说明保密要求。**第二，家属之间也会泄露。** 住院这件事，建议由患者指定“可以告诉谁”，其他人统一口径为“身体不舒服住院调理”。这不是撒谎，是划定边界。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> **住院期间，立刻找护士或值班医生**：患者突然异常安静或开始交代后事；出现高热、意识模糊、肌肉僵硬、抽搐；拒食拒水超过一天；与其他患者发生冲突或被打；被约束后出现肢体麻木、疼痛。
>
> **出院后，立即去急诊或拨打 120**：自杀念头重新出现且有计划；自伤；几乎不睡且兴奋话多；停药后出现严重不适。
>
> **出院后当天联系医生**：药物吃完了没续上、副作用明显、情绪在几天内快速下滑、复诊挂不上号。随时可拨 12356 心理援助热线；地方热线以当地卫健委公布为准。

四个容易踩的坑

1. **把住院当成“关起来”。** 现代精神科病房多数是开放式或半开放式管理，重点是治疗和观察，不是限制自由。真正被限制的部分，法律有明确条件。
2. **入院时隐瞒用药和饮酒。** 隐瞒会直接影响医生判断，尤其是药物相互作用和撤药风险。说清楚，医生不会因此“给你加罪”。
3. **出院就停药、就复工。** 出院时症状减轻，不等于病程结束。维持治疗的时间通常以月计，减药要在医生指导下慢慢来。
4. **家属替患者做所有决定。** 哪怕是非自愿住院，也应尽量让患者参与能参与的部分（吃什么、什么时候探视、出院后住哪）。被当成“物件”对待，是住院体验里最难修复的部分。

参考来源

- 国家法律法规数据库.《中华人民共和国精神卫生法》
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议，也不构成法律意见；具体方案以面诊医生为准，法律问题以现行法律和当地政策为准。

模块 10：共病治疗

抑郁症很少“单独出现”。焦虑、失眠、疼痛、ADHD、PTSD、物质使用都会改变治疗选择。这一模块讲整合治疗，不要求你自行判断。

10.1 抑郁合并焦虑

抑郁和焦虑同时出现，是最常见的组合之一。很多人描述不出来，只会说“心里堵得慌，坐也不是站也不是”。这一页帮你分清“抑郁里的焦虑症状”和“真的合并了焦虑障碍”，讲清楚药物与心理治疗怎么分工、苯二氮䓬类为什么只能短期用、以及为什么不能自己加量。读者是患者和家属，具体用药仍以面诊为准。

一、焦虑是抑郁的一部分，还是另一个病

两者经常同时出现。研究显示，抑郁患者中合并某种焦虑障碍的比例相当高，超过一半并不罕见。【研究】但“同时存在”有两种情况，处理方式不同。

情况一：焦虑是抑郁发作的一部分。 抑郁本身就会带来担心、坐立不安、心慌、胸闷、注意力涣散。抑郁好转，焦虑跟着减轻。这种情况下不需要单独治焦虑。

情况二：合并独立的焦虑障碍。 常见的有广泛性焦虑（长期过度担心，难以控制）、惊恐障碍（突然发作的心慌、气短、濒死感）、社交焦虑（怕被评价、回避场合）、广场恐惧（怕人多、怕出不去）。这类焦虑往往**起病更早**、**在抑郁缓解后仍然存在**、有自己的诱发情境和回避行为。

几个实用的区分点：

- **时间线**：焦虑是不是先于抑郁很多年就存在？
- **情境性**：是不是只在特定场合出现（开会、坐地铁、当众说话）？
- **躯体症状的峰值**：惊恐发作是突然冲到顶峰、十几分钟内最难受；广泛性焦虑是长期紧绷。
- **回避行为**：有没有因为害怕而明显改变生活（不敢出门、不敢坐电梯、拒绝社交）？
- **缓解后残留**：抑郁好了以后，焦虑还在不在？

特征	更像抑郁伴焦虑症状	更像合并焦虑障碍
起病顺序	与抑郁同时或之后	常早于抑郁数年
担心内容	泛泛的、与自责相关	具体、反复、指向特定对象
躯体表现	乏力、食欲差为主	心慌、出汗、发抖、气短突出
回避行为	因没力气而减少活动	因害怕而主动回避
抑郁缓解后	焦虑随之减轻	焦虑仍持续
治疗反应	抗抑郁治疗即可覆盖	常需针对焦虑的评估与心理治疗

需要提醒：**GAD-7 之类的量表只能筛查，不能诊断。** 它告诉你“值得进一步评估”，不告诉你“你得了焦虑症”。而且焦虑和抑郁的条目高度重叠，单看分数容易混淆。

二、治疗：一类药覆盖两个问题，心理治疗不能省

药物方面，SSRI 和 SNRI 是抑郁合并焦虑的一线选择，因为它们对两个问题都有效。【指南】这一点很重要：不需要“治抑郁吃一种、治焦虑再吃一种”，多数情况下一种药足够，前提是剂量和疗程到位。

几个需要预期的事：

- **起效慢**：通常要两到四周才开始有感觉，焦虑的改善有时比情绪更晚。
- **早期可能“更焦虑”**：部分人在开始服药或加量后的头一两周，会出现坐立不安、心慌、失眠加重。这叫“激活”或“早期焦虑加重”，很常见，通常短暂。所以医生往往从低剂量开始，缓慢上调。**这也是不能自己加量的原因之一。**
- **足量足疗程**：剂量不够、时间不够，是最常见的“无效”原因。是否加量、加到多少，由医生根据反应和耐受性判断。
- **不要突然停**：突然停用 SSRI/SNRI 会出现头晕、恶心、电击感、焦虑反跳，也会抬高复发风险。

心理治疗方面，CBT 对焦虑障碍有扎实的证据，核心是两件事：一是识别并修正“灾难化”的想法（“心跳快就是要死了”）；二是**暴露**——在安全的前提下，逐步面对被回避的情境，让身体学会“原来不会出事”。【指南】对惊恐障碍，还要加上对躯体感觉的脱敏（比如刻意加快呼吸，体验并学会耐受）。回避是焦虑的燃料，暴露是撤掉燃料。

对广泛性焦虑，CBT、应用放松训练、以正念为基础的方法都有帮助；对社交焦虑，认知重建加暴露是标准组合。心理治疗不是“谈谈就好”，它需要每次的作业和练习。

药物和心理治疗联合，通常优于单用一种，尤其是中重度、病程长、回避明显的情况。【指南】

三、苯二氮䓬类：能救急，但不能当家

苯二氮䓬类（常说的“安定”“阿普唑仑”“劳拉西泮”这一类）起效快、效果直观，很多人一吃就觉得“终于能喘气了”。正因为太有效，它最容易被长期使用。

它适合的位置：急性期严重失眠、激越、惊恐发作频繁，或在抗抑郁药起效前的两到四周做“过渡”。【指南】这是一种“桥”的作用：等主药起效，就逐步撤掉。

为什么不能长期用：

1. **耐受**：同样的量越来越不管用，于是加量，然后更需要加量。
2. **依赖与戒断**：突然停用可能出现焦虑反跳、失眠、心慌、出汗、手抖，严重时抽搐、意识混乱。**苯二氮䓬类的戒断可以危及生命，不能自行骤停。**

3. **认知与跌倒**：注意力、记忆、反应速度下降；老年人跌倒和髋部骨折风险明显升高。
4. **呼吸抑制**：与酒精、阿片类止痛药、其他镇静药合用时，可能抑制呼吸，这是真实的致死风险。
5. **掩盖病情**：长期用镇静药可能让人误以为“好了”，却延误了针对焦虑本身的治疗。

使用场景	合理做法	需要避免
抗抑郁药起效前的过渡	短期、按需、设定撤药时间表	一吃就是半年，没人提停药
急性惊恐发作	配合呼吸调整与认知技术	每次难受就加一片，剂量越来越高
严重失眠	优先 CBT-I，药物短期	长期每晚依赖，白天昏沉
老年、合并呼吸疾病	尽量不用或极短期	与阿片类、酒精同用
停药	医生指导下缓慢减量	自行骤停，尤其是长期大剂量

【指南】多数指南建议苯二氮䓬类用于焦虑时不宜超过数周，且应与患者明确讨论依赖风险与退出计划。

绝对不要自行加量。 耐受一旦形成，“多加一片”带来的往往不是更好的效果，而是更高的跌倒、认知损害和戒断风险。觉得原来的量不管用了，正确做法是联系医生，而不是自己调。

四、容易踩的坑

- **“焦虑就是性格急，忍忍就过去了”**：广泛性焦虑和惊恐障碍是能治疗的疾病，长期不治会拖出抑郁、物质使用和心血管负担。
- **“抗抑郁药也治焦虑？是不是开错了”**：SSRI/SNRI 同时有抗焦虑作用，这是标准做法，不是误开。
- **“吃了两天更难受，说明这药不适合我”**：早期激活很常见，通常一两周减轻。先联系医生，不要自己停。
- **“安定最管用，其他都太慢”**：快不等于好。长期用苯二氮䓬类，焦虑反而更难断根。
- **“感觉好了就停”**：焦虑的复发很常见，停药需要计划和随访。
- **“喝酒能压惊”**：酒精短期让人放松，之后反跳性焦虑更重，还会干扰睡眠、加重抑郁。
- **“多做检查就能放心”**：反复查心脏、查甲状腺，能排除器质病，但排不掉焦虑本身；该做的是暴露和认知工作。

日常可以照着做的清单：

- ☐ 记录焦虑发作的时间、情境、身体感觉、当时在想什么。
- ☐ 每天固定时间做 10 分钟慢呼吸或身体扫描，不是为了“压住”，而是练习观察。
- ☐ 列一张“回避清单”，从最容易的一项开始，每周迈一小步。
- ☐ 咖啡、浓茶、能量饮料减量，尤其在下午之后。
- ☐ 规律起床和运动，睡眠紊乱会放大焦虑。
- ☐ 把“我可能要死了”改写成“这是惊恐发作，峰值一般十几分钟，会过去”。
- ☐ 复诊时带上记录，不要只说“还行”或“不好”。

五、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 胸痛、胸闷持续不缓解，伴大汗、放射到手臂或下颌（要先排除心脏问题）；
- 严重呼吸困难、嘴唇发紫、晕厥；
- 明确的自杀计划或已采取行动；
- 突然停用苯二氮䓬类后出现抽搐、意识混乱、高热；
- 大量饮酒后与镇静药同用，出现叫不醒、呼吸很慢。

当天联系开药医生：

- 加药后焦虑明显加重、坐立不安到无法静坐；
- 惊恐发作频率明显增加，或完全无法出门；
- 需要不断加量才能维持效果；
- 出现新的自伤念头。

一两周内复诊：

- 规律服药四到六周仍无明显改善；
- 想减少或停用苯二氮䓬类；
- 焦虑开始影响工作、学业或家庭角色。

区分“心脏问题”和“惊恐发作”有时很难。第一次出现剧烈胸痛、气短，按急症处理，先排查躯体原因。

参考来源

- NICE. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management (CG113). https://www.nice.org.uk/guidance/cg113
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

本页为科普，不构成个体化医疗建议；药物选择、剂量与减停方案须由精神科医生面诊决定，具体方案以面诊医生为准。

10.2 抑郁合并失眠

几乎每个抑郁的人都有睡不好的时候，但“抑郁时睡不好”和“抑郁合并慢性失眠”不是一回事。前者随情绪好转而改善，后者会独立存在，还会把抑郁重新拉回来。这一页讲清楚怎么分辨、为什么 CBT-I 是首选、安眠药该怎么取舍、以及为什么打鼾的人要先查睡眠呼吸暂停。

一、失眠是症状，还是独立的病

先分清三种情况。

第一种：抑郁发作中的失眠症状。 入睡困难、早醒、夜间频繁醒，是抑郁的常见表现。抑郁缓解后，睡眠通常也会跟着改善。

第二种：抑郁缓解后残留的失眠。 情绪已经好转，睡眠却一直没恢复。这种情况很值得重视——残留失眠是抑郁复发最强的预测因素之一。【研究】它意味着治疗不能停在“心情好了”。

第三种：独立的慢性失眠障碍。 判断标准大致是：每周至少三晚入睡困难、维持睡眠困难或早醒，持续三个月以上，并且白天有明显损害（疲劳、注意力差、情绪不稳、工作学习受影响）。它可能先于抑郁出现，也可能与抑郁并行。

特征	更像抑郁的失眠症状	更像独立的失眠障碍
与情绪的关系	情绪差时加重，情绪好时减轻	情绪好转后仍持续
起病顺序	与抑郁同时或之后	常早于抑郁数月甚至数年
典型模式	早醒、夜间醒后难再入睡	入睡困难为主，或对睡眠过度关注
白天表现	乏力、兴趣丧失	疲惫、易怒、注意力差，但兴趣尚可
对失眠的态度	想睡但没力气	强烈担心“今晚又睡不着”
治疗重点	随抑郁治疗	需要专门的 CBT-I

还要排除几个“假失眠”：睡眠时间足够但质量差（睡眠呼吸暂停）、作息推迟导致的入睡困难（睡眠时相延迟）、不宁腿综合征、夜间疼痛、夜尿、药物或咖啡因的影响。这些不解决，怎么调安眠药都效果有限。

二、CBT-I 为什么是一线

CBT-I（失眠的认知行为治疗） 是目前证据最强的慢性失眠治疗方法，多数指南把它列为一线，优先级高于安眠药。【指南】它的效果不如安眠药“当晚见效”，但停止治疗后效果仍能维持，这是药物做不到的。

CBT-I 通常包含五到八个模块：

1. **睡眠限制**：先压缩卧床时间，让“躺着的时间”接近“实际睡着的时间”，提高睡眠效率，之后再逐步延长。听起来反直觉，但对入睡困难很有效。

2. **刺激控制**：床只用于睡觉和性生活；困了才上床；躺二十分钟睡不着就起来，做点无聊的事，有困意再回去；固定起床时间，不管前晚睡多久。
3. **认知干预**：处理“今晚肯定又睡不着”“睡不够明天就完了”这类想法，减少对睡眠的过度监控和焦虑。
4. **放松训练**：渐进式肌肉放松、腹式呼吸、身体扫描，用来降低睡前的生理唤醒。
5. **睡眠卫生教育**：见下一节的清单，但要知道，单靠睡眠卫生治不好慢性失眠。
6. **复发预防**：识别压力事件后的早期信号，提前调整。

需要特别注意的一点：睡眠限制会短暂增加白天的困倦，对**双相障碍**患者还有诱发转躁的风险，睡眠剥夺本身就是躁狂的诱因之一。因此双相患者做 CBT-I 必须由了解病情的医生或治疗师评估后再进行，不能照搬网上的模板。【指南】

三、睡眠卫生：能做的事，和它做不到的事

睡眠卫生是基础，不是治疗。它能让好的睡眠更稳，但很难单独治好已经形成的慢性失眠。

可以照着做的清单：

- ☐ 固定起床时间，包括周末，误差不超过一小时。
- ☐ 只有困了才上床，不在床上刷手机、办公、吃饭。
- ☐ 躺下约二十分钟仍清醒，就起身到光线昏暗的地方，做不刺激的事，有困意再回床。
- ☐ 下午之后不喝咖啡、浓茶、奶茶和能量饮料。
- ☐ 睡前两小时不大量进食、不剧烈运动、不处理工作消息。
- ☐ 卧室保持安静、黑暗、凉爽；遮光窗帘和耳塞比“换床垫”更实用。
- ☐ 白天有光照和活动，午睡不超过半小时，且不晚于下午三点。
- ☐ 酒精不助眠：它让人更快入睡，但后半夜的睡眠更碎。
- ☐ 不反复看表算“还能睡几个小时”。
- ☐ 把担心的事写在纸上，告诉自己“明天再处理”。

一个常见的误区是“努力睡觉”。睡眠是没法靠意志完成的，越用力越清醒。CBT-I 的核心之一，恰恰是**放弃对睡眠的控制**。

四、药物：镇静类抗抑郁药与助眠药怎么取舍

当失眠严重到影响日间功能，或 CBT-I 暂时不可及时，药物是合理的补充。但要用得明白。

镇静类抗抑郁药：有些抗抑郁药本身有镇静作用（如米氮平、曲唑酮，以及低剂量的多塞平），常被用来兼顾抑郁和失眠。优点是“一箭双雕”，不额外增加一种药；代价是可能体重增加、口干、次日困倦、体位性低血压（起身头晕，老年人尤其要小心）。【指南】

专门的助眠药：

- **Z 药**（唑吡坦、佐匹克隆等）：起效快，适合短期使用。风险包括次日残留的困倦、复杂睡眠行为（睡梦中吃东西、走动甚至开车，醒后不记得）、依赖与耐受。部分国家的说明书对这类行为有特别警示。【指南】
- **苯二氮䓬类**：不建议长期用于失眠。耐受、依赖、跌倒、认知影响和戒断风险都明确，老年人尤其如此。
- **褪黑素与褪黑素受体激动剂**：对倒时差、作息紊乱有帮助，对慢性失眠的证据有限，效果通常温和。【研究】
- **食欲素受体拮抗剂**：较新的一类，通过抑制“清醒信号”起效，部分人会出现次日嗜睡，价格通常较高，需医生评估。【研究】
- **抗组胺药、褪黑素保健品**：证据弱，且可能与其它药物相互作用，不建议自行长期服用。

选择	适合谁	主要代价
CBT-I	慢性失眠，多数人首选	需要几周投入，初期更困
镇静类抗抑郁药	抑郁与失眠同时存在	体重、口干、次日困倦、低血压
Z 药	短期、应激性失眠	耐受、依赖、复杂睡眠行为
苯二氮䓬类	极短期过渡	依赖、跌倒、认知、戒断
褪黑素类	作息紊乱、倒时差	效果温和，证据有限

三条原则：**不自行加量**（安眠药的耐受来得很快）；**不长期每晚用**（尤其是苯二氮䓬类）；**不突然停**（长期使用后骤停可能出现反跳性失眠和焦虑）。所有调整都应在医生指导下进行。

五、别忽略睡眠呼吸暂停

如果一个人睡得时间不短，白天却困得不行；或者打鼾很响、家人发现他睡觉时呼吸会停几秒再“猛吸一口气”；或者血压怎么都控制不好、早上起来头痛口干——要想到**阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）**。

OSA 在抑郁人群中并不少见，而且会带来两个问题：一是它的症状（疲乏、注意力差、情绪低落）本身就像抑郁；二是未治疗的 OSA 会明显削弱抗抑郁治疗的效果，还会增加心血管风险。【研究】

常用的初筛工具是 **STOP-BANG**，包括打鼾、白天疲倦、被观察到呼吸暂停、高血压、体重指数、年龄、颈围、性别八项。分数高不等于确诊，需要做睡眠监测。确诊后，减重、体位治疗、口腔矫治器或持续正压通气（CPAP）都可能用上，具体由睡眠专科决定。

如果抑郁怎么治都不见好，又长期打鼾、白天嗜睡，值得主动向医生提一句“要不要查一下睡眠呼吸暂停”。

容易踩的坑

- **“失眠只是抑郁的附带品，情绪好了自然就睡了”**：残留失眠会显著增加复发风险，需要单独处理。

- **“安眠药吃了就停不下来，所以一片都不能吃”**：短期、按需、有退出计划的使用是合理的，关键是别失控。
- **“喝酒助眠”**：入睡快了，但深睡眠减少、夜醒增多，还会与安眠药叠加抑制呼吸。
- **“白天补觉能补回来”**：长时间午睡会进一步削弱夜间的睡眠驱动力。
- **“CBT-I 就是讲睡眠卫生”**：睡眠限制和刺激控制才是核心，睡眠卫生只是配角。
- **“自己买褪黑素长期吃”**：剂量、时机、纯度都不确定，长期效果证据有限。
- **“睡得少就是抑郁加重，要加抗抑郁药”**：也可能是药物本身（某些 SSRI 早期）或咖啡因导致的，需要区分。

六、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 连续多日几乎不睡，同时话多、兴奋、行为失控（可能是转躁）；
- 服用安眠药后出现叫不醒、呼吸很慢、嘴唇发紫；
- 安眠药与酒精、止痛药同用后意识不清；
- 明确的自杀计划或已采取行动；
- 睡眠中出现长时间呼吸暂停、口唇发紫、抽搐。

当天联系开药医生：

- 服药后出现睡梦中走动、进食、开车等行为，醒后不记得；
- 白天困倦到无法工作或开车；
- 需要不断加量才能入睡；
- 停药后出现严重反跳性失眠、心慌、手抖。

一两周内复诊：

- 失眠持续三个月以上，影响白天功能；
- 打鼾、憋醒、晨起头痛，怀疑睡眠呼吸暂停；
- 想减少安眠药，需要制定计划。

开车、操作机器前，先确认药物是否让你白天困倦。这属于安全问题，不是小事。

参考来源

- American Academy of Sleep Medicine. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: clinical practice guideline, 2021. https://aasm.org/clinical-resources/practice-standards/practice-guidelines/
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.

- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；助眠药物与抗抑郁药的调整须由精神科或睡眠专科医生面诊决定，具体方案以面诊医生为准。

10.3 抑郁合并慢性疼痛与躯体症状

疼痛和抑郁经常一起出现，而且互相加重：疼久了人容易垮，情绪差了疼得更明显。这类患者常在多个科室之间转，检查做了一轮又一轮，却始终没人把两头连起来。这一页讲清楚疼痛与抑郁的双向关系、哪些药有证据、心理治疗和运动怎么起效、为什么阿片类不是出路。

一、疼痛与抑郁，是两个方向的路

从疼痛到抑郁：持续三个月以上的疼痛，会打断睡眠、限制活动、影响工作和收入、让人反复就医却得不到确定答案。这种“看不到头”的消耗，本身就足以拖出抑郁和焦虑。【研究】

从抑郁到疼痛：抑郁会降低人对疼痛的耐受，放大身体信号，让原本“轻微”的不适变得难以忍受。抑郁常伴随的乏力、食欲差、睡眠紊乱，又会进一步降低活动量，形成“越不动越痛、越痛越不动”的循环。

共同的生物学基础：疼痛和情绪调节共用一部分神经通路，5-羟色胺和去甲肾上腺素既参与情绪调节，也参与下行疼痛抑制。这解释了两件事：为什么抗抑郁药能止痛，为什么治抑郁有时能顺带减轻疼痛。【研究】

还有一类情况叫**中枢敏化**：神经系统长期处于“警报开太大”的状态，明明没有新的组织损伤，疼痛却持续存在、范围扩大、轻轻一碰就疼。纤维肌痛、部分慢性腰痛、肠易激都属于这一类。它不是“想出来的”，而是真实的神经系统改变。

现象	更偏向伤害性疼痛	更偏向中枢敏化
起病	有明确损伤或劳损	常无明确诱因，或由小诱因引发
疼痛范围	局限、可定位	弥散、游走、超过一个区域
与情绪睡眠	关系较弱	情绪差、睡不好时明显加重
检查	可能有结构异常	常无对应发现
对治疗反应	处理局部问题有效	需要药物、运动、心理综合干预

这张表只是帮助理解，不是诊断工具。两者也常常同时存在。

二、先查因，但不要用“再查一次”代替治疗

慢性疼痛的评估要同时做两件事：排除需要处理的器质性问题，以及评估疼痛对功能、睡眠、情绪的影响。

必须尽快查因的“红旗征”：

- 新出现的剧烈疼痛，与以往模式完全不同；
- 大小便功能改变、会阴部麻木、下肢进行性无力（可能是马尾综合征，需急诊）；
- 发热、体重明显下降、夜间痛醒且越躺越痛；

- 有肿瘤病史，新出现持续骨痛；
- 外伤后出现的颈腰痛，伴肢体麻木无力；
- 胸痛伴大汗、气短、放射痛。

排除这些之后，如果检查结果始终无法解释全部症状，正确的方向不是“再做一次全身扫描”，而是转向**功能康复和综合治疗**。反复检查有三重代价：花钱、拖延、以及不断强化“我身体里一定有个没查出来的大病”的恐惧，而恐惧本身会放大疼痛。

这不等于“你的痛是装的”。 疼痛是主观体验，没有对应的检查发现，不代表没有痛苦。理解这一点，是从“找病灶”转向“改善功能”的前提。

三、药物：哪些有证据，哪些要小心

SNRI 类是抑郁合并慢性疼痛时最常被考虑的一类，因为它们同时作用于情绪和下行疼痛通路。其中**度洛西汀**在糖尿病周围神经痛、纤维肌痛、慢性肌肉骨骼疼痛上有相对较多的研究支持，部分国家的审批包含这些适应症。【指南】文拉法辛、米那普仑也有类似方向的证据，但强度和适应症范围不同。

需要说明：**这类药起效通常比止痛药慢，评估止痛效果往往需要几周，而且剂量与治抑郁可能不同。** 不要吃三天没感觉就停，也不要自行加量。

三环类（如阿米替林）在神经病理性疼痛和偏头痛预防上有较长使用历史，剂量通常低于抗抑郁剂量。【指南】但它们有明显的抗胆碱能作用（口干、便秘、排尿困难、视物模糊）、心脏传导影响和体位性低血压，老年人、青光眼、前列腺增生、心律失常者要格外谨慎；过量时有致死风险，家里有自杀风险的人尤其要评估。

抗惊厥类（加巴喷丁、普瑞巴林）用于神经病理性疼痛有一定证据，但会引起嗜睡、头晕、水肿，与其他镇静药或阿片类合用时呼吸抑制风险升高，而且这类药存在被误用的可能。【研究】

曲马多要单独提醒：它既是止痛药，也有血清素能作用。与 SSRI/SNRI 合用时，血清素综合征和癫痫的风险升高，不能自行叠加。【指南】

阿片类：见下一节。

选择	主要用途	需要留意
SNRI（如度洛西汀）	神经痛、纤维肌痛、慢性肌肉骨骼痛合并抑郁	起效慢、恶心、血压、出汗
三环类（如阿米替林）	神经痛、偏头痛预防	抗胆碱能、心脏、过量风险
抗惊厥类	神经病理性疼痛	嗜睡、头晕、水肿、呼吸抑制
曲马多	中度疼痛	与抗抑郁药合用风险、癫痫
阿片类	急性剧痛、癌痛	长期用于慢性非癌痛风险大于收益

所有药物都必须在医生评估后使用，个体差异很大。

四、心理治疗、运动与多学科：让身体重新动起来

CBT 对慢性疼痛有明确证据，目标不是“把痛变成零”，而是减少疼痛带来的痛苦和功能丧失。它处理的是：灾难化想法（“这痛永远不会好，我完了”）、对活动的恐惧、过度休息与过度用力之间的摇摆，以及睡眠和情绪。【指南】

正念（如正念减压）帮助人把“疼痛”和“我对疼痛的反应”分开，减少对抗带来的额外紧张。证据中等，但对一部分人确实有效。【研究】

运动是被低估的治疗。长期卧床会让肌肉萎缩、关节僵硬、体能下降，反而更痛。有效的方式是**分级活动**：从很小的量开始，固定频率，宁少勿多，逐步增加，而不是“疼就停、不疼就猛练”。水中运动、步行、太极、普拉提都可以，关键是可持续和循序渐进。【指南】

多学科疼痛门诊通常把疼痛科、康复科、精神科/心理科、护理整合在一起，对病程长、多次治疗无效的人尤其合适。可以主动问当地医院有没有这类门诊。

日常可以照着做的清单：

- ☐ 记录疼痛日记：时间、部位、强度、当时在做什么、情绪和睡眠。
- ☐ 把活动拆成小段，做 20 分钟休息 5 分钟，而不是一次做完再躺两天。
- ☐ 设定“功能目标”（能走多久、能睡几小时），而不只是“疼痛分数”。
- ☐ 每周三次低强度有氧，从十分钟开始。
- ☐ 睡眠固定起床时间，床只用来睡觉。
- ☐ 学一种放松方法，疼痛加剧时先用，而不是立刻加止痛药。
- ☐ 把止痛药的使用频率记下来，复诊时给医生看。
- ☐ 明确告诉医生：我最想恢复的功能是什么。

五、为什么阿片类不是慢性疼痛的答案

阿片类（吗啡、羟考酮、曲马多、芬太尼等）对急性剧痛和癌痛有明确地位，但对**慢性非癌性疼痛**，长期使用的证据有限，而风险是确定的：

- **耐受与依赖**：同样的量效果越来越差，停药时出现戒断。
- **过量与呼吸抑制**：与酒精、苯二氮䓬类、加巴喷丁类合用时，呼吸抑制风险成倍上升。
- **阿片诱导的痛觉过敏**：长期使用反而让疼痛更敏感，这是一个反直觉但真实存在的现象。
- **内分泌与免疫影响**：长期使用可能影响性激素、睡眠和免疫功能。
- **功能未必改善**：很多研究显示，长期阿片治疗对功能和生活质量的改善有限。

因此，主流指南建议：慢性非癌痛不常规长期使用阿片类；确需使用时，要有明确的适应症、最短疗程、定期评估功能和风险。【指南】如果你已经在长期使用，**不要自行骤停**（可能出现戒断），应与医生制定减量计划。

容易踩的坑

- **“痛就是痛，跟情绪没关系”**：情绪和疼痛共用神经通路，治情绪不是否认疼痛。
- **“检查没发现问题，就是我装病”**：检查阴性只说明没有结构性病变，不说明没有痛苦。
- **“再查一次就能放心”**：反复检查短期缓解焦虑，长期强化恐惧，还耽误功能康复。
- **“疼就不动，不疼就猛练”**：这是最伤的模式，分级、定量、持续才是正解。
- **“止痛药加量就能压住”**：耐受会让效果越来越差，混合用药的呼吸风险是真实的。
- **“抗抑郁药是治心情的，不能止痛”**：SNRI 类在多种慢性疼痛上有明确证据，但起效慢，需要给它时间。
- **只吃药不改生活**：睡眠、活动量、饮酒、对疼痛的恐惧，都会决定药物能起多大作用。

六、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

立即呼叫 120 或去最近医院急诊：

- 突发剧烈胸痛、腹痛，伴大汗、气短、晕厥；
- 大小便失禁或排不出、会阴部麻木、下肢进行性无力；
- 外伤后颈腰痛伴肢体麻木、无力；
- 发热伴剧烈腰痛或皮疹；
- 服止痛药后叫不醒、呼吸很慢、嘴唇发紫；
- 明确的自杀计划或已采取行动。

当天联系医生：

- 疼痛突然加重且性质改变；
- 止痛药越用越多、越用越不管用；
- 出现新的肢体麻木、无力、走路不稳；
- 加用抗抑郁药后出现心慌、出汗、手抖、腹泻、意识改变（需排除血清素综合征）。

一两周内复诊：

- 疼痛持续三个月以上，影响睡眠和工作；
- 多次检查无明确发现，却仍无法正常活动；
- 想减少止痛药或安眠药。

疼痛的“原因不明”不等于“没得治”。方向对了，功能是可以一点点恢复的。

参考来源

- NICE. Chronic pain (primary and secondary) in over 16s: assessment of all chronic pain and management of chronic primary pain (NG193). https://www.nice.org.uk/guidance/ng193
- NICE. Depression in adults with a chronic physical health problem (CG91). https://www.nice.org.uk/guidance/cg91

- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；止痛药与抗抑郁药的选择、剂量和减停须由医生面诊决定，具体方案以面诊医生为准。

10.4 抑郁合并 ADHD PTSD 与物质使用

有些抑郁怎么治都不见好，原因不在药不够强，而在旁边还站着另一个问题：注意缺陷多动障碍（ADHD）、创伤后应激障碍（PTSD），或者酒精与其他物质的使用。这三类共病会改变诊断顺序、药物选择和风险判断。这一页讲清楚筛查该按什么顺序、先稳定哪一个、药物之间会怎么打架、以及为什么不能自己硬戒。

一、筛查顺序：先排“模仿者”，再定“主角”

抑郁合并共病时，最容易犯的错是“谁先被看见就先治谁”。更稳妥的顺序是：

1. **先看安全**：有没有自杀计划、自伤、精神病性症状、意识障碍、严重戒断。有，就先处理安全。
2. **再排“模仿者”**：物质使用、甲状腺疾病、贫血、睡眠呼吸暂停、药物副作用、慢性疼痛。这些能制造出几乎一模一样的抑郁表现。
3. **再看创伤史**：PTSD 的回避、麻木、失眠、易惊，和抑郁高度重叠，不问就永远发现不了。
4. **最后看发育史**：ADHD 的核心是“从小就这样”，需要回溯童年，而不是只看现在。
5. **然后才谈抑郁的正式治疗**：此时选的药、定的疗程，才不容易被共病拖垮。

这个顺序不是官僚流程，而是因为每一步都会改变下一步的答案。比如一个有酒精依赖的人，不先把饮酒问题纳入方案，抗抑郁药的效果会被持续饮酒抵消，还会增加肝损伤和出血风险。

初诊时值得主动说的事：

- ☐ 从小学到现在，有没有“坐不住、丢三落四、作业拖到最后一刻”的持续模式。
- ☐ 有没有经历过死亡威胁、暴力、性侵、严重事故、长期忽视。
- ☐ 喝酒的频率、量、开始时间，有没有“不喝就难受”。
- ☐ 用不用安眠药、止痛药、减肥药、兴奋剂，从哪来的。
- ☐ 有没有赌博、网游、短视频的失控使用。
- ☐ 家族里有没有物质使用、自杀、双相、ADHD。
- ☐ 现在最想解决的是哪一个问题（这决定治疗从哪下手）。

二、ADHD：从童年史开始，而不是从“注意力差”开始

ADHD 不是“不专心”这么简单，核心是三组表现：注意力难以维持、冲动、活动过多或内心坐立不安。诊断的关键在于：**症状在十二岁前就已出现、持续六个月以上、跨两个以上场景（学校/工作、家庭、社交）、并且造成实际损害**。成年后才“突然注意力差”，更可能是抑郁、焦虑、睡眠不足或物质使用。

ADHD 与抑郁常常互为因果：长期被批评、学业受挫、计划能力差带来的失败体验，很容易拖出抑郁；而抑郁的注意力下降、动力缺失，又会被误认为 ADHD 加重。

先治哪个？ 没有统一答案，看功能损害和安全风险。一般原则是：

- 抑郁严重、有自杀风险、无法起床时，先处理抑郁。
- 抑郁稳定后 ADHD 仍明显影响功能，再系统评估 ADHD 并考虑治疗。
- 两者都明确且互相拖累时，可以在同一方案里同时处理，但需要更密的随访。

药物相互作用要留意的点：

- 兴奋剂类（哌甲酯、安非他明类）可能升高血压和心率、加重焦虑和失眠，也可能影响食欲。开始前通常要评估心血管风险。
- 兴奋剂与某些抗抑郁药合用，整体上是常见组合，但需要监测心率、血压、焦虑、睡眠，以及少见但严重的血清素能反应。
- 兴奋剂与单胺氧化酶抑制剂（MAOI）类抗抑郁药属于明确禁忌，不能同时使用。
- 非兴奋剂类（如托莫西汀）起效慢，可能影响血压和肝功能，需医生监测。
- ADHD 药物多属于管制药品，必须凭处方、按医嘱使用，不能自行加量或转借他人。

【指南】ADHD 与抑郁共病时，指南建议整合评估、分阶段处理，而不是把两个诊断分开、由两个医生各治一半。

三、PTSD：创伤聚焦治疗是核心，不必等“完全稳定”

PTSD 的四个症状群：反复体验（闪回、噩梦）、回避（不去相关地点、不谈相关事）、负性认知与情绪（自责、麻木、觉得世界危险）、警觉增高（易惊、失眠、易怒）。它和抑郁的重叠度极高，很多人被诊断了多年抑郁，却从没被问过创伤史。

治疗上，创伤聚焦的心理治疗是一线：延长暴露疗法（PE）、认知加工治疗（CPT）、眼动脱敏与再加工（EMDR）。它们的共同点是直面创伤记忆并重新加工，而不是只做放松训练。【指南】

一个常见的误解是“必须先完全稳定才能碰创伤”。实际上，对多数人来说，创伤聚焦治疗可以且应该与抑郁治疗同时进行；只有在自杀风险很高、精神病性症状、严重解离或物质戒断未处理时，才需要先稳定化。【指南】

药物方面，SSRI 类对 PTSD 有证据，也常同时改善抑郁；但药物通常作为心理治疗的补充，而不是替代。【指南】

需要提醒的：不要自行使用大麻、酒精、“助眠”药物来对抗闪回和噩梦。它们短期能麻痹，长期会加重回避、破坏睡眠结构，并让 PTSD 更难治疗。

四、物质使用：戒断可能致命，整合治疗优于分开治

这是三类共病里风险最高的一类，因为**戒断本身可以危及生命**。

- **酒精**：长期大量饮酒后突然停酒，可能在数小时到数天内出现手抖、出汗、心慌、幻觉，严重时癫痫发作、震颤谵妄（意识混乱、高热、大汗），有死亡风险。**不能自己在家硬戒。**
- **苯二氮䓬类**：长期使用后骤停可能引起焦虑反跳、失眠、癫痫，同样需要医生指导下的缓慢减量。
- **阿片类**：戒断非常难受（流涕、腹泻、肌肉酸痛、失眠、烦躁），但直接致死风险相对较低；真正的致命风险是过量导致的呼吸抑制。
- **兴奋剂类**（冰毒、可卡因）：戒断以情绪低落、乏力、嗜睡为主，抑郁症状可能在停用后持续数周，容易误判为“抑郁症加重”。

药物相互作用的高危组合：

组合	风险	处理方向
酒精 + 苯二氮䓬类/安眠药	呼吸抑制、跌倒、意识不清，可致死	不同时使用，必须告知医生饮酒量
酒精 + 阿片类止痛药	呼吸抑制、过量死亡	避免联用，尤其在有镇静药时
酒精 + 抗抑郁药	加重肝负担、嗜睡、情绪恶化	治疗期间尽量戒酒
兴奋剂 + MAOI	高血压危象等严重反应	明确禁忌
曲马多 + SSRI/SNRI	血清素综合征、癫痫	避免自行叠加

治疗方向上，整合治疗优于“先戒了再来治抑郁”。把物质使用和抑郁放在同一个方案里处理，同时处理睡眠、疼痛、社交环境，脱落率和复发率都更低。【指南】具体手段包括：动机性访谈、认知行为治疗、复发预防、家庭参与；阿片类使用障碍可用替代治疗（美沙酮、丁丙诺啡）；酒精使用障碍有纳曲酮、阿坎酸等药物可选，是否需要由成瘾专科评估。

如果当地有“物质依赖科”“成瘾医学门诊”，优先选择；没有的话，让精神科医生知道你完整的饮酒和用药情况，是最低要求。

容易踩的坑

- **“我只是心情不好才喝两杯”**：如果喝酒是为了入睡、压住情绪、应对闪回，它已经在承担“自我治疗”的功能，需要正式处理。
- **“先把酒戒了再说抑郁”**：顺序反了。很多人在戒断期抑郁最重，正是需要治疗的时候。
- **“ADHD 就是不够专心，长大就好了”**：ADHD 会持续到成年，未治疗与学业失败、事故、物质使用风险相关。
- **“PTSD 是过去的事，提它没用”**：回避维持症状，创伤聚焦治疗正是针对“不敢碰”的部分。
- **“抗抑郁药和 ADHD 药一起吃太危险”**：常见组合，风险可控，关键是医生知情和随访，而不是自行取舍。
- **“自己减量戒酒/戒药更有毅力”**：酒精和镇静药的戒断可以致命，毅力解决不了生理问题。
- **只治一头**：抑郁好了但酒没停，或酒停了但 PTSD 没碰，复发几乎是必然的。

五、什么时候需要联系医生，什么时候去急诊

> **立即呼叫 120 或去最近医院急诊：**

- 停酒后出现抽搐、意识混乱、高热、大汗、幻觉（震颤谵妄）；
- 停用镇静药后出现癫痫、极度兴奋；
- 饮酒或服药后叫不醒、呼吸很慢、嘴唇发紫；
- 过量服药、混用多种物质后意识不清；
- 闪回中出现伤人、自伤行为，或明确的自杀计划；
- 严重兴奋、冲动到无法控制，伴幻觉或妄想。

当天联系医生：

- 想戒酒或停安眠药，需要制定安全的减量计划；
- 停用兴奋剂后情绪急剧下滑，出现自杀念头；
- 闪回、噩梦频率明显增加，无法工作或出门；
- 开始新的 ADHD 药物后出现心慌、胸闷、血压升高。

一两周内复诊：

- 抑郁治疗数月无效，且存在未处理的创伤史或物质使用；
- 需要评估是否合并 ADHD；
- 想转介到成瘾专科或创伤治疗。

涉及戒断时，宁可按急症处理。酒精和镇静药的戒断，是不能靠“扛一扛”过去的。

参考来源

- NICE. Post-traumatic stress disorder (NG116). https://www.nice.org.uk/guidance/ng116
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

本页为科普，不构成个体化医疗建议；共病评估、药物联用与戒断处理须由精神科、成瘾专科等面诊决定，具体方案以面诊医生为准。

模块 11：就医、费用与权益

治疗不只是医学问题，也是现实问题：去哪看、怎么请假、能不能报销、隐私会不会泄露。这一模块讲操作层面的信息。

11.1 如何选择医院与医生

> 第一次去看精神科，最难的一步往往不是开口，而是“去哪看、挂谁的号”。这一页把精神专科医院、综合医院精神科/心理科、社会心理咨询机构放在一起比较，讲清楚各自的资质、能做什么、不能做什么，以及第一次该挂什么号、远程医疗什么时候够用。读完你可以按自己的情况排出两三个备选，而不是在网上乱搜。

三类机构，先分清它们能做什么

同样是“看抑郁”，不同机构的法律权限和工作方式差别很大。分不清这一点，最容易出现两种浪费：在只能做咨询的地方等诊断，在只能开药的地方期待长谈。

机构类型	能做什么	不能做什么	适合谁
精神专科医院（含区县精神卫生中心）	诊断、开药、住院、物理治疗（如 MECT、rTMS）、复杂评估、危机处置	挂号紧张、等待久；离家可能远	症状重、需要调药或住院、诊断不明确、共病复杂
综合医院精神科/心理科/心身医学科	诊断、开药、门诊心理治疗、会诊联络（躯体病共病）	多数无精神科急诊或病房；心理治疗排期长	首次就诊、合并躯体疾病、孕产期、老年、行动不便
社会心理咨询机构	心理咨询与心理治疗（谈话为主）、部分团体课程	不能诊断、不能开药、不能开病假条、通常不能医保	轻中度、已确诊且稳定、关系与成长议题、复发预防

几个容易混淆的名字，先说明白：

- **“心理科”不等于“心理咨询”。** 很多综合医院的心理科（或临床心理科）由精神科医生坐诊，可以诊断开药；也有些医院的“心理咨询门诊”只做评估和谈话治疗，不能开药。挂号前看一眼科室介绍和出诊医生资质。
- **“心身医学科”通常也是精神科。** 名字不同，权限类似，擅长处理躯体症状与情绪相互影响的情况。
- **社会机构里的“心理医生”不是法定称谓。** 中国没有“心理医生”这个执业类别，只有精神科执业医师、心理治疗师、心理咨询师等不同身份。

资质怎么看

不需要成为资质专家，但要知道自己面对的是哪一类人。最简单的办法是看**执业证书上的执业范围**，而不是看头衔和宣传语。

身份	关键资质	能做什么	注意
精神科执业医师	医师资格证书 + 医师执业证书，执业范围为精神卫生专业	诊断、开药、开住院单、开病假条	“主任医师”“副主任医师”是职称，不是资质本身；职称高不等于擅长你的问题
心理治疗师	卫生专业技术资格（心理治疗），多在医疗机构内执业	在医疗机构内开展心理治疗	不能开药；《精神卫生法》规定心理治疗活动应在医疗机构内开展
心理咨询师	2017 年国家职业资格统一鉴定已取消，现存证书多为培训或行业协会颁发	心理咨询	不能诊断、不能治疗精神障碍；看系统培训（如 CBT 长程项目）、督导时数、从业年限
“健康管理师”“婚姻家庭咨询师”等	与精神卫生无直接执业关系	—	不能替代上述任何一类

两条底线值得记住：

1. **诊断和处方只能由精神科执业医师做出。** 咨询师说“你这是中度抑郁”，只能当作观察，不能当诊断。
2. **心理治疗和心理咨询不能处理需要医疗监护的情况。** 有自杀风险、精神病性症状、拒食、意识问题时，先去精神科。

第一次去，挂什么号

第一次就诊的目标通常不是“马上治好”，而是**把诊断和治疗方向定下来**。所以第一次优先挂“能诊断、能开药、能给方案”的号。

你的情况	建议挂	理由
第一次看，症状明显，影响工作学习	精神科普通门诊	普通号足够完成初诊评估，专家号留给疑难
有自伤、自杀计划、幻觉、木僵、拒食	精神科急诊（或综合医院急诊）	需要当天处置，不能等预约
未成年人	儿童青少年精神科	评估方式、用药考虑、家庭参与都不同
孕产期	有孕产期经验的精神科，或会诊联络精神科	需要权衡用药与不治疗的风险
已确诊、稳定，只想做谈话治疗	心理治疗门诊，或医院内的心理治疗	药物由原医生继续管
以失眠为主，情绪问题较轻	睡眠医学门诊或精神科	先排除睡眠障碍与躯体原因
躯体病合并情绪问题	综合医院精神科/心身医学科	方便多科协作、减少奔波

挂号渠道以医院官方公众号、App、电话和现场自助机为准。**不要通过“代挂号”买号**，既有信息泄露风险，也可能遇到假号。

远程医疗：什么时候够用，什么时候不够

互联网医院和线上问诊这几年很普遍，它确实解决了一部分人的困难，但边界要清楚。

适合远程	不适合远程
已确诊、病情稳定者的复诊与调药	首次诊断、症状复杂、需要鉴别诊断
取药、看检查结果、问副作用	有自杀计划或近期自伤
稳定期的心理咨询（视频）	需要体格检查、量表施测、心电图等
异地、行动不便、照顾孩子走不开	意识障碍、兴奋冲动、拒食、木僵
家属代问护理与沟通问题	需要开病假条、伤残鉴定、住院手续

用远程之前，问自己三个问题：**这个平台能不能查到医生的执业信息？出现紧急情况，我身边有没有人能立刻到场？我在的地方网络和隐私够不够？** 三个都过关，再考虑线上。

远程还有一个常被忽略的限制：**急救可及性**。线上问诊时如果情绪突然失控，医生无法派人到你身边。所以远程更适合“稳定期管理”，不适合“危机期兜底”。

怎么判断“这个医生适不适合我”

好医生不等于“说话好听”，也不等于“职称最高”。可以用下面这份清单在头两次就诊后自查，符合五条以上，通常可以继续；低于三条，可以考虑换一位。

- ☐ 他/她让我把话说完，没有在我讲到一半时打断或下结论。
- ☐ 他/她给出了明确的诊断或“目前还不能确定，需要观察”的说明，而不是含糊其辞。
- ☐ 治疗方案讲清了：吃什么、吃多久、可能有什么副作用、什么时候复诊。
- ☐ 我问的问题被正面回答了，包括“这个药会不会影响性功能”“能不能少吃一点”。
- ☐ 他/她问过自杀念头、睡眠、饮酒，而不只是问“心情好点没”。
- ☐ 复诊时间、加号方式、出现什么情况要提前来，都交代清楚了。
- ☐ 费用和疗程我能承受，不需要靠借钱维持。
- ☐ 我感到被当作一个人对待，而不是一个“病例”。

可以考虑换医生的情况：连续几个月方案没有任何调整也不解释；你提出疑问被嘲讽或威胁（“你不吃就等着住院”）；超范围执业（咨询师给你开药、推荐保健品）；频繁爽约、每次只给两分钟；涉及让你不舒服的边界行为。

换医生时不必“撕破脸”，可以说“我想再听一个意见”，并把既往病历、用药记录带全。**不建议频繁换**——治疗联盟本身就有作用，每换一次都要重新建立信任、重讲一遍病史。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> **首次就诊前如果出现以下情况，不要等预约**：有自杀计划或准备行为、已经自伤、几乎不睡且兴奋话多、拒食拒水、出现幻觉或言行紊乱——直接去精神科急诊或综合医院急诊，必要时拨 120。
>
> **就诊后**：加药或换药后情绪急剧恶化、出现高热抽搐、皮疹迅速扩散，立即联系开药医生或去急诊。
>
> **不确定去哪看**：可拨 12356 心理援助热线询问转介方向；地方资源以当地卫健委公布为准。

五个容易踩的坑

1. **只看头衔和宣传。** “名医”“首席”不等于适合你；执业范围、沟通方式、可达性更重要。
2. **把心理咨询当成诊断。** 咨询师没有诊断权，如果你还没确诊，先去医院。
3. **一次挂好几个科，同时吃几套方案。** 药物相互作用是真实风险，所有医生都应该知道你正在吃什么。
4. **迷信“基因检测选药”。** 目前这类检测对多数人的用药选择帮助有限，不能替代医生的临床判断【待验证】。
5. **因为一次不愉快就认定“所有医生都一样”。** 换个机构、换个医生，体验常常差别很大。

选医院和选医生，本质上是选一段能持续几个月甚至几年的合作关系。**能稳定复诊、能把话说清楚、出事能找到人**，这三点比“最有名”实用得多。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022
- 国家法律法规数据库.《中华人民共和国精神卫生法》
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

11.2 初诊与复诊准备清单

> 精神科门诊的时间通常很短：初诊十几到二十分钟，复诊可能只有五分钟。同样的五分钟，有人能说清关键，有人出来才发现“忘了问”。这一页给你两份可打印的准备单：初诊带什么、怎么讲症状，复诊怎么用三句话讲完重点，以及一张可以照着问的问题清单。适合第一次就诊的人，也适合复诊多次却总觉得“没说清楚”的人。

初诊带什么

初诊的信息量最大，医生要在有限时间里拼出一张完整的图。你带得越全，误判越少。

证件与手续

- ☐ 身份证、医保卡（或电子医保凭证）、就诊卡。
- ☐ 既往在本院或其他医院的就诊卡、门诊病历本。
- ☐ 如果是复诊转院，带上转诊单或出院小结。

病历与检查

- ☐ 出院小结、门诊病历、既往化验单（甲状腺功能、血常规、生化、维生素等）。
- ☐ 心电图、脑电图、影像报告（有的话）。
- ☐ 做过的心理测评报告，注意看日期——两年前的量表说明不了现在。
- ☐ 既往心理治疗的记录（做了多久、什么流派、有没有效果）。

用药

- ☐ 正在吃的所有药，**带药盒**，不要只报药名。很多药名相近，剂量写法也不同。
- ☐ 吃过的药：药名、吃了多久、有没有效、有什么副作用、为什么停。
- ☐ 保健品、中药、助眠药、减肥药，也要说。它们会影响判断和相互作用。
- ☐ 过敏史：对什么药过敏、当时什么反应。

自己准备的材料

- ☐ 一张时间线（见下一节），手写或打印都行。
- ☐ 最近两周的睡眠记录：几点睡、几点醒、中间醒几次。
- ☐ 情绪或症状日记（如果有）。
- ☐ 想问的问题，按重要性排序，写在纸上。
- ☐ 一位了解你情况的家属或朋友，能补充你注意不到的变化。

怎么讲症状：一条时间线，四件必说的事

医生不是靠“我不舒服”来诊断的，而是靠**时间、变化、功能、风险**。把这四样讲清楚，比描述得多生动都有用。

医生想知道的	怎么讲	例子
时间线	第一次什么时候、之前有没有类似、这次从什么时候开始变	“去年三月开始睡不着，去年九月明显加重，今年一月起请了长假。”
变化	是持续变差、时好时坏、还是某件事之后突然变	“过年回家后好了一周，回来又不行了。”
功能影响	工作、学习、家务、人际具体受影响到什么程度	“两个月没上班；能做饭但做完要躺一下午；不接电话。”
风险	有没有自杀念头、计划、准备、既往尝试	“想过，觉得活着没意思；没计划；三年前有过一次吞药。”

关于**功能影响**，很多人只会说“还行”“不太好”。可以换成可数的事实：这周上了几天班、请了几天假、几天没出门、几天没洗澡、一天能看几页书、还联不联系朋友。医生判断严重程度，主要看这些，而不是看你哭没哭【临床经验】。

关于**自杀念头**，请务必主动说，不要等医生问。可以按四个层次讲：**想过（有没有）→ 想过什么（具体内容）→ 有没有计划（怎么做、在哪、什么时候）→ 有没有准备（攒药、查方法、写过东西）**。主动说不会让你被“抓走”，反而能让医生给出更合适的方案——指南本身就把“直接询问自杀念头”列为评估的常规步骤【指南】。多数医生听到这些，第一反应是帮你降低风险，而不是评判你。

其他必说：最近喝不喝酒、抽不抽烟；月经是否规律、是否备孕或怀孕；有没有躯体疾病（甲状腺、肝病、心脏病、癫痫、青光眼）；家族里有没有人得过精神疾病或自杀。这些直接影响选药。

一段可以照着说的话

不知道从哪开口，可以用这个结构，三十秒讲完：

> “医生，我这次主要是因为睡不好和什么都提不起劲来的。大概从去年十月开始，最早是凌晨三四点醒，后来白天也没力气，最近一个月连班都上不了。我之前没吃过抗抑郁药，只在社区开过安眠药，吃了两周就不敢吃了。最近两周想过‘不如算了’，但没有计划。我想知道这算不算抑郁，要不要吃药，吃了会不会影响工作。”

这段话包含了时间、症状、功能、既往治疗、风险、诉求，医生接得住。

复诊只有五分钟，讲什么

复诊不是“汇报近况”，而是**让医生做出下一步决定**。带上记录，用三句话开场：

1. **哪里变了**：“这两周睡眠从四小时到六小时，白天能出门一次了。”
2. **有没有问题**：“早上还是恶心，大概一小时后缓解；性功能有影响。”
3. **这次想问什么**：“能不能减量？如果要吃半年，中间能不能停几天？”

如果医生只有五分钟，这三句话能让他立刻抓到重点。剩下的时间留给他追问。

医生常问	提前准备什么	一句话回答
药还在吃吗？	数一下这周漏了几次	“这周漏了一次，周三晚上忘了。”
睡得怎么样？	看睡眠记录	“平均六小时，早醒三次。”

医生常问	提前准备什么	一句话回答
情绪怎么样？	用 0–10 打分，和自己的基线比	“比上次好一点，6 分，之前是 4 分。”
有没有不舒服？	记副作用出现的时间和持续时间	“吃完两小时恶心，下午就好。”
有没有想不开？	直接说，不回避	“有过一次，很快就过去了，没计划。”
有什么想问的？	纸条，按顺序	见下一节清单

一个实用习惯：**每次复诊后，用手机记一行**“日期、药名剂量、主要变化、下次复诊时间”。三个月后回看，趋势就出来了，比回忆可靠。

可以问医生的问题清单

不必一次问完，挑三到五个最要紧的。问题按主题分组，方便勾选。

关于诊断

- ☐ 我现在的诊断是什么？依据是什么？
- ☐ 需要排除哪些其他可能（甲状腺、双相、睡眠障碍、药物影响）？
- ☐ 这个诊断会不会随时间改变？什么情况下需要重新评估？

关于治疗

- ☐ 为什么选这个方案，而不是心理治疗/另一种药？
- ☐ 大概多久能见效？如果四周没变化，下一步是什么？
- ☐ 有没有需要我现在就做的检查？

关于药物

- ☐ 这个药叫什么、作用是什么、最常见的前三个副作用是什么？
- ☐ 副作用大概多久会减轻？出现什么必须停药并联系您？
- ☐ 漏服了怎么办？能和别的药、酒一起吃吗？
- ☐ 要吃多久？什么时候评估能不能减？
- ☐ 有没有疗效相近、价格更低的同类药？

关于生活与风险

- ☐ 我现在能上班/上学吗？需要开病假条吗？
- ☐ 能运动、能开车、能喝酒吗？
- ☐ 出现什么情况必须马上来，而不是等复诊？

关于下次

- ☐ 下次什么时候复诊？怎么加号？临时不舒服找谁？

如果医生对某个问题明显不耐烦，仍然值得问完最重要的两个：**“出现什么情况必须马上来”和“多久没效要换方案”**。这两个答案直接关系到安全。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> **不要等到复诊，当天联系**：吃药后出现皮疹、高热、抽搐、意识模糊；情绪在几天内急剧恶化；自杀念头变强或出现计划；连续多日几乎不睡且兴奋话多；呕吐腹泻到无法进食。
>
> **立即去急诊或拨 120**：已经自伤或服药过量；有明确自杀计划并开始准备；出现幻觉、冲动伤人、木僵拒食。
>
> **不确定时**：拨 12356 心理援助热线；地方资源以当地卫健委公布为准。

六个容易踩的坑

1. **一次准备二十个问题。** 五分钟问不完，反而一个都记不住。挑三个最影响治疗的。
2. **隐瞒自杀念头或饮酒量。** 这两项被隐瞒，方案就容易偏离，风险反而更高。
3. **只讲情绪，不讲功能。** “我很痛苦”很难量化，“两个月没上班”医生一听就明白。
4. **复诊只说“还行”。** “还行”提供不了任何决策信息，至少说出睡眠、副作用、情绪分数三项。
5. **换医院不带病历。** 重复检查、重复试药，既花钱也耽误时间。
6. **家属抢答。** 家属的补充很有价值，但请让患者先说完；医生需要听到本人的表述。

最后提醒一句：准备清单不是为了“表现得像个好病人”，而是为了让有限的门诊时间用在刀刃上。**你不需要讲得专业，只需要讲得具体。**

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

11.3 费用医保病假与权益

> 治疗不只是医学问题。一个月药费多少、门诊能不能报、请假会不会被单位知道、病历会不会传到学校——这些现实问题处理不好，人会先被“麻烦”劝退，而不是被症状打败。这一页讲清费用大致花在哪、医保和商保各自管什么、病假条怎么开、隐私可能从哪里漏出去，以及《精神卫生法》给你的几条底线。只讲原则和操作思路，具体比例、额度、病种目录一律以当地医保部门和单位规定为准。

钱花在哪：先看清费用结构

同样叫“看抑郁症”，费用差别可能有好几倍。差别主要来自四个方面：机构类型、药物选择、是否做心理治疗、是否住院。

费用项	大致构成	可以怎么省
挂号与诊查	普通号、专家号、特需号价格差很大	首诊普通号通常够用；疑难再挂专家
检查	甲状腺功能、血常规、生化、心电图、量表	带上近期外院结果，避免重复；按医生要求做，不要自己加项
药物	原研药与仿制药、是否集采品种、剂量与种类	主动问“有没有集采的同类药”；稳定期可问长处方
心理治疗	医院心理治疗门诊按次收费；社会机构按小时收费，差价大	医院内通常低于社会机构；也可考虑团体治疗、自助课程
物理治疗	rTMS、MECT 等，按疗程计	有明确适应证再做；问清总费用与次数
住院	床位、护理、治疗、检查、伙食	能门诊就不住院；必须住院时问清结算方式
隐性成本	交通、误工、异地住宿、家属陪护	优先选可达性好的医院；远程复诊可减少奔波

一个常被忽略的事实：**最贵的方案不一定最有效，最便宜的方案可能最贵**。为了省钱自行减量、停药，导致复发再住院，总花费往往更高【临床经验】。

医保能覆盖哪些部分

中国的医保分职工医保和城乡居民医保两套体系，同一套体系内各省、各市细则也不同。下面只讲“有哪些通道”，不写比例，具体以参保地医保部门答复为准。

通道	管什么	你需要做什么
普通门诊统筹	门诊挂号、检查、药品的一部分	在定点机构就诊，持医保卡结算；多数地区有起付线和年度限额
门诊慢特病（门诊慢性病/特殊病种）	长期用药的门诊费用，报销待遇通常优于普通门诊	先确认本地病种目录是否包含抑郁症；按流程申请认定，准备病历与诊断证明
住院报销	住院期间的床位、治疗、检查、药品	在定点医院住院，出院时直接结算；注意起付线与目录内外用药
大病保险	住院或门诊自付超过一定额度后的二次报销	多数地区自动结算，无需单独申请；异常情况问参保地医保局
医疗救助	低保、特困、低保边缘等困难群体的补充救助	向户籍地民政部门或街道申请

通道	管什么	你需要做什么
商业保险	住院医疗、重疾、门诊险等	投保时如实告知；理赔时准备病历、发票、费用清单

关于**门诊慢特病**，需要特别说明：各地病种目录差别很大。有的地区把精神分裂症、双相障碍等重性精神疾病列入，抑郁症是否纳入、认定标准是什么、额度多少，必须查参保地医保局的公开目录，或直接打当地医保服务电话询问。**不要根据网上的“全国统一政策”去预期报销。**

关于**商业保险**，有三点实务提醒：

1. **投保时要如实告知。** 隐瞒抑郁症病史，理赔时可能被拒赔甚至解除合同，这是《保险法》如实告知义务的基本要求。
2. **既往症条款要看清楚。** 多数医疗险对投保前已存在的疾病不赔或设等待期。
3. **重疾险里的“严重抑郁症”有严格定义。** 不是确诊抑郁就能赔，通常要求达到特定严重程度或住院天数，以条款为准。

异地就医别忘了备案。通过国家医保服务平台 App 或参保地医保局办理异地就医备案后，在就医地定点医院可以直接结算；未备案可能降低报销比例，具体以参保地规定为准。

少花钱的八个实际做法

- ☐ 先确认自己的医保类型、定点医院和年度额度，很多人其实不知道自己能报多少。
- ☐ 每次就诊主动问一句：“有没有集采的同类药？有没有价格更低的替代？”
- ☐ 病情稳定后问医生能不能开长处方，减少挂号与交通次数（以当地规定为准）。
- ☐ 保留所有发票、费用清单、病历和处方，商保理赔和单位补充医疗都用得上。
- ☐ 了解居住地的社区精神卫生服务，部分地区提供免费随访、用药指导与转介。
- ☐ 学生可以用校医院或学校心理咨询中心，通常免费或低价。
- ☐ 心理治疗优先考虑医院心理治疗门诊，价格通常低于社会机构。
- ☐ 真的困难时，向医院医务社工、民政救助或慈善项目求助，不要靠停药省钱。

病假条、复学与复工

病假条（诊断证明） 通常包含：姓名、就诊日期、诊断、建议休息天数、医生签名、医院盖章。缺一项，人事可能不认。开的时候可以直接说：“我需要一张病假证明，单位要求写休息天数并盖章。”

几个现实问题：

- **单位会不会看到诊断？** 多数病假证明上会写诊断。如果单位只需要休息建议，可以和医生沟通证明的写法；但**不要要求医生写虚假诊断**，也不要自己用“失眠”“胃炎”去骗假。一旦涉及医保结算、商保理赔或劳动仲裁，前后诊断不一致会带来更大麻烦。

- **病假期间工资怎么算？** 按病假工资或疾病救济费的规定执行，各地标准不同，以当地人社部门规定和劳动合同为准。
- **能请多久？** 取决于医嘱、工龄和单位制度。医疗期有法定框架，但具体计算复杂，建议咨询当地人社部门或法律援助。

复学通常需要复学证明或评估，学校可能要求医院出具“可以返校”的意见。比较稳妥的做法是渐进复学：先上半天、先上部分课程、暂时不参加高强度考试，和班主任、辅导员约定一个“状态变差时怎么办”的方案。

复工同理。突然满负荷回去，是复发最常见的诱因之一【临床经验】。可以和单位商量：先半日、先减少夜班、先做熟悉的任务、暂时不出差。如果遭遇以患病为由的辞退或调岗降薪，可以保留证据，向工会、人社部门或法律援助机构求助。

隐私：可能从哪里漏出去

抑郁症属于敏感个人信息。现实中泄露往往不是“有人故意害你”，而是流程中的默认设置。

场景	可能知情的人	你能做什么
单位请假	人事、直属领导，有时会传到同事	只提交必要材料；书面说明希望保密的范围
医保报销	医保经办机构；单位补充医疗可能经手明细	问清单位补充医疗是否能看到具体病种
学校	班主任、校医、档案管理部门	要求限定知悉范围，约定不公开通报
商业保险	核保与理赔人员	如实告知，同时要求按个人信息保护规定处理
亲友	家属、亲戚，容易口口相传	由本人指定“可以告诉谁”，统一对外的说法
网络	社交平台、病友群	不晒药盒与病历；关闭“通过手机号找到我”；群内不透露真实姓名与单位

被问到时，可以准备一句通用回答：“最近身体不太好，在调理，需要休息一段时间。”这不叫撒谎，是划定边界。**你有权不向无关的人解释你的诊断。**

《精神卫生法》与你的几条底线

下面只讲原则，不构成法律意见。具体条文以官方公布文本为准，各地执行以当地卫健部门和司法机关的解释为准。

- **自愿原则。** 精神障碍的住院治疗实行自愿原则。能门诊就门诊，住院原则上需本人同意。
- **非自愿住院有严格条件。** 须是严重精神障碍患者，且已经发生伤害自身的行为或有伤害自身的危险，或者已经发生危害他人安全的行为或有危害他人安全的危险。伤害自身的情形通常还需监护人同意；危害他人的情形，监护人阻碍或患者擅自离院时可由公安机关协助。对诊断有异议，可以要求再次诊断和鉴定。

- **人格尊严与人身安全不受侵犯。** 禁止侮辱、虐待、非法限制人身自由；约束、隔离只能在特定条件下作为保护性措施使用，并须记录。
- **隐私受保护。** 姓名、肖像、住址、工作单位、病历资料等可能推断身份的信息，不得随意泄露。
- **教育、劳动、医疗等合法权益受法律保护。** 法律禁止歧视精神障碍患者；具体到就业、入学争议，还要结合劳动、教育领域的法律法规处理。

如果权益受到侵害，可以走的路径大致是：向医院医务科或当地卫健部门反映；向单位工会、人社部门投诉；申请法律援助；涉及诉讼的，咨询专业律师。**保存证据**（病历、通知、聊天记录、录音需注意合法性）比情绪宣泄有用。

> **什么时候需要联系医生 / 去急诊**
>
> **因为费用想停药、减药时**：先联系医生，说明经济困难，讨论换用价格更低的同类药、长处方或减少复诊频次。**不要自行停**——突然停药可能出现头晕、恶心、失眠、电击感，也会明显增加复发风险。
>
> **当天联系医生**：停药或减量后出现明显不适；情绪在几天内快速下滑；睡眠连续多日变差。
>
> **立即去急诊或拨 120**：出现自杀计划或自伤行为；停药后出现严重撤药反应（剧烈头晕、呕吐、意识模糊）；出现兴奋话多、几乎不睡、行为失控。

五个容易踩的坑

1. **以为“精神病”相关的门诊都不能报销。** 多数地区的精神科门诊、住院都在医保范围内，关键是定点、目录和备案。先查清楚，再决定放不放弃。
2. **为了省挂号费，一次开几个月的药。** 稳定期可以长处方，但需要医生评估；长期不复诊会错过调整时机。
3. **用别的诊断开假条。** 短期看似省事，长期会在医保、商保、劳动纠纷里变成把柄。
4. **怕单位知道，硬扛着不休假。** 拖到必须住院，暴露的范围反而更大。
5. **投保时隐瞒病史。** 理赔时被查出来，损失的不只是保费。

钱、假、隐私，这三件事没有一件是“小事”。把它们提前处理掉，治疗才有条件稳定地进行下去。

参考来源

- 国家法律法规数据库.《中华人民共和国精神卫生法》
- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议，也不构成法律或保险意见；报销、病假与权益问题以现行法律、当地政策和经办机构答复为准。

模块 12：误区、问答与决策

这一模块把最常见的误解集中拆掉，并给你一份“可以拿去问医生”的问题清单。

12.1 常见治疗误区 40 条

这一页把诊室、家庭群和短视频里最常出现的 40 句“治疗忠告”逐条拆开：这句话为什么流传、哪一部分不准确、更靠谱的说法是什么。它适合刚确诊的人、正在被亲友“指导”的人，也适合想帮忙却怕说错话的家属。读完不必去和谁争论，只要在再听到这类话时，心里有一个站得住的判断。

先看一张地图

40 条误区大致分成六类。来源不同，破解的重点也不同：

类别	条数	最常听到的说法	通常从哪来
关于疾病本身	5	“想开点就好了”	长辈、亲戚、同事
关于药怎么吃	9	“好了就停”	病友群、自己的直觉
关于药的安全	10	“吃药会变傻”	短视频、朋友转述
关于心理与物理治疗	6	“电休克很可怕”	影视剧、旧传闻
关于生活方式	7	“运动能替代药”	健身博主、养生号
关于怎么看病	3	“找熟人开药”	熟人社会

读的时候可以留意一个规律：**越是把问题说得简单、把方案说得唯一的说法，越值得怀疑。** 抑郁症的治疗本来就有多条路径，也本来就有不确定性。下面每条都按“误解”与“澄清”两段写，方括号里是这条信息的证据分量。

一、关于疾病本身（第 1–5 条）

1.“想开点就好了”

误解：抑郁是想不开，劝通了、想明白了自然就好。

澄清：抑郁症是有诊断标准的疾病，牵涉神经递质、睡眠节律、内分泌和免疫多个系统，不是“观点”出了问题。劝解能让人感到被关心，却不会让早醒消失，也不会让注意力回来。真正有用的是陪他就诊、帮他记录症状、在他做不动的时候少一点指责。【指南】

2.“就是矫情、意志薄弱”

误解：别人都能扛过去，你扛不过去就是娇气。

澄清：很多人在生病前恰恰是特别能扛的那一类。意志力不是病因，也不能替代治疗；把抑郁说成“矫情”，最直接的后果是患者开始隐瞒症状，硬撑到更重的程度才就医。精神科的判断依据是症状、持续时间和功能损害，不是“够不够坚强”。【指南】

3.“青少年就是叛逆，过了这阵就好”

误解：孩子顶嘴、关门、成绩下滑，是青春期正常现象。

澄清：青少年抑郁常表现为易激惹、昼夜颠倒、躯体不适和成绩骤降，而不是成年人那种“悲伤”，所以容易被当成叛逆。叛逆和抑郁可以同时存在，区别在于持续时间、功能受损和是否出现自伤、拒学。用“过了这阵就好”拖着，往往拖掉的是最可干预的一段时间。【指南】

4.“人老了情绪低是正常的，不用治”

误解：上了年纪没精神、没胃口，是自然衰老。

澄清：老年抑郁常以躯体不适、记忆下降、食欲差、不愿出门为主诉，容易被当成“老了”或“痴呆”。它可治，而且不治疗的代价更高：跌倒、失能、营养不良和自杀风险都会上升。老年用药需要更关注多重用药、低钠和跌倒，但这属于“怎么治”，不是“不用治”。【指南】

5.“抑郁症会遗传给孩子，最好别生”

误解：家里有人得病，孩子早晚也会得，生了是害他。

澄清：遗传增加的是风险，不是命运。抑郁属于多基因加环境共同作用的疾病，家族史会让风险升高，但绝大多数有家族史的人并不会因此失去正常生活。家族史真正的用处是：提醒医生在选药和随访时更细致，也提醒家庭更早识别早期信号。【指南】

二、关于药怎么吃（第 6–14 条）

6.“吃药会变傻”

误解：抗抑郁药伤脑子，吃完反应慢、记不住事。

澄清：抗抑郁药不损伤智力。“变傻”的体验通常来自三个地方：抑郁本身造成的注意力与工作记忆下降、长期失眠，以及某些镇静作用较强的药带来的困倦。治疗有效后认知多半会改善；如果服药后持续迟钝，要如实告诉医生，可能是残留症状、甲状腺问题或其他药物在起作用，而不是“药把脑子吃坏了”。【指南】

7.“抗抑郁药会上瘾”

误解：一吃就停不下来，越吃越多，这就是成瘾。

澄清：成瘾的核心是渴求、失控、不断加量、为得到药不择手段，抗抑郁药不具备这些特征。停药时出现的头晕、恶心、失眠、电击感是撤药反应，说明需要缓慢减量，不等于成瘾。真正的区别是：成瘾者很难减少用量，而撤药反应在规范减量下通常可以避免或减轻。【指南】

8.“抗抑郁药伤肝伤肾”

误解：长期吃药，肝肾早晚吃坏。

澄清：大多数抗抑郁药经肝脏代谢、肾脏排泄，在常规治疗剂量下，对原本肝肾功能正常的人风险较低。有肝病、肾病或同时用多种药的人，需要调整方案并定期复查，这属于常规监测，不是“必然损伤”。真正需要担心的伤肝因素是长期大量饮酒，以及来路不明的“保肝”“排毒”产品。【指南】

9.“副作用大就赶紧停”

误解：既然吃了不舒服，说明这药不适合，停了就好。

澄清：恶心、头晕、失眠、出汗这类早期副作用很常见，多数在开始服药后的前一两周内减轻。突然停药会叠加撤药反应，让人更难受，也更难判断到底是什么问题。正确做法是记录出现时间、程度和对生活的影响，然后联系开药医生，由医生决定减量、换药还是加对症处理。只有皮疹迅速扩散、高热、意识改变这类危险反应，才需要立即停药并急诊。【指南】

10.“感觉好了就可以停”

误解：症状没了就是病好了，还吃药干什么。

澄清：症状消失只是“缓解”，不是疾病结束。缓解之后还有巩固期和维持期，目的是把已经拿到的效果稳住、把复发风险压下去。过早停药的人，复发往往发生在停药后的几个月内，而且下一次治疗可能更费劲。停药本身不是禁区，但应该是和医生一起定的计划，而不是某天早上突然不吃了。【指南】

11.“剂量越大效果越好”

误解：既然吃了，就吃到最大量，好得快。

澄清：抗抑郁药确实存在剂量与疗效的关系，但也存在平台期：超过某个剂量后，疗效增加有限，副作用却明显上升。“足量”指的是对这个人合适的治疗剂量，不是说明书上的最大剂量。加量要看起效时间、耐受情况和合并用药，由医生决定；自己加量最常见的后果是副作用先来，疗效没跟上。【指南】

12.“换药越频繁越好”

误解：这个药吃了一周没感觉，赶紧换下一个。

澄清：每种药需要足够的时间和足够的剂量，才能判断它对这个人有没有用。频繁换药的结果是每种药都停在“刚起步”的阶段，永远得不到答案。反过来说，明确不能耐受、出现危险反应、或有更强

指征时，早换是对的。换药有交叉换、叠替、停药清洗等不同方式，选哪种要由医生根据药物特性和你的情况定。【指南】

13.“进口药比国产药好”

误解：同样的成分，进口的更纯、更有效。

澄清：同通用名、同剂型的药，疗效主要由成分和剂量决定。国内仿制药上市前需通过一致性评价，要求在质量与疗效上与参比制剂一致。辅料差异可能让个别人耐受性不同，但“进口一定更好”没有依据。价格、医保报销和能不能稳定买到，都是选药时要一起算的现实因素；换厂家后可以观察几周再评估。【指南】

14.“药越贵越好”

误解：贵的药肯定比便宜的好，医生开便宜的是敷衍我。

澄清：药价由研发成本、专利期、市场竞争和流通环节决定，和你吃下去有没有效没有直接关系。选药看的是既往反应、家族反应、共病、相互作用、副作用谱和费用可及性。一种贵药可能正好不适合你，一种集采后的便宜药可能正好合适。如果预算紧张，直接告诉医生，让他把费用纳入方案，比自行减半安全得多。【指南】

三、关于药的安全与特殊情形（第 15–24 条）

15.“抗抑郁药会让人自杀”

误解：吃了抗抑郁药反而会想不开，还不如不吃。

澄清：需要正视的是：治疗初期，尤其 25 岁以下人群，自杀想法和行为的风险可能升高，这正是药品黑框警告的内容。原因是情绪和精力的恢复不同步——人先有了力气，绝望感还没退，反而更容易行动。但另一面是，不治疗的抑郁本身自杀风险更高。所以结论不是“别吃”，而是“开始治疗的前几周要有人盯着”：家属观察言语和行为变化，出现自杀念头加重、交代后事、送东西，立即联系医生或去急诊。【指南】

16.“双相障碍也能单吃抗抑郁药”

误解：都是抑郁，吃抗抑郁药就行。

澄清：双相抑郁单用抗抑郁药，可能诱发转躁、混合状态和快速循环，部分指南因此不建议单用，或要求与心境稳定剂、抗精神病药联用。问题是双相常以抑郁首发，患者自己往往只记得“低落”，不记得“兴奋”。如果你有过持续几天睡得很少却不困、话多、冲动消费、自信爆棚的阶段，或家族中有类似表现，一定要主动告诉医生。【指南】

17.“怀孕绝对不能吃药”

误解：药会伤胎儿，怀孕就得全部停掉。

澄清：这是最需要个体化权衡的问题之一。孕期抑郁不治疗，与复发、营养不良、早产和低出生体重的关联、产后抑郁以及自杀风险都相关；用药则有相应的孕期证据和风险分级。结论取决于病情严重度、既往发作史、孕周和具体药物，通常由精神科和产科一起定。最危险的做法是发现怀孕后自行骤然停药——那等于同时承担撤药反应和复发风险。【指南】

18.“哺乳期不能吃药”

误解：吃药就不能喂奶，喂奶就不能吃药。

澄清：不同药物进入乳汁的量差别很大，部分药物在哺乳期有较多使用经验，可以在医生评估后继续。完全不治疗同样有代价：母亲的抑郁会影响母婴互动、喂养和婴儿的发育。可行的做法是：和医生讨论药物选择，和儿科医生约定观察点（喂养、睡眠、体重、是否异常嗜睡），并选择相对方便的服药与哺乳时间。【指南】

19.“吃药会影响生育”

误解：抗抑郁药伤生殖，吃了就怀不上、生不了。

澄清：部分药物与催乳素升高、性功能改变、精子质量变化有关，但不是人人发生，多数在停药或换药后可逆。真正影响生育的还有抑郁本身：它会影响性欲、月经、作息和伴侣关系。有生育计划时提前告诉医生，让他把“生育”作为一个选药因素考虑，比自行停药更靠谱。【指南】

20.“吃药期间不能打疫苗”

误解：抗抑郁药和疫苗冲突，打针前必须停药。

澄清：抗抑郁药与常用疫苗之间没有普遍禁忌，不需要为了接种停药。需要个别评估的是：正在使用免疫抑制剂、生物制剂或大剂量激素，正在发热或处于急性感染期，或对疫苗成分有严重过敏史。接种前把正在吃的所有药和补充剂告诉接种医生，以疫苗说明书和接种点的评估为准。【指南】

21.“吃药就不能做手术”

误解：麻醉和抗抑郁药会打架，手术前得先停几周。

澄清：多数抗抑郁药不需要术前停药，但有些确实需要特别处理：例如 MAOI 与某些麻醉药、升压药同用可能引起血压剧烈波动；部分药物影响凝血或与镇痛药叠加。正确做法是术前主动告知外科医生和麻醉医生你在吃什么、吃多久，由三方共同决定是否调整、怎么调整。自己偷偷停药，反而可能在围手术期出现撤药反应或情绪崩溃。【指南】

22.“吃药就不能开车”

误解：抗抑郁药会让人犯困，吃了就别碰方向盘。

澄清：不是一律禁止，而是需要个体评估。部分药在开始服用的头几天、加量后或换药后，会引起嗜睡、头晕、视物模糊和反应变慢；稳定服用一段时间后，很多人并不受影响。可行的做法是：调整方案的初期先避免长途和夜间驾驶，观察自己的反应，避免与酒精、镇静药、熬夜叠加。营运车辆驾驶另有行业规定，需按当地要求执行。感觉明显困倦时就不要开，这不是意志问题。【指南】

23.“吃药就不能运动”

误解：吃了药心跳快、头晕，运动会有危险。

澄清：恰恰相反，运动是抑郁的辅助治疗之一，药物并不妨碍运动。开始阶段可能因为头晕、乏力而吃力，可以从走路这类低强度活动开始，逐步增加，避免高温下脱水和突然的剧烈运动。需要提醒的是：运动不能替代药物，也不要在明显心慌、胸闷、眩晕时硬练。【指南】

24.“停药以后就永不复发”

误解：治好了、停了药，这事就翻篇了。

澄清：复发并不罕见，尤其在发作次数多、症状有残留、起病年龄早、合并焦虑或物质使用、有家族史的人身上。维持治疗和规律随访能降低风险，但不能把风险降到零。停药后的前半年到一年是值得留意的窗口期：睡眠变浅、兴趣下降、容易烦躁，往往比情绪明显低落出现得更早。【指南】

四、关于心理治疗与物理治疗（第 25–30 条）

25.“心理咨询没用，就是聊聊天”

误解：找个人说话谁不会，花那钱不如自己扛。

澄清：有结构的心理治疗和“聊天”的区别在于：有明确目标、有治疗框架、有评估、有回家要练的作业。CBT 处理想法与行为，行为激活从“先动起来”入手，IPT 聚焦人际关系中的四类问题，MBCT 用于预防复发——这些都有对照研究支持。觉得没用，常见原因是诊断不准、疗法与问题不匹配、频率太低、或没有做练习，而不是“心理治疗本身没用”。【指南】

26.“心理治疗能替代药物”

误解：吃药是治标，心理治疗才是治本，那就别吃药了。

澄清：轻度抑郁可以单用心理治疗，这是指南支持的；但中重度、伴精神病性症状、双相抑郁、自杀风险高的情况，通常需要以药物为基础，心理治疗作为联合。把心理治疗当成“不用吃药的替代品”，最常见的结局是拖到更重。两者作用层面不同，一个调生理状态，一个改应对方式，多数时候是加法而不是减法。【指南】

27.“电休克很可怕，是拿电电人”

误解：像电影里那样，人被按住通电、抽搐、失忆。

澄清：现代的无抽搐电休克在全身麻醉和肌肉松弛下进行，患者睡着、没有抽搐、没有疼痛，整个过程几分钟。常见的不良反应是短期记忆受影响，多数会逐步恢复。它对精神病性抑郁、拒食拒水、严重自杀风险、紧张症等情况，是起效最快、有时是救命的手段。它需要术前评估和知情同意，也确实不是所有抑郁都需要做。【指南】

28.“rTMS 就是电击”

误解：头上放个东西通电，本质还是电疗。

澄清：重复经颅磁刺激用的是磁场，在头皮下的局部脑区诱导微弱电流，不需要麻醉，不引起抽搐，也不做全身通电。人是清醒的，治疗结束后通常可以正常活动和进食。常见的不适是头皮发麻、轻微头痛，多可缓解。它和电休克是两种不同的治疗，适应证、流程和风险都不一样。【指南】

29.“中药没有副作用”

误解：中药是天然的，长期吃也不伤身。

澄清：“天然”不等于安全。中药同样有药理作用，也存在肝损伤、肾损伤、过敏和与西药相互作用的风险，部分药材对心脏、凝血有影响。正在服用的中成药、汤剂、颗粒剂，都应该告诉开西药的医生，包括成分和服用时间。中药可以作为讨论的选项，但不建议用它替代规范的抗抑郁治疗。【指南】

30.“保健品能治好抑郁”

误解：广告说某某胶囊调节情绪、没有副作用，比吃药强。

澄清：保健食品不是药品，依法不能宣称治疗作用。少数成分（如某些脂肪酸、维生素）在特定人群中有研究，但结果并不一致，产品质量和剂量也参差。把保健品当治疗，最实际的风险是花钱、延误治疗，以及和处方药发生相互作用。想试之前，先问医生“这个东西和我现在吃的药有没有冲突”。【待验证】

五、关于生活方式（第 31–37 条）

31.“运动能替代药”

误解：跑步治抑郁，药可以不吃。

澄清：运动确实有抗抑郁证据，指南把它列为辅助治疗，对轻度抑郁的作用更明显。但对中重度抑郁、伴精神病性症状或自杀风险高的人，运动不能替代药物和专业治疗。另外要小心一种副作用：把运动变成新的考核指标，“今天没跑够”又成了自责的理由。从十分钟走路开始，比立一个宏大的健身计划更可持续。【指南】

32.“晒太阳能治好抑郁”

误解：多晒太阳、多出门，抑郁自然好。

澄清：光照治疗对季节性抑郁有较明确的证据，对部分非季节性抑郁也有研究支持，但它是有具体参数的治疗（时间、强度、时长、时段），不是“随便晒晒”。日常晒太阳对作息有帮助，但不能替代治疗。双相障碍的人使用光照治疗还要注意诱发转躁的可能，需要在医生指导下进行。【指南】

33.“旅行能治好抑郁”

误解：换个环境、出去走走，心情就好了。

澄清：换环境可能带来短暂的轻松，但它不是治疗。旅行中的时差、饮酒、漏服药、复诊中断，都可能让症状反弹；严重抑郁时长途奔波、语言不通、独处酒店，反而是风险场景。把旅行当作“休息”和“奖励”是合理的，把它当作“治疗方案”则容易失望，也容易耽误时间。【待验证】

34.“断食能治好抑郁”

误解：断食排毒、生酮饮食能重启大脑，抑郁就好了。

澄清：断食或生酮饮食在抑郁方面的研究还很初步，样本小、时间短，结论不稳定。断食可能引起低血糖、电解质紊乱、乏力加重，与降糖药、利尿剂、降压药都有交互风险；孕产妇、老年人、糖尿病和进食障碍的人尤其不适合自行尝试。如果确实想了解，先在门诊提出来，让医生评估有没有禁忌。【待验证】

35.“喝点酒好睡觉”

误解：睡不着喝两口，晕乎乎就睡着了。

澄清：酒精让人更快入睡，但会破坏后半夜的睡眠结构，让早醒更严重，第二天更疲惫。它还会和抗抑郁药、镇静安眠药叠加，抑制呼吸和意识；饮酒本身也与冲动行为和自杀风险升高相关。用酒来解决睡眠，是物质使用问题最常见的起点之一。睡不好，正确的入口是评估失眠原因和做失眠的认知行为治疗。【指南】

36.“咖啡一定会加重抑郁”

误解：抑郁就不能碰咖啡，一口都不行。

澄清：咖啡因的影响个体差异很大。适量咖啡不必然加重抑郁，但下午之后摄入会影响入睡和深睡眠，对焦虑明显、心悸、手抖的人也更不友好。重点不是一刀切戒断，而是看它有没有偷走你的睡眠。突然停咖啡同样会有戒断性头痛和疲乏，减量也要慢慢来。【研究】

37.“抽烟能缓解抑郁”

误解：烦的时候抽一根，人就松下来了。

澄清：尼古丁带来的放松很短暂，随后是戒断性的烦躁和焦虑，于是越抽越多。吸烟者中抑郁的发生率更高，部分研究还提示吸烟与治疗反应较差相关。用烟自我治疗，等于用一个会加重焦虑的依赖去

缓解焦虑。想戒烟的人可以走戒烟门诊，配合行为支持和尼古丁替代，同时让精神科医生知道，以便监测情绪波动。【指南】

六、关于怎么看病（第 38–40 条）

38.“找熟人开药更方便”

误解：有熟人打个招呼就能拿药，何必排队挂号。

澄清：熟人开药往往跳过完整评估：病史问不全、量表没做、躯体疾病没排除、复诊没人跟。剂量调整和副作用监测是需要连续性的，一次“帮忙”开出的处方，后面可能没人负责。更合理的用法是：请熟人推荐靠谱的医生和就诊路径，然后按正常流程看病。医生给熟人开药，本身也有专业边界。【临床经验】

39.“网络问诊就能开药”

误解：手机上描述几句，药就能寄到家。

澄清：互联网诊疗有明确的资质和范围要求，首诊通常需要线下进行。抑郁的诊断依赖面谈、量表、病程判断和排除躯体疾病，仅凭文字很难完成。线上更适合复诊续方、调药后的短期随访、以及不方便出门时的补充。出现自杀风险、精神病性症状、复杂共病或急症时，线上不合适，必须去急诊或门诊。【指南】

40.“AI 能替代医生”

误解：AI 什么都懂，问它比挂号方便，还能给方案。

澄清：AI 不能做诊断，不能开处方，也不能在危机时刻替代人。它擅长的是帮你整理症状时间线、解释术语、准备就诊问题；它也会编造看似权威的结论，还会顺着你的说法往下讲。此外，把病历、用药、自杀念头这类信息输入公开工具，本身有隐私风险。把它当“就诊前的草稿纸”可以，当“医生”不行。【待验证】

一张可以贴冰箱的核对清单

听到任何关于抑郁治疗的说法时，可以照着这几条过一遍：

- ☐ 它有没有说清楚“适用于谁”？轻度、重度、孕产期、青少年，答案常常不同。
- ☐ 它有没有给出证据来源？是指南、研究，还是“我认识一个人”。
- ☐ 它是不是在卖东西？卖保健品、卖课程、卖“疗程”，动机要先打个折。
- ☐ 它有没有劝你停药、减药、换药？凡是让你绕开医生的建议，先放下。
- ☐ 它是不是把“可能”说成了“一定”？包好、根治、无副作用，都是危险词。
- ☐ 它有没有制造恐惧？“再吃就毁了”“不吃就完了”，两头吓人都不可信。

- ☐ 它有没有要求你隐私？要你加私人微信、发身份证、发病历给陌生账号，先停。
- ☐ 说这话的人有没有资质？能不能查到执业注册和所在机构。
- ☐ 拿不准时，把截图带给医生看，请医生帮你判断，而不是自己赌。
- ☐ 记住一句兜底的话：“我下次复诊和医生确认。”这句话可以挡掉大部分压力。

什么时候需要联系医生，或直接去急诊

下面这些情况不属于“误区讨论”的范围，不要等复诊：

- **出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤**：不要独处，让信任的人陪着你，呼叫 120 或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。把可能用于自伤的物品暂时交给他人保管。
- **高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快**：可能是血清素综合征等严重药物反应，立即急诊。
- **皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难**：严重过敏，立即呼叫 120。
- **突然话多、睡得很少却不困、冲动消费或冒险行为**：可能是转躁，尽快联系精神科医生，不要自行加药或停药。
- **连续多日几乎不吃不喝不睡、行为失控、拒食脱水**：需尽快精神科评估，必要时住院。

为什么这些误区这么难改

有三个原因值得知道，能让你少一点自我怀疑。

第一，**误区通常有一半是真的**。“副作用大就停”背后是真实的难受，“运动能替代药”背后是真实的疗效证据。半真半假的说法最难反驳，因为它抓住了你的体验，只错在程度和适用范围。

第二，**说这些话的人多半出于关心**。长辈劝你“想开点”，是希望你少受罪；朋友劝你别吃药，是怕你被药困住。反驳他们的说法，不等于否定他们的好意。可以这样回应：“我知道你是为我好，我这段时间在按医生的方案走，有变化我会告诉你。”

第三，**网络把个案当成了规律**。一个人停药后好了，会被讲成“停药也能好”；九个人停药后复发，不会有人拍视频。你看到的是被筛选过的故事，不是全部。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.2 患者与家属高频问答

这一页收了 25 个诊室里最常被问到、网上又最难查到靠谱答案的问题，涉及告诉谁、上不上班、要不要孩子、副作用、家人反对、住院和钱。每个回答都尽量给出“可以怎么做”，而不只是“要看情况”。适合患者自己读，也适合家属先读一遍再开口。

这 25 个问题是怎么选出来的

它们来自三类场景：诊室里反复被问的、家属在门口小声问的、以及患者在网上搜到一堆矛盾答案的。回答按“先给结论，再说条件和例外”的顺序写，方括号里是这条信息的证据分量。

你现在的处境	先看哪几问
想让家人理解，又怕被否定	Q1、Q11、Q12
在犹豫要不要继续上班、上学	Q2、Q7
担心恋爱、结婚、生孩子	Q3、Q4
副作用难受，或者觉得药没用	Q9、Q10、Q20
家里为“该不该停药”吵架	Q11、Q12
医生建议住院，心里发怵	Q16、Q17
钱紧张，想省一点	Q18、Q19
总在刷偏方和“自愈法”	Q21、Q22

一、说，还是不说（Q1–Q2）

Q1 要不要告诉家人和同事？

家里人通常值得说，因为他们能帮你观察睡眠和情绪、提醒复诊、在状态差的时候搭把手；可以先只说“我在看医生、在吃药”，不必一次交代全部细节。同事和领导不必主动说，法律也没有要求你披露诊断；但如果你要请假、调岗，或工作涉及驾驶、高处、操作危险设备，和直属领导说“我在规律复诊，近期需要调整”更实际。病历和诊断属于隐私，用人单位无权随意索取。【指南】

Q2 能不能上班、上学？

多数人在治疗期间可以继续工作或上学，规律的结构反而有帮助。要不要暂停，看三件事：注意力和反应速度是否影响安全（开车、操作机械、管钱），症状是否重到完不成基本任务，身边有没有人能接住你的状态。需要时可以请病假、减少工时、申请弹性安排或暂时休学。不必用“硬扛”证明自己，恢复期从半量开始，比一上来满负荷更稳。【临床经验】

二、关系、生育与日常生活（Q3–Q6）

Q3 能不能恋爱、结婚？

可以。抑郁不影响你拥有亲密关系的资格，也不等于你会拖累对方。需要留意的是时机：急性期做结婚、买房、移民这类重大决定，容易在情绪推动下后悔，可以等状态稳一些再定。要不要告诉对方、什么时候说，由你决定；很多人会在关系稳定后说“我有抑郁，正在治疗”，并邀请对方陪一次门诊。伴侣能支持你，但不能替代医生。【临床经验】

Q4 要不要孩子？

可以要，但值得提前规划，而不是“怀上再说”。孕前找精神科和产科一起评估：目前用药在孕期有没有更合适的选择，停药或换药的风险有多大，既往发作史如何。不治疗的风险（复发、营养不良、产后抑郁、自杀风险）和用药风险要放在一起算。遗传增加的是风险，不是宿命，不必因为家族史放弃生育计划。【指南】

Q5 能不能喝酒？

最好不喝。酒精会破坏后半夜的睡眠、加重早醒，和抗抑郁药、镇静药叠加会抑制呼吸和意识，也会放大冲动和自杀风险。“少量红酒养生”的说法不适用于正在服药、正在发作的人。如果已经离不开酒，不要自己骤然停——酒精戒断可能引起抽搐甚至危及生命，需要就医处理。【指南】

Q6 能不能运动？

可以，而且推荐。从走路开始，十分钟也算，目标是“每周有几次”，不是“练到某个强度”。开始阶段可能头晕、乏力，把强度降下来再试，避免睡前剧烈运动和高温脱水。运动是辅助治疗，不能替代药物；也别把“今天没做到”变成新的自责理由。【指南】

三、工作、沟通与治疗中的不顺（Q7–Q10）

Q7 要不要辞职？

先别急。辞职会同时失去收入、日常结构和社交，这三样恰恰是恢复期的重要支撑，冲动辞职后后悔的人不少。可以给自己一个期限：先按方案治疗四到八周，同时和医生讨论要不要病假、减工时或调岗，再做决定。如果确实要辞，也和医生、家人一起把经济账和安全网算清楚。【临床经验】

Q8 怎么和医生说出不满？

把“不满”说成具体的事，比说“我觉得没用”更有用。可以说：哪句话让你不舒服、哪个决定你不理解、哪种副作用影响了生活。带上记录（睡眠、情绪、副作用时间线），并直接问：“为什么选这个方案？”“还有别的选择吗？”“如果四周后没改善，下一步做什么？”如果沟通始终无效、信任已经破裂，换医生是合理选择，不算背叛。【指南】

Q9 副作用受不了怎么办？

先记录，再联系医生，不要自行停。记下出现时间、程度、对生活的影响（能不能上班、睡不睡得着），复诊时给医生看。医生能做的比“忍着”多：减量、换同类药、换类别、调整服药时间、加对症处理。多数早期副作用在一两周内减轻；但皮疹迅速扩散、高热、意识改变、剧烈腹泻要立即急诊。【指南】

Q10 觉得药没用怎么办？

先确认四件事：吃了多久（通常两到四周起效，六到八周评估）、有没有漏服、剂量是否足够、诊断和共病是否清楚。这些都没问题还是没效果，才轮到调整：加量、换药、增效、加心理治疗或物理治疗。不要自己加量，也不要把两种药叠着吃，那是最容易出危险的做法。【指南】

四、家人、复发与要吃多久（Q11–Q15）

Q11 家人不信这是病怎么办？

争论“是不是病”通常没用，换成可观察的事实：“他这个月没出过门”“他瘦了八斤”“他凌晨三点还醒着”。可以给他看医生的诊断、量表结果或一页科普；更好的是邀请他陪一次门诊，让医生当面说。找一个家里有话语权、又愿意听的人做盟友，比一个人对抗全家有效。不必逼所有人立刻转变。【临床经验】

Q12 被劝停药怎么办？

先问对方担心什么——副作用、怕上瘾、怕花钱，还是听人说不该吃。担心被听懂了，话才谈得下去。可以用“医生说”当挡箭牌：“我也想停，但医生说现在停容易反弹，让我下次复诊再评估。”停药该由医生根据病程和复发风险决定。如果对方持续施压甚至藏药、换药，要明确边界，必要时请医生或信任的第三方介入。【临床经验】

Q13 复发几次算严重？

不是只看次数。要看每次的严重程度、有没有残留症状、功能损害多大、有没有自杀风险、两次之间隔了多久。发作次数越多、间隔越短，维持治疗就越重要。复发一次就值得和医生重定计划：是剂量不够、疗程不足、停药太早，还是有共病没处理。【指南】

Q14 要不要终身吃药？

不是所有人都要。发作次数多、已经慢性化、有过严重发作或高自杀风险的人，可能需要长期维持；“长期”也不等于“终身”，可以隔一段时间复评一次。更实际的目标是：用最小的有效剂量把复发风险压住，同时把副作用控制在能接受的范围。这个平衡要定期重新谈，不是一次决定管一辈子。【指南】

Q15 心理治疗多久见效？

通常四到六次开始有变化，一个完整疗程常在八到十六次之间；行为激活起效相对快，CBT 和 IPT 需要练习和积累。前几次可能更难受，因为要正面谈一直回避的事，这不算“越治越糟”。如果十次左右仍无进展，和治疗师讨论目标与方法是否匹配，或请医生重新评估诊断。【指南】

五、住院、标签与费用（Q16–Q18）

Q16 要不要住院？

看四类情况：自杀或自伤风险高、出现精神病性症状或木僵拒食、需要做电休克、门诊治疗已经不够。住院不是惩罚，也不是“病得更重”的标签，它的作用是把人放进一个能随时观察和保护的环境。有些情况可以先考虑日间病房，白天治疗、晚上回家。【指南】

Q17 住院会不会被贴标签？

病历属于隐私，受法律保护，用人单位和学校不会自动知道。需要提前了解的是保险：部分商业保险的健康告知和理赔会涉及精神科住院记录，买之前看清条款。病耻感更多来自社会偏见，而不是住院这个动作本身；很多人恰恰是在住院期间把风险和用药调整清楚的。【指南】

Q18 费用太高怎么办？

先把预算告诉医生，让他把费用当成选药因素——集采后的仿制药往往便宜很多，同类药之间价格差别也大。可以问清楚：有没有门诊慢特病待遇、住院报销比例多少、当地有没有低价心理服务、社区精防网络能不能随访。高校和部分公立医院有低价心理咨询，公益热线可以做情绪支持。不要因为贵而自行减半，那会让前面的钱白花。【临床经验】

六、替代方案、自己调药与作息（Q19–Q25）

Q19 能不能只做心理治疗？

轻度抑郁可以，指南支持心理治疗单用；中重度、伴精神病性症状、双相抑郁、自杀风险高的情况，通常需要以药物为基础。心理治疗对重度抑郁起效可能更慢，先用药把状态稳住、再加心理治疗，是常见也合理的顺序。这个选择要和医生一起定，不是“想不想吃药”的问题。【指南】

Q20 能不能自己调药？

不建议。加量、减量、停药、叠药都有具体风险和时序问题；漏服怎么补也有规则，补错了等于加倍。感觉好转不是减量的指标，感觉变差也不是加量的指标——两者都要医生看过再定。如果你已经自行调整过，别隐瞒，如实告诉医生，他需要知道真实用量才能判断。【指南】

Q21 中药能不能一起用？

可以讨论，但一定要主动告知。部分中药会影响肝药酶、凝血功能或血清素系统，和西药同用可能改变血药浓度或增加出血风险；具体间隔和监测由医生定。不要用中药替代抗抑郁药，也不要因为“中药温和”就自行长期服用。开中成药时，把西药清单给中医师看一遍。【指南】

Q22 保健品能不能吃？

先看它有没有宣称治疗作用——保健食品依法不能这样宣传，敢这么说的先打个问号。鱼油、维生素 D、叶酸这类成分有一些研究，但结论不一致，适用人群也特定；部分还会和抗凝药、甲状腺药相互作用。想吃之前问医生一句“和我现在的药有没有冲突”，比看一百条评价有用。【待验证】

Q23 能不能抽烟？

不建议。尼古丁带来的放松很短，随后是戒断性的烦躁，于是越抽越多；吸烟还可能影响部分药物的代谢，让剂量更难调。戒烟过程中情绪会波动，最好配合戒烟门诊、行为支持和尼古丁替代，并让精神科医生知道，以便同步监测情绪。别用“抽烟能缓解抑郁”来说服自己。【指南】

Q24 能不能喝咖啡？

多数人可以适量，关键是时间：下午之后最好不喝，否则影响入睡和深睡眠。焦虑明显、心悸、手抖的人要减量；突然停咖啡会有戒断性头痛和疲乏，减也要慢慢减。不要用咖啡对抗药物带来的困倦——那通常说明服药时间或药物选择需要调整，问医生比加咖啡有效。【研究】

Q25 能不能熬夜？

最好别。睡眠紊乱既是抑郁的核心症状，也是最敏感的复发信号之一；通宵和长期轮班会让情绪更不稳。比“强迫自己早睡”更有效的，是固定起床时间、白天见光、白天活动，睡前减少屏幕和咖啡因。急性期把“保住睡眠”放在优先位置，比多干一件事重要。【指南】

带去诊室的提问清单

复诊时间短，可以把下面几条抄在纸上，按顺序问：

- ☐ 我现在吃的这个药，主要是哪一类，为什么选它而不是别的？
- ☐ 起效大概要多久？到什么时候评估“有没有效”？
- ☐ 我遇到的这个副作用，是继续观察、调整时间，还是需要换药？
- ☐ 如果这次方案不管用，下一步有哪几个选项？
- ☐ 我现在的阶段是急性期、巩固期还是维持期？大概还要走多久？
- ☐ 我需要复查哪些指标？多久查一次？
- ☐ 我能不能继续上班、开车、运动？有什么限制？
- ☐ 出现什么情况要立刻联系你，什么情况要直接去急诊？

- ☐ 我同时在吃的中药、保健品、其他科开的药，有没有冲突？
- ☐ 如果我以后想减药，应该怎么开始，找谁评估？

什么时候需要联系医生，或直接去急诊

这些问题不适合等到下次复诊再问：

- **出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤**：不要独处，让信任的人陪着你，呼叫 120 或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。把可能用于自伤的物品暂时交给他人保管。
- **高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快**：可能是血清素综合征等严重药物反应，立即急诊。
- **皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难**：严重过敏，立即呼叫 120。
- **突然话多、睡得很少却不困、冲动消费或冒险行为**：可能是转躁，尽快联系精神科医生，不要自行加药。
- **连续多日几乎不吃不喝不睡、行为失控、拒食脱水**：需尽快精神科评估，必要时住院。

回答这些问题时，记住三件事

第一，**答案有前提**。同样是“能不能上班”，轻度抑郁和伴精神病性症状的重度抑郁，答案完全不同。上面每个回答都写了条件，读的时候别只看第一句。

第二，**“看情况”不是敷衍**。精神科治疗的个体差异确实很大，同一种药在不同人身上效果和耐受可以差很远。一个敢说“要看你具体情况”的医生，通常比一个拍胸脯保证的医生可靠。

第三，**你有决定权，但没有独自承担的风险**。可以拒绝某个方案、可以要求第二意见、可以换医生；但不要在没有医生参与的情况下改变用药。把疑问带到诊室，是最省事也最安全的做法。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

12.3 网络信息与偏方辨别

确诊之后，多数人都会在网上查一轮：查症状、查药、查“有没有不吃药的办法”。查得到处都是答案，却没人告诉你哪条能信。这一页给一套可以自己用的判断方法：证据分几层、哪些信号一出现就该关掉页面、保健品和“自愈疗法”问题出在哪、AI 能帮到哪一步、以及怎么拿不准时找医生核对。读完你未必能判断所有信息，但至少能识别出最危险的那一类。

一条信息值不值得信：先看它站在金字塔的哪一层

医学证据大致分五层。层次越高，通常越接近“对多数人成立”；层次越低，越可能只是“某个人身上发生过”。

层级	是什么	能说明什么	看到时要注意
系统综述、meta 分析	把多个研究的数据合起来算	目前所有研究加在一起，倾向支持什么	也要看纳入的研究质量，垃圾研究合起来还是垃圾
随机对照试验	随机分组，一组用药一组用安慰剂	这个干预是否比对照更能改善结局	样本多大、随访多久、谁出钱做的
队列研究	跟一群人很多年，看谁得病、谁复发	某些因素与结局的关联	关联不等于因果
个案报告、专家意见	一位患者、一位医生的观察	有没有这种可能性	不能说明概率和普遍效果
传言、短视频、个人经历	“我吃了三个月就好了”	一个人的体验	无法排除自愈、安慰剂和同时接受的其他治疗

这张金字塔有三个容易忽略的地方。

第一，塔尖也可能有烂研究。 一篇 meta 分析如果纳入的都是小样本、短期、药厂资助的研究，结论照样可疑。看到“荟萃分析证明”就放心，是另一种轻信。

第二，塔底不等于没价值。 个案报告常常是发现罕见副作用的第一现场；专家意见在没有高质量证据时，是合理的经验补充。关键是要分清它在回答哪个问题：个案能回答“有没有可能”，回答不了“对我有多大用”。

第三，层级和“适不适合我”是两件事。 一项针对轻中度抑郁、平均年龄四十岁的试验，结果未必能直接套到孕妇、老人或青少年身上。看研究时先看它排除了谁，往往比看结论更重要。【指南】

七个危险信号：看到就该关掉页面

下面这些特征，任意一条出现都值得警惕；同时出现两三条，基本可以判定为不可信。

1. **承诺治愈、断根、包好。** 抑郁症可以治疗，大多数人会好转，但没有人能对个体保证结果。“三个月彻底断根”“不复发”是营销语言，不是医学语言。
2. **一边科普一边卖产品。** 卖保健品、卖“疗程”、卖仪器、卖课程、卖“一对一指导”，内容就会朝有利于销售的方向偏。不是说卖东西的人一定说谎，而是他的结论有利益在里面。

3. **要求或暗示你停掉正规治疗。** “先停西药，才能看出效果”“吃药会掩盖真实病情”——这类话最危险，因为它直接把你从有证据的治疗上拉下来。
4. **贬低正规治疗。** “精神科只会压制症状”“抗抑郁药就是合法毒品”，用整体否定来建立自己的权威。真正专业的科普会讲边界和副作用，不会靠踩别人抬自己。
5. **制造恐惧。** “再吃下去脑子就坏了”“不住院就完了”。恐慌状态下人最容易做决定，所以恐吓是常见的推销手段。反过来，把治疗说得毫无风险，也是同一套手法。
6. **索要隐私或引导私下交易。** 让你加私人微信、发病历照片、发身份证、先转账再看方案。正规医疗不会在私聊里完成诊断和收费。
7. **查不到资质。** 作者是谁、在哪执业、什么专业背景，一概模糊。可以到国家卫生健康委官网查询医师执业注册信息，也可以核实机构是否有医疗机构执业许可证。

还有一类更隐蔽：内容本身没大错，但**只讲一半**。比如大谈抗抑郁药的副作用，不提不治疗的风险；或者只讲运动的好处，不提它对重度抑郁不能替代药物。判断一篇文章，不只看它说对了几分，还要看它**刻意没说什么**。

保健品、“排毒”与“自愈疗法”

常见说法	听起来合理的地方	实际问题
某某胶囊调节神经递质，无副作用	成分听起来“天然”，包装上写着“改善情绪”	保健食品不是药品，依法不能宣称治疗作用；成分含量与质量参差，还可能和处方药相互作用
断食、轻断食重启代谢	有人反馈“头脑清醒了”	抑郁相关研究样本小、时间短；低血糖、电解质紊乱、乏力加重是现实风险
排毒、灌肠、肝胆排石	“身体干净了，情绪就好了”	没有可信证据支持“排毒”治抑郁；操作本身有感染、损伤、脱水风险
高压氧、吸氢、能量舱、频率疗法	设备看起来高级，有“原理图”	抑郁治疗证据不足；费用高、疗程长，容易拖延规范治疗
停西药改中药“治本”	中药有整体调理的说法	中药也有不良反应和相互作用；停药风险由患者独自承担
冥想 App、正念课包治一切	正念确有证据	正念认知疗法用于预防复发，有具体疗程和指导；App 打卡不能替代治疗，也不是对所有人都合适

为什么有人真的觉得有效？原因通常不在产品本身：

- **安慰剂效应。** 期待、仪式感、被关注，都会让人短期感觉好一些，这在抑郁里尤其明显。
- **自然波动。** 抑郁本来就有起伏，刚好在吃产品的这段时间好转，很容易被归功于产品。
- **同时还在接受正规治疗。** 很多人是一边吃药一边吃保健品，好转了却只记得后者。
- **幸存者偏差。** 有效的人愿意发帖，没效的人沉默；你看到的是被筛选过的样本。
- **销售话术的“确认偏误”。** 对方不断问你“是不是睡得好了点”“是不是轻松了点”，你很容易顺着点头。

一个实用原则：**任何声称能治抑郁、又让你停掉正规治疗的东西，不管它多便宜、多“天然”、多少人推荐，都不要碰。** 想试保健品，先问医生一句“和我现在的药有没有冲突”，这句话能挡掉大部分麻烦。【待验证】

AI 聊天工具的边界

AI 在抑郁这件事上能帮的忙和不能帮的忙，差别很大。

它可以做	它不能做	怎么用才安全
把零散的症状整理成时间线	诊断、判断你是不是抑郁	当草稿纸，不当医生
解释术语、把医嘱改写成清单	开药、建议剂量、判断该不该停	药物问题只找开药医生
帮你准备复诊要问的问题	评估自杀风险、做危机干预	有危险时直接找人
陪你梳理情绪、练习表达	保证信息准确	重要结论回查指南原文

需要特别记住三点。

第一，它会编。 AI 可能给出看似权威、实际不存在的指南条款、研究结论和参考文献。它说话的语气越确定，越需要你去核对原文。

第二，它会顺着你。 你问“我是不是可以停药”，它很可能给你一套“可以考虑”的理由。这不是它的判断，是你问题的回声。

第三，它不能救命。 如果你出现自杀念头，AI 不是求助对象。那一刻需要的是身边的人、120、最近的急诊，或 12356 心理援助热线。任何聊天窗口都替代不了这些。

另外，别把可识别信息输进去：真实姓名、身份证号、就诊卡号、详细住址、单位名称。这些信息一旦离开你的设备，就收不回来了。

自己动手查：指南、说明书和审批信息

想认真核实一条信息，按下面的顺序查，比在搜索框里翻十页有用：

- **先查指南。** NICE NG222（英国）、CANMAT 2023（加拿大）、中国抑郁障碍防治指南（第二版），是最常用的三份。看它们对同一个问题怎么说，比看单篇科普可靠。
- **再查药品说明书。** 在国家药监局官网按通用名或批准文号查，重点看适应证、用法用量、禁忌、不良反应、药物相互作用五栏。
- **看年份。** 指南和说明书都有更新日期；五年前的“最新研究”，现在可能已经被推翻。
- **看人群。** 研究纳入了谁、排除了谁。排除了孕妇和老人的结论，不能直接用在孕妇和老人身上。
- **看结局指标。** 是“量表分数降了两分”，还是“达到缓解的人比例”？前者听起来有效，实际可能感觉不到差别。
- **看谁出钱、谁写的。** 药企资助的研究不是不能用，但要知道利益关系；作者有没有相关利益声明。

- ☐ **核对参考文献。** 把文章里引用的标题拿去 PubMed 或期刊官网搜，搜不到就是危险信号。
- ☐ **查人。** 作者是不是注册医师、在哪个机构执业、是不是精神科背景。头衔越多、越模糊，越要小心。
- ☐ **看评论区以外的证据。** 一百条“亲测有效”加起来，仍然只是一百个个案。

拿不准时，怎么和医生核对

最省事的办法是：**把截图或链接带去门诊，请医生帮你判断。** 医生不会因为你查资料而生气，多数人反而欢迎患者带着具体问题来。

问的时候，把范围收窄到三个问题，比问“这个能不能信”有效得多：

1. “这个说法的依据是什么？是研究、指南，还是个人经验？”
2. “以我目前的情况（病程、用药、共病），它适合我吗？有什么风险？”
3. “它会不会和我现在吃的药冲突？需要监测什么？”

如果医生很忙，可以先把资料留给诊室，或请医生在下次复诊时一并回答。也可以在病历本上记下医生的原话，回家再对照，避免记忆走样。

遇到医生和网上说法冲突时，一个基本判断是：**面诊医生掌握你的完整病史、用药和检查结果，网上的内容不掌握。** 但这不意味着医生永远正确——你可以要求解释、要求第二意见。真正专业的医生会说得出理由，也会承认“这块证据不足”。

什么时候需要联系医生，或直接去急诊

- **出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤**：不要独处，让信任的人陪着你，呼叫 120 或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。把可能用于自伤的物品暂时交给他人保管。
- **高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快**：可能是血清素综合征等严重药物反应，立即急诊。
- **皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难**：严重过敏，立即呼叫 120。
- **突然话多、睡得很少却不困、冲动消费或冒险行为**：可能是转躁，尽快联系精神科医生，不要自行加药。
- **因为看到某条信息而自行停了药，随后出现头晕、恶心、失眠、情绪急转**：尽快联系开药医生，说明停了什么、停了多久。

三个最容易踩的坑

把“有研究”当成“有结论”。 一项小样本研究能发论文，不等于结论成立。看到“某大学研究发现”，先问样本多大、随访多久、有没有重复验证。

把“别人有效”当成“我也有效”。 抑郁的治疗反应个体差异很大，同一种药有人两周见效，有人毫无反应。别人的经验可以给你参考，不能给你方案。

把“没有副作用”当成“安全”。 没有副作用常常意味着没有足够的药理作用，或者根本没做监测。“纯天然、无副作用”是最该警惕的一句话。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

模块 13：记录工具与量表

这一模块是可以直接打印/照抄的工具页。记录不是为了“监控自己”，而是为了让复诊更有效、让变化更早被看见。

13.1 情绪与症状日记

情绪日记不是作业，也不是给自己打分的考卷。它的用处很具体：让你在复诊的几分钟里说清“这两周到底怎么样”，也让那些慢慢发生的变化早一点被看见。这一页给你一个一分钟就能填完的模板，讲清楚记什么、多久记一次、怎么看趋势，以及什么时候该停下来少记一点。

一、先想清楚：为什么记，不为什么记

值得记的理由：

- 复诊时医生问“最近怎么样”，你常常只能想起昨天。日记能补上这两周的全貌。
- 抑郁症的变化很慢，慢到当事人感觉不到。连续记两周，才看得出“其实这周比上周多睡了两个小时”。
- 有些规律只有记下来才看得见：每次月经前三天情绪必掉、换药第二周开始恶心、加班那周一定失眠。
- 它能帮你把“我很糟”这种整体感受，拆成“我这周睡了五小时、没出门、但还能做饭”，后者更接近事实，也更能拿去和医生讨论。

不值得的理由：

- 不是为了“监控自己”，不是为了证明你很努力，也不是为了给医生交一份漂亮作业。
- 不是诊断工具。日记里的分数不能拿来给自己定性。
- 不是情绪的发泄场。如果每次写完都更难受，那就要改写法，或者停一停。

一句话：**日记是给复诊用的，不是给自我审判用的。**

二、记什么、多久记一次

刚开始记的时候，项目越少越容易坚持。先记五项：

项目	怎么记	为什么值得记
情绪	0–10 分，0 是最低，10 是最好	看整体走向，不纠结单日
睡眠	几点睡、入睡大概多久、夜里醒几次、总共几小时	睡眠往往是最早变化的信号
兴趣	0–10 分，今天有没有一件事让我稍微投入	快感缺失是抑郁的核心症状之一

项目	怎么记	为什么值得记
用药	吃了没、有没有漏、有没有副作用	复诊时最容易被问到
一句话	今天最影响我的一件事	给分数一个背景

有余力再加几项，不必全上：

- **焦虑**：0–10 分，或“有没有心慌、坐不住”。
- **精力**：0–10 分，或“下午几点开始撑不住”。
- **食欲**：正常、减少、暴食。
- **注意力**：能不能看完一集剧、读完一页书。
- **活动量**：出门了没有、走了多久、见了人没有。
- **月经周期**（如适用）：不少人的情绪和经期明显相关。
- **酒精、咖啡因**：喝了多少，几点喝的。
- **自杀念头**：有或没有。如果有，写一句“今天有过‘不想活’的念头，晚上重一些”，不需要写细节，也不需要写方法。

最后一项要单独说：**记录自杀念头不是为了自己扛，而是为了告诉医生。** 如果你连续几天都记到，说明这不是偶发，应该尽快联系医生，而不是等复诊。

多久记一次

- **每天一次，固定在同一个时间**，比如晚上八点或睡前。固定时间比“想起来就记”更容易坚持。
- **每次一到两分钟**。超过五分钟的版本，多数人坚持不过两周。
- **症状重的时候可以一天两次**，比如早晚各一次，用来观察“早晨重、晚上轻”这种规律。
- **每周回看一次**，看看七天的平均，而不是每天的起伏。
- **不要每小时记**。那不是在观察，是在反复检查自己。

如果某天忘了，不用补记。空着就空着，补记的数据反而不准。连续空三天以上，说明这个模板对你太重了，换成更简单的版本。

三、可以直接照抄的模板

版本 A：一周一张表

日期	情绪/兴趣（0–10）	睡眠（小时/入睡）	用药与一句话
周一	4 / 3	5 / 难	按时；开会时被点名，慌了一下午
周二	5 / 4	6 / 一般	按时；傍晚散步 20 分钟，稍好
周三	3 / 2	4 / 难	晚上漏服；和家里人吵架
周四	4 / 3	6 / 一般	按时；无特别
周五	6 / 5	7 / 容易	按时；和朋友吃了饭
周六	5 / 4	7 / 容易	按时；下午很累，睡了两小

日期	情绪/兴趣（0–10）	睡眠（小时/入睡）	用药与一句话
			时
周日	5 / 4	6 / 一般	按时；想到下周要上班就烦

版本 B：一分钟三格

如果表格太麻烦，只写三行：

```
日期：
情绪（0-10）：
睡眠（几小时）：
一句话：
```

版本 C：只记“变化”

不记分数，只在有变化的日子写一句：

```
3 月 4 日：今天第一次主动出门买菜。
3 月 6 日：早醒，四点醒后再没睡着。
3 月 9 日：复诊，医生说继续原方案。
```

三个版本没有高下，能坚持的那个就是好版本。

开始记之前，照着勾一遍：

- ☐ 我选了一个固定时间（比如晚上八点）
- ☐ 我只记五项，不超过两分钟
- ☐ 我把本子/手机放在看得见的地方
- ☐ 我知道分数只是参考，不是诊断
- ☐ 我知道自杀念头要告诉医生，不是只写在纸上
- ☐ 我给自己定了一个“每周回看一次”的时间

四、怎么看趋势，而不是盯单日

单日分数受太多东西影响：昨晚没睡好、今天下雨、跟人吵了一架、正好在经期。把单日分数当结论，只会让自己一天天堂一天地狱。

看趋势的方法有这么几个：

1. **看七天平均**。把这一周的分数加起来除以七，和上一周比。差一分两分不算什么，差三分以上值得注意。
2. **看“最低的那天”有没有变高**。抑郁的人常常不是每天都很低，而是“低谷特别深”。低谷变浅，往往比平均分更早反映好转。
3. **看功能，不只看分数**。这周出门几次、做饭几次、和人说话几次。功能比情绪更稳定，也更难骗自己。
4. **看变化的速度**。两周内从 8 掉到 3，比两个月慢慢从 8 掉到 5 更值得警惕。
5. **看情境**。分数掉的那几天，是不是都有同一件事？月经、加班、吵架、换药、喝酒。

6. **看滞后**。睡眠往往先变，情绪后变；副作用先来，疗效后到。别用今天的分数判断今天的药。

容易犯的错	换个看法
“今天只有 3 分，我完了”	“这周平均 4.5，上周 4.8，基本持平”
“今天 7 分，我好了”	“这周有两天到 6 分以上，但睡眠还是差”
“分数没变，治疗没用”	“分数没变，但我这周能出门三次了”
“我每天都记，怎么还不好”	“记录是观察，不是治疗本身”

五、避免过度记录

记录是有副作用的。下面这些信号出现时，说明该减量了：

- 一天要检查好几次记录，不记就心慌；
- 写完日记情绪更差，反复回看、反复分析；
- 半夜醒来第一件事是打分；
- 为了让数字好看，开始挑着记；
- 把日记当成诊断书，对照条目给自己“确诊”；
- 因为某天分数高，就否定自己“装病”。

如果中了其中两三条，可以这样调整：

- **降到每周三次**，比如一、三、五。
- **只记事实，不写评价**。“今天睡了五小时”可以，“今天又废了”不要写。
- **不补记**。过了两天就翻篇。
- **每周只看一次**，固定在周日晚上，看平均和功能，不逐日复盘。
- **把日记和情绪分开**。写完就合上，不在睡前反复读。
- **实在难受就停一周**。少记一周不会耽误治疗，硬记下去反而可能加重反刍。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 日记里连续几天出现自杀念头，或出现具体计划、开始安排后事：**不要独处**，立刻联系信任的人，呼叫 120 或去最近医院急诊；也可以拨打 12356 心理援助热线。
- 连续多日几乎不睡、不吃、不出门，或几天内情绪急剧下滑：尽快联系医生，提前复诊。
- 出现明显兴奋、话多、睡得很少却不困：尽快联系精神科医生，不要自行加药。
- 服药后高热、意识混乱、肌肉僵硬、大汗、心跳很快：立即急诊。

日记只是记录，不能替代求助。写下来之后，要把它交给人看。

常见问题

“分数必须每天一样才正常吗？” 不需要。情绪本来就有波动，看一周的平均和低谷更有意义。

“我记着记着就忘了，是不是没毅力？” 不是。多数人坚持不了复杂模板，换成三行版本就行。

“医生会看我的日记吗？” 你可以选择给他看哪部分。不想给看的，可以不给。但涉及自杀念头和安全的信息，建议一定说出来。

“记录能代替复诊吗？” 不能。它是复诊的辅助材料，不是诊断依据。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.2 用药与副作用记录表

抗抑郁药的效果和副作用，都不是一句话能说清的：“吃了有点晕”和“吃完两小时头晕，站起来眼前发黑，持续三天，第三天开始减轻”，对医生来说是完全不同的两条信息。这一页给你一张可以照抄的记录表，教你怎么把副作用描述到医生能用的程度，以及复诊时怎么在三分钟里把关键信息讲完。它不教你调药，只教你把话说清楚。

一、这张表解决什么问题

- **记得住**：今天吃了什么、几点吃的、有没有漏，隔两周常常想不起来。
- **说得清**：副作用什么时候开始、有没有加重，靠回忆很容易说错。
- **看得出**：换药前后对比、加量后第一周的反应，只有记录才能对上时间。
- **防遗漏**：中药、保健品、感冒药、止痛药，常常忘了告诉医生，而它们可能相互作用。

还有一条：记录能帮你避免“凭感觉调药”。很多人因为难受自己减半，过几天又加回去，血药浓度忽高忽低，副作用和疗效都变得难以判断。

二、记哪些字段

最少记这几项，够用了：

字段	怎么填	为什么重要
药名	通用名 + 商品名，比如“舍曲林（左洛复）”	同名不同厂、同厂不同名很常见，写全才不会混
时间与剂量	早上/晚上，几片或多少毫克，按处方原样抄	复诊时医生要核对，别凭记忆
漏服	哪顿漏了、有没有补、补了多少	漏服会影响判断“疗效不好”的原因
副作用	什么时候开始、什么感觉、多严重、持续多久	决定要不要调整方案的关键信息
睡眠	入睡多久、夜里醒几次、总共几小时	睡眠既可能是症状，也可能是副作用
其他药物	中药、保健品、感冒药、止痛药、避孕药、酒	相互作用常常藏在这里

如果只记一栏，就记“药名 + 时间 + 副作用”。如果还有余力，加上“今天情绪几分”和“今天最影响我的一件事”。

不要在这张表上写“我觉得该减了”。 记录是给医生看的材料，不是处方。想减药，把想法写下来，复诊时问。

三、怎么描述副作用

医生最怕听到的是“我不舒服”，最需要的是四件事：

1. **什么时候开始的**：换药后第几天？加量后第几天？还是吃了某样东西之后？
2. **和吃药的时间关系**：吃完一小时出现，还是第二天早上？和某顿饭有关吗？
3. **多严重**：轻（能忍，不影响做事）、中（影响做事，但还能撑）、重（做不了事，或需要别人帮忙）。也可以打个 0–10 分。
4. **持续多久、有没有变化**：一直这样，还是一天比一天轻？有没有哪个时间段特别重？

再加一句“影响了什么”，信息就完整了：影响开车、影响开会、影响睡觉、影响吃饭、影响性生活。

模糊的说法	医生能用的说法
“吃了很难受”	“换药第三天开始恶心，早饭后一小时最重，持续到下午，这几天在减轻”
“头晕”	“起身时眼前发黑，一天两三次，量过血压偏低”
“睡不着”	“入睡要两小时，凌晨三点醒，醒了就睡不着，持续五天”
“没性欲”	“这两周完全没有性欲，之前是正常的，影响到了伴侣关系”
“拉肚子”	“每天三四次，水样，饭后明显，没有发烧和便血”
“心慌”	“每天下午心跳快，坐不住，持续半小时左右，和喝咖啡有关”

描述副作用时，**不要只报坏消息**。好转的部分也要说：睡眠从四小时变成六小时、恶心从每天变成隔天、能出门了。医生需要同时看到收益和代价，才能判断值不值得继续。

四、可以直接照抄的表格

表 1：正在服用的药物清单（贴在药盒上）

药名（通用名/商品名）	怎么吃（时间 + 片数）	从哪天开始	谁开的、为什么
舍曲林（左洛复）	早饭后 1 片	3 月 2 日	精神科张医生，抑郁
佐匹克隆	睡前 1 片，按需	3 月 2 日	同上，失眠
维生素 D	每天 1 粒	去年 10 月	自己买的

表 2：一周用药与副作用记录

下面是一张示例。药名和时间按你自己的处方原样抄，不要照搬这里的写法。

日期	药名与时间	漏服/剂量	副作用与睡眠
3/4	舍曲林 早 1 片	无	恶心，轻；睡 5 小时，凌晨醒一次
3/5	舍曲林 早 1 片	无	恶心，中，午饭后缓解；睡 6 小时
3/6	舍曲林 早 1 片	晚上佐匹克隆漏了	恶心，轻；入睡两小时，睡 4 小时
3/7	舍曲林 早 1 片	无	恶心基本消失；睡 6.5 小时
3/8	舍曲林 早 1 片	无	头晕，起身时明显；睡 6 小

日期	药名与时间	漏服/剂量	副作用与睡眠
			时
3/9	舍曲林 早 1 片	无	无恶心；睡 7 小时，一次没醒
3/10	舍曲林 早 1 片	无	轻微头晕；睡 6 小时

表 3：单独记一次“这次不舒服”

```
发生时间：
当时吃了什么药、几点吃的：
症状（用大白话写）：
程度（轻/中/重，或 0-10 分）：
持续多久：
有没有加重或减轻：
当时还吃了别的什么（中药、感冒药、酒）：
有没有联系医生、医生怎么说：
```

换药或加量后的前两周，每天照着勾一遍：

- ☐ 今天吃了几次、几点吃的、有没有漏
- ☐ 有没有新出现的不舒服，什么时候开始的
- ☐ 睡眠几小时，夜里醒几次
- ☐ 有没有吃其他药、中药、保健品，有没有喝酒
- ☐ 有没有影响到开车、上班、上课
- ☐ 有没有出现需要立刻联系医生的情况

五、复诊时怎么用

三分钟讲完，按这个顺序：

1. **先讲变化**：“这两周整体比上次好一点，睡眠从四小时到六小时。”
2. **再讲问题**：“但早上吃药后恶心，持续了五六天，现在轻了。”
3. **讲依从性**：“有一次晚上忘吃，第二天没有补。”
4. **讲新增的东西**：“上周感冒，吃了两天复方感冒药，还喝了两次酒。”
5. **讲想问的**：“这个恶心要不要处理？下次什么时候复查？”

带的东西：

- 药盒或药品照片（比说药名可靠）；
- 这张记录表，或者手机里的记录；
- 上次的处方和化验单；
- 一张写好的问题清单，最多三个。

如果医生说“最近怎么样”，不要只回答“还行”。可以拿出表，指给他看这三行：“这周睡眠、这周恶心、这周漏服。”医生看到具体的时间线，判断会快很多。

几个容易踩的坑

- **只记商品名**：不同厂家的商品名不一样，通用名才是“身份证”。
- **漏服不说**：怕被批评，就瞒着。其实漏服是常见现象，说出来医生才能判断“疗效不好”是不是因为这个。
- **把新症状都归给药**：感冒、失眠、焦虑、躯体病也会引起类似表现。记录时间线，让医生判断。
- **保健品不算药**：圣约翰草、鱼油、褪黑素、中药，都可能相互作用，都要记。
- **记录完自己调药**：这是最危险的一条。记录的目的是沟通，不是自行处方。
- **只记副作用，不记好转**：医生会误以为这个方案只有代价没有收益。
- **用记录替代复诊**：数据再多，也不能代替面诊。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：立即呼叫 120，可能是严重过敏。
- 高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快：立即急诊，可能是血清素综合征（一种由药物相互作用或过量引起的、可能危及生命的反应），带上药盒。
- 黑便、呕血、明显皮下出血、持续头痛：尽快急诊。
- 抽搐、晕厥、胸痛、意识丧失：立即呼叫 120。
- 开始吃药或加量后，出现自杀念头加重、极度坐立不安、冲动行为：当天联系医生，不要等复诊。
- 尿不出、严重便秘、视物模糊、心跳很慢：尽快联系医生。

出现以上任何一条，**不要自行停药或加药**，先联系医生或急诊。

常见问题

“副作用写下来，医生会不会觉得我事多？” 不会。副作用是调整方案的重要依据，写清楚反而省时间。

“我漏服了，要不要下次补两倍？” 不要自行加倍。按医生或药品说明书的漏服指引处理，记下来，复诊时说。

“记录表要天天填吗？” 换药、加量、出现新症状的那几周建议天天填；稳定期一周记两三次就够。

“药名太长记不住怎么办？” 拍药盒照片，或者让医生把通用名写在处方上。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222

- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.3 复诊沟通单

精神科门诊常常只有几分钟。很多人走出诊室才想起来：“我本来想问副作用的”“我忘了说这周早醒”。不是你不会表达，是没准备。这一页给你一张一页纸的复诊单：诊前用三分钟填好，诊中照着说，诊后照着确认。它不能让你变成医生，但能让你在有限的时间里，把最要紧的事说完、问清。

一、诊前 3 分钟：只准备三件事

不要试图把两周的生活全讲一遍。挑三样：

1. **这次最想问的一件事**。只能一件。是副作用？是睡不好？是想减药？是想要病假条？
2. **这两周最大的变化**。变好或变坏都算，最好带一个具体例子：“从每天睡四小时变成六小时”“这周有三天没出门”。
3. **三个想问医生的问题**。写下来，按重要程度排序。

把这三样写在纸上或手机备忘录里，进诊室前看一眼。写下来的东西，比脑子里的东西可靠。

准备项	写在哪	例子
最想问的一件事	便利贴第一行	“早上吃完药恶心，要不要换时间？”
最大的变化	第二行，带数字	“睡眠 4 小时→6 小时，但下午还是累”
三个问题	第三行起，编号	“1. 什么时候复评？2. 恶心多久会好？3. 能开病假条吗？”

顺手带上：医保卡/就诊卡、正在吃的所有药（或药盒照片）、上次的处方和化验单、之前的病历、一张能记录的本子。如果家属陪同，提前说好谁主说、谁补充，别在诊室里互相纠正。

二、诊中必说：五件事

医生问“最近怎么样”时，按这五条说，基本不会漏：

1. 症状。 情绪最低的那天几分、持续多久；睡眠（入睡多久、夜里醒几次、总共几小时）；食欲和体重；兴趣；注意力；焦虑；有没有自责。

2. 功能。 这周上班/上学几天、缺勤几天；能不能做饭、出门、见人；有没有连洗漱都困难。功能比“心情几分”更能说明严重程度。

3. 用药。 有没有漏服、漏了几次；副作用什么时候开始、多严重、有没有减轻；有没有自行减量或加量（说了不会被骂，瞒着才危险）。

4. 风险。 有没有自杀念头、自伤行为、有没有具体计划。这一条要**主动说**，不要等医生问。如果当着家属说不出口，可以提前写在纸上递过去。

5. **其他。** 最近有没有感冒、手术、怀孕或备孕、月经变化；有没有吃中药、保健品、止痛药、感冒药；有没有喝酒；有没有换工作、搬家、亲人去世这类大事。

说不出口的时候，用这个句式开头：“我有件事想说，但有点难开口。”医生大多听得懂。

三、诊中必问：六个问题

不问，医生可能默认你都知道。问了，才叫共同决策。

问题	为什么值得问
我的诊断是什么？依据是什么？需要排除什么？	避免治错方向，尤其要排除双相、躯体疾病
这次治疗的目标是什么？多久评估一次？	知道“什么时候算有效”，不至于两周就慌
如果这个方案没效果，下一步有哪些选择？	提前知道退路，减少无助感
出现哪些副作用要立刻来，哪些可以先观察？	分清“忍一忍”和“马上就医”
药具体怎么吃？漏服了怎么办？	时间、与食物的关系、漏服处理，都影响效果
下次什么时候复诊？中间出问题找谁？	避免空档期，也知道急诊去哪

还可以问，但要看时间：能不能开诊断证明或病假条；这个方案大概要持续多久；有没有医保内可选的药；心理治疗怎么约；能不能减量、什么时候考虑。问的时候尽量具体，别问“我什么时候能好”，医生很难回答；可以问“按现在的方案，我大概多久能看到哪些变化”。

四、诊后确认：别急着走

走出诊室前，做四件事：

1. **复述一遍**：“我理解是，早上吃这个药，两周后复诊，如果出现恶心加重就提前联系，对吗？”说错的地方，医生当场就能纠正。
2. **记下重点**：药名（通用名）、怎么吃、下次时间、什么情况提前来。可以让医生写在处方或病历上，或自己拍照。
3. **确认联系方式**：医院总机、门诊电话、急诊在哪、12356 这个号码存进手机。
4. **当场把药放进药盒**，或设好手机提醒。回家再弄，常常就忘了。

如果实在记不住，可以征得医生同意后录音。多数医生不介意，但先问一句。

一张纸的复诊单

打印或照抄下面这张表，每次复诊带一张。

栏位	我填的内容
今天最想问的 1 件事	
这两周最大的变化（带数字）	
睡眠：入睡多久/醒几次/共几小时	
情绪最低几分（0–10），持续多久	
用药：有没有漏、副作用	

栏位	我填的内容
有没有自杀念头（有/没有）	
想问医生的 3 个问题	1. 2. 3.
医生说的重点	
下次复诊时间	
什么情况要提前来	

背面可以贴一张用药记录表，或者把药盒拍照存在手机相册里，命名成“用药”。

五、时间不够、说不出口怎么办

- **只有五分钟**：先说要紧的。开口第一句就是“我今天最想问的是……”，比从头讲病史有效。
- **一紧张就忘**：把这张纸直接递给医生，说“我怕忘，写下来了”。
- **有家属在，不敢说**：可以提前跟医生说“有些话我想单独说”，请家属在外面等一会儿。这是你的权利。
- **觉得被敷衍**：可以问“能不能再解释一下为什么选这个方案”。如果多次沟通都不顺，考虑换医生，见 1.3 共同决策与治疗联盟。
- **忘了问**：记下来，下次问；紧急的问题打电话问，不要自己猜。
- **听不懂术语**：直接说“这个词我不懂，能用大白话讲讲吗”。医生有义务解释。

六、什么时候需要联系医生或去急诊

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- 出现自杀念头、自伤行为，或开始安排后事、查方法：**不要独处**，立刻联系信任的人，呼叫 120 或去最近医院急诊；也可以拨打 12356 心理援助热线。
- 服药后高热、意识混乱、肌肉僵硬、大汗、心跳很快：立即急诊，带上药盒。
- 皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难：立即呼叫 120。
- 症状几天内急剧加重、整夜不睡、无法进食：尽快联系医生，提前复诊。
- 出现明显兴奋、话多、睡得很少却不困、冲动消费：尽快联系精神科医生，不要自行加药。

复诊单是给“计划内”的沟通用的。计划外的情况，直接打电话或去急诊，不要等下一次预约。

常见问题

“医生很忙，我问太多会不会被讨厌？” 多数医生不怕问题，怕的是说不清。三个问题、按顺序问，是效率最高的方式。

“我可以带家属进诊室吗？” 可以，由你决定。家属可以帮忙记、补充观察，但涉及隐私的部分，你可以请他们回避。

“我想问第二意见，算不算不信任医生？” 不算。带着病历和用药记录去问，是对自己负责。问完可以把意见带回来和原医生讨论。

“医生说的我没听懂，回家就忘了。” 当场复述一遍，或请医生写下来。这是最有效的办法。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫健委公布为准。

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

13.4 PHQ-9 与 GAD-7 使用说明

PHQ-9 和 GAD-7 是门诊里最常用的两个自评量表，一个测抑郁，一个测焦虑。它们填写快、能重复、方便看变化，所以很多人会在网上测、在手机上测、在复诊前自己测。但“测出一个分数”和“知道自己得了什么病”是两件事。这一页讲清楚这两个表问的是什么、怎么计分、临界值怎么用、第 9 题为什么特殊，以及它们做不到什么。读完你可以更准确地使用它们，也不会被一个数字吓到。

一、PHQ-9：九个条目，问最近两周

PHQ-9 的正式名称是“患者健康问卷抑郁量表”，共 9 个条目，对应抑郁的九类常见表现。它问的是**最近两周**，不是今天，也不是“从小到大”。

九个条目的大意是：

1. 做事提不起劲，或没有兴趣；
2. 心情低落、沮丧、绝望；
3. 入睡困难、睡不安稳，或睡得过多；
4. 疲倦、没有活力；
5. 食欲不振，或吃得过多；
6. 觉得自己很糟、很失败，或让家人失望；
7. 注意力难以集中，比如看书、看电视时；
8. 动作或说话慢到别人能看出来，或者相反，烦躁、坐立不安、动来动去比平时多；
9. 有“不如死掉”或伤害自己的念头。

每条按最近两周出现的天数打分：

分数	含义
0	完全不会
1	好几天
2	一半以上的天数
3	几乎每天

九条相加，总分 0–27 分。分数越高，症状越多越重。但它测的是“症状有多少”，不是“病有多重”，更不是“你有多不努力”。

怎么读总分

总分	常用分级	可以怎么理解
0–4	无或极轻	目前症状很少；如果有困扰，仍值得和医生谈
5–9	轻度	有一些症状，功能可能受影响；建议随访、心理干预或生活调整

总分	常用分级	可以怎么理解
10–14	中度	常作为“需要进一步评估、考虑治疗”的区间
15–19	中重度	症状较明显，通常需要规范治疗
20–27	重度	症状重，需尽快专业评估，注意安全风险

常用临界值：10 分。多数研究里，10 分以上提示“可能存在抑郁”，作为筛查工具敏感性和特异性都比较理想（简单说，就是“真有病的人大多能查出来，没病的人不容易被误判”）。【研究】但它是筛查线，不是诊断线。15 分以上更可能达到中重度，20 分以上要格外注意功能和风险。

还要提醒一句：**分级是人群层面的经验，不是对你个人的判决。** 有人 12 分还能正常上班，有人 9 分已经起不来床。功能和风险，永远比分数重要。

二、第 9 题：必须单独看

第 9 题问的是“有不如死掉或用某种方式伤害自己的念头”。这一题很特殊：

- **只要不是 0 分，就值得说出来。** 哪怕只是“偶尔闪过一下”，也告诉医生。
- **它不是自杀风险评估工具。** 它只筛“有没有念头”，不评估“有多危险”“有没有计划”“有没有保护因素”。真正的风险评估要靠医生面谈，问想法、计划、准备、既往尝试、保护因素。
- **分数低不等于安全。** 有人第 9 题答 1 分，但已经有具体计划；也有人答 2 分，只是被动的“活着没意思”。不能只看数字。
- **答了也不会被“抓走”。** 医生问这些，是为了帮你，不是为了评判你。如实回答，才能得到合适的帮助。

如果第 9 题≥1 分，同时又出现下面任何一种情况，应当天联系医生或去急诊：有具体计划、开始准备东西、写过告别的话、觉得自己拖累别人、无法保证自己安全。

三、GAD-7：七个条目，测焦虑

GAD-7 是“广泛性焦虑障碍量表”，7 个条目，同样问最近两周，按 0–3 计分，总分 0–21。条目大意是：

1. 感到紧张、焦虑或急切；
2. 没法停止或控制担忧；
3. 对各种各样的事担忧过多；
4. 很难放松下来；
5. 因为不安而坐不住；
6. 容易烦恼或急躁；
7. 感到好像会有可怕的事情发生。

总分	常用分级
0–4	无或极轻
5–9	轻度
10–14	中度
15–21	重度

常用临界值：10 分，作为“可能存在焦虑”的筛查线。【研究】GAD-7 也被用来粗略评估惊恐、社交焦虑、创伤后应激的症状强度，但那些情况有各自的专门量表，不能只靠 GAD-7 判断。

抑郁和焦虑经常一起出现。两个表一起测，能帮医生看清“主要是抑郁、主要是焦虑，还是两者都有”，但**不能靠两个分数自己下诊断**。

两个表放在一起看

项目	PHQ-9	GAD-7
测什么	抑郁症状	焦虑症状
条目数	9	7
总分范围	0–27	0–21
常用临界值	10 分	10 分
特殊条目	第 9 题（自伤念头）	无

两个表都问“最近两周”，都按天数计分，都可以重复测量看变化。它们的区别在于：PHQ-9 里有两三条是躯体症状（睡眠、食欲、疲倦、动作迟缓），GAD-7 更偏认知和紧张感。躯体疾病、药物副作用、失眠本身，都会让分数偏高，这也是为什么不能只看分数。

四、量表的局限：它不能做什么

1. **不能确诊。** 诊断需要医生面谈，看症状持续时间、功能损害、排除躯体疾病和药物影响、排查双相障碍和精神病性症状。量表只是筛查。
2. **不能替代访谈。** 同样的分数，背后的原因可能完全不同：一个是抑郁，一个是甲状腺功能异常，一个是药物副作用。
3. **不能测功能和生活质量。** 有人分数不高但完全无法工作，有人分数中等但生活正常。
4. **会受状态影响。** 昨晚没睡、今天吵架、经期、感冒，都会让分数上下浮动几分。
5. **有文化和语言差异。** 不同版本、不同翻译、不同理解，都会影响结果。尽量用同一版本、同一语言重复测。
6. **不适合每天测。** 每天测会放大正常波动，也容易变成反复检查自己的强迫行为。
7. **不能用于鉴定。** 劳动能力鉴定、伤残评定、司法鉴定，都需要专门评估，不是自评量表能承担的。
8. **青少年有专门版本。** 儿童青少年的量表条目和临界值不同，不能直接套用成人版。

五、多久复测一次

- **常规随访**：每 2–4 周一次，或每次复诊前测一次。
- **调整治疗后的最初几周**：可以 2 周左右复测一次，看方向和副作用。
- **稳定期**：1–3 个月一次即可。
- **不要每天测**。情绪本来就有波动，天天测只会让你盯着数字过日子。
- **复测时记录总分 + 关键条目**，比如第 9 题、睡眠条目。只看总分，会漏掉重要的变化。
- **变化多少算有意义**：研究中常把 5 分左右的变化当作“可能有临床意义”的参考。【研究】但这不是硬标准，还要结合功能和你自己的感受。

测之前，照着勾一遍：

- ☐ 我按“最近两周”回答，不是按今天
- ☐ 我没有为了“看起来好一点”或“证明我很严重”而改答案
- ☐ 我用的是同一版本、同一语言
- ☐ 我知道分数只是参考，不是诊断
- ☐ 第 9 题如果非 0，我会告诉医生
- ☐ 我记下了总分和日期，方便下次比较
- ☐ 我没有因为分数高就自行加药，也没有因为分数低就自行停药

六、什么时候需要联系医生或去急诊

什么时候需要联系医生 / 去急诊

- PHQ-9 第 9 题≥1 分，同时有具体计划、准备行为，或觉得自己无法保证安全：**不要独处**，立刻联系信任的人，呼叫 120 或去最近医院急诊；也可以拨打 12356 心理援助热线。
- 总分达到重度范围（20 分以上），或几天内快速上升：尽快联系医生，提前复诊。
- 出现幻觉、妄想、坚信被害：尽快精神科就诊。
- 出现明显兴奋、话多、睡得很少却不困：尽快联系医生，不要自行加药。
- 服药后高热、意识混乱、肌肉僵硬、大汗、心跳很快：立即急诊。

量表分数再高，也不能代替求助。分数是给你和医生用的，不是给你一个人扛的。

常见问题

“我测了 12 分，是不是中度抑郁？” 12 分落在“中度”区间，但那是筛查分级，不是诊断。是否患病、要不要治疗，要医生面谈后决定。

“网上的免费量表准吗？” 看它是不是完整的原版条目、计分是否正确。很多“10 秒测抑郁”的测试改过条目，结果不能参考。

“分数降了 3 分，算有效吗？” 3 分可能在正常波动范围内。可以结合睡眠、功能、兴趣一起看，别只盯一个数字。

“我不想让单位知道，测出来的结果会泄露吗？” 自评结果属于个人健康信息，给谁看由你决定。医院内的病历管理有相应规定，具体可以问就诊医院。

“两个表都测了，是不是就确诊了？” 不是。它们只是筛查工具，确诊必须靠医生。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

附录：术语与参考文献

本模块的篇目可以按顺序读，也可以按问题单独查。

A 术语表

这一页把资料库里反复出现的 60 个术语，翻译成不需要医学背景也能懂的话。它适合在读病历、看说明书、听医生解释时随手查，也适合家属用来听懂患者在说什么。每个词两句话：第一句说它是什么，第二句说它容易搞混在哪。少数密切相关的词合并成一条（两本诊断手册、两种谷氨酸能药物），所以总数是 60 条。

不用背。读不懂某段话时回来查一条，比从头看到尾有用。要提醒的是：**术语是描述工具，不是诊断工具**。看到“难治性抑郁”“精神病性抑郁”这类词，别往自己身上套，那需要医生结合病程、检查和用药史判断。下面按主题分成六组，编号连续，方便互相引用。

一、诊断与分类（第 1–9 条）

- **1 抑郁障碍**：以持续情绪低落、兴趣减退、精力下降为核心的一组疾病的总称，包含多个亚型。它不是“心情不好”，而是有诊断标准、会损害工作与生活功能的状态。
- **2 MDD（重性抑郁障碍）**：抑郁障碍里最典型的一类，要求至少两周的持续低落或兴趣丧失，并伴随睡眠、食欲、精力、注意力、自责等改变。诊断前要排除药物、甲状腺等躯体原因。
- **3 ICD-11 与 DSM-5-TR（两本诊断手册）**：世界卫生组织与美国的分类系统，医生靠它们统一“什么算抑郁、分几度”。国内临床与医保编码长期以 ICD-10 为主，近年逐步向 ICD-11 过渡；DSM-5-TR 更常用于研究。两本不完全一致，换个系统可能换个说法。
- **4 精神病性抑郁**：抑郁重到出现幻觉或妄想，内容常与自责、罪恶、贫穷、躯体疾病有关。它需要尽快就医，常需药物联合治疗，电休克对这类情况效果明确。
- **5 非典型抑郁**：不是“不典型所以轻”，而是一组特征：能吃能睡、体重增加、四肢沉重、对人际拒绝特别敏感、情绪能因好事短暂好转。这些特征会影响医生的选药判断。
- **6 季节性抑郁**：随季节规律出现，多见于秋冬和日照变短的时节，表现为嗜睡、贪食碳水、精力下降。光照治疗对它的证据相对明确。
- **7 持续性抑郁障碍**：症状不算最重，但拖了两年以上，中间很少有连续几个月的完全缓解。它容易被当成“性格就这样”，治疗往往需要更长疗程。
- **8 混合特征**：抑郁的同时出现话多、思维奔逸、冲动、精力过剩等躁狂样症状，程度不够诊断躁狂。它提示双相可能，单用抗抑郁药要谨慎。

- 9 **共病**：同时存在另一种疾病，如焦虑障碍、失眠、物质使用、慢性疼痛、ADHD。共病会改变选药和疗程，需要一起处理，而不是只挑一个治。

二、治疗目标与疗程（第 10–17 条）

- 10 **应答**：症状减轻到一定程度，临床上常看量表分数下降约一半，但还没完全好。应答说明方向可能对，不代表可以停药。
- 11 **缓解**：症状基本消失、功能恢复，量表落回正常范围并维持一段时间。缓解是治疗的目标，比“好一点”要求更高。
- 12 **康复**：不只是没有症状，还包括能工作学习、维持关系、应对压力。它是一个过程，不是某天到达的终点。
- 13 **复发**：缓解之后又出现一次新的发作。停药过早、有残留症状、发作次数多的人风险更高；复发不是“白治了”，而是需要重新评估方案。
- 14 **急性期**：治疗的头一阶段，目标是尽快控制症状、把风险降下来。这个阶段复诊最密，方案调整也最频繁。
- 15 **巩固期**：症状缓解后的几个月，药物通常维持原剂量，目的是把效果稳住、防止反弹。很多人在这里误以为“已经好了”而停药。
- 16 **维持期**：巩固之后的更长一段时间，通常沿用已经有效的剂量预防复发，是否调整由医生根据耐受性和风险决定。要维持多久，取决于发作次数、严重度和风险因素。
- 17 **难治性抑郁**：规范使用两种或以上不同机制的抗抑郁药、足量足疗程仍无效。判断之前要先排除“假难治”：剂量不足、漏服、误诊、共病没处理。

三、药物与用药风险（第 18–28 条）

- 18 SSRI：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂，最常用的一类抗抑郁药。整体耐受性较好，早期常见恶心、失眠、出汗和性功能影响。
- 19 SNRI：同时作用于 5-羟色胺和去甲肾上腺素的一类药，常用于抑郁伴疼痛或乏力明显的人。部分人会出现血压升高，需要监测。
- 20 NaSSA：主要阻断 α2 受体、增强去甲肾上腺素和 5-羟色胺传递的一类药，常用来改善睡眠和食欲。镇静和体重增加比较常见。
- 21 NDRI：主要作用于多巴胺和去甲肾上腺素的药，对快感缺失、乏力、注意力差可能更有帮助，也会让人更警醒。
- 22 TCA：三环类，老一代抗抑郁药，疗效确切但副作用和过量风险较大，现在多用于特定情况。过量可能致命，家里有高风险的人要格外注意保管。
- 23 MAOI：单胺氧化酶抑制剂，用于难治病例，需要严格的饮食限制并避免多种药物同用。与某些麻醉药、曲马多等合用可能引起血压危象。

- 24 **增效**：在原有抗抑郁药基础上加另一种不同机制的药，来增强效果。加什么、加多少必须由医生决定并监测，自己叠加很危险。
- 25 **换药**：从一种药换到另一种，有交叉增减、叠替、停药清洗等方式。怎么换取决于药物半衰期和相互作用，自己换容易出问题。
- 26 **撤药反应**：突然减量或停药后出现的头晕、恶心、失眠、电击感、焦虑加重，通常在几天内出现。它不是成瘾，也不是复发，但需要靠缓慢减量避免。
- 27 **血清素综合征**：5-羟色胺过多引起的药物反应，表现为高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识改变、心跳很快。这是急症，立即就医。
- 28 **转躁**：抗抑郁治疗过程中出现躁狂或轻躁狂，表现为话多、睡得少却不困、冲动、易怒。出现后要尽快联系医生，不要自行加药。

四、心理治疗（第 29–37 条）

- 29 CBT（**认知行为治疗**）：通过识别和改变想法与行为来改善情绪的结构化治疗。通常带作业，疗程十几次上下，对抑郁有较强证据。
- 30 **行为激活**：从“先动起来”入手，通过安排有意义和愉快的活动，打破“不想动—更不想动”的循环。对乏力、快感缺失明显的人常常先起效。
- 31 IPT（**人际心理治疗**）：聚焦四类人际问题：悲伤、角色转换、人际冲突、社交孤立。适合抑郁与人际事件明显相关的人。
- 32 MBCT（**正念认知疗法**）：八周课程，训练对想法和感受的觉察，主要用于预防复发，尤其适合已经多次发作的人。
- 33 **正念**：有意识地、不评判地注意当下正在发生的事。它不是“清空大脑”，而是练习在念头出现时不立刻跟着走。
- 34 **去中心化**：把“我就是个失败者”看成“我脑子里出现了一个‘我是失败者’的念头”。这个距离感能降低想法的杀伤力。
- 35 **暴露**：在安全条件下，分级、逐步地面对因害怕而回避的情境或感受。它需要计划和陪同，不是硬闯。
- 36 **行为实验**：把“我一开口就会被拒绝”这类预测，变成现实中可以检验的小实验。结果常常比想象温和。
- 37 **认知歪曲**：系统性偏离事实的思维方式，如非黑即白、灾难化、读心术、以偏概全。识别它不是自责，而是给想法松绑。

五、评估工具与物理治疗（第 38–45 条）

- 38 PHQ-9：九个条目的抑郁自评量表，用于筛查和追踪严重度。分数高提示需要专业评估，不能拿来自行确诊。

- 39 GAD-7：七个条目的焦虑自评量表，常与 PHQ-9 一起用。它测的是最近两周的焦虑症状，不是“性格急”。
- 40 HAMD（汉密尔顿抑郁量表）：医生他评的抑郁量表，多用于研究和临床试验。它需要受训的评定者，不适合自测。
- 41 MECT（无抽搐电休克）：在麻醉和肌肉松弛下，用短暂电流诱发一次受控的治疗性发作，外观上通常只有轻微抽动。对精神病性抑郁、拒食、高自杀风险起效快，常见短期记忆影响。
- 42 rTMS（重复经颅磁刺激）：用磁场刺激特定脑区，不需要麻醉，也不引起抽搐。常见头皮不适和轻微头痛，多数在门诊完成。
- 43 tDCS（经颅直流电刺激）：用微弱电流调节大脑皮层兴奋性，证据强度弱于 rTMS。家用设备缺乏监管，自行使用有风险。
- 44 光照治疗：用特定强度的亮光在固定时段照射，主要用于季节性抑郁。它有具体参数、需要指导，双相患者要警惕转躁。
- 45 氯胺酮与艾司氯胺酮：起效快、维持时间短的药物，用于难治性抑郁，必须在医疗场所给药并监测。有解离反应、血压升高和滥用风险。

六、证据、预防与权益（第 46–60 条）

- 46 安慰剂效应：因为期待、仪式感和被关注而产生的真实改善。它说明症状会被非药物因素影响，不说明药物无效。
- 47 证据等级：对一条结论可信程度的排序，通常按研究设计分级。等级高不等于对你一定有效，等级低也不等于无效。
- 48 RCT（随机对照试验）：把受试者随机分到治疗组和对照组，以减少偏倚。它是判断“有没有效”的核心设计，但要样本够大、随访够久、利益关系清楚。
- 49 meta 分析：把多个研究的数据合并统计，得出更稳的总体估计。纳入研究的质量，决定了它自己的质量。
- 50 依从性：按约定服药、复诊和做练习的程度。它受副作用、理解、费用、病耻感和医患关系影响，不是单纯的“听不听话”。
- 51 共同决策：医生提供专业信息，患者提供目标和偏好，一起选方案。它不是“医生说了算”，也不是“患者自己拍板”。
- 52 安全计划：提前写好的危机应对步骤：预警信号、能找谁、做什么、危险物品放哪。危机时人很难临场思考，所以要提前写。
- 53 病耻感：因为得病而觉得自己低人一等、害怕被歧视的感受。它常常比症状本身更阻碍就医。
- 54 社会功能：工作、学习、家务、社交、自我照顾的能力。治疗目标不只是症状减轻，还包括功能恢复。
- 55 残疾/病假：因病暂时或长期不能工作时的制度安排，涉及病假条、劳动能力鉴定和医保政策。具体标准以当地规定和经办机构答复为准。

- **56 知情同意**：医生说明方案、风险、替代选择和后果，患者在理解后自主决定。它是权利，不是走形式。
- **57 非自愿住院**：在患者有伤害自己或他人的危险、且拒绝就医时，依法定程序实施的住院。《精神卫生法》对条件和程序有明确规定。
- **58 心理教育**：向患者和家属讲清楚疾病、治疗和复发的知识。它不是走过场，能提高依从性、减少复发。
- **59 复发预防**：一整套做法：维持用药、识别早期信号、稳定作息、处理压力、定期复诊。它比“等复发了再治”省力得多。
- **60 数字 CBT**：通过 App 或网络平台提供的结构化认知行为治疗，有真人指导的版本证据更好。它适合轻中度、等待期或作为面对面治疗的补充，不能替代危机干预。

最容易混淆的四组词

容易混的	区别	为什么重要
应答 vs 缓解	应答是“好了一半”，缓解是“基本好了并维持一段时间”	只有达到缓解，维持治疗才有明确的意义
撤药反应 vs 复发	撤药反应多在减停后几天内出现、以躯体症状为主；复发多在数周内、以情绪和兴趣下降为主	处理方式不同：一个要放慢减量，一个要恢复治疗
转躁 vs 混合特征	转躁是出现躁狂或轻躁狂发作；混合特征是同期躁狂样与抑郁症状并存但不够诊断	两者都提示双相可能，都可能需要调整方案
难治性抑郁 vs 治疗不充分	前者是足量足疗程、两种机制都试过仍无效；后者是剂量或疗程没到位	把“没吃够”当成“治不好”，会错过有效方案

看病历时，先弄清这九个词

- ☐ 我的诊断具体是哪一类？是单次发作还是反复发作？
- ☐ 医生说的“缓解”，是指症状消失，还是分数下降？
- ☐ 我现在在急性期、巩固期还是维持期？
- ☐ 这次调整是加量、换药，还是增效？
- ☐ 我出现的这个反应，是副作用、撤药反应，还是复发？
- ☐ 有没有“混合特征”或“转躁”的迹象需要排查？
- ☐ 我的共病有哪些？在不在同时治？
- ☐ 下次复诊要评估什么指标？
- ☐ 如果出现危险情况，我该联系谁、去哪里？

什么时候需要联系医生，或直接去急诊

术语能帮你听懂，但不能帮你判断轻重。下面这些情况不需要查术语，直接行动：

- **出现自杀念头、计划或准备行为，或已经自伤**：不要独处，让信任的人陪着你，呼叫 120 或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。
- **高热、大汗、肌肉僵硬或抽动、意识混乱、心跳很快**：可能是血清素综合征，立即急诊。
- **皮疹迅速扩散、面唇肿胀、呼吸困难**：严重过敏，立即呼叫 120。
- **突然话多、睡得很少却不困、冲动消费或冒险行为**：可能是转躁，尽快联系精神科医生。
- **连续多日几乎不吃不喝不睡、行为失控**：需尽快精神科评估，必要时住院。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines
- 李凌江, 马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社, 2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。

B 参考文献与指南版本

这一页列的是本资料库主要依据的指南、法规和公共来源，写明它们各自的用途、发布或更新年份，以及证据是怎么分级的。它适合想追原文的人、想判断“这条说法出自哪里”的人，也适合需要向单位、学校或保险公司说明依据的人。只列真实存在、可以核对到出处的来源；不确定的宁可不列。

这份清单怎么用

三种用法：

- **查依据。** 某篇正文写了“指南推荐”，可以到这里找对应来源，再去看原文的那一节。
- **判断新旧。** 对照发布和更新年份，判断你看到的信息是不是已经过期。
- **准备沟通材料。** 需要向单位、学校、保险公司说明治疗合理性时，指南名称和年份比“网上说”有分量。

要说明的是：本资料库是科普，不是指南的替代品。指南给出的是人群层面的推荐，具体到个人还要看病情、共病、用药史和偏好。

主要指南与来源

来源	发布/更新	主要用途	分级方式（简述）
NICE NG222《成人抑郁：治疗与管理》	2022 发布，持续更新	成人抑郁的分级治疗路径、心理治疗与药物选择、难治性抑郁的处理	证据质量与推荐强度分开，推荐用词有明确层次
CANMAT 2023 成人重性抑郁障碍临床指南	2023 发布（Can J Psychiatry, 2024）	药物序贯治疗、换药与增效、联合策略、特殊人群	每条建议标注证据级别与推荐强度，具体以原文表格为准
APA《重性抑郁障碍治疗实践指南》第 3 版	2010	美国精神医学界的治疗框架，急性期与维持期安排	证据等级与推荐强度分开标注
《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》	2015	国内临床路径、药物可及性、分级治疗与本土经验	沿用国际分级体系，结合国内实际调整
WHO 抑郁事实清单	持续更新	公共卫生视角、疾病负担、基本治疗原则	机构共识与科普，不逐条分级
NIMH 抑郁专题	持续更新	面向公众的症状、治疗与研究进展介绍	科普性质，不替代临床指南
《中华人民共和国精神卫生法》	2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行	自愿就医原则、非自愿住院的条件与程序、隐私与权益	法律条文，不属于医学证据分级
12356 心理援助热线	2025 年起全国推行	危机时的即时心理支持与转介	服务渠道，不是治疗证据
药品说明书（国家药监局批准）	随审批与修订更新	适应证、用法用量、禁忌、不良反应、药物相互作用	法定文本，具有法律效力

这张表里有一条容易被忽略的区别：**指南、法律、说明书、热线，是四种不同性质的东西**。指南说“通常怎么治”，法律规定“什么能做、什么不能做”，说明书是药品的法定文本，热线是服务通道。它们不能互相替代，也不该混着引用。

三份最常用的指南，各自适合查什么

NICE NG222 的长处是路径清楚：轻度、中度、重度分别怎么起步，心理治疗放在什么位置，什么情况下换药或加增效，难治性抑郁往哪走。它的推荐用词有严格层次，“提供”“考虑”“不要提供”之间不是修辞差别，而是推荐强度差别。想看“标准流程长什么样”，从这份入手最快。

CANMAT 2023 的长处是药物细节和序贯策略：第一轮、第二轮、第三轮分别有哪些选择，换药和增效怎么权衡，联合用药的证据到什么程度。它的表格密度高，适合带着具体问题去查，不适合从头读到尾。

《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》 的长处是本土情境：国内可及的药物、医保与分级诊疗的现实、常见的中西药联用问题。它的出版年份较早（2015），读的时候要留意：部分药物信息和证据在那之后已经更新，遇到具体用药问题仍以当前说明书和面诊医生为准。

证据等级怎么读

不同指南用的符号不一样，粗略可以这样对照：

大致级别	通常指什么	举例
高（如 1 级 / A）	多项随机对照试验或 meta 分析，结果一致	某种心理治疗对轻中度抑郁有效
中（如 2 级 / B）	单项随机对照试验，或结果不完全一致	某类药在特定人群中的增效作用
低（如 3 级 / C）	非随机对照、队列研究、个案系列	罕见副作用的信号
很低（如 4 级 / D）	专家意见、病例报告、机制推测	“可能通过某通路起效”

读这张表要带着四个提醒：

第一，证据等级不等于推荐强度。 一条建议可能证据等级不高，但因为风险小、成本低、患者看重，仍然被“可以考虑”。反过来，证据等级高的干预，也可能因为副作用、费用或可及性，不被列为一线。

第二，等级高不等于对你有效。 研究纳入的是“平均患者”，不是你。孕产妇、老年人、青少年、肝肾功能不全的人，常常被试验排除在外，套用结论要格外小心。

第三，等级低不等于无效。 罕见副作用、特殊人群的经验，很难做大样本试验，但不能因此忽略。

第四，还要看结局指标和利益关系。 量表降两分和“能回去上班”是两回事；药企资助的研究可以用，但要知道利益在哪。

本资料库正文里的【指南】【研究】【临床经验】【待验证】【个人体验】五个标签，是上面这套分级的**简化版**，方便普通读者快速判断分量，不等于指南的正式分级。

版本记录

版本	日期	主要内容
V1.0	2026-10	建立 13 个模块、63 篇正文；统一体例、证据标签与安全声明；本附录同步建立术语表与来源清单

维护约定：每 12 个月复核一次，重点看 NICE NG222 的更新、CANMAT 的新版、中华医学会指南的修订，以及药品说明书的适应症变化。发现错误时，先在对应篇目顶部标注“待核”，再集中修订。

怎么判断一条信息是不是过时了

- ☐ 它引用的指南是哪一年的？超过五年的药物治疗建议，要重新核对。
- ☐ 它说的药，现在还在用吗？有没有撤市、新增禁忌或适应证变化？
- ☐ 热线号码、医保政策、病假规定，是不是近两年内的信息？
- ☐ 它有没有标注“截至某年某月”？没有日期的科普，默认按过期处理。
- ☐ 它引用的研究，后来有没有更大规模的试验得出相反结论？
- ☐ 它说的人群和你一样吗？青少年、孕产期、老年的结论常常不能通用。
- ☐ 它是不是把“指南推荐”写成了“必须”，或把“可以考虑”写成了“首选”？

最后一条尤其常见：把有条件推荐说成绝对推荐，是最容易误导人的改写方式。

引用这份资料时请注意

- 引用时请注明“《抑郁症治疗资料库》V1.0，2026-10”，并附上具体篇目名称。
- 不要摘取单句当作医嘱转发。一句话离开上下文，很容易变成另一个意思。
- 不要修改数字、年份和来源名称；不确定的地方标注“待核”，不要猜。
- 涉及具体个人的用药，请引用面诊医生的意见，而不是本资料库。

免责声明

本资料库仅用于科普学习，**不能替代精神科医生面诊、诊断与处方**。不可依据本资料判断病情、自行选药、增减或停用药物。指南会更新，药物适应证会变化，热线号码和医保政策也会调整；当本资料与面诊医生的判断或最新指南不一致时，以医生和最新指南为准，并把差异告诉医生。

若出现自杀念头、自伤行为、意识障碍、高热、严重过敏、胸痛、晕厥、抽搐等情况，请立即呼叫 120 或前往最近医院急诊；也可拨打 12356 心理援助热线。

参考来源

- NICE. Depression in adults: treatment and management (NG222), 2022（持续更新）. https://www.nice.org.uk/guidance/ng222
- CANMAT. 2023 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder. https://www.canmat.org/2023-canmat-clinical-guidelines/
- American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Major Depressive Disorder, 3rd ed., 2010. https://www.psychiatryonline.org/guidelines
- WHO. Depressive disorder (depression) fact sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression
- NIMH. Depression. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/depression
- 李凌江，马辛 主编.《中国抑郁障碍防治指南（第二版）》. 中华医学电子音像出版社，2015.
- 《中华人民共和国精神卫生法》，2012 年通过，2013 年 5 月 1 日施行. https://flk.npc.gov.cn/
- 国家卫生健康委 12356 心理援助热线（2025 年起全国推行）；地方热线以当地卫生健康委公布为准。

> 本页为科普，不构成个体化医疗建议；具体方案以面诊医生为准。